

En este libro, dirigido a profesionales especializados en la evaluación y tratamiento de casos de abuso sexual, a padres de familia preocupados por la seguridad y el bienestar de sus hijos, y al público en general interesado en el tema, el lector encontrará un estudio completo de los múltiples aspectos del problema:

- el método sistemático recomendado para evaluar si un menor ha sido o no víctima de abuso sexual
- el tratamiento especializado: de niñas y niños, adolescentes, víctimas de incesto, y adultos hostigados durante su infancia o adolescencia
- los tipos más comunes de sistemas familiares incestuosos
- los efectos de la agresión sexual (de corto y largo plazo) en víctimas y familiares
- el perfil psicológico del agresor
- las consecuencias legislativas del abuso sexual de menores

Aunque el tema es ciertamente doloroso, debemos aceptarlo y enfrentarlo. En tanto sigamos ignorándolo, continuará magnificándose, y nuestros niños no recibirán la protección que necesitan y merecen.

Escrita por expertos en el tema, esta obra no sólo se dirige a quienes han sufrido o han estado en contacto con el hostigamiento sexual, sino que representa una poderosa llamada de atención y una excelente herramienta de prevención al respecto.

Diseño portada: Angélica Pereyra, Víctor Gally, Luna Nueva Editores

EL SEXO QUE SE CALLA • Diana Sullivan / Louis Everstine



EDITORIAL PAX MÉXICO



EL SEXO QUE SE CALLA

Diana Sullivan Everstine • Louis Everstine

**DINÁMICA
Y TRATAMIENTO
DEL ABUSO Y TRAUMAS
SEXUALES EN NIÑOS
Y ADOLESCENTES**



EL SEXO QUE SE CALLA

DINÁMICA Y TRATAMIENTO
DEL ABUSO Y TRAUMAS SEXUALES
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Diana Sullivan Everstine
Louis Everstine


EDITORIAL
PAX MÉXICO

EL LIBRO MUERE CUANDO LO FOTOCOPIAN

Amigo lector:

La obra que usted tiene en sus manos es muy valiosa, pues el autor vertió en ella conocimientos, experiencia y años de trabajo. El editor ha procurado dar una presentación digna a su contenido y poner su empeño y recursos para difundirla ampliamente, por medio de su red de comercialización.

Cuando usted fotocopia este libro, o adquiere una copia "pirata", el autor y el editor dejan de percibir lo que les permite recuperar la inversión que han realizado, y ello fomenta el desaliento de la creación de nuevas obras.

La reproducción no autorizada de obras protegidas por el derecho de autor, además de ser un delito, daña la creatividad y limita la difusión de la cultura.

Si usted necesita un ejemplar del libro y no le es posible conseguirlo, le rogamos hacérselo saber. No dude en comunicarse con nosotros.

EDITORIAL PAX MÉXICO

Título original de la obra: *Sexual Trauma in Children and Adolescents: Dynamics and Treatment*

Publicada por Brunner/Mazel, Inc., Nueva York, NY, EUA

COORDINACIÓN EDITORIAL: Gilda Moreno Manzur

TRADUCCIÓN: Víctor Becerril Montekio

DISEÑO: Lina Nueva Editores

© 1997 Diana Sullivan Everstine y Louis Everstine

© 1997 Editorial Pax México, Librería Carlos Cesarman, S.A.

Av. Cuauhtémoc 1430

Col. Santa Cruz Atoyac

México, D.F. C.P. 03310

Teléfono: 5605 7677

Fax: 5605 7600

Correo electrónico: editorialpax@editorialpax.com

Página web: www.editorialpax.com

ISBN 968-860-472-0

Reservados todos los derechos

Impreso en México / Printed in Mexico

Agradecimientos

Nos familiarizamos con el tema de este libro a través de nuestra experiencia en el Emergency Treatment Center (ETC, Centro de Tratamiento de Emergencia), agencia de salud mental con fines no lucrativos descrita en nuestra obra *People in Crisis (Personas en crisis)*. El Centro, fundado en 1975, continúa funcionando y progresando, habiendo sido recientemente calificado como un proyecto United Way. Agradecemos a United Way de Santa Clara, California, su impulso al trabajo del Centro.

Desde el principio de esta década, el ETC ha recibido un creciente número de peticiones de ayuda en casos de abuso sexual de niños. Algunas han provenido de abogados, otras de oficinas policiacas contra la agresión sexual y muchas más de programas de Ayuda a Víctimas y Testigos de los condados de Santa Clara y San Mateo.

A fin de separar estos casos de los más generales que llegaban a nosotros en relación con niños y adolescentes, y para darles una atención y un enfoque especiales, se creó un Centro de Traumas Infantiles. El equipo a cargo está compuesto por médicos con experiencia en el ETC y por miembros del grupo de práctica privada Psicólogos Afiliados de Palo Alto, California. En las reuniones semanales del dicho Centro, se analizan nuevos casos y se presentan aquellos ya en progreso para consulta.

Uno de los principales patrocinadores del Centro de Traumas Infantiles es el doctor Ben Hammett, miembro del Consejo Directivo del ETC y del Mental Research Institute (MRI, Instituto de Investigación Mental). El doctor Hammett ha dedicado un enorme esfuerzo a ayudar y promover el trabajo de ambos centros y, sin su ayuda, ninguno de ellos hubiera podido sobrevivir con tanto éxito.

Nuestro reconocimiento y agradecimiento para otros miembros del Consejo Directivo del ETC por su apoyo permanente y valiosísimo: a la abogada Liz Shively, la Capitán Lucy Carlton y el Sargento Tom Sing, a la consejera matrimonial Sarita Ledet y los doctores en psicología Marguerite McCockle, Roger Smith, y John McNeel. Se debe una mención especial al doctor Arthur M. Bodin, uno de los fundadores del Centro y por mucho años el presidente de su Consejo.

El Centro de Traumas Infantiles se ha beneficiado con el consejo y la ayuda de los abogados Richard Alexander y Richard Gregg. Este último colaboró con nosotros en la elaboración del capítulo 8.

Las ideas aquí presentadas se describieron y discutieron en conferencias internacionales co-organizadas por el ETC y el MRI en Niza (1982), Munich (1984)

y Amsterdam (1985). Hemos tenido el privilegio de ser invitados a varios países de Europa para hablar de este tema en talleres, seminarios y conferencias; y gracias a nuestros anfitriones, el doctor Mony Elkaim de Bélgica, el doctor Herman Vergouwen y Bert van Luyn de Holanda, Bjorn Reigstad y Knut Sorgaard de Noruega, y la doctora. Anne Ancelin-Schutzenberger y Catherine Mesnard de Francia. Su inspiración ayudó al desarrollo de las ideas expresadas en este libro y con ellos aprendimos que el maltrato a los niños es un mal endémico de la cultura occidental.

Ann Alhadeff, nuestra editora, sufrió un accidente fatal poco antes de terminar este libro. Ella fue una fuente de ayuda y aliento en cada paso dado en el camino. No olvidaremos su gentil guía ni su insistencia en la perfección.

Prólogo

En su obra *People in Crisis: Strategic Therapeutic Interventions*, (Personas en Crisis: Intervenciones terapéuticas estratégicas), Diana y Luis Everstine abordaron el delicado problema de la intervención ante la crisis provocada por situaciones violentas, desde las originadas en el ámbito familiar (esposas e hijos golpeados), hasta los casos de agresión sexual en contra de los niños y las familias incestuosas.

Ahora, los autores arrojan una reveladora luz sobre la dinámica y el tratamiento del abuso sexual de niños y adolescentes. En esta obra nos entregan uno de los análisis más útiles de todos los aspectos de este trágico problema.

El capítulo 1 se inicia con una visión global del hostigamiento sexual e incluye una exposición de los más comunes mal entendidos en relacionados con el abuso

sexual de menores. En el capítulo 2 los autores presentan un método sistemático para evaluar si un menor ha sido o no víctima de abuso sexual, así como de la medida en que esto ha generado un trauma. En este capítulo se exponen también los resultados de otras investigaciones existentes, los efectos psicológicos posteriores al trauma sexual, los síntomas clave manifestados por los menores de quienes se ha abusado y la manera en que se deben realizar las primeras entrevistas con el menor y sus padres.

Los siguientes cinco capítulos versan sobre el tratamiento de las víctimas de abuso sexual, incluyendo el de adultos que lo sufrieron durante su infancia o adolescencia. Se consideran tanto los casos en los que se solicita la intervención del terapeuta después del trauma sexual, como aquellos en los que es necesario alterar un tratamiento en proceso debido a la revelación de ese tipo de abuso.

En el capítulo 3 se estudia el tratamiento de la víctima infantil y de los otros miembros de su familia que se hayan visto afectados por el trauma; los objetivos de la terapia; de la reacción familiar; la negación del trauma por parte de los padres; las familias emocionalmente empobrecidas; la relación entre el terapeuta y la madre del niño; el comportamiento sexualizado del menor; la terapia que se recomienda y los procesos de tratamiento.

En el cuarto capítulo se presenta el tratamiento de las víctimas adolescentes enfocando los temas más importantes que enfrenta el terapeuta. Se introduce el "síndrome de trauma por violación y el ciclo de recuperación", la "violación secreta", cuando la adolescente trata de ocultar lo sucedido a sus padres, el impacto de la violación de una adolescente sobre el sistema familiar, y otros temas.

En el capítulo 5 se revisan las investigaciones y los trabajos teóricos relacionados con el incesto; se describe la evolución de los tipos más comunes de sistemas familiares incestuosos, lo mismo que el tratamiento de dichas familias.

En el capítulo 6 se trata el tema del niño varón víctima, considerando los efectos de la agresión sexual sobre él en el corto y el largo plazo, los efectos sobre la familia, la fuente de la agresión, el perfil psicológico del agresor, y los métodos de tratamiento.

El capítulo 7 resulta de interés especial pues abarca el problema de los adultos que fueron víctimas de abuso sexual durante su infancia o adolescencia. En él se hace un retrato clínico de las características de estas víctimas y se analizan la relación entre el cliente y el terapeuta, el proceso de descubrimiento del "secreto" de la víctima, los errores comunes de los terapeutas que tratan a estas personas y el proceso terapéutico en sí.

Finalmente, en el capítulo 8 se hacen las consideraciones éticas y legales relacionadas con la denuncia del abuso sexual de un menor, la importancia de que el terapeuta lleve un registro del tratamiento, y los asuntos legales.

Por todo lo anterior, éste es un libro oportuno e invaluable para los profesionistas de la salud mental dedicados a la evaluación y el tratamiento de niños y adolescentes que han sufrido de abuso sexual y de sus familias.

Índice

Agradecimientos	iii
Prólogo	vii
Prefacio	xi
Capítulo uno.	
El problema del hostigamiento sexual	1
Capítulo dos.	
Evaluación del trauma	16
Capítulo tres.	
Tratamiento de la víctima infantil	44
Capítulo cuatro.	
Tratamiento de la víctima adolescente	94
Capítulo cinco.	
Incesto	126
Capítulo seis.	
El niño víctima	185
Capítulo siete.	
Adultos que fueron traumatizados en la infancia	218
Capítulo ocho.	
El abuso sexual de menores y sus consecuencias legislativas en México	252

Bibliografía	269
--------------	-----

Prefacio

Las trágicas historias de niños que han sufrido de abuso sexual llegan a conocerse de muy diversas maneras. Los siguientes son algunos lacerantes ejemplos: Danielle tenía cuatro años cuando sus padres se divorciaron. Su madre pensaba que su ansiedad e irritabilidad se debían al divorcio, pues su conducta era especialmente difícil después de las visitas a su padre. Aproximadamente a los cinco años de edad, Danielle comenzó a masturbarse abiertamente y, cuando su madre le dijo que no hiciera eso delante de la gente, la niña contestó: "¿Por qué no, mami? Si eso es lo que papi y yo hacemos."

El padre de Doug murió cuando él tenía sólo ocho años. Su madre creyó que quizá le haría falta un modelo masculino correcto, de modo que lo inscribió en un equipo de atletismo por las tardes. Pensaba que el niño estaba

enojado y distante debido a la muerte de su padre. Pero una noche se presentó en su casa un detective que investigaba un caso de pornografía infantil y le informó que Doug era uno de varios niños que el entrenador utilizaba para tales fines.

Cuando Donna y Susan tenían ambas catorce años, una noche bebieron alcohol por primera vez. Ya intoxicadas, juraron decirse sus secretos más profundos y oscuros, pero Susan no estaba preparada para oír la historia de su amiga, quien le reveló que había sostenido relaciones sexuales con su padre desde los cuatro o cinco años de edad —no recordaba exactamente cuándo había comenzado.

A los seis años de edad, Alice visitaba a menudo a sus abuelos. Después de una de esas visitas, se quejó de dolores abdominales y se rehusó a dormir en su cama; decía que había enormes serpientes de colores que escupían veneno. Cuando su madre la llevó al pediatra por sus dolores abdominales y su extraña conducta, se descubrió que la niña había sido violada por su abuelo.

Lisa tenía dieciséis años. Había sido una niña modelo hasta los catorce, cuando empezó a tomar drogas, a escaparse de la casa y a comportarse promiscuamente. Desesperados, sus padres acudieron a un terapeuta. Al realizar éste la historia clínica, los padres revelaron que el tío de Lisa la había hostigado sexualmente cuando ella tenía siete años. Sin embargo, como el hecho "no pareció haberla molestado", tan sólo la apartaron de él y asumieron que todo estaba en orden.

Durante un examen médico de rutina, Annette, de dieciséis años, reaccionó de manera tensa y ansiosa cuando la doctora, tratando de tranquilizarla le pasó el brazo sobre los hombros. Aunque la conocía de toda la

vida, Annette se retiró bruscamente y empezó a sollozar. Al preguntarle qué pasaba, la profesional se enteró de que la joven había sido violada seis meses antes y no había dicho nada a sus padres. La doctora le explicó que debía denunciar la violación y que ella le ayudaría a lo largo de todo el proceso. Tratando de darle algo de seguridad en sí misma, le preguntó si prefería decirlo a la policía antes que a sus padres. Annette contestó que comenzaría por la policía, de modo que la doctora canceló sus citas para el resto del día y la acompañó a levantar la denuncia.

Carol disfrutaba una exitosa vida profesional a los treinta años. Entró en terapia para intentar comprender por qué tenía tantos problemas para establecer relaciones sanas con los hombres. Tenía una larga historia de relaciones abusivas y se describía a sí misma como una persona que vivía a cierta distancia de los demás: cuando trataba de acercarse, empezaba a sentirse "adormecida". Sólo después de varios meses de terapia pudo sacar a la luz el hecho de que su padre la había hostigado sexualmente desde los seis años de edad.

Este tipo de experiencias afectan a la víctima y a quienes la aman. Irónicamente, algunas víctimas aceptan su suerte como algo que se merecen, o simplemente por lo que piensan que así es la vida. Sin embargo, todas continúan su búsqueda hasta encontrar a alguien dispuesto a escucharlas:

Las cosas más importantes son las más difíciles de decir... pues las palabras las disminuyen. Las palabras "encogen" cosas que dentro de tu cabeza parecían ilimitadas, volviéndolas a su tamaño natural. Pero hay algo más que eso, ¿no es cierto? Las cosas más importantes se encuentran dema-

siado cerca del sitio donde se halla enterrado tu corazón secreto, como señales que guían hacia un tesoro que a tus enemigos les encantaría robarse. Y uno puede hacer revelaciones tremendamente dolorosas sólo para encontrar que la gente te mira de manera extraña, sin comprender lo que dijiste o por qué pensaste que era algo tan importante que casi llorabas al decirlo. Eso es lo peor, creo. Cuando el secreto permanece encerrado no por falta de alguien que lo diga, sino por falta de un escucha comprensivo (King, 1983, p. 289). Este libro se escribió para aquellos que están tratando de oír.

Organización del libro

Los capítulos del libro están organizados de la siguiente manera: el capítulo 1 presenta una visión general del problema del hostigamiento sexual a los niños. El capítulo 2 presenta un método sistemático para evaluar si un niño ha sido o no hostigado y, en caso afirmativo, la profundidad del trauma causado. En los dos capítulos siguientes se analiza de manera detallada el aspecto del tratamiento, primero el del niño víctima (capítulo 3) y después el de la víctima adolescente (capítulo 4). El capítulo 5 abarca el tema del incesto, su tratamiento y su evaluación, incluyendo el tema de las acusaciones falsas. En el capítulo 6 se aborda el hostigamiento a los niños varones.

En el capítulo 7 se estudia el tipo de caso en el cual un adulto revela que él o ella sufrió de violencia sexual durante la infancia. En el capítulo 8 se describe la interacción del psicoterapeuta que trabaja con víctimas de traumas sexuales y el sistema legal.

Aclaración sobre algunos términos empleados

Las diversas formas de traumas sexuales que se pueden causar en los niños varían de acuerdo con su intensidad y la naturaleza de su impacto psicológico en el niño. Así pues, pensamos que es importante dar definiciones claras de las diferentes formas de trauma.

Vale la pena notar que buena parte de la investigación previa sobre el tema de los traumas sexuales infantiles se dirigió a grupos de víctimas de caricias y exhibicionismo, y no a aquellas que sufrieron ataques tan devastadores como la violación y la sodomía. Por tanto, la validez de los resultados de estos estudios es dudosa, y al menos, debe tenerse cuidado de hacer generalizaciones a partir de ellas. Existe una diferencia considerable entre el trauma de un infante de ocho años que ve a un exhibicionista en el parque y el de aquel que es sodomizado por un amigo cercano de la familia.

Tal como lo usamos aquí, el término *trauma sexual* comprende todo el rango de categorías físicas descritas a continuación, así como sucesos traumáticos de la niñez con un trasfondo sexual, como son el haber presenciado el acto sexual o una conducta inapropiada o seductora por parte de un adulto. Este término se utiliza como sinónimo de *abuso sexual*. De manera más específica, la expresión *agresión sexual* se utiliza como descripción de cualquier forma de contacto sexual adulto-niño en el cual el adulto toca, acaricia o penetra el cuerpo del niño. Dentro de la categoría de agresión sexual, *hostigamiento* se refiere a las caricias, besos o masturbación del niño por parte de

un adulto sin que haya penetración del cuerpo. *Violación* se refiere a la penetración forzada de la vagina de una niña, con el dedo o el pene de un adulto, o con cualquier objeto. Otra forma de violación es la *copulación oral forzada*, a la cual llamamos en esta obra *violación oral*. La *sodomía* se define como la penetración anal forzada con el pene o el dedo, o con cualquier objeto.

El *incesto* se define generalmente como la actividad sexual entre dos personas a las cuales la ley no les permite contraer matrimonio. En el contexto de este libro, incesto es el contacto sexual entre un niño y a) un padre consanguíneo; b) un pariente, incluyendo el padrastro o la madrastra, o c) alguien que realiza el papel de padrastro, tal como el compañero o compañera del padre o madre y a quien el niño considera un sustituto de su padre o madre.

El *exhibicionismo* se define como el acto de mostrar los genitales realizado por un adulto frente a un menor.

El término *pedófilo*, que originalmente se refería sólo a quienes hostigan a niños de edad menor a la pubertad, se utiliza aquí para designar a cualquier hostigador (no familiar) de un menor.

uno

El problema del hostigamiento sexual



Finalmente, los terapeutas comienzan a aceptar la horrenda realidad de la agresión sexual a los niños. Un tema doloroso, sí, pero uno que debemos enfrentar a manera de declaración, dejando de relegarlo al dominio de la fantasía de niños neuróticos. En tanto los adultos ignoren el problema de la agresión sexual, éste continuará creciendo en magnitud, y nuestros niños no recibirán la protección que merecen. Algunas personas han adoptado la postura de que en Estados Unidos existe una histeria nacional en torno al abuso sexual. Debido a esta visión, es posible que se requiera de un escándalo considerable para sacar al problema de uno de los rincones más oscuros de la sociedad.

Al igual que con otros tipos de abuso de los niños, muchos ignoran las dimensiones del hostigamiento sexual en nuestra cultura. Sólo podemos espe-

cular al respecto, aplicando todos los multiplicadores que nos parezcan adecuados a las cifras reportadas. Dado que el número de incidentes *denunciados*, tanto de niños como de niñas, ha crecido de un año al otro durante los últimos quince años (Finkelhor, 1984), podemos asumir que la frecuencia del fenómeno va en aumento. Tal creencia es obviamente errónea, aunque la inclinación a aceptarla sea fuerte. No cabe duda que debe haber existido tanto o más hostigamiento sexual a niños durante la época victoriana (por nombrar sólo un periodo específico de la historia) que ahora, pero los valores de entonces hacían que el informe fuera recibido con más desprecio que el acto reportado. Lo que sabemos de nuestra época es que más casos de hostigamiento están saliendo a la luz y su denuncia atrae la atención del público hacia el problema. La atención crea un clima que favorece la denuncia y así se crea una cadena. En resumen, es cada vez más claro que podemos saber cuánto hostigamiento ocurre en nuestra sociedad. Y ello nos hace confiar en que al menos estamos atrayendo los casos más graves hacia nuestros sistemas de tratamiento.

Ideas erróneas sobre el hostigamiento a los niños

Las agresiones sexuales contra niños definitivamente son un fenómeno raro. De acuerdo con Finkelhor (1979, 1982, 1987), y Fritz, Stoll y Wagner (1981), entre un 15 por ciento y un 45 por ciento de las mujeres y entre un 3 por ciento y un 9 por ciento de los hombres han sido

traumatizados sexualmente durante la infancia.* Y mientras las denuncias de abuso físico de niños en Estados Unidos aumentaron en un 16 por ciento entre 1983 y 1984, durante el mismo periodo, las denuncias de abuso sexual se elevaron en un 59 por ciento (García, 1986). Más aún, de manera conservadora se estima que sólo uno de cada cinco casos de hostigamiento a niños es reportado a la policía. Considerando esta baja tasa de denuncias, resulta claro cuán equivocado es considerar que los casos son poco frecuentes. Antes de tratar los aspectos clínicos de la traumatización sexual de los niños, es importante revisar algunas de las causas de este malentendido.

En la mayoría de los casos, los adultos tienden a tener un "marco" mental respecto de que los niños requieren supervisión cuidadosa y disciplina: se considera que son "malcriados" y que no se puede confiar en ellos. Muchos adultos creen que deben cuidarse de las mentiras, las exageraciones y los "cuentos" infantiles. En muchos casos, incluso cuando un niño informa que ha sido agredido sexualmente por un adulto, se considera que miente en tanto no se pruebe que está diciendo la verdad. Nos parece irónico que en un sistema de justicia responsable de proporcionar protección a los niños, un adulto sea considerado inocente en tanto no se prueba su culpabilidad, mientras que la palabra de un niño contra un adulto siempre se recibe con escepticismo. También vale la pena notar que antes de 1970 la mayor parte de la literatura profesional sobre el tema de los traumas sexuales infantiles versaba sobre si el niño estaba mintiendo o no, y no sobre las implicaciones emocionales de la experiencia en su persona.

* Los autores opinan que los porcentajes generalmente aceptados para los varones que han sido hostigados cambiarán al 10 por ciento o al 15 por ciento de la población cuando se tengan datos más precisos.

Según nuestra propia experiencia (apoyada por la de otros, por ejemplo, Finkelhor y Browne, 1985; Geiser, 1979; Green, 1986; Hilberman, 1976; Peters, 1973), en la mayoría de los casos el niño está diciendo la verdad. Al evaluar la veracidad de los alegatos de un menor, preferimos empezar por asumir que lo que se dice es verdad en tanto no se pruebe lo contrario mediante una valoración exhaustiva (Geiser, 1979). Al hacerlo de este modo, uno puede echar a andar un proceso que asegure que el niño esté protegido de cualquier abuso posterior.

Otra desafortunada fuente de errores concierne a la agresión sexual hacia los menores puede encontrarse en los escritos de Sigmund Freud. Dado que no pudo aceptar que algunos de sus pacientes adultos habían sido víctimas del incesto, Freud presentó ciertos estudios de casos como ejemplos de fantasías incestuosas y no de incesto real (Peters, 1973). ¿Por qué lo hizo? Peters supone que Freud tuvo que soportar demasiadas críticas profesionales debido a sus teorías sobre la sexualidad infantil y no deseaba enfrentar una censura adicional por revelar que un número importante de sus pacientes (en su mayoría, miembros de prominentes familias vienesas) habían sido realmente víctimas de incesto. Además, Peters sostiene la hipótesis de que en lo personal, el propio Freud, padre de hijas, no podía tolerar tales revelaciones. Desafortunadamente, pocos terapeutas se han atrevido a cuestionar estas falsedades clínicas. Por ende, dicha opinión equivocada puede haberles permitido evitar tratar aspectos especialmente dolorosos y difíciles de la conducta humana, y relegarlos a la vida fantasiosa de simples niños. A pesar del recono-

cimiento actual de que tales ideas de Freud eran falsas, aún prevalece mucha reticencia entre los profesionales a involucrarse en el tema.*

Otra consideración, relacionada con la anterior, es que la mayoría de los adultos que abusan sexualmente de menores son conocidos por la familia de éstos o forman parte de ella (DeFrancis, 1969; Finkelhor y Browne, 1985). De modo que el niño puede denunciar la agresión cometida por un amigo de la familia, un miembro de la comunidad conocido de la familia, o por un integrante de la familia. Algunos padres simplemente no están preparados para enfrentar la ruptura familiar o la presión social creada por dar crédito a semejante denuncia. Por desgracia, muchos sencillamente se niegan a creer que un miembro de la familia o el amable señor que vive en la misma calle pudiera haber hecho tal cosa. Generalmente se piensa que los hostigadores sexuales de menores son viejos hostiles, o miembros de otra raza o personas que obviamente están mal de la cabeza. La realidad es muy diferente: la mayoría de los hostigadores de menores pertenecen a la misma raza que el niño y son hombres aparentemente sanos de alrededor de treinta años (Groth y Birnbaum, 1978).

El Departamento de Policía de Los Ángeles ha completado un perfil de los hombres que hostigan a jovencitos. Suele tratarse de un hombre casado, con hijos, perteneciente a la clase media y con un título profesional. En muchos casos sostiene una vida sexual relativamente activa con su esposa. En general, no tiene buenas relaciones interpersonales, pero a menudo se le percibe como un

* Con estos comentarios no pretendemos disminuir el innegable valor del trabajo de Freud dentro del campo de la psicología. Pensamos que nadie ha contribuido a nuestra ciencia tanto como él.

ciudadano respetable. Este perfil está muy lejos del típico "viejo cochino que le regala dulces a los niños en el parque". De hecho, pocos niños son agredidos sexualmente por gente vieja.

Dado que gran parte de los niños traumatizados sexualmente son víctimas de alguien a quien conocen y en quien confían, la mayoría de las agresiones ocurren dentro del entorno habitual del menor. Muchos pedófilos buscan trabajo o se ofrecen como voluntarios en lugares frecuentados por niños y en donde los padres piensan que sus hijos estarán seguros, por ejemplo: escuelas, centros recreativos, guarderías, grupos de Niños Exploradores, Niñas Guías, etcétera (Geiser, 1979, p. 93). Debido a este tipo de fenómenos, el terapeuta debe considerar que la historia del niño es cierta hasta no estar *completamente seguro* de que no es así. Nuestra experiencia nos ha demostrado que al denunciar agresiones sexuales, los niños suelen decir la verdad más frecuentemente que los adultos.*

Otra faceta de este dilema que confunde e influye en que los adultos no crean en el niño o culpen a éste, es que muchos de los casos de agresión sexual contra menores no implican el uso de fuerza física extrema. El tipo de fuerza que se usa sobre los niños es generalmente una amenaza o coacción verbal (DeFrancis, 1969; Finkelhor y

*Es más factible que un reporte falso sobre agresión sexual provenga de un adulto que de un menor. Cuando un menor efectivamente hace una acusación falsa de abuso sexual, por lo general lo hace obedeciendo a la presión de un adulto (Green, 1986). Por ejemplo, un niño puede acusar falsamente a uno de sus padres de haber abusado sexualmente de él o ella en el contexto de un juicio por la custodia, como resultado de la presión o del "lavado de cerebro" por parte del otro progenitor. El tema general de las acusaciones falsas se trata en detalle en el capítulo 5.

Browne, 1985; Groth y Birnbaum, 1978; Schultz, 1975; Sgroi, 1978). Casi siempre el niño es llevado con engaños a la situación. Es lógico pensar que los adultos que intentan hostigar sexualmente a menores no necesitan usar mucha fuerza física: dado que son más grandes, pueden someter a sus víctimas con facilidad. Y, considerando que la mayoría de los hostigadores son conocidos y gozan de la confianza del niño, en muchos casos no se requiere de fuerza alguna. Dada la notoriedad que se da a los asesinatos y otro tipo de crímenes violentos contra niños, la gente cree firmemente que las agresiones sexuales a menores son violentas. Así pues, cuando un niño le dice a un adulto que él o ella ha sido agredido sexualmente, aquél puede malinterpretar la ausencia de pruebas de fuerza física como una comprobación de la conformidad del infante; o bien, puede creer que se trata de una historia falsa. Hemos observado que la gente tiende a mostrar-se más comprensiva con víctimas de agresión sexual que han sido lastimadas físicamente (bien sean niños o adultos), pues puede enfocar su atención en las heridas físicas. De este modo, evitan tratar los difíciles aspectos sexuales de la agresión, lo mismo que las "invisibles heridas psicológicas" de la víctima (Everstine y Everstine, 1983, pp. 163-164).

Finalmente, hay muchos aspectos de la conducta infantil que harán que el adulto dude de la realidad de la historia. Algunos niños que han sido hostigados muestran una reacción plana que los adultos tienden a interpretar como indiferencia o impasividad ante el suceso (Burgess y Holmsrom, 1974; Everstine y Everstine, 1983; Green, 1986; Peters, 1973; Sgroi, 1978). Pero en realidad se trata de un indicador de la depresión del menor, de su estado de shock o de su temor, y no de su indiferencia o calma. La falta superficial de emociones en el niño puede incluso llevar a los adultos a creer que no ha sido afectado

por la agresión, o a dudar que ésta haya ocurrido. Más bien, lo que puede estar ocurriendo es que el niño esté deprimido y sea incapaz de expresarse, o bien que tenga un gran temor de exponer sus sentimientos a un adulto. Este fenómeno fue muy bien descrito por Sgroi (1978):

Los niños pueden presentar una enorme gama de conductas en respuesta a la agresión sexual, las cuales van desde lo positivo hasta lo negativo. Observadores no especializados pueden notar una conducta tranquila y despreocupada o una directa negación de la situación, o una actitud positiva del niño hacia el sospechoso de haberlo hostigado (todas estas conductas han sido frecuentemente observadas en las víctimas infantiles de casos comprobados de agresión sexual). Esto lleva a la errónea conclusión de que, dada la reacción del menor, no puede haber existido tal agresión. Es fundamental que los profesionales responsables de tratar a estos niños conozcan el amplio rango de reacciones que pueden presentarse (véase la página 90).

Algunos niños quizá parezcan débiles o neutros, emocionalmente, mientras otros acaso exhiban sentimientos positivos e incluso afecto hacia la persona que los ha traumatizado. Otros, por el contrario, pueden mostrar emociones claramente negativas hacia los agresores; algunos reaccionan al trauma sexual con una o varias de las posibles manifestaciones somáticas: problemas de sueño y alimentación, micciones en la cama o reacciones fóbicas. Dada la complejidad de estos factores, puede transcurrir un periodo de varias semanas o meses, en los cuales se requerirá un considerable apoyo, antes de que el menor pueda revelar sus auténticos sentimientos en relación con el incidente y el agresor.

La conducta que se presta especialmente a una trágica mala interpretación es la del (llamado) niño se-hostigador. A menudo, los adultos aceptan las protestas del hostigador que alega haber sido seducido por un menor sexualmente agresivo. Según nuestra experiencia, y la de otros especialistas (por ejemplo, Geiser, 1979; Green, 1986; Meiselman, 1978; Porte, Blick y Sgroi, 1982), tales excusas rara vez resultan ciertas. Los niños emocionalmente necesitados o abandonados (como lo son muchas de las víctimas de agresión sexual) pueden tratar de agradar a un adulto respondiendo a las proposiciones sexuales, abiertas o encubiertas, que éste les hace; no suelen actuar con sexualidad ante adultos ni dirigirla a ellos, a menos que hayan sido ya traumatizados sexualmente por otro adulto. Muchos tienen un comportamiento sexual hacia otros niños en una forma exploratoria, por lo general a espaldas de los adultos. Sin embargo, incluso si un niño fuera sexualmente agresivo con un adulto, la mayoría de la gente estará de acuerdo en que la responsabilidad del autocontrol y la conducta adecuada le corresponde precisamente a este último.

Los niños son esencialmente polimórficos en su orientación sexual. Como ha señalado Schultz (1975), los niños pueden ser curiosos sexualmente de una manera infantil, esto es, en relación con su nivel de desarrollo. Cuando su curiosidad culmina con un acto sexual genital adulto, el menor puede aterrorizarse o sentirse traicionado o confundido, pues él o ella no tiene manera de resolver o dar cauce a la sobreexcitación surgida. Lo que pudo comenzar como curiosidad o como un intento por ganarse el afecto y la atención de un adulto, a menudo termina siendo una pesadilla de la cual es imposible despertar.

Cabe notar que la conducta sexual abierta de parte del niño a menudo es un grito de auxilio. En otras

palabras, es una manera de tratar de decir lo que sucedió a los adultos que lo rodean. Un niño traumatizado puede tener una actitud sexual con otros niños, puede realizar actos autoeróticos en público o incluso actuar de un modo primitivamente erótico hacia los adultos. Estas actitudes generalmente son indicadores de un trauma sexual previo y es preciso cuidarse de responder con agresividad a ellas por muy chocantes que sean. El niño puede estar poniendo a prueba al adulto, para ver si éste abusa de él o de ella sexualmente, tal como alguien ya lo hizo. Puede estar representando, de manera patética, lo que le resulta imposible decir. (El tema de la actitud abiertamente sexual se trata en detalle en el capítulo 3.)

Muchos factores han interactuado para originar conceptos equivocados en relación con el abuso sexual de los niños. Los terapeutas empiezan a percatarse de que se trata de un problema enorme de nuestra sociedad y de que literalmente existen miles de jóvenes víctimas necesitadas de cuidado y protección adultos. Más aún, hay miles de "víctimas silenciosas" (Hilberman, 1976; Nelson, 1982): los niños a quienes no se les creyó o que simplemente no se atrevieron a decir a un adulto de la agresión sexual sufrida en la infancia, y que conservan, ya como adultos, las heridas emocionales de las agresiones.

Quiénes hostigan sexualmente a los niños

La mayoría de las agresiones contra niños son cometidas por hombres (Finkelhor, 1982, 1987; Geiser, 1979). Finkelhor sugiere algunos factores en la socialización masculina que podrían jugar un papel importante en la etiología del problema:

1. Las mujeres aprenden más pronto y de manera más completa a distinguir entre las formas de afecto sexuales y no sexuales. En parte, debido a su preparación para la maternidad, son sensibilizadas para apreciar las satisfacciones que implica el afecto sin componente sexual. Desafortunadamente, los hombres no tienen muchas oportunidades legítimas de practicar la crianza y de expresar sus necesidades de dependencia sino por medio de sexo. De modo que, cuando necesitan afecto y se sienten dependientes, tienden a buscar un desahogo en términos sexuales, incluso con una pareja inconveniente. Las mujeres pueden satisfacer tales necesidades con los niños sin que el sexo entre en escena.
2. Los hombres crecen con la imagen del éxito heterosexual como algo más importante para la identidad de su género de lo que sucede con las mujeres. Cuando su ego o su capacidad sufren un agravio, el varón tiende a sentir la necesidad del sexo como una manera de reafirmar su funcionalidad. Si la única pareja sexual a la mano es un niño, la confirmación es poca, pero es alguna.
3. A los hombres se les enseña a enfocar sus intereses sexuales aislándolos del contexto de una relación. En cambio, las mujeres fantasean con situaciones totales y relaciones completas. Para ellas, el hecho de que la pareja sexual fuera un menor haría mucho más difícil experimentar interés sexual por él (ella). Los hombres, por su parte, pueden vivir la excitación tan sólo

porque la pareja, aunque sea un menor, tiene los genitales adecuados o puede participar en el acto sexual deseado.

4. Por último, la socialización del hombre le hace concebir a la pareja sexual adecuada como una persona menor en edad y tamaño, mientras que la mujer espera que su pareja sexual sea mayor y más grande. Hay menos deformación en un hombre que encuentra sexualmente atractivo a un menor, porque se trata sólo de una extensión del rango de sus apetitos (1982, p. 101).

No pretendemos decir que las mujeres no abusan sexualmente de los niños. De hecho lo hacen, pero cuando así ocurre, a menudo es en la forma más sutil (aunque igualmente dañina en lo emocional) de caricias inapropiadas, caricias durante el baño o el cambio del niño, o mediante una actitud sexualmente seductora hacia el menor. Las diferencias de orden masculino o femenino que se encuentran en los tipos y severidad de la traumatización sexual son complejas y multifacéticas, y provocan cuestionamientos que exigen una continua investigación.

Observaciones generales

Es importantes subrayar que la eventual recuperación del menor dependerá de la manera en que el adulto responde a su informe de haber sido hostigado. Uno de los factores clave en la recuperación del niño es que sus padres y los adultos importante para él lo hagan sentirse protegido y apoyado (Everstine y Everstine, 1983;

Finkelhor y Browne, 1985; Geiser, 1979; Katan, 1973; Peters, 1973; Tufts, 1984). Sin embargo, el apoyo o la protección paterna no es suficiente para resolver el trauma de una agresión sexual durante la infancia. En nuestra opinión (véase también Porte, Blick y Sgroi, 1982) estas víctimas necesitan recibir tratamiento durante varios meses, o incluso durante varios años, dependiendo de la severidad del trauma.

En general, el tratamiento requiere que los terapeutas conceptualicen primero al niño en términos de su desarrollo, luego dentro del contexto de su sistema familiar y, finalmente, en relación con el sistema social.

Nivel actual de desarrollo

El terapeuta debe evaluar el nivel de desarrollo actual del menor y ayudarlo a *comprender* así como a resolver el trauma. La estructura de la terapia individual debe darle una situación segura en la cual el niño pueda construir un marco sano de conceptualización del evento traumático. El terapeuta lo ayuda a crear este marco conceptual interpretando la conducta del menor de manera que él o ella pueda aprehender su nivel de desarrollo. Debe también ayudarlo a liberar sus sentimientos a través del uso de juegos expresivos. Debe estar preparado para darle información exacta y adecuada a su edad sobre el hostigamiento sexual, sobre el hostigador y sobre la relación del niño con este último. Desafortunadamente, los niños agredidos frecuentemente se ven atrapados en la desinformación, la cual puede conducirlos a un sentido equivocado de su propio ser en relación con el mundo. Esta percepción errónea de sí mismo —si no se trabaja para cambiarla por una más sana y positiva— puede tener efectos desastrosos en la vida futura. En el capítulo 7,

que abarca el tema de los adultos que fueron agredidos durante la infancia, se proporciona una descripción completa de los efectos posteriores de las agresiones sexuales no resueltas.

El sistema familiar

El terapeuta deberá también trabajar con el niño dentro del contexto del sistema familiar. Tal intervención dependerá de la naturaleza y el grado del trauma. La familia generalmente requiere ayuda considerable durante la fase inicial de descubrimiento, en la cual prevalece el temor y la ansiedad y sería útil que el terapeuta dedicara tiempo a cada miembro de la familia por separado. Más tarde, la terapia familiar puede asumir diversas formas, desde reuniones mensuales de los padres o la familia hasta —en casos de incesto— una completa reestructuración del sistema familiar (este formato se analiza en el capítulo 5).

El sistema social

Por último, el terapeuta debe ayudar al niño o adolescente para que sea capaz de lidiar con su entorno social. El menor y la familia pueden haber entrado en contacto con algún aspecto del sistema legal. Es importante que los terapeutas encargados conozcan dicho sistema a fin de guiar a la familia a lo largo de sus complicaciones y tensiones. Además, quienes tratan a niños y adolescentes sexualmente traumatizados deben prepararse para trabajar más allá de los confines de sus oficinas y ayudar a otros profesionales (profesores, clérigos y pediatras) que puedan tener contacto con aquéllos. Estos menores tienen necesidades especiales y tal vez, en alguna esfera de su vida, actúen de forma incomprensible.

En resumen, el tema de la agresión sexual a niños es complejo y despierta concepciones equivocadas. Los terapeutas que deseen tratar a las víctimas serán golpeados por emociones fuertes y se verán forzados a moverse entre campos minados de prejuicios.



dos

Evaluación del trauma



El papel del terapeuta en casos de traumas sexuales en niños o adolescentes puede cobrar varias formas. Por ejemplo, el curso del tratamiento de un niño con problemas puede verse interrumpido por la revelación de un trauma sexual, pasado o actual, en cuyo caso el contexto de la terapia resultará profundamente modificado. Obien, la intuición del terapeuta puede llevarlo a descubrir, mediante la exploración del tema, la existencia del abuso sexual. En tal caso, su papel cambiará de inmediato. En otra secuencia común de acontecimientos, un niño es llevado ante el terapeuta por un padre preocupado y la primera tarea clínica consiste en evaluar si ha habido abuso y determinar la profundidad del trauma causado. Éste es el papel que con más frecuencia han venido desempeñando los terapeutas en los últimos años. Y por tal razón, en el presente capítulo, se separa la función de evaluación de la del tratamiento, para así analizarla en detalle.

En los casos en que la evaluación efectivamente lleva al terapeuta a sospechar que ha habido abuso, él o ella deberá denunciar el delito (en el capítulo 8 se estudian los requerimientos de este tipo de denuncias). Una vez dado este paso, lo común es que a quien realizó la evaluación se le solicite proporcionar tratamiento al menor. Cuando un terapeuta acepta este nuevo papel, puede empezar a aplicar los métodos terapéuticos que se presentan en el siguiente capítulo.*

Factores complejos intervienen en la evaluación del grado de trauma emocional inmediato y de largo plazo que sufre y sufrirá el menor que ha sido agredido sexualmente. Se requiere una gran investigación empírica y clínica para aclarar los asuntos metodológicos relacionados con esta forma de evaluación. Sin embargo, los resultados de las investigaciones y los estudios de casos disponibles sugieren algunos criterios útiles para determinar hasta qué grado ha sido traumatizado el menor, y para recomendar su tratamiento.

* Cuando la "evaluación" (término utilizado en el ámbito legal) de un menor se realiza debido a una petición de orden judicial con el fin de determinar si existe o no abuso sexual, el terapeuta se enfrenta a diferentes contingencias. Esto suele suceder en disputas por la custodia de los niños, cuando el proceso requiere que se defina lo que es mejor para el menor. Cuando un terapeuta acepta este tipo de casos debe considerar que la evaluación puede provocar una denuncia legal ante una autoridad oficial (la policía, o algún departamento de protección a menores) o el dar testimonio durante el juicio. Debido a los conflictos de confidencialidad (entre otros problemas) que esto conlleva, recomendamos que el terapeuta turne el caso a un colega si se señala la necesidad de tratamiento. Del mismo modo, si el menor ya está en tratamiento cuando se presenta la solicitud legal de una evaluación, el terapeuta debe rehusarse a realizarla y turnar al paciente a un colega.

Nuestra experiencia coincide con la de Schultz y DeSavage (1975), quienes afirman que el grado del trauma psicológico se relaciona con la cantidad de violencia o terror asociada con el evento, aunada a la severidad de la agresión física sufrida. Landis (1956) descubrió que los niños víctimas de violación habían sido dañados emocionalmente de una forma más profunda que los que habían sufrido otro tipo de abuso sexual. Otros autores han apuntado que la manera en que los padres, los parientes, maestros y otros adultos responden al niño tiene un efecto significativo en su recuperación (DeFrancis, 1969; Finkelhor, 1984; Peters, 1973, 1974, 1976). La reacción de los padres tanto hacia el menor como hacia el agresor puede contribuir a un trauma permanente y al desarrollo de culpa y vergüenza por parte del niño. Dicho con sencillez, los niños cuyos padres responden en forma comprensiva y cariñosa generalmente experimentan menos trauma. Por otro lado, la edad del menor se considera un factor importante en la determinación de cuán traumática ha sido la agresión y cuán exitosa será la recuperación (Burguess y Holstrom, 1984; Peters, 1974). En efecto, cuanto más pequeño sea el niño, más vulnerable será al trauma y mayores posibilidades tendrá de verse abrumado por la experiencia.

Obviamente, el número de incidentes sexuales traumatizantes sufridos por el menor, lo mismo que la cantidad de tiempo a lo largo del cual se ha abusado de él o ella son factores que predisponen a un mayor daño emocional (Yates, 1982). Como podría esperarse, el abuso sexual repetido a lo largo de un cierto periodo tiende a ser más traumático que un acontecimiento aislado. Aun así, se debe evitar considerar que un abuso aislado es menos importante en tanto no se hayan examinado en profundidad las circunstancias y las reacciones del menor.

Las investigaciones de Peters (1974), DeFrancis (1969) y Sgroi (1978) han mostrado que las agresiones a niños realizadas por personas que ellos conocen y en quienes confían pueden ser más traumáticas que las perpetradas por extraños. Según Sgroi: "En general, cuanto mayor sea la distancia emocional entre el menor y el agresor, menor será el trauma emocional previsible" (p. 135). Lo anterior señala la importancia de considerar en profundidad la naturaleza de la relación entre el niño y el agresor al evaluar la severidad del trauma sufrido. El terapeuta debe preguntarse, por ejemplo: ¿Qué necesidades satisface esta relación en la vida del niño y qué significado tendrá perderla? Es importante recordar que muchos menores traumatizados provienen de hogares caóticos o con un ambiente emocional muy empobrecido y que el hostigador puede ser percibido como el único amigo del niño o como una fuente importante de afecto y atención. Así pues, el terapeuta debe dejar sus prejuicios a un lado y evaluar realísticamente los beneficios secundarios que el menor ha asociado con el encuentro sexual. De este modo, será posible empezar a entender el clima de miedo dentro del cual el menor teme perder la relación con el adulto agresor. Cuando, más tarde, el chico llega a creer que es responsable de que el adulto haya sido castigado o puesto en prisión, se agrava su paradójico dilema.

Hemos descubierto, para nuestra desagradable sorpresa, que el grado de apoyo recibido por un menor está en proporción inversa al temor de la familia de soportar la vergüenza y el escándalo provocados por dar a conocer la agresión (véase Kaufmann, Peck y Tgiuri, 1954; Sgroi, 1978). Ésta es la trágica realidad en los casos de incesto perpetrados por el padre, quien es la fuente principal de ingresos de la familia. En muchos de estos casos, la madre prefiere pasar por alto el abuso sexual

del que su hijo o hijos son víctimas a cambio del continuo apoyo económico de su marido.

Las primeras publicaciones al respecto reflejan una considerable controversia sobre cuán duraderos son los efectos de la agresión sexual sufrida por menores. Las investigaciones de Bender (1965), citadas frecuentemente para probar que los niños se pueden adaptar satisfactoriamente después del trauma sexual, es poco convincente debido a que su diseño original no incluyó un grupo de control, esto es, un grupo paralelo de niños que por alguna razón no hubieran recibido tratamiento. Y en el estudio retrospectivo de Gagnon (1956), la mayoría de los niños había sido víctima de exhibicionismo o de caricias, mientras que menos del 5 por ciento lo había sido de violación. De hecho, casi todos los estudios importantes que han sugerido que los niños no sufren traumas perdurables debido a agresiones sexuales han carecido de grupos de control (de víctimas sin tratamiento) y han incorporado una amplia variedad de tipos de incidentes de abuso, en su mayoría sin violencia física. En contraste, se cuenta con creciente evidencia, acorde con nuestra experiencia clínica, en el sentido de que existen traumas prolongados y problemas posteriores de adaptación como resultado de una agresión sexual durante la infancia (Bauer y Stein, 1973; DeFrancis, 1969; Finch, 1967, 1973; Finkelhor, 1984; Katan, 1973; MacDonald, 1971; MacFarlane y Waterman, 1986; McCauldron, 1967; Peters, 1974, 1976; Price, 1975).

A manera de resumen, tenemos que los efectos psicológicos posteriores al hostigamiento pueden depender de una o varias de las siguientes variables (adaptadas de Katz y Mazur, 1979, p. 247):

1. *La edad del menor*: es considerada como un elemento que afecta el grado en el cual éste es

traumatizado. Se piensa que los niños más pequeños son más vulnerables al trauma; sin embargo, MacFarlane (1978) afirma que los niños mayores pueden resultar heridos de manera más profunda pues son más conscientes del estigma social asociado con la agresión sexual.

2. *Las condiciones psicológicas de la víctima*: las víctimas que han tenido problemas emocionales anteriores (o son emocionalmente vulnerables por provenir de un hogar inestable o deshecho) pueden experimentar problemas más graves como resultado de haber sido agredidas, más que los que pueden durar más.
3. *La experiencia o el conocimiento sexual*: los menores que no tienen ninguna experiencia sexual previa pueden ser más vulnerables que los demás.
4. *El tipo de agresión*: definitivamente, la cantidad de violencia y el grado de penetración corporal son factores que determinan el trauma. Asimismo, el grado en el cual el menor siente que su cuerpo ha sido dañado por el suceso puede contribuir al nivel del trauma experimentado.
5. *Agresiones repetidas*: éstas pueden causar más daño que una agresión aislada.
6. *El hostigamiento por parte de un extraño o por parte de alguien conocido en quien el menor confía*: la agresión sexual perpetrada por un conocido confiable tiende a provocar un daño más perdurable que la agresión de un desconocido.
7. *Reacciones de los demás*: las reacciones negativas por parte de la policía, los padres, los maes-

tros, los compañeros y (o) los amigos de la familia o los vecinos pueden contribuir a la severidad del trauma.

8. *Falta de confianza o apoyo*: los niños a quienes los padres o encargados no les creen o no les dan apoyo, sufren un mayor trauma emocional que aquellos que sí lo reciben.
9. *Terapia*: al igual que los adultos, los niños víctimas de abuso sexual que reciben psicoterapia tienen más oportunidades de recuperarse que los que no reciben tratamiento.

Las secuelas traumáticas del abuso sexual infantil se describen con claridad en dos categorías: 1.) síntomas que generalmente ocurren en los dos primeros años después de que la agresión ha cesado; y 2.) efectos a largo plazo. Los síntomas iniciales mostrados por niños traumatizados sexualmente se presentarán en detalle más adelante en este capítulo y pueden resumirse como sigue: temor y ansiedad, problemas con el sueño, quejas somáticas, conducta regresiva, baja autoestima, incapacidad para confiar en los demás, depresión y sus correspondientes hostilidad y enojo ocultos, problemas escolares, conducta sexual inapropiada, culpa, vergüenza y (o) una conducta autodestructiva. Los efectos de más largo plazo, que se describirán de manera más completa en el capítulo 7, pueden resumirse así: depresión, conducta autodestructiva o suicida, ansiedad, sentimientos de aislamiento y enajenación, un concepto negativo de sí mismo, malas relaciones interpersonales, vulnerabilidad para repetir como víctimas, propensión a escoger parejas abusivas, problemas de adaptación sexual y (o) abuso del alcohol o drogadicción.

No es posible evaluar el nivel en el cual la agresión sexual traumatiza a los menores sin analizar la controversia sobre si tal impacto ha sido exagerado o no. En nuestra opinión (y de acuerdo con Finkelhor, 1984), uno debe considerar el impacto de semejante suceso en el niño en términos de la percepción infantil del dolor y el trauma. Sería tonto pensar que el único trauma "verdadero" es el que conduce al mal funcionamiento posterior del adulto.

La mayoría de la gente reconoce que ciertos eventos traumáticos en el curso de la vida adulta, como la violación, las heridas físicas graves o la pérdida de un ser amado, pueden causar un dolor emocional sumamente grave; gravedad que se acepta aun cuando no incapacite emocionalmente al adulto al convertirse en viejo. De hecho, casi toda la gente se sentiría aliviada al saber que esos sucesos traumáticos no necesariamente dejan cicatrices para el resto de la vida. Entonces, ¿por qué la insistencia en restar seriedad al trauma sexual infantil, a menos que se pruebe que ha dañado la vida del menor para cuando éste llegue a la edad adulta? Es obvio que no hay lógica en esto, pero lo más molesto es la resistencia a aceptar que el dolor y el sufrimiento de la infancia son válidos en sus propios términos.

En conclusión, las investigaciones recientes, lo mismo que la observación clínica, firmemente sugieren que los niños son traumatizados y sufren emocionalmente como resultado directo de haber sido víctimas de abuso sexual. Browne y Finkelhor (1986) lo expresan de manera sucinta:

Debido a la falta generalizada de investigación en este campo, los terapeutas apenas recientemente han podido respaldar, con pruebas de estudios científicos, sus impresiones de que el abuso sexual es

traumático. No obstante, a medida que tales pruebas se acumulan, surge la clara sugerencia de que el abuso sexual es un serio problema de salud mental, estrechamente ligado con problemas graves en una importante proporción de las víctimas (p. 72). Como veremos más adelante, los resultados de investigaciones recientes sobre el impacto en el largo plazo son especialmente convincentes.

Síntomas clave

El conjunto de síntomas generalmente aceptado para tipificar los efectos del abuso sexual en los niños comprende (resumiendo de Browne y Finkelhor, 1986; Everstine y Everstine, 1983; Green, 1986; Heiman LoPiccolo y LoPiccolo, 1981; Meiselman, 1978; Peters, 1976; Reich y Gutierrez, 1979; Tufts, 1984):

1. *Miedo*: ésta es la reacción inicial más común. Por ello, el niño que expresa miedo y (o) ansiedad extremos sin razón aparente debe ser visto con cuidado.
2. *Incapacidad de confiar*: debido a la traición que el niño ha sufrido a manos de un adulto, la cual lo ha llevado a sentirse desvalido, se encuentra seriamente limitado para tener confianza. Esta incapacidad podrá afectar sus relaciones futuras de diversas maneras.
3. *Cólera y hostilidad*: los menores rara vez pueden expresar su cólera hacia el agresor, de modo que frecuentemente la transfieren hacia los demás. No obstante, en ciertos casos (por lo general aquellos de abuso extrafamiliar) el menor sí puede encontrar la oportunidad para expresar su cólera o enojo hacia el agresor.

4. *Conducta sexual inapropiada*: los niños víctimas de abuso sexual pueden tratar de mostrar o decir a los demás lo que les hicieron haciéndolo o actuándolo en público. Es posible que intenten también obtener la sensación de dominio sobre el trauma mediante la repetición de los hechos en una forma simbólica; por ejemplo, especialmente los varones, pueden tratar de eliminar sus sentimientos de impotencia haciendo a otros niños lo que a ellos les hicieron, con lo cual se manifiesta "identificación con el agresor".
5. *Depresión*: dada la imposibilidad de expresar la impotente rabia por lo que se les ha hecho, los niños agredidos pueden llegar a la depresión clínica, mostrando signos de restricción emocional, de afecto plano o inexistente y otros similares.
6. *Culpa o vergüenza*: puesto que los niños pequeños son por naturaleza egocéntricos, pueden erróneamente aceptar la responsabilidad por los actos de otras personas hacia ellos. Esta tendencia, sumada a los intentos del agresor de achacar lo sucedido a la víctima, a menudo provocan que ésta sienta fuerte culpabilidad por ello.
7. *Problemas en la escuela*: un repentino descenso en el desempeño del menor en la escuela puede ser signo de abuso sexual; no obstante, esto no siempre es así pues el niño puede encontrar cierta seguridad en la estructura del ambiente escolar.
8. *Problemas somáticos*: muchos menores que han sido sexualmente agredidos interiorizan su trauma y pueden mostrar desórdenes somáticos diversos, tales como dolores de cabeza o de estómago sin ninguna causa orgánica.

9. *Problemas para dormir:* frecuentemente estos niños sufren de dificultad para dormir, temor a dormir solos, pesadillas e incluso terror nocturno.
10. *Problemas con la comida:* algunas víctimas de abuso sexual tienen problemas con la comida: un repentino aumento o descenso del apetito o el atesoramiento de alimentos. El terapeuta debe prestar especial atención al tratar problemas de anorexia o bulimia en adolescentes, pues tales síntomas pueden esconder traumas causados por abuso sexual.

11. *Conducta fóbica o evasiva:* las víctimas pueden mostrar una amplia gama de conductas fóbicas: agorafobia, o fobia a la escuela, o temor hacia alguien un tanto parecido al agresor.

12. *Conducta regresiva:* los menores pueden tener regresiones a causa de traumas sexuales. Por tanto, los casos de regresión que no puedan explicarse con claridad deben analizarse con cuidado en busca de posibles evidencias de abuso sexual.

13. *Conducta autodestructiva o tendencia hacia los accidentes:* éstas pueden ser salidas para los sentimientos de culpa o vergüenza del menor. Muchos niños agredidos se sienten dañados o devaluados y su conducta adquiere esta forma.

14. *Conducta de escape:* los niños más grandes y los adolescentes pueden intentar sobreponerse al abuso sexual escapando de su casa.

Entrevistas iniciales

En esta sección se revisan algunos factores que deben tomarse en consideración cuando el terapeuta realiza un primer contacto con un menor sexualmente traumatizado

o con sus padres. Debe darse atención especial a estos primeros encuentros porque a menudo son momentos extremadamente sensibles que, en muchos casos, pueden convertirse en puntos nodales en la dirección y el resultado del tratamiento. Según nuestra experiencia y la de autores como Sgroi (1978) y Green (1986), el caso tendrá más oportunidades de llegar a una conclusión satisfactoria si estos primeros contactos son positivos.

Un niño víctima de abuso sexual generalmente llega a ver al terapeuta en alguna de las maneras siguientes. El terapeuta puede ser llamado para hacer una evaluación del niño en una situación de crisis o emergencia, atendida por alguna organización o servicio de protección a menores o el servicio de urgencias de algún hospital. O bien, el menor es llevado para la evaluación pues uno de los padres sospecha que "algo le ha sucedido". También es posible que se solicite al terapeuta realizar una evaluación del menor durante un proceso de divorcio en el cual se han hecho acusaciones de abuso sexual, bien sean éstas del menor o de alguno de los padres contra el otro. Por último, el menor puede ser llevado ante el terapeuta a causa de un problema emocional o de comportamiento que podría ser resultado de algún trauma sexual desconocido por los padres.

Implicar a los padres

Cuando el trauma sexual es desconocido (o proclamado como tal) por los padres, el terapeuta debe proceder con considerable cautela si en la primera entrevista sospecha que efectivamente lo hay. La reacción de los padres de un niño sexualmente traumatizado al enterarse del hecho tiene impacto en cuán bien su hijo logre recuperarse del mismo. Dado que tales reacciones van desde un apoyo

emotivo al menor hasta la rabia ciega o la falta total de apoyo o bien la negación del hecho, lo mejor es excluir al menor de la entrevista en la cual se informa a los padres de la agresión. Las confrontaciones emocionales o las escenas de cólera pueden ser tan traumáticas y creadoras de confusión para el niño como la propia agresión sexual, de modo que es sabio tomar precauciones para evitarlas en lo posible.

El terapeuta debe también considerar que el padre o la madre del menor pueden haber sufrido a su vez alguna forma de agresión sexual durante la infancia, lo cual lo llevaría a analizar dilemas intergeneracionales complejos y delicados inapropiados para discutirse en presencia de un niño ya afectado. Nuestra experiencia indica que muchos de los padres de niños que sufren abuso sexual han sido también víctimas durante su infancia, en muchos casos aproximadamente a la misma edad que sus hijos. Así pues, revelar el abuso al padre previamente traumatizado puede crear una situación sumamente difícil de la cual debe protegerse al menor recién agredido.

Otra razón para mantener al menor alejado de la primera plática con los padres, especialmente en casos de agresión en el seno de la familia, es que así se evita que el menor se vea forzado a contradecir la versión de un miembro de la familia respecto de lo sucedido. A menudo, los niños traumatizados guardan mutismo en tales situaciones, o incluso cambian sus historias, por no poder soportar la presión de confrontar a un adulto importante para ellos. Pocos padres son capaces de escuchar los detalles de la traumatización sexual de sus hijos y de mantener la actitud de aceptación sin juicios requerida en tales situaciones.

El menor puede malinterpretar el dolor de uno de sus padres al oír los detalles como enojo hacia él o ella. Sin embargo, si el niño insiste en que alguno de sus padres esté presente, recomendamos respetar sus deseos, a menos que exista una fuerte sospecha de que éste sea el agresor, en cuyo caso la entrevista deberá realizarse a solas.

Cuando el menor se rehusa o se muestra temeroso a ser visto sin la presencia de sus padres, la mejor estrategia consiste en verlos juntos al principio para hacerlos participar en una conversación neutral no comprometedora durante un corto periodo y luego preguntar al menor si está dispuesto a hablar a solas con el terapeuta. Si continúa negándose, el padre o la madre podrá quedarse, pero el terapeuta deberá estar alerta a cualquier intento por parte de éste para influenciar, callar o censurar al niño.

Entrevista a solas con el menor

Una virtud de la entrevista a solas con el menor es que le puede servir como protección contra comentarios bien intencionados pero en realidad dañinos por parte de los padres: "Te dije que no fueras allá solo" o "¿Por qué lo dejaste...?". Comentarios comprensibles pero cargados emocionalmente de padres angustiados que pueden hacer sentir al niño o niña que lo sucedido es culpa suya. El terapeuta debe también considerar que el agresor puede ser un amigo que goza de la confianza de la familia cuya identidad el menor tal vez tema revelar en presencia de los padres. Quizá tema hablar porque efectivamente tuvo una actitud curiosa o participativa al principio del abuso. En ocasiones, tristemente, éste se da por la inocente curiosidad del menor o por sentirse halagado con la atención de un adulto. Es posible que haya estado buscando una forma de interés y cuidado que no tiene en casa.

La mayoría de los niños encuentra consuelo si logra decir a un adulto lo que sucedió y éste responde de manera apropiada, pues eso les muestra que son aceptados y que no hicieron nada malo. Además, puede ayudarles a rechazar algunas de las cosas que el agresor quiso les dijo para lograr su cooperación o seducirlos, o para evitar que contaran lo sucedido. Algunas de las amenazas más comunes que los hostigadores de niños usan para callar a sus víctimas son variaciones de lo siguiente:

"Si dices algo, regresaré a matarte."

"Esto es un secreto entre nosotros, y si lo revelas te llevarán a otra parte."

"Si tus papás se enteran de lo que hicimos, te meterán a la cárcel."

"Tus papás ya no te van a querer si se enteran de lo que hicimos."

Tales amenazas suelen lograr silenciar a un menor y hacerlo sentirse tremendamente culpable. Esto es cierto sobre todo en casos de niños con problemas de carencia de amor y atención.

Entonces, cualquier reacción histérica de parte de uno de los padres o cualquier otro adulto importante que pueda causar que el menor crea que las amenazas del hostigador eran ciertas y lo lleve a retractarse de su acusación, puede evitarse viendo al niño a solas. Los casos de niños que se retractan de denuncias verdaderas por la presión familiar o la conducta de adultos enojados son mucho más frecuentes de lo que generalmente se sabe.

Un menor asustado

El caso de Adam, un niño de tres años que había sido víctima de repetidos abusos sexuales por parte de su nue-

vo padrastro, ilustra este punto. Su madre y su padrastro habían estado casados durante tan sólo cinco meses cuando empezó el abuso. El padrastro llevaba a Adam al cuarto de baño (con el pretexto de bañarlo) y sodomizaba al niño. Durante el abuso, el padrastro le metía la cabeza en el agua y le decía que si lo contaba a alguien sería alejado de su madre y encerrado en un lugar para niños malos.

Conforme pasó el tiempo, Adam empezó a manifestar una regresión en su conducta. Comenzó a orinarse en la cama, a abrazarse incesantemente a su madre y a hacer berrinches inexplicables. Aun cuando su padrastro achacó su conducta a problemas de celos y de adaptación a la presencia de un nuevo hombre en la casa, la madre llevó al niño con su pediatra y lo consultó sobre cómo lidiar con los repentinos cambios de conducta de su hijo. Adam conocía a la pediatra desde siempre, de modo que se sentía en confianza al estar con ella. Durante el examen, la pediatra encontró pruebas de trauma anal. Rompiendo en llanto, Adam le contó a ella y a su madre lo que sucedía durante sus baños con el padrastro.

Desafortunadamente, el niño aterrizado no mencionó las amenazas recibidas. La madre, pensando que hacía lo correcto, llevó a Adam con su verdadero padre mientras hacía la denuncia ante la policía. Aun cuando la madre pensó que llevar al niño con su padre era un acto cariñoso y de cuidado, Adam temió que lo iba a abandonar.

Más tarde, cuando la madre habló con la policía, se decidió que era necesario hablar con el menor y enviaron una patrulla a recogerlo. Cuando Adam vio la patrulla llegar a casa de su papá, se convenció de que todas las amenazas del padrastro se estaban volviendo realidad. Cuando la policía lo interrogó, simplemente dijo: "Nadie me ha tocado atrás nunca" y más tarde,

"Dos grandes hombres azules de la casa de junto me lo hicieron". Finalmente, se rehusó completamente a hablar.

La policía llamó a un terapeuta del Centro de Tratamiento de Emergencia (ETC) para que les ayudara en la entrevista con Adam, pues les preocupaba que aun en presencia de evidencia física de la agresión sexual de la que había sido víctima, la historia del niño era tan confusa, que no podían saber quién la había perpetrado. (De hecho, para ese momento, el padrastro ya negaba rotundamente haber tocado al niño.)

Después de hablar con Adam y su mamá, el terapeuta del ETC se dio cuenta de que el hecho de que el niño hubiera sido separado de ella en un momento tan grave había sido algo terrorífico para él y que necesitaba que ella le confirmara que nunca lo abandonaría nuevamente. Finalmente, cuando la madre lo hizo sentir suficientemente seguro, Adam pudo contar que había sido amenazado.

Ayudar al niño a sentirse cómodo

Desde la primera entrevista, el terapeuta debe decir a las víctimas que no hicieron nada malo y que toda la responsabilidad por lo ocurrido le corresponde al adulto que los agredió. El terapeuta debe ser especialmente sensible para comunicar al niño o niña agredido que el descubrimiento del abuso representa la posibilidad de encontrar ayuda y apoyo, y no la realización de su temor a la separación o la culpabilización con que lo amenazó el hostigador. El niño puede acabar por sentirse enormemente reconfortado al poder decir a un adulto lo que sucedió y descubrir que éste responde de manera cariñosa y comprensiva. El terapeuta debe estar consciente de que cuando un niño denuncia un abuso sexual ése puede ser sólo uno de muchos eventos sexualmente traumáticos.

Antes de hablar con un menor, el terapeuta debe averiguar las palabras que se usan en la familia para hablar de los genitales, lo mismo que para orinar y defecar; el menor se sentirá más a gusto utilizando esos nombres. Durante el primer encuentro, el terapeuta debe hacer saber al menor que él o ella tiene toda la libertad para hablar de lo ocurrido, pero que puede no hacerlo. Si opta por lo último, no deberá forzársele, sino empezar algún juego en el cual se usen dibujos o muñecos. Se debe permitir que el niño avance a su propio ritmo sin presionarlo para que dé detalles o información. La meta principal es establecer la confianza y una buena relación con él durante estas primeras entrevistas.

La renuencia de un menor para hablar del incidente en cuestión no debe ser interpretada como que en realidad no ha pasado nada o como que el niño no es de fiar. Puede que simplemente esté apenado, confundido o asustado. Los adultos están de acuerdo en que el sexo es un tema difícil para discutir entre adultos, ya no digamos con los niños. Es claro, entonces, que no debemos esperar que un menor pueda discutir libremente, con un extraño, lo que los adultos tienen dificultad en hablar entre gente de confianza. De hecho, muchos padres hacen sentir a sus hijos desde pequeños que el sexo y las sensaciones y sentimientos sexuales están asociados con la culpa o con el mal. Hablar de traumas sexuales será una tarea imposible para esos niños.

Una víctima infantil puede no sentirse a gusto con un adulto en un espacio cerrado, especialmente si no lo conoce, ya que puede tratarse de una situación similar a la de la agresión. El terapeuta puede dejar que el niño escoja no sólo el tipo de actividad a realizar en la primera entrevista, sino el sitio en donde se realizará; tal vez fuera de la oficina o consultorio. Si se lleva a cabo en el consul-

torio del terapeuta, se puede preguntar al niño si desea que la puerta permanezca abierta o cerrada. Hemos descubierto que muchos niños con traumas sexuales severos desean abrir y cerrar la puerta varias veces para comprobar si pueden salir. También puede desear probar el teléfono para ver si en verdad funciona, por si acaso necesitará pedir ayuda. Sugerimos que se le permita hacer todo esto y al mismo tiempo darle el máximo de confianza respecto de que no se le hará ningún daño.

Recopilar la información

Los niños se pueden sentir más a gusto describiendo lo que les sucedió con muñecos, o preferir hacer dibujos que hablar de lo sucedido. En general, en la primera entrevista no se recomienda mostrar los muñecos con cierta precisión anatómica utilizados por la policía o algunos servicios sociales, ya que tan sólo el hecho de verlos puede resultar demasiado estimulante o atemorizante para los niños traumatizados. Esto es especialmente importante cuando existe la posibilidad de una acción legal basada en la evaluación. Algunos casos recientes han demostrado que la validez testimonial de los interrogatorios con ese tipo de muñecos sexualmente explícito puede ser puesta en duda. La idea subyacente es que semejante utilización hará que las preguntas que se le hacen al menor sean tendenciosas. Es bien sabido que los niños ansiosos o confundidos son fácilmente sugestionables debido a sus necesidades de dependencia. De tal modo, el menor puede malinterpretar lo que se le está mostrando y malinterpretar lo que se le pregunta. Puede sentir que el terapeuta quiere que haga declaraciones sobre asuntos sexuales y responder de acuerdo con esa idea sólo por agradar.

Una alternativa útil y no amenazante a ese tipo de muñecos, son los tradicionales de niños y niñas o bien, muñecos que representen animales machos y hembras. En algunos casos de trauma severo, incluso estos muñecos, de forma humana o animal, y los dibujos de figuras humanas, pueden resultar atemorizantes, sobre todo si el menor en cuestión es muy pequeño. En tales casos extremos, se aconseja que el terapeuta le permita al niño o niña jugar mientras va estableciendo una relación de confianza. No obstante, en la mayoría de los casos, puede pedirle que escoja entre muñecos de forma animal o humana para representar lo sucedido. Por ejemplo, existen ciertas marcas de muñecos a los que se les puede quitar la ropa y otros cuyo sexo es claramente distinguible y pueden servir al menor para "actuar" lo que le ha sucedido. (En el capítulo 3 se dan recomendaciones específicas sobre los juguetes que pueden ser útiles.)

Mientras observa al niño, el terapeuta debe estar alerta a los detalles que significan que el menor ha tenido un encuentro sexual con un adulto. Por ejemplo, si en un contexto neutral un niño de siete años describe un pene en erección eyaculando semen, es bastante probable que haya sido víctima de un abuso sexual. Sólo existen tres fuentes de donde el niño puede haber aprendido esto, principalmente: 1) siendo testigo o partícipe de alguna forma de contacto sexual adulto-menor; 2) porque un adulto le ha descrito tal contacto; 3) porque ha visto a un adulto en actividad sexual en fotografías o videos.

Aun cuando en un principio el menor se rehuse a hablar de lo que le ha sucedido, el terapeuta podrá ver la evidencia del trauma si logra construir una relación positiva con él. En consecuencia, el establecimiento de esa relación deberá ser el interés primordial de las primeras entrevistas destinadas a la evaluación del abuso. Uno de

los principales errores de los terapeutas durante las entrevistas iniciales consiste en permitir que su propia ansiedad o preocupación por descubrir lo sucedido creen presión sobre un niño ya ansioso o atemorizado de por sí. Esto puede causar que el menor se retraiga o se asuste porque ahora se siente atacado o presionado por el terapeuta. Si el menor *efectivamente* sufrió una agresión sexual, eso saldrá a la luz en un momento u otro, con una revelación directa al terapeuta o simbólicamente mediante juegos. Además, los tests de proyección (por ejemplo, dibujos, Rorschach, CAT o TAT) son medios eficaces para obtener información cuando el niño teme hablar con libertad.

Comprender al menor

Pueden requerirse de tres a cuatro sesiones de evaluación antes de que el menor empiece a comunicar su trauma e incluso en ese momento la expresión puede ser solamente simbólica a través de juegos. En estas primeras sesiones, el menor puede estar observando o poniendo a prueba al terapeuta para ver si se trata de un adulto en quien pueda confiar. Tal puesta a prueba puede manifestarse en una de las siguientes formas:

1. Actitud plana, rígidamente controlada o desinteresada ante los juegos.
2. Actitud agresiva hacia el terapeuta o hacia los juguetes que hay en la sala de terapia.
3. En contraste, el niño puede dar (consciente o inconscientemente) claves para que el terapeuta se entere de lo sucedido, esperando para ver cuál es su respuesta ante los mensajes enviados. El objetivo es saber si está en una situación segura para continuar haciendo revelaciones.

El terapeuta debe recordar que, aunque los mensajes sean inconscientes para el menor, éste aún será sensible y consciente de las respuestas del terapeuta a sus intentos inconscientes de comunicación.

4. Tal vez el menor tenga una actitud abiertamente sexual hacia el terapeuta o hacia alguno de los juguetes. En tal caso, el terapeuta debe ser muy cuidadoso en su forma de responder a esa conducta. El niño no está tratando de que el terapeuta participe en la actividad sexual, sino más bien probándolo para ver si es una persona "segura". También puede estarle mostrando lo que le hicieron, temiendo decirlo con palabras porque fue amenazado o amenazada para que no lo hiciera.

La manera en que el terapeuta responda a estos avances sexuales es crucial para el curso que seguirá la evaluación o el tratamiento. El terapeuta debe evitar cualquier actitud que pudiera ser interpretada como enjuiciadora o castigadora. No importa cuán aberrante pueda ser la conducta del menor, él o ella debe asumir una actitud calmada y neutral que permita al menor comunicarle libremente lo que ha sucedido.

Durante las primeras entrevistas con un menor víctima de abuso sexual, el terapeuta debe ser extremadamente sensible a los problemas de relación que aquél tenga con su agresor. Debido a que bien puede tratarse de alguien que antes gozó del cariño o la confianza del niño, tal vez un conocido de la escuela o el centro recreativo, o incluso un miembro de la familia, es posible que el niño o niña lo considere su única fuente de apoyo emocional y

cuidados. Por otro lado, quizá el menor haya sufrido el abuso de manera repetida durante un largo lapso. Una relación tal entre el agresor y su víctima puede significar que el trauma sexual del menor sea mucho más complejo de lo que sería para un adulto, en cuyo caso, por ejemplo, la violación generalmente es un evento aislado perpetrado por un extraño. El terapeuta debe considerar que el menor puede estar muy confundido y ser ambivalente hacia lo sucedido, incluso manifestar temor por la pérdida de su relación con el agresor.

Por encima de todo, el terapeuta debe esforzarse por conocer a fondo cómo percibe el menor su relación con el hostigador. De nuevo, el terapeuta necesita tener cuidado de no manifestar sus propios sentimientos y prejuicios para así evitar que el niño se sienta juzgado o estigmatizado por tener sentimientos positivos o mezclados hacia su agresor. Los adultos suelen enfrentar problemas para resolver sus sentimientos mezclados o ambivalentes respecto de ciertas personas y es posible imaginar cuán enorme puede resultar para un niño el tratar de resolver tal enjambre de emociones. Otra razón por la cual el terapeuta no debe dejar que sus prejuicios intervengan en la terapia es que, de ser así, estaría predeterminando la manera en que la experiencia del menor debe haberse dado, lo cual le impediría escuchar y comprender los auténticos sentimientos de la víctima.

Por último, el terapeuta debe ser consciente de que muchos de estos niños simplemente no tienen confianza en los adultos en general, de modo que no le dirán a uno, de manera directa, lo que les ha sucedido. Más bien, lo comunicarán mediante su conducta y esperarán las respuestas del adulto. Este tipo de caso requiere gran paciencia y sensibilidad del terapeuta y un contexto o ambiente en el cual el menor pueda empezar a comprender lo sucedido y, finalmente, a comunicarlo directamente.

Dado que pueden necesitarse varias sesiones para determinar si un menor ha sido o no traumatizado sexualmente, el terapeuta debe conducir esas sesiones de manera relajada y sin prisas, pensando siempre que el niño puede malinterpretar la presión de su parte como una prueba de que habrá censura o disgusto. Es importante aclarar la razón por la cual se está hablando para que el menor no se sienta confundido o traicionado cuando el terapeuta informe lo que él ha dicho o hecho durante las sesiones. Se le puede decir algo como: "Tus padres (o maestro, etcétera) me han pedido que te vea algunas veces porque les preocupa que te haya pasado algo; y yo hablaré con ellos después al respecto". De acuerdo con nuestra experiencia, lo mejores mantener ese mensaje como algo neutral hasta saber cómo se siente el menor respecto de lo sucedido y cuál es su relación con el agresor.

Comprender a la familia

Además de realizar la evaluación de la situación actual del menor, el terapeuta debe también investigar su sistema familiar y de apoyo antes de iniciar el tratamiento. Es posible que la búsqueda de cualquier tipo de afecto de un adulto haya sido lo que condujo a la agresión. Una manera general de comprobar cuáles son los recursos o el apoyo con que cuenta el menor es averiguar a quién y cómo fue que denunció (si lo hizo) el abuso sexual y cómo reaccionó la familia una vez que el menor realizó la denuncia. Por ejemplo, ¿reveló el niño lo sucedido a alguno de sus padres o a ambos?, ¿la reacción fue apropiada?, ¿lo apoyaron y protegieron? O, por el contrario, ¿hizo la denuncia ante una persona ajena a la familia: un profesor, conserjero, amigo o el padre de algún amigo? Y, cuando los padres fueron informados, ¿creyeron en la denuncia o la descartaron diciendo que eran "puros cuentos"?

Un elemento importante en la determinación de los recursos emocionales de que dispone el menor es el tiempo que le ha tomado a éste realizar la denuncia ante un adulto. Por ejemplo, en el caso en que un niño denuncia un incidente traumático inmediatamente o muy pronto después de que éste haya sucedido, generalmente descubrimos que cuenta con más fuentes de apoyo emocional dentro de la familia de lo que ocurre con aquel que no pide ayuda de inmediato. El niño que es víctima de un abuso sexual prolongado por lo general proviene de un sistema familiar más desordenado o patológico que le brinda poco apoyo.

Por último, probablemente el menor con quien más difícil resulta establecer contacto sea aquel que nunca ha dicho nada y que es enviado a evaluación debido a una conducta anormal. Este niño o niña puede estar terriblemente atemorizado por las amenazas del agresor o puede estar consciente de su falta de apoyo dentro de la familia. En casos de incesto, el menor puede creer que está salvando a la familia de algún tipo de destrucción al aceptar su papel de víctima y que la revelación del "secreto" podría arruinarla.

El menor antes del trauma

Al iniciar la evaluación de un menor posiblemente traumatizado, el terapeuta debe intentar recabar información sobre la forma de actuar del niño o niña *antes* del supuesto trauma. Debe tratar de tener el consentimiento para buscar esa información en la escuela del menor, con su pediatra, en la guardería o cualquier otro lugar en donde se le haya cuidado. Se recomienda buscar información adicional en fuentes familiares más allá de la familia nuclear. Se debe preguntar sobre los niveles de funcionamiento cognoscitivo, emocional e intelectual del menor.

Con este tipo de información, el terapeuta puede empezar a medir si la conducta actual del niño o niña resulta o no consistente con sus patrones habituales.

Después de las primeras entrevistas

Si el terapeuta tiene razones para creer que el menor efectivamente fue víctima de una agresión sexual, debe realizar lo conveniente para denunciar esto a las autoridades indicadas y asegurar que el menor sea sometido a un examen pediátrico completo. Dicho examen puede dar mucha confianza al menor, ya que muchas de estas víctimas suelen sentirse "cambiadas" o dañadas por la experiencia (Sgroi, 1982). Si se realiza con delicadeza, puede ayudar a asegurar al menor que no ha sido dañado y que los adultos que lo rodean están haciendo todo lo posible por protegerlo y cuidarlo.

Es preferible que el reconocimiento sea realizado por un pediatra con experiencia en la evaluación y tratamiento de víctimas de agresiones sexuales y que sea capaz de actuar como testigo especializado en caso de que el problema sea llevado a juicio. Desgraciadamente, no todos los médicos están calificados en lo que respecta a la agresión sexual contra menores y con demasiada frecuencia esos exámenes son realizados por internos inexpertos de turno en una sala de urgencias. Más aún, un médico inexperto no sólo suele carecer de la experiencia necesaria, sino que tiende más a evitar el manejo de los aspectos chocantes o difíciles del caso, considerando que el menor está histérico o que su padre o madre están exagerando.

Casos sin resolver

Acaso los casos más difíciles y desoladores para un terapeuta son aquellos en los que no se puede hacer ninguna

comprobación de lo que en realidad le sucedió al menor y que, tristemente, son frecuentes. En ellos, los adultos reaccionan tratando de "olvidar que el asunto sucedió".

Es probable que los niños que más necesitan tratamiento sean precisamente éstos, por varias razones: consideremos el impacto emocional que sufre un menor que en efecto fue agredido sexualmente y a quien sus padres no le creen. O bien, cuando un agresor conocido es declarado inocente porque no se han podido reunir las pruebas legales necesarias (lo cual es frecuente).^{*} Agréguese a lo anterior el que la mayoría de los hostigadores de menores son conocidos de la víctima (DeFrancis, 1969; Finkelhor, 1984), lo cual quiere decir que ésta tendrá que seguir frecuentándolo en muchas situaciones. Ese niño o niña se sentirá completamente desamparado ante la posibilidad de repetición de la agresión. ¿Qué provoca esto en su sentido propio del ser en relación con los demás o en su visión del mundo —cosas que se hallan ambas en formación? Los efectos en el desarrollo personal y social del menor pueden ser considerables.

En casos no resueltos como los que anotamos antes, los menores pueden sentirse abandonados y traicionados por los adultos en cuya protección confiaban. Esos niños pueden, a su vez, convertirse en personas que no confían en los demás y que siempre deben controlar a quienes los rodean. O pueden absorber la experiencia de manera que se vuelven masoquistas, "víctimas eternas" que se definen a sí mismas como personas desamparadas a quienes las cosas "les pasan". En una proyección diferente, es posible que reproduzcan la situación en la cual

^{*} Otra situación desafortunada es cuando la denuncia se realiza una vez que el tiempo transcurrido desde que ocurrió la agresión hace que el delito ya haya prescrito legalmente (véase el capítulo 8).

han sido víctimas en espera de que "esta vez" alguien los proteja, lo cual, obviamente, nunca ocurre. Este síndrome de vulnerabilidad a la agresión repetida ha sido identificado en las investigaciones de Miller y sus colegas (1978), Brandt y Tisza (1977), Fromuth (1986) y Russell (1986). Otro patrón identificado en las investigaciones es aquel en el que esos niños, al volverse adultos, escogen parejas abusivas (véase Briere, 1984; Katan, 1973; Russell, 1986).

En resumen, las primeras sesiones destinadas a evaluar el abuso sexual deben conducirse con extremo cuidado. Los niños en situaciones de este tipo pueden ser extremadamente temerosos y su conducta quizá varíe ampliamente. Así pues, el terapeuta debe aceptar que la evaluación puede tomarle mucho más tiempo de lo normal. Es más, algunos niños están a tal punto aterrorizados que simplemente no pueden dar ninguna información clara de lo sucedido. En estos casos, el contenido simbólico de actividades como los juegos y las pruebas puede resultar muy informativo.

Durante la evaluación, el terapeuta debe obtener las historias de la conducta anterior y posterior al trauma de tantas fuentes independientes como le sea posible (esto es, los padres, profesores, parientes, pediatras y otras personas a cargo) y en relación con aspectos como el estado emocional del menor, su proceso de desarrollo, su funcionamiento cognoscitivo, sus habilidades para enfrentar la vida y reacciones típicas ante el estrés. Finalmente, el terapeuta debe valorar estos datos tomando en cuenta la descripción del menor que ha sufrido abuso sexual realizada en este capítulo y en otras fuentes.



tres

Los objetivos de la terapia

El mundo del niño es muy pequeño, está compuesto por los materiales con los cuales se integrará su personalidad futura. A medida que se desarrollan, los niños utilizan esos elementos para construir su visión del mundo o su concepción de la "realidad", su concepto de sí mismos o de lo que creen que son para sí y en relación con los demás. Tales percepciones pueden variar de acuerdo con la estructura de su entorno y las partes que lo componen. La agresión sexual de un adulto en contra de un menor altera los elementos básicos de su mundo; puede introyectar componentes tales como la sexualidad adulta, la traición, la violencia y el desamparo, por citar sólo algunos. Dado que los niños pequeños no tienen un marco de referencia adecuado para juzgar esos eventos, dependen de las interpretaciones que realizan los adultos que los rodean y en quienes ellos confían.

En conclusión, pensamos que una de las principales tareas del terapeuta, lo mismo que de los demás adultos en la vida del niño, es ayudarlo a entender el trauma y a no incorporarlo a su concepción de su propio ser o de la realidad. La manera en que el mencionado trauma es definido o interpretado por los padres o figuras paternas, lo mismo que por el terapeuta del menor, será central en la determinación de integrarlo o relegarlo al sitio de una experiencia desagradable pero externa que puede ser superada. Si un menor es agredido sexualmente y sus padres, alegando que son "puros cuentos", no hacen nada al respecto o culpan a su hijo, tal conducta puede influenciar negativamente su desarrollo saludable. Puede contribuir a sellar el trauma, convirtiéndolo en uno de los elementos fundamentales con los que se construye la futura personalidad del niño.

Tratamiento de la víctima infantil



En este capítulo y los siguientes separamos el tratamiento de la evaluación del trauma para cubrir dos tipos de casos: 1) aquel en el cual a un terapeuta se le solicita dar tratamiento una vez descubierto (y por supuesto, denunciado) el abuso sexual, y 2) cuando un tratamiento en curso debe ser alterado debido a la revelación del abuso. En resumen, aquí trataremos las situaciones en las que *ya se ha comprobado* la existencia del trauma sexual.

Este capítulo se centra en el tratamiento de niños hostigados cuya edad oscila entre los cinco y los once años, aunque algunos de sus conceptos son también pertinentes para los casos de las víctimas de incesto (tema que se tratará en profundidad en el capítulo 5). Este capítulo incluye asimismo métodos de tratamiento para otros miembros de la familia del menor (esto es, parientes y hermanos) que quizá no fueron agredidos directamente, pero que también han sido afectados por el abuso.

Cuando un menor pide ayuda a sus padres, está pidiendo que se le apoye en varios niveles, por ejemplo, "Protégeme"; "Explicame esto que pasó"; "¿Acaso los adultos le hacen esto a los niños?"; "¿Es esto lo que merezco?"; "¿Acaso es esto una relación amorosa?"; "¿Acaso soy yo?". Si los adultos no dan importancia al suceso o reaccionan con una preocupación inadecuada (de acuerdo con el nivel de desarrollo del menor), pensamientos tales como "Nadie me protege"; "Estoy desamparado"; "El mundo puede ser caótico y violento"; "La gente puede usarme sexualmente"; o "Ser amado es igual que sufrir abusos" pueden incorporarse a los conceptos que el niño tiene de sí mismo y de la realidad. Si los adultos importantes reaccionan de manera exageradamente agresiva, el impacto en el menor puede ser igualmente confuso, pues tal conducta puede transmitir el mensaje: "Si pides ayuda a los adultos, éstos se enojan" o "Si pasa algo malo, la respuesta adecuada es la violencia".

El terapeuta no sólo debe considerar el significado que el trauma sexual tiene en el presente para el menor y su sistema familiar, sino también la manera en que afectará el desarrollo de su personalidad. Una clave para lograr esto consiste en ayudar al niño a exteriorizar el trauma a partir de sus ideas de lo que su persona es en el presente y lo que será en el futuro. El trauma debe ser definido como algo malo que *le hicieron* al niño a fin de que no sea interiorizado en formulaciones como: "Soy el tipo de persona a quien le pasan estas cosas". En otras palabras, para que no crezca viéndose a sí mismo como víctima o como una persona mala o sin valor. Por último, el terapeuta debe poner gran cuidado en facilitar la correcta exteriorización de los sentimientos de ansiedad y coraje por parte del menor en relación con el suceso. Así acabará por considerar el abuso como algo que le sucedió a él o ella pero no como algo que define quién es.

La víctima infantil y la familia

Cuando a un niño se le lleva a tratamiento poco después de haber sido agredido sexualmente, él o ella, lo mismo que la familia, tienden a estar en un estado de gran alteración. El terapeuta debe hacer esfuerzos para tratar al menor dentro del contexto de la familia. Aun cuando se le vea en forma individual como parte del tratamiento, usualmente tendrá gran dependencia en el apoyo de su familia en momentos tan traumáticos. Debido a que los niños pequeños son todavía emocional y físicamente dependientes del cuidado y protección de sus padres y otros familiares, a menudo reflejan los sentimientos propios de la familia en relación con los sucesos de su vida. Es por esto que el terapeuta debe involucrar desde el principio tanto a los padres como a los hermanos en el proceso de terapia.*

Este tipo de trabajo con los sistemas familiares se adaptará a la estructura de la familia y a la naturaleza del trauma del menor: desde las tradicionales reuniones de terapia familiar paralelas al tratamiento del niño, hasta entrevistas individuales con cada miembro de la familia.**

* Esto difiere del procedimiento que se realiza para evaluar a un niño y determinar si hubo o no abuso, tal como se describe en el capítulo 2; éste puede implicar reuniones a solas con el niño durante las etapas iniciales.

** En los casos más complejos, es acertado acudir a colegas terapeutas para trabajar en equipo, con el fin de asegurar que cada miembro de la familia del menor reciba la atención y el apoyo apropiados para que pueda ayudar a éste a resolver sus necesidades. Este tipo de trabajo en equipo, si se coordina correctamente, puede evitar el desgaste del terapeuta. No se debe subestimar el hecho de que tratar casos de traumas severos es muy desgastante para el terapeuta que trabaja solo.

Aun cuando la forma de las sesiones puede variar de acuerdo con las necesidades de cada caso, lo que es de gran importancia es lograr incorporar a los miembros de la familia dentro del plan de tratamiento de manera significativa y no sólo tratar al menor como a un individuo aislado.

La reacción de la familia

Algunos padres requieren de una guía considerable para poder comprender lo que la agresión significó en términos del nivel de desarrollo del menor. Pueden hacer proyecciones de sus propios conocimientos o de su experiencia sexual como adultos o pueden desear restar importancia al evento sobre la base de que el niño o niña no puede haber sabido lo que realmente ocurrió (en términos de adultos). Ambas respuestas son igualmente inapropiadas. Es importante notar que el nivel de conocimiento de un niño es tan diferente del de un mayor que, para la mayoría de los adultos, es prácticamente imposible pensar como lo haría un niño ante un evento de tal naturaleza. De ahí que una de las primeras tareas del terapeuta consista en ayudar a los padres a conceptualizar la agresión en términos acordes con el marco cognoscitivo de su hijo o hija.

Un ejemplo de una respuesta inapropiada por parte de los adultos es el caso de una niña de siete años que fue arrinconada en el baño de la escuela por un hombre que le mostraba su pene en erección y que la obligó a masturbarlo. Los padres de la niña denunciaron el incidente a la policía y preguntaron a su médico familiar qué debían hacer. Les dijeron que ella lo olvidaría pues simplemente no se podía dar cuenta de lo que había ocurrido.

do. El doctor incluso les dijo que nunca más volverían a mencionar el suceso. Los padres, obviamente, se sintieron muy aliviados al saber que su hija simplemente olvidaría el incidente, así que siguieron sus consejos.

Durante las semanas siguientes, la niña comenzó a desarrollar ciertos síntomas relacionados con el traumático incidente. Empezó a tener pesadillas, se rehusaba a jugar afuera de la casa y hacía berrinches terribles en la escuela. Cuando los padres recibieron la llamada de la maestra, se dieron cuenta de que había habido un terrible cambio en la conducta de su hija, que antes solía ser una niña agradable y obediente. Fue entonces que decidieron consultar a un psicólogo.

Ni los padres ni el médico pudieron percatarse de que, aunque la niña no tenía conciencia completa sobre el significado sexual de la agresión, sí estaba completamente consciente de que un adulto extraño la había arrinconado en un sitio que ella creía seguro y privado, la había obligado a hacer algo que la confundía y la asustaba y le había hecho pensar que la iba a matar.* Esta niña siempre había confiado en los adultos y pensaba que eran gente segura. Y aunque el hostigamiento sexual no era lo único terrorífico de la agresión, la niña había sufrido un trauma emocional serio que necesitaba hablarse y resolverse. De tal modo, cuando sus padres de pronto dejaron de hablar del asunto, ella pensó que no les importaba lo que le había pasado.

* Ésta también había sido la primera vez que la menor había visto un pene, y hacerlo le causó gran confusión respecto de la anatomía masculina y femenina. Y el hecho de que el hombre lo hubiera usado en forma agresiva le hacía sentir aún más ansiedad y temor.

Una reacción familiar al trauma del tipo de la anteriormente mencionada puede oscilar desde una bien intencionada negación de la realidad de lo ocurrido hasta la confusión y el escándalo. Estas últimas emociones pueden ser especialmente exageradas si los padres se enteran de que su hijo o hija ha sido víctima de abuso sexual durante largo tiempo sin ellos saberlo. Tal situación implica asuntos familiares más complejos y que van más allá del solo trauma sexual. Pocos padres están preparados para enfrentar la agresión a sus hijos. En consecuencia, el terapeuta debe planear, desde el inicio del tratamiento, una forma de ayudar a toda la familia a afrontar la crisis. Esto hará que el menor agredido enfrente el suceso y eventualmente se recupere.

Negación por parte de los padres

Hemos descubierto (confirmando el trabajo de DeFrancis, 1969; Finkelhor, 1984; Peters, 1975) que muchos padres tienden a subestimar la profundidad del trauma psicológico que resulta de una agresión sexual. La subestimación probablemente es causada por su deseo de que el terrible incidente nunca hubiera ocurrido y por sus propios sentimientos de culpa o vergüenza. Esa manera de pensar puede llevar a los padres a creer que su hijo no necesita tratamiento porque no ha sido dañado por la agresión. Finkelhor (1984) también descubrió que muchos padres piensan que ellos pueden "resolver" el asunto por su cuenta. Tal impulso les sirve para mantenerlo en privado, lo mismo que para escudarse respecto de la gravedad del trauma. Así pues, en algunos casos un deseo fantasioso por parte de los padres puede impedir que un menor obtenga el tratamiento necesario para curarse del proceso traumático.

Otra forma de negación por parte de los padres que origina diversos problemas es pretender que el menor olvidará lo ocurrido. De este modo, le dan mensajes sutiles e indirectos o de plano le dicen directamente al niño o niña que no mencione lo sucedido, o que simplemente "se lo saque de la cabeza". Esta actitud, frecuentemente bien intencionada pero no por ello menos equivocada, puede sentar las bases para conflictos más serios en el futuro, pues el niño *no* puede olvidar lo que pasó. Más aún, los padres con su actitud de "no hablemos del asunto" están sugiriendo que se avergüenzan del incidente. Entonces el menor puede sentir que él o ella es realmente culpable de algo malo, cuando se trata de todo lo contrario. Hemos encontrado a demasiados adultos traumatizados durante la infancia quienes, debido a comportamientos silenciadores de este estilo por parte de sus padres, interiorizaron la experiencia percibiéndose como malos, "cochinos" o sin valor alguno. En el mejor de los casos, este proceso conduce a una desvalorización personal y puede ser la causa de patrones de conducta autodestructiva o masoquista en la adolescencia o la edad adulta. (Para mayor profundidad respecto de este proceso, véase el capítulo 7.)

Los terapeutas deben hacer saber a los padres que por lo general es importante que las víctimas infantiles hablen con ellos sobre lo sucedido. Algunos niños no desearán decirlo, pero la mayoría necesita hacerlo y muchos necesitan contar la historia más de una vez. Cuando un niño le dice a uno de sus padres lo que ocurrió, generalmente él o ella está buscando aceptación, comprensión y una sensación de protección paterna o materna; busca que se le dé seguridad de no haber sido dañado o marcado feamente por lo sucedido. Y el que sus padres reaccionen con indiferencia, puede tener efectos de muy

largo alcance. Muchos padres pueden sentir gran dolor y tensión al escuchar los detalles del hostigamiento, y necesitar ayuda considerable de parte de un terapeuta.

Familias emocionalmente empobrecidas

Otro asunto que debe ser considerado al tratar a víctimas infantiles, sobre el cual ya se habló brevemente antes, es que muchas de ellas provienen de hogares con un ambiente emocionalmente empobrecido, esto es, de sistemas familiares que no fueron (ni son) capaces de satisfacer sus necesidades emocionales. En tales casos, es tan importante tratar a la familia —a fin de ayudarlo a funcionar mejor y aprender a satisfacer las necesidades del menor— como tratar al niño agredido. Si no es posible sensibilizar a la familia a las necesidades del menor, el terapeuta puede decidirse por un tratamiento alternativo en el cual se incluya una red de apoyo extrafamiliar para el menor. Dicha red puede estar compuesta por agencias clínicas o sociales, lo mismo que por actividades extraescolares o actividades religiosas para jóvenes. Frecuentemente, la capacidad de un menor de construir una o dos relaciones sanas fuera de un sistema familiar que le da poco apoyo, junto con la ayuda del tratamiento, puede ser un factor crucial en la recuperación. De hecho, tales casos requieren que el papel del terapeuta vaya más allá del mero tratamiento del trauma. El proceso de la terapia debe dar al menor una experiencia enriquecedora en nivel social, cultural y emocional con el objetivo de ayudarlo a construir una visión del mundo más sana y positiva. Un proceso de elevación de la autoestima como el que se propone, necesariamente tendrá efectos benéficos en la terapia misma.

El terapeuta y la madre del menor

El establecimiento de una buena relación terapéutica con la madre del menor suele ser crucial para alcanzar un tratamiento exitoso por varias razones. Primero, muchas madres sienten que de alguna manera le fallaron a su hijo por haberse dado tal hostigamiento sexual. Como resultado de este sentimiento de fracaso, algunas madres pueden percibir al terapeuta como una amenaza o como un rival. Algunas son mujeres emocionalmente necesitadas, dependientes (especialmente aquellas que, a su vez, fueron víctimas de abuso sexual en la infancia). Debido a sus enormes necesidades insatisfechas de afecto, es posible que no permitan que sus hijos reciban cuidado y atención del terapeuta. Este tipo de madre generalmente no es consciente de lo que provoca su ansiedad y su incomodidad hacia la terapia de su hijo. Si el terapeuta no pone atención a la ansiedad subyacente en la madre, ésta puede obstaculizar el tratamiento del menor.

La ansiedad materna provocada por necesidades insatisfechas de dependencia puede revelarse en conductas como las siguientes. Puede acaparar el tiempo de la terapia del niño hablando de sus propias necesidades o de la maternidad y sus problemas; usar ese tiempo para quejarse de la conducta del niño. Después de la sesión, la madre puede presionar al menor para que cuente lo que sucedió en ella o preguntar insistentemente al terapeuta qué está pasando con el niño. La interferencia de la madre puede cobrar la forma de resistencia, que consiste en no asumir su responsabilidad en que el niño llegue a sus citas o quejarse de que tales citas son una imposición para ella. Si el terapeuta responde en la manera tradicional, poniendo límites a las intrusiones de la madre en la terapia del niño o pidiéndole que sea más responsable, es

muy probable que ella intente obstaculizar el tratamiento o incluso saque a su hijo de la terapia. Por lo general, estos problemas pueden resolverse realizando sesiones individuales con la madre una vez a la semana durante el inicio del tratamiento o coordinando que ella vea a su propio terapeuta mientras su hijo está en tratamiento.

Conducta abiertamente sexual en el niño

Al tratar a un niño o niña en el contexto de su familia, el terapeuta debe considerar que el menor probablemente ha tenido una experiencia sexual que va mucho más allá de su nivel de desarrollo apropiado. La agresión sexual sufrida pudo haber sido dolorosa, terrorífica, extraña o confusa; pero al mismo tiempo, al menos en ciertos aspectos, también pudo haber sido placentera para el menor. Y como secuela del trauma, es posible que éste tenga una conducta abiertamente sexual hacia los adultos o hacia los otros niños de la familia. Lo mismo puede ocurrir con sus compañeros de juegos o en la escuela. Es aconsejable que el terapeuta prepare a los padres para reaccionar apropiadamente en caso de que surja una conducta de este tipo. También puede pedirles permiso para hablar con los maestros del niño en caso de que la conducta tenga lugar en la escuela.

En el tratamiento de este tipo de conducta, el terapeuta ayudará a los padres a controlarla y les recomendará no transmitir un sentimiento de vergüenza al niño. Esto se obtiene si los padres logran separar la conducta inadecuada de la identidad del niño, diciéndole, por ejemplo: "No debes hacer esto", en vez de "Eres malo". Es decir, hacerle saber tranquilamente que debe dejar de hacer esas cosas. Se le puede decir algo como "Una persona mayor (u otro niño) te hizo algo incorrecto, pero lo que

tú estás haciendo ahora también es incorrecto". Se puede reafirmar en el niño el sentimiento de que es una buena persona. En la mayoría de los casos, el menor se siente aliviado cuando un adulto pone límites a su conducta sexual de manera que le permite entenderla. Al establecerse límites de esta forma, el menor empieza a dominar sus impulsos de actuar sexualmente, en vez de sentirse castigado por "ser" malo.

Lo anterior puede ejemplificarse con el caso de una niña de nueve años que fue sexualmente agredida por un hombre que vivía en el mismo conjunto de departamentos. Él la había obligado a lamerle el pene y la había hecho participar en juegos masturbatorios. Esa misma noche, la niña le dijo a su madre lo que había pasado y ésta llamó a la policía, quien la turnó a un servicio de terapia, pues ambas estaban muy traumatizadas por lo ocurrido.

Después de dos sesiones de la terapeuta con la madre y la hija, aquélla recibió una alarmadísima llamada telefónica de la madre pidiéndole consejo. Apparently, el hombre que había agredido a su hija le había dado un vibrador de pilas que la niña escondió en su recámara y del cual no le dijo nada ni a ella ni a la policía.* La madre estaba muy preocupada, pero quería actuar de una manera apropiada, pues era claro que la niña tenía sentimientos muy mezclados sobre lo que le había pasado. (Una de las razones por las cuales la niña había sido vulnerable a los avances del hombre es que su papá había abandonado a su mamá por otra mujer. Ninguna de las

* Esa noche, encontró a su hija en su recámara masturbándose con el vibrador, lo cual la había horrorizado.

dos lo había visto durante los ocho meses anteriores y debido a su abandono, la niña buscaba una figura paterna.)

La terapeuta habló con la madre por un rato a fin de calmarla para que cuando empezara a hablar con su hija lo pudiera hacer protegiéndola de traumas adicionales. Le dio instrucciones de entrar a la recámara de la niña y pedirle que le entregara el vibrador, preguntarle en dónde lo había conseguido y explicarle que ése no es un juguete para niños. Cuando la madre le preguntó a su hija de dónde había sacado el vibrador, ésta le dijo que el vecino se lo había dado como un "juguete secreto especial". La mamá le dijo que no era un juguete para niños y que el hombre había hecho mal en dárselo, de modo que ella se lo llevaría.

Al día siguiente la madre llamó a la terapeuta para decirle que, después de una leve protesta, la niña había aceptado que, sin hacer juicios, su madre detuviera la conducta inapropiada. También dijo que su hija incluso pareció aliviada de que su mamá se hubiera llevado el vibrador. La niña jamás volvió a mencionarlo.

Después de ese incidente, en dos ocasiones la menor trató de hacer participar a otros niños en juegos sexuales similares a aquél del que había sido víctima. En los dos casos, la madre intercedió calmadamente y le dijo a su hija que dejara el juego sexual pues lo que el hombre le había enseñado estaba mal y no debía hacerlo con otros niños. Insistió en que era una niña buena y que el malo era el hombre que la agredió. Después de estos incidentes, la madre continuó dando apoyo a su hija y, como resultado de su decidida intervención, la niña dejó de tener una conducta abiertamente sexual.

En suma, este tipo de conducta sexual "reactiva" debe ser controlado tan pronto como ocurre. La intervención debe enmarcarse cuidadosamente de modo que se

minimicen los sentimientos de culpa en el niño. Más aún, se debe ayudar al niño a comprender que aunque algunas cosas de la vida dan placer, no siempre son buenas para una persona, y la gente debe aprender a no hacerlas porque así es mejor.

En el tratamiento de un menor traumatizado en el contexto de su familia, el terapeuta debe tomar en cuenta otro factor importante: que el niño pudo haber sido agredido en un momento en el cual había otro problema serio dentro de su existencia. (Lo cual también sucede con las víctimas en edad adulta.) El caso citado de la menor que fue sexualmente agredida por su vecino describe a una menor vulnerable debido a una crisis en su vida, en particular, el haber sido abandonada por su papá. Ella estaba receptiva a la atención de un adulto porque había sido privada del cuidado paterno que necesitaba. Nuevamente, debemos tratar a estos niños en relación con el ambiente familiar que requieren para madurar y crecer. Si algunos de los componentes esenciales de su cuidado no son aportados por ese entorno, el menor puede ser llevado hacia otras fuentes posibles de apoyo que no tiene a la mano de manera natural.

Con el tiempo, muchos niños con estas carencias tratan de agradar a los adultos para satisfacer sus necesidades normales de dependencia llegando a parecer (superficialmente) niños exageradamente maduros. En realidad no lo son, sino que se mueren por tener el cuidado como elemento básico de su desarrollo normal. Como una manifestación del pensamiento mágico, estos niños sienten que la única manera en la que podrán recibir una aproximación de los cuidados paternos es pagando por ello sexualmente. Por desgracia, muchos terapeutas que se topan con una conducta infantil orientada a los adultos o seductora, se sienten negativamente sorprendidos y

giran su atención (o la culpa) a esa conducta. En nuestra experiencia, tales profesionales rara vez ven más allá de la conducta seductora inmediata hacia su origen, es decir, la carencia.

La desafortunada tendencia a transferir la responsabilidad del hostigador hacia la víctima sirve varios propósitos. Primero, protege a los que participan del mundo del niño de la necesidad de enfrentar el reconocimiento de que un adulto *como ellos* pudo hacerle tal cosa a un niño. Cada uno de nosotros se inclina a resistirse a mirar el lado más oscuro de la naturaleza humana. Segundo, culpabilizar al niño sirve para proteger a sus padres de tener que asumir alguna responsabilidad por lo sucedido a su hijo o hija. Y la culpabilidad puesta en la víctima (de manera similar a lo que ocurre en los casos de violación de adultos, por ejemplo, "No la violé, me sedujo") puede ser especialmente "conveniente" si la persona a quien se acusa de la agresión es un miembro respetado de la comunidad, un pariente o un amigo de la familia.

Hermanos y hermanas

Los hermanos y hermanas de una víctima infantil generalmente requieren cierta atención clínica. Primero, los padres deben ser ayudados por el terapeuta en la preparación de una explicación, adecuada a sus edades, de lo sucedido al hermano o hermana. Los pequeños intuitivamente sabrán que algo ha pasado y si los padres no les dan una explicación razonable, ellos tratarán de construirla por su cuenta. Es muy probable que la explicación que ellos construyan o imaginen sea mucho más terrible y emocionalmente dañina (en caso de que la víctima tenga conocimiento de ella) que la realidad. El hecho de que los padres no den una explicación adecuada puede tam-

bién hacer creer que la víctima es de algún modo responsable o que ha sido "manchada". En caso de que el agresor sea una persona importante en la vida de la familia, es necesario explicar a los hermanos y hermanas por qué esa persona ya no será parte de sus vidas. Esto es importante ya que de otro modo es posible que culpen a la víctima por la pérdida de un ser querido.

Es necesario dar atención especial a los hermanos y hermanas pues, como secuela, ellos pueden convertirse en el blanco de conductas abiertamente sexuales por parte del niño que ha sufrido el abuso. También es posible que sientan cierto remordimiento por no haber sido capaces de proteger a su hermano o hermana o de evitar que sucediera el trauma; incluso pueden, en el peor de los casos, sentirse responsables de lo sucedido. (Es por esto que el terapeuta debe examinar cuidadosamente lo que las víctimas piensan del cómo y el porqué sucedió la agresión, así como de lo que se podía haber hecho para evitarla.)

Finalmente, el hermano o hermana de una víctima puede ser quien haya descubierto el abuso, y estar también emocionalmente traumatizado por el incidente. En ocasiones, justo después de una agresión, se olvidan las necesidades de estos menores que también son víctimas.

La terapia de una víctima infantil

Ahora consideraremos el tratamiento de la víctima infantil de manera individual. En esta sección hacemos sugerencias sobre cómo debe presentarse a sí mismo el terapeuta, sobre cómo debe formularse la situación de la terapia al menor y sobre la manera en que debe presentarle los juguetes y juegos que se desea que se utilicen en la

sala de terapia. Se añaden sugerencias en relación con el tipo de estructura y límites que el terapeuta debe incorporar en la terapia de juegos. También se analizan aspectos importantes del proceso terapéutico.

Por lo general, acercarse clínicamente a un menor que ha sido víctima de abuso sexual por parte de un adulto ajeno a su familia no es tan difícil como cuando el agresor proviene de ésta. Algunas de las situaciones en que esto puede no ser así son las siguientes:

1. casos en los que el menor ha sido víctima de abuso repetido por un largo periodo y cuya familia está demasiado desorganizada como para poder seguir el tratamiento de manera adecuada;
2. casos en los que los padres necesitan eludir el hecho de ser de algún modo responsables de lo ocurrido a sus hijos, o
3. casos en los que está implicado algún amigo o persona importante para la familia, la cual desea proteger a la persona acusada.

Otros casos de agresión extrafamiliar que pueden ser muy difíciles son aquellos en los que los padres desean hacerse justicia por sí mismos. En ellos es necesario que el terapeuta diga claramente a los padres que deben mantenerse tranquilos si desean que el menor se sienta seguro y protegido. Tal como una pequeña niña dijera a su furioso padre, cuando éste prometió matar al hombre que la había agredido: "Papi, por favor no lo mates porque entonces la policía te va a llevar y te van a encerrar y yo me voy a quedar sin papá que me cuide".

Al empezar una relación terapéutica con una víctima infantil (al igual que sucede en la evaluación clínica descrita en el capítulo 2), el terapeuta debe explicar al

niño y a la familia cuál es su papel y cuál es la naturaleza de la relación. Algunos padres pueden ser muy protectores en esta etapa y desean conocer bien la formación y la experiencia del terapeuta. Esto no debe ofenderlo pues generalmente consiste en una expresión de la sensación de los padres de ser "malos protectores" de su hijo o hija. Mediante ese "examen" practicado al terapeuta intentan recuperar el sentimiento de ser guardianes adecuados del menor.

Se debe informar a los padres que deberán asistir regularmente a reuniones con el terapeuta en ausencia de su hijo. Los padres excesivamente ansiosos o aquellos cuyo hijo ha sido severamente traumatizado requieren reuniones semanales de este tipo. En situaciones menos críticas, puede bastar con una quincenal o mensual. Por otro lado, el terapeuta debe expresar su voluntad de ayudar a los padres para enfrentar cualquier problema de conducta que pudiera surgir. Sentirán gran seguridad si el terapeuta insiste en que pueden llamarlo si tienen dudas sobre cómo reaccionar ante alguna situación en particular. El caso de la niña a quien le dieron un vibrador es un ejemplo de cómo ese tipo de consultas puede evitar una posible crisis al ayudar a una madre asustada a detener en forma correcta una conducta inapropiada de la menor.

Aparte de los asuntos que se refieren al deber de prevenir o informar, la relación entre el menor y el terapeuta debe ser confidencial a fin de que éste se sienta en confianza para expresarse. La mayoría de los padres puede entender la necesidad de la confidencialidad en la relación terapéutica, pero algunos necesitarán que se les tranquilice al respecto para no sentirse amenazados. La plática con los padres sobre la naturaleza de la relación terapéutica por lo general debe contener la siguiente información:

1. La formación y experiencia del terapeuta.
2. El diagnóstico general del menor.
3. El tipo de terapia que se usará para tratar al niño y en qué consiste, por ejemplo, una descripción de lo que implica la terapia mediante juegos o alguna otra.
4. El pronóstico y la estimación del tiempo que durará la terapia.
5. La solicitud de consultar a otros adultos significativos en la vida del menor (profesores, nanas, etcétera) en caso de que sea necesario.
6. Una proposición de calendario de reuniones con el padre, la madre o con ambos.
7. Explicación de la naturaleza confidencial de la relación terapéutica con el niño, y del hecho de que ésta tiene como objetivo darle mayor libertad de expresión y no esconder cosas de los padres.
8. Una clara explicación de los honorarios que causará el tratamiento del niño o niña.

El terapeuta también debe explicar la naturaleza de la relación de terapia al menor. En esa plática se deben describir la estructura y los límites del tratamiento, lo mismo que la posible frecuencia de las sesiones y la duración de la relación. El primer paso del terapeuta consiste en presentarse a sí mismo ante el menor diciendo algo como lo siguiente:

Hola, me llamo _____.

Tus papás me pidieron que te viera a causa de lo que te sucedió. Si quieres, puedes contármelo o podemos jugar con muñecos o títeres sobre lo sucedido.

Pero si no quieres jugar ni hablar de ello, está bien.

Enseguida, el terapeuta debe hacer saber al menor que lo que le pasó a él o ella ya le ha pasado a otros niños. El mensaje es que no es el único a quien le ha sucedido algo así. Debe hacerle saber que sus sentimientos respecto al incidente son muy importantes y que él lo considera una persona única y valiosa.

El terapeuta puede continuar diciendo al menor que se reunirán una o dos veces a la semana, de acuerdo con el plan de la terapia. Enseguida, debe decirle que lo que se diga, haga o juegue ahí será confidencial, y que no le dirá nada a otros si el niño no le da permiso para hacerlo. (Esta consideración hace que la relación de terapia, que tiene que ser confidencial, sea diferente de la relación de evaluación descrita anteriormente. Debido a esta diferencia es aconsejable —aunque no siempre posible— separar las dos relaciones para que la evaluación —que no es confidencial y puede conducir a un juicio— sea hecha por otro terapeuta.)

El terapeuta debe comunicarle al menor que se reunirá periódicamente con sus padres, que estas reuniones tienen como objetivo ayudarles a comprender lo que le sucedió a él o a ella y que antes de esas reuniones podrán ponerse de acuerdo sobre lo que se hablará en ellas. Al principio es posible que el menor no entienda cabalmente lo que esto significa, pero a medida que se desarrolla la terapia y estas ideas se hablan en el contexto de sucesos reales, él o ella lo entenderá mejor y apreciará su significado.

Por último, el terapeuta debe explicarle la estructura básica y los límites de la situación de la terapia de juego. El niño necesita entender que la hora de la terapia es su tiempo para decir, o expresar mediante el juego, lo que él o ella desea. Habrá una variedad de actividades y juguetes a escoger y la decisión sobre qué hacer durante

la terapia será enteramente del niño. Lo único que no se le permite hacer es lastimarse o lastimar al terapeuta.

Es importante que la terapia de juego sea estructurada de tal manera que los impulsos destructivos o la cólera sean dirigidos hacia juegos simbólicos y no hacia personas. El terapeuta debe vigilar que cualquier expresión de cólera suceda sólo dentro de la sala de juegos. Por ejemplo, los juguetes que han sido objeto de la ira del menor o los dibujos con los que la ha expresado deben permanecer en la sala de juegos. No deben salir de ahí incluso si el niño desea llevárselos a su casa. El terapeuta debe asegurar al menor que esos objetos permanecerán bien cuidados ahí hasta que él o ella regrese a la siguiente sesión, asegurándole al mismo tiempo que la sala de terapia de juego es un ambiente seguro en el cual puede expresar esos sentimientos de cólera o enojo. De este modo el niño no teme que tales impulsos sean vertidos sobre sus parientes o amigos.

No exageramos al poner énfasis en cuán delicado es el equilibrio que se requiere entre el facilitar la expresión de enojo del menor y, al mismo tiempo, dar la estructura y la seguridad necesarias para que esa expresión no cree más incompreensión. Cuando sale a la superficie, el enojo de algunos niños traumatizados sexualmente puede ser muy primitivo e intenso, y debe ser claramente dirigido a objetos simbólicos y no a personas. Aparte de estos límites, el terapeuta debe asegurar al menor que el control del juego en la hora de la terapia está completamente bajo su mando.

Los terapeutas deben tener cuidado especial en lo que se refiere a tocar a niños traumatizados sexualmente. Un gesto de esa naturaleza, aunque bien intencionado, puede ser malinterpretado por el menor como un avance sexual o una amenaza por su parte. Bastará al lector reflexionar sobre el hecho de que la mayoría de estos niños

ya han sido estimulados sexualmente por un adulto sin que hubiera los medios adecuados para dar salida a las emociones. En consecuencia, son extraordinariamente sensibles a cualquier forma de contacto físico con un adulto y muchas víctimas que han sufrido un hostigamiento prolongado pueden no ser capaces de discriminar entre el contacto físico sexual y el no sexual.

Si tal es el caso, sugerimos que el terapeuta empiece por explicar al menor que ya sabe que ha tenido una relación con un adulto (o con adultos) en la cual se tocaban, pero que esta relación (con el terapeuta) no incluye el tocarse. En esta nueva relación, el terapeuta y el niño se comunicarán hablando y jugando. Se le puede explicar al niño que ambos aprenderán a expresar todo tipo de emociones, desde el afecto hasta el enojo, con esos medios. En especial, el terapeuta debe decir claramente al menor que no necesita tocarse con los demás o tener una conducta sexual a fin de establecer una relación positiva con los adultos. Así se hace posible construir un marco para la relación terapéutica dentro del cual el menor puede expresar sus sentimientos de manera apropiada.

La sala de terapia de juego y los juguetes sugeridos

La sala de terapia debe ser un sitio diseñado para que resulte cómodo a los niños. Debe ser cálido pero neutral, para que el niño o niña pueda acercarse libremente a los juguetes que le atraigan. El cuarto debe estar modestamente arreglado para que no se sienta ansioso o angustiado por hacer desorden o por dejar caer algo. Debe haber una selección de juguetes que estén *por debajo* de su edad (por si acaso necesita entrar en una conducta regresiva), y otros adecuados a su edad para diferentes tipos de juegos. A continuación presentamos una lista, por categorías, de ciertos juguetes que pueden ser útiles en una sala de terapia de juego.

Equipo recomendado para la sala de terapia

Juguetes de regresión:

- Biberón
- Plastilina
- Pintura digital (algunos niños muy traumatizados pueden tener miedo de esta pintura)
- Animales de peluche muy suaves

Material de dibujo:

- Crayolas
- Pintura
- Se recomienda un rollo de papel de estraza para que el niño pueda usar los tamaños que quiera

Muñecos

- Muñecos de niños y niñas con ropa que se pueda quitar
- Muñeco bebé

Juegos de mesa y cartas

- Diversos tipos de cartas o barajas, damas, ajedrez y otros

Juguetes para impulsar la plática y la fantasía

- *Títeres:*
- Títeres de animales machos y hembras (nosotros tenemos ranas niño y niña)
- Títere claramente malo (tenemos una víbora y un diablo)
- Figuras claramente buenas, por ejemplo, papá y mamá, policía, médicos y enfermeras, el Príncipe Azul (tenemos un unicornio y una enfermera)

Diversos títeres neutrales de forma animal o humana a los cuales el niño o niña puede asignar diferentes papeles

- Casa de muñecas (con muebles y muñecos representando a la familia)
- Charola de arena
- "El no-juego"
- "Imagina"

El terapeuta puede tener en la sala de juegos un osito de peluche o algún otro animal relleno con algo suave para aquellos niños que han sido tan seriamente traumatizados que se rehúsan a comunicarse con otra persona. Todos los niños pueden caer en el mutismo, desconectarse o regresar a balbuceos primarios debido a su fragilidad. En estos casos, el terapeuta puede colocar uno de esos muñecos de peluche junto al menor y hablarle de manera suave y agradable sobre un tema neutral. El objeto seguro no-humano puede ayudarle a realizar la transición de vuelta hacia la comunicación con la gente.

Un ejemplo del uso de este tipo de objeto lo ilustra el caso de un niño de cinco años y medio que fue llevado a tratamiento. Había sido sodomizado repetidamente por tres hombres que lo sedujeron mientras jugaba solo en un parque público. Cuando su madre y un policía lo llevaron al consultorio del terapeuta, la madre dijo que se había quedado prácticamente mudo; había balbuceado algunas frases relativas a la agresión, pero desde entonces casi había perdido el habla. Cuando la mamá del niño salió del cuarto, éste se sentó en la orilla de la silla mirando al vacío. El terapeuta hizo varios intentos fallidos para que participara en la plática o el juego. El niño se bajó de la silla y se sentó en el piso mirando hacia donde no estaba el terapeuta.

Después de varios minutos, la perrita *cockerspaniel* del terapeuta, que había estado durmiendo bajo el escritorio, se despertó. En su terrible ansiedad el niño no la había visto al entrar al consultorio. Pensando que quizá el menor se sentiría mejor en compañía de la perra, el terapeuta empujó suavemente la pelota de ésta en su dirección. Cuando la perra fue tras la pelota, vio al niño en el piso, se la llevó y lo invitó a jugar con ella. El terapeuta observó silenciosamente, esperando que la perrita lograra hacer algún contacto con el niño. El animal primero se sentó en silencio junto a él y luego lo empujó suavemente con su hocico varias veces, mostrándole la pelota. Como el niño no se movía, la perrita empujó la pelota hacia él con su hocico. Cuando la pelota iba hacia el niño, la perrita nuevamente lo empujó con su hocico. Entonces el niño, con movimientos lentos y torpes, empezó a acariciar a la perrita y suavemente le devolvió la pelota.

El menor pasó el resto de la primera sesión sentado calladamente junto a la perrita y acariciándola. El terapeuta decidió no intervenir en esta relación. En la segunda sesión, el niño tímidamente saludó al terapeuta y de inmediato se puso a jugar con la perra. Lentamente, a lo largo de varias semanas, fue logrando hacer la transición del juego con la perra a la interacción con el terapeuta. Este caso indica cómo es posible traer a un niño de vuelta al contacto con la gente mediante el uso de un objeto sustituto.

Algunos niños severamente traumatizados tratan de soportar la situación mediante defensas tan primitivas que no pueden responder a las formas tradicionales de terapia interpretativa de juego. En tales situaciones, el terapeuta debe brindar al niño un ambiente terapéutico seguro y nutritivo para que finalmente vuelva a un nivel

emocional que le permita entrar en las técnicas de juego más tradicionales. Para estos niños, las metas iniciales de la terapia deben ser muy modestas, reconociendo su psicología traumatizada.

Por ejemplo, en el caso del niño agredido que analizamos, la primera meta de la terapia fue que el niño tolerara estar solo en un cuarto con un adulto. La siguiente meta era que intentara comunicarse con el terapeuta de algún modo. Desde ese punto el terapeuta trató de hacer que la experiencia de la terapia fuera positiva y enriquecedora. Las metas se alcanzaron después de meses de trabajo. Y sólo después de darse esos primeros pasos pudo el niño empezar a participar en juegos de terapia interpretativa relacionados con el trauma.

Dinámica de tratamiento

En general, los niños responden de dos maneras ante una agresión o trauma sexual: 1) se da una aparición inmediata de síntomas somáticos y conductuales y 2) la reacción es más bien retardada o "silenciosa" y suele ser de naturaleza depresiva.

Síntomas somáticos

Algunos de los efectos somáticos que pueden aparecer inmediatamente después de una agresión de este tipo son dolores amorfos, problemas gastrointestinales, cambios súbitos en los hábitos de evacuación y orina y enuresis (en niños menores). Las víctimas infantiles frecuentemente se retiran de sus actividades y relaciones acostumbradas volviéndose fóbicos, en ocasiones rehúsándose a jugar afuera de la casa o desarrollando una fobia a la escuela. Burgess y Holmstrom (1974), DeFrancis (1969), Gibbons y Prince (1963), el Centro Médico Tufts

de Nueva Inglaterra (1984) y Finkelhor (1987) han anotado en sus estudios que la mayoría de estas víctimas tenían al menos desde síntomas leves hasta síntomas agudos posteriores al trauma.

Terror nocturno y pesadillas son síntomas comunes entre los niños traumatizados. Muchos de ellos tienen miedo de dormir solos e insisten en hacerlo con sus padres. No recomendamos que un niño que ha sido víctima de abuso sexual duerma en la misma cama que alguno de sus padres o de ambos. Si no tolera estar solo en la noche es buena idea prepararle una cama en la recámara paterna, manteniendo así las fronteras adecuadas hasta que el menor esté listo para volver a su propio cuarto. También recomendamos el uso de luces nocturnas, así como tener una campana o silbato junto a la cama del menor para que pueda llamar a sus padres en caso de que tenga miedo. También hemos descubierto que es útil darle un peluche diciéndole que éste tiene poderes especiales contra las cosas malas. Se le alienta a tomarlo y abrazarlo cuando le dé miedo, haciendo que las cosas malas se vayan.

Al igual que Peters (1976), hemos descubierto que en muchos casos se requiere de una terapia de juego relativamente larga antes de que el menor pueda expresar sus sentimientos sobre la agresión. Como mencionamos en el capítulo 1, una de las razones por las cuales a algunos les cuesta tanto trabajo expresar su enojo hacia el adulto que los traumatizó, es que la mayoría de los niños han sido educados para no expresar esos sentimientos. A ellos se les enseña a obedecer a los adultos y a "no responderles". Cuando uno considera que muchos niños fueron llevados con engaños hacia la situación en la cual fueron traumatizados por alguien conocido y en quien confiaban, uno se percató de que la agresión los pone en una si-

tuación muy ambivalente. El niño ha sido agredido por que obedeció a un adulto; puede tener sentimientos de enojo pero no debe expresarlos porque hablar mal de los adultos está prohibido.

Muchos niños no pueden sobreponerse a esta situación ambivalente. Y resuelven el conflicto interiorizando el coraje y la confusión hasta deprimirse. Si los padres reaccionan en una forma que transmite el mensaje "sólo olvídale", esto les confirma que el enojo contra los adultos no está permitido, lo cual profundiza su sentimiento de desamparo. O si los padres se van al otro extremo —volviéndose demasiado restrictivos o supervisando en exceso la conducta del niño— el menor puede malinterpretar esta sobreprotección como castigo por sus pensamientos de enojo. Cualquier reacción extrema de parte de los padres puede provocar que el niño o niña bloquee sus verdaderos sentimientos en relación con la agresión evitando que encuentre su salida del trauma.

Reacciones retardadas

En los casos de reacciones retardadas o depresivas ante la traumatización sexual, el terapeuta puede necesitar de cuatro a seis semanas (o más) de juego con el niño, transmitiéndole el mensaje de que sus sentimientos son aceptados y de que la sala de juegos es un lugar seguro en donde puede expresarlos. Hemos descubierto que algunas de las técnicas de entremezclado de Milton Erickson, en las cuales el mensaje que el terapeuta desea que el cliente reciba es introducido sutilmente a lo largo de la conversación (Erickson, Rossi y Rossi, 1976), pueden ser muy útiles. Además, el terapeuta puede decir al niño algo como esto:

Sé que tienes pensamientos y sentimientos acerca de lo que te ha pasado. Tal vez desees compartirlos conmigo ahora, o hablarme de ellos más adelante. Si no me quieres decir nada ahora, y prefieres esperar otro momento, a mí me parece bien.

Ésta es una versión de la técnica Ericksoniana llamada "ilusión de alternativas". Es una manera de dar a una persona la ilusión de que tiene alternativas "permi-tiéndole" que escoja entre hacer algo ahora o después. La alternativa de no hacerlo nunca es ofrecida.

Otra técnica indirecta que puede usarse en el tratamiento de un niño que tiene miedo de decir lo que le pasó es la de contar cuentos o historias. En ésta, el terapeuta cuenta una historia sobre un niño hipotético que se encuentra en una situación similar con el fin de encontrar una manera de interpretar el acertijo del menor. Por ejemplo, en el caso de un niño temeroso de hablar del hostigamiento, el terapeuta puede contar la historia de un niño a quien le pasó algo que lo espantó y le dio vergüenza, pero que un adulto entendió sus sentimientos y él pudo decirle qué había pasado. El proceso de contar historias es especialmente eficaz porque entra perfectamente en el estilo concreto de pensamiento de los niños. La historia o cuento le da un ejemplo de cómo puede resolver un problema que resulta demasiado complejo para sus capacidades cognoscitivas. En resumen, una historia o cuento puede servir como un mapa teórico hacia la solución del dilema del niño. Nosotros hemos comprobado la eficacia de este tipo de métodos indirectos de terapia.

Continuación del tratamiento

Con el tiempo, el niño comienza a comunicar al terapeuta lo que piensa y siente de la agresión. Como ya dijimos, el

profesional puede facilitar esto mediante la técnica Ericksoniana o algún otro método indirecto, pero firmemente aconsejamos que no se usen métodos terapéuticos de confrontación o intrusión. A medida que el terapeuta juega y habla con el menor, debe estar alerta a lo que el trauma significó para él o ella en términos de su visión del mundo. Al igual que con las víctimas adultas, los aspectos sexuales de la agresión tal vez no hayan sido la fuente primera de los sentimientos traumáticos del menor. Tal como lo hacen al ser confrontados con la agresión a un adulto, las personas que conocen al menor pueden centrarse en los detalles sexuales, debido a que son extraños y chocantes, y de ese modo no ver que la mayoría de las víctimas se preocupan principalmente por cosas como: 1) podían haberlos matado; 2) se sienten completamente desamparados o utilizados; 3) fueron traicionados por alguien en quien confiaban, o 4) perdieron para siempre a la única persona que les brindaba atención.

Esto no significa que los asuntos sexuales no son importantes. Lo son pero pueden no ser los aspectos principales que el niño víctima debe enfrentar como resultado del trauma. Por tanto, cada uno de los aspectos que antes mencionamos debe ser interpretado para el niño para que él o ella pueda entenderlos en el contexto de su nivel de desarrollo. El terapeuta busca encontrar cómo percibió el trauma el menor para empezar desde ahí, en vez de hacerlo con su propia percepción del suceso. Como sucede en cualquier otra situación en la cual interactúan dos personas, no se puede asumir que ambas comparten la misma "realidad".

Cuando los pensamientos o sentimientos relacionados con el trauma salen a la superficie de manera simbólica durante la terapia, tal vez se expresen de alguna de las maneras siguientes. Un niño puede actuar historias

con el tema de "gente buena" que repentinamente se vuelve "mala", o situaciones en las que uno tiene que adivinar quiénes son los buenos y quiénes los malos. Con estas historias, el niño intenta resolver la ansiedad que le provocó creer que alguien era bueno y ser agraciado después, por él o ella, así como la aprehensión de lograr progresar en el futuro.

En ocasiones el menor se ensucia de alguna manera y le pide ayuda al terapeuta para limpiarse. Al hacerlo, el terapeuta puede interpretar directamente lo que se hace introduciendo un mensaje como: "Quieres sentirte limpio de nuevo después de lo ocurrido". Puede agregar que, en efecto, el niño se sentirá limpio nuevamente. Insistimos en que hemos notado que es mejor que tales interpretaciones sean hechas (directa o indirectamente) en un tono muy casual y sólo se introduzcan de vez en cuando a lo largo de la conversación con el menor.

Es posible que el niño trate de deshacer de manera simbólica la experiencia desarmando repetidamente los juguetes para luego juntar los pedazos y armarlos. Puede insistir en desarmar todos los juguetes que pueda (incluso algunos que no son desarmables) y juntar los pedazos o bien centrarse en un solo juguete. Durante ese juego de desarmar y armar, el terapeuta debe transmitir un mensaje que contenga los siguientes elementos: las cosas rotas o lastimadas pueden arreglarse y no tienen por qué permanecer rotas; la gente puede sentirse rota, pero puede también mejorar y volver a sentirse completa.

Algunos niños traumatizados pueden enfocar su atención en un juego en particular y utilizarlo durante largos periodos o durante toda la terapia. El juego se convierte en un vehículo simbólico con el cual resuelve su trauma. A menudo cambia las reglas básicas del juego para adecuarlo a sus necesidades. Con la repetición pue-

de estar buscando confirmación de que tiene una relación constante con el terapeuta, aunque su propio mundo esté hecho un caos. Una niña le recordaba a su terapeuta cuántos juegos de cartas habían jugado juntos. Al finalizar la terapia habían jugado 257. Algunos niños necesitan ganar cada juego —ya sea cambiando las reglas o haciendo trampas descaradas— como una forma de deshacerse de su sentimiento de desamparo resultante del trauma. La creativa invención de reglas o las trampas empiezan a desaparecer conforme el menor va recuperando seguridad en sus capacidades. Lo esencial es que si un niño escoge un juego o actividad repetidamente, el terapeuta continúe participando en ella hasta que el niño decida cambiarla.

Muchos niños muy pequeños pasan por un periodo regresivo a lo largo del tratamiento, el cual generalmente se presenta al principio de la terapia aunque en los casos de respuesta retardada ante la crisis ocurre más tarde. En dicho periodo de regresión, el menor puede desear comer o que le den de comer con un biberón. O jugar con pinturas digitales o plastilina de manera muy primitiva. El terapeuta puede interpretar esta conducta ante él diciéndole, por ejemplo: "A veces, cuando estamos asustados o nos sentimos mal, nos da seguridad o nos ayuda hacer cosas de bebés por un rato, para volver al tiempo en el que todo era seguro".

Si el niño actúa regresivamente durante la terapia de juego, es buena idea hacer saber a los padres que tal vez muestre la misma conducta regresiva en casa o en la escuela. Puede pedir un biberón, o viejos juguetes que ya no usaba o mostrar cualquier otra forma de conducta infantil. Los padres no deben alarmarse pues esto generalmente pasará en unas semanas si ellos y los demás adultos responden apropiadamente. Aunque pueden poner

límites a la conducta, deben permitirle al menor la seguridad de ese periodo de regresión posterior a un trauma sexual. Dado que tal conducta suele asustar a los padres, éstos necesitarán de una buena ayuda por parte del terapeuta. Es conveniente explicárselas dándoles confianza al señalar que, por medio de la regresión, el niño o niña trata de volver a un nivel de desarrollo anterior al trauma con el fin de restablecer una base sólida para sus necesidades psicológicas.

En un momento u otro, los menores víctimas de abuso sexual logran expresar su enojo o cólera por lo que les sucedió, pero pueden requerir gran ayuda para lograrlo. Teniendo en consideración toda la formación que impide que un niño exprese su coraje contra un adulto, el terapeuta puede introducir afirmaciones cuidadosamente construidas para ayudar al menor a expresar su cólera. Estos mensajes deben decir que, en ciertas circunstancias, los niños tienen derecho a estar enojados contra los adultos y a expresar ese enojo. Lo que les hicieron es algo malo y, por lo tanto, el terapeuta entiende su enojo. Pero también se le debe explicar que no está bien lastimar a la gente cuando uno está enojado. La cólera del niño será cuidadosamente guiada dentro de la terapia hacia juguetes u objetos simbólicos y nunca hacia personas o animales. El periodo en el cual el menor expresa su cólera es muy delicado y mientras facilita esa expresión, el terapeuta debe mantenerla dentro del contexto de la estructura de la terapia de juego.

Aun cuando la investigación empírica controlada sobre los efectos de largo plazo de la traumatización sexual infantil en el desarrollo de la personalidad del adulto apenas se inicia, no podemos ignorar el hecho sorprendente de que una buena cantidad de agresores adultos fueron a su vez víctimas de abuso sexual cuando niños.*

Por tal razón pensamos que la forma en que se trabajan los sentimientos de desamparo y cólera del menor puede tener un gran impacto en el posterior desarrollo del adulto.

El terapeuta debe considerar, asimismo, que en ciertos casos de abuso sexual puede haber varias víctimas del mismo agresor conocidas entre sí. Aunque es importante considerar cada caso en particular, el terapeuta debe recordar que esos niños pueden llegar a hablar entre ellos de lo "sucedido". Entonces, aunque el terapeuta dé los pasos adecuados para trabajar con los padres del menor y con los otros adultos importantes en su vida, el niño puede estar en contacto con otra(s) víctima(s) infantiles (es) que le transmitan mensajes conflictivos. Por esto, en caso de que efectivamente se sepa que existen otras víctimas conocidas por el menor, el terapeuta debe intentar averiguar algo sobre ellos y sobre su tratamiento y así ayudar al menor a manejar la información que pueda recibir de los otros niños.

Dos estudios de casos

Las siguientes descripciones ilustran la terapia con dos niñas de nueve años que fueron víctimas de abuso sexual y negligencia prolongados. Las dos, aunque víctimas de formas similares de abuso, tenían necesidades relativamente diferentes en términos de terapia y manejo del caso.

* Aunque se han hecho muchas investigaciones de los efectos de traumas sexuales en el desarrollo psicológico del niño, ninguna (por lo que conocen los autores) ha tenido un adecuado grupo de control o una muestra correctamente estratificada de acuerdo con los diversos tipos de abuso sexual sufrido por los menores.

El caso de Amy

Amy había sido relativamente bien cuidada por sus padres hasta que su mamá dejó a su papá cuando ella tenía tres años y medio. Su papá era una persona del tipo "salvador-cuidador" de modo que mientras la familia estuvo unida, su vida había sido estable. Desgraciadamente, cuando la mamá de Amy se la llevó y se fue con otro hombre, su mundo cambió dramáticamente en el peor sentido. La madre, que tenía antecedentes de drogadicción antes de casarse, pronto volvió a consumir drogas. El padre de Amy trató de encontrar a la niña por miedo a lo que le pudiera pasar estando bajo el cuidado de su madre, pero no logró localizarla.

Después de cerca de tres años, la madre estaba completamente metida en su adicción, en relaciones abusivas con varios hombres y se prostituía ocasionalmente para conseguir dinero para sus drogas. Amy no recordaba cuál de los novios de su mamá fue el primero en abusar de ella. Pero sí se acordaba de la primera vez en que ésta la entregó a un hombre "para que jugaran" a cambio de dinero: fue justo después de su séptimo cumpleaños. El hombre tuvo relaciones sexuales con ella. Amy dijo que su nombre era Ron, que lo que le hizo le dolió terriblemente y que venía a verla como una vez al mes. En poco tiempo la madre comenzó a forzarla regularmente a prostituirse y a posar para pornografía. Amy se preguntaba qué había pasado con su papá y por qué no venía a verla. Dijo que pensó que se había olvidado de ella.

Una noche, la madre de Amy fue arrestada en su departamento por vender drogas y por prostitución. Amy fue llevada al centro de atención para menores y ahí se supo de su horrible historia de abuso sexual prolongado. Cuando la madre fue liberada bajo fianza, dejó la ciudad y nunca más se volvió a saber de ella. Poco después se encontró al padre, a quien le dieron la custodia de la niña.

Pronto el padre se dio cuenta de los serios problemas emocionales de su hija. Mientras estuvo con su mamá prácticamente no había ido a la escuela y a los nueve años de edad se hallaba en nivel de unos seis. Frecuentemente se orinaba en la cama y ensuciaba sus pantalones cuando estaba bajo estrés. Su conducta variaba entre seductora y acomodaticia hasta berrinches infantiles. Por tal razón, su padre pidió a la trabajadora social a cargo del caso que le recomendará a un terapeuta para menores.

Cuando Amy fue llevada por su padre a la terapia por primera vez, no quería quedarse sola en la oficina con la psicóloga. Después de que su papá le aseguró que todo estaba bien, aceptó pero sólo si prometían dejar la puerta completamente abierta. Durante esta primera sesión Amy adoptó una postura ansiosa y se sentó lo más lejos posible de la terapeuta, evitando completamente el contacto visual. La profesional pensó que sería conveniente hacerle unas pruebas antes de empezar el tratamiento, por varias razones. Antes que nada, era necesario tomar ciertas decisiones respecto de la escolarización de Amy ya que era obvio que no podía funcionar en una clase normal. A su padre le preocupaba no poder cuidarla bien en casa y tener que internarla en una escuela especial o incluso hospitalizarla. En varias ocasiones, la niña había entrado a su recámara durante la noche haciéndole avances sexuales. Ese comportamiento le chocaba y le hacía dudar si podía cuidar correctamente de su hija en ese momento. Además, la terapeuta necesitaba respuestas para algunas preguntas diagnósticas específicas concernientes a ciertos aspectos de la extraña conducta de Amy en su oficina.

Los resultados de tales pruebas mostraron que se trataba de una niña intacta en lo fundamental, en el sentido de que no había ninguna evidencia de desórdenes psicológicos o de psicosis. Revelaron también que Amy tenía una terrible ansiedad que la podía conducir a en-

cerrarse y retirarse del mundo a manera de defensa. Este proceso explicó su rígida postura durante la primera entrevista. Según las pruebas, Amy percibía el mundo como un lugar hostil y peligroso en el cual ella trataba de sobrevivir alternando entre la hipervigilancia y el bloqueo emocional y el retraimiento. Más adelante se vio que la menor se veía a sí misma completamente desamparada y sin ninguna posibilidad de influenciar o cambiar su mundo. Su coeficiente intelectual mostraba que era un niño de inteligencia ligeramente superior a la normal, de modo que, considerando lo que había vivido, era probable que en condiciones normales estaría funcionando en un nivel aún superior. Aunque era fundamentalmente lista, su nivel de desempeño en tareas elementales estaba dos años por debajo de su edad.

Al terminar las pruebas, la terapeuta se reunió con el padre y con los directivos de la escuela. Decidieron colocar a Amy en una pequeña clase para niños con problemas emocionales (dentro de su escuela normal) y ayudarla con trabajo suplementario. Debido a que la conducta evasiva y rara de la menor, al igual que su actitud abiertamente sexual, obedecían más a lo que el ambiente había hecho que a una patología subyacente, la terapeuta optó por trabajar con el papá y con la escuela con el fin de crear un medio estructurado y cuidadoso en el cual Amy pudiera recuperarse de su largo trauma y alcanzar su nivel de desarrollo. A pesar de que la niña se hallaba en un estado tal de fragilidad emocional y de trauma severo que se la podía haber hospitalizado, la terapeuta quería evitar un internamiento institucional que haría que la catalogaran como patológica. Aunque algunos de los demás profesionales que participaron en el caso tenían dudas, ella pensaba que la niña respondería a la terapia en conjunción con un ambiente más sano en su casa.

Inicialmente, la terapeuta se reunía con Amy dos veces a la semana y con su papá una vez a la semana, además de que regularmente hablaba por teléfono con los maestros de su escuela y los encargados de su guardería. Trabajó muy de cerca con el padre de Amy para que pudiera lidiar con la conducta abiertamente sexual de su hija, y para ayudarla a aceptar que aunque ésta tuviera cronológicamente nueve años, funcionalmente era menor. Hubo también de ayudarla a comprender su cólera en contra de su exesposa, así como su propio sentimiento de culpa por no haber hecho nada por encontrar a su hija antes.

Durante la etapa inicial de la terapia Amy apenas toleraba estar sola en una habitación con la terapeuta. Incesantemente iba a comprobar si podía abrir y cerrar la puerta. Cuando lo hacía, la terapeuta le daba confianza diciéndole que el seguro nunca estaría puesto y que además podía verificarlo cuando ella quisiera. Entonces le preguntaba a Amy si deseaba hablar de las puertas y de lo que habían significado para ella en el pasado, pero la niña se volteaba y se sentaba rígidamente en su silla.

En general, Amy era sumisa y obediente con la terapeuta. Después del primer mes de tratamiento siempre llevaba consigo una muñeca de trapo. Durante varios meses fue absolutamente incapaz de formular cualquier tipo de demanda. Si la terapeuta le preguntaba qué le gustaría hacer, al principio miraba a otro lado y se ponía rígida, pero si le sugería alguna actividad de juego, ella obedientemente participaba. Cuando se le preguntaba qué estaba pensando o sintiendo, nunca daba una respuesta. Era como si, para ella, pensar, pedir o considerar sus emociones fuera algo prohibido desde hacía mucho tiempo.

Las actividades de la terapia de juego de Amy fueron regresivas durante un largo periodo. Se mecía en su mesa mientras abrazaba algún juguete acolchonado o su muñeca y tomaba jugo en un biberón. Cuando se sentía presionada se ponía rígida o actuaba de manera rara o decía cosas sin sentido. Era claro que esas actitudes eran la forma en que trataba de alejar a la gente que la amenazaba. Siempre que hacía esas cosas la terapeuta le dejaba tanto espacio emocional como le era posible, mientras que al mismo tiempo interpretaba esa conducta y le daba alternativas para lograr satisfacer sus necesidades. Trató también de que tanto el padre como las demás personas cercanas a Amy comprendieran el sentido de tales actitudes, y respondieran de manera similar.

Amy permaneció en ese estado infantil de regresión durante varios meses del proceso de terapia. Aunque empezó a hacer algunos progresos en la escuela y en el plano emocional (fuera de las sesiones de terapia), en el tratamiento continuó actuando como si tuviera cerca de seis años. La terapeuta pensó que esto era un buen indicador de que Amy se había estabilizado pues estaba usando el tiempo de la terapia para hacer su regresión y, de este modo, recuperar una base emocional; y, al mismo tiempo, lograba avances a nivel intelectual, que era donde se sentía más fuerte.

Lentamente, el juego de Amy cambió de actividades infantiles y regresivas con muñecas y animales de peluche a inventar historias en una casa de muñecas con temas de alimentar, lavar y en general, cuidar niños. Entonces empezó a hacer repetidamente un juego proyectivo en el cual ella era el médico que examinaba y trataba a una niña que había sido lastimada. Era claro que actuaba el examen médico que se le practicó cuando fue separada de la madre. Amy examinaba metódicamente a la

muñeca para asegurarse de que se cuidara de sus lastimaduras. Durante ese juego, la terapeuta le daba interpretaciones de lo que sucedía, al tiempo que mezclaba mensajes diciendo que la niña ahora estaba bien y era buena.

Amy continuó mejorando en la escuela y en poco más de un año ya estaba logrando avances en su nivel correcto, aunque todavía era retraída y temerosa socialmente. La terapeuta decidió pedir la ayuda en el curso de la terapia a alguien del programa Hermana Mayor (*Big Sister*) para dar a Amy un modelo femenino más claro y ayudarla a desarrollar sus capacidades de socialización. Debido a que sus experiencias con sus profesores y con la terapeuta habían sido buenas, Amy respondió bien a la Hermana Mayor. Con el tiempo, su comportamiento en la escuela mejoró a tal grado que decidieron colocarla en una clase normal.

En cierto momento la niña comenzó a interesarse por los juegos de mesa que había en la sala de juegos de la terapeuta, en especial, el ajedrez. Cada vez que jugaba ajedrez con ella, Amy intentaba ganar a toda costa, incluso recurriendo a trampas evidentes. Cuando el juego avanzaba de tal modo que la niña iba perdiendo, se ponía muy enojada y empezaba una pataleta, agarrando las piezas de la terapeuta para asegurarse de ganar. Era claro que, a través del juego, empezaba a expresar su necesidad de control así como su cólera contra su madre y los adultos que abusaron de ella. La terapeuta le permitía que ganara y aprovechaba la oportunidad para hacerle saber qué había detrás de su comportamiento.

Naturalmente, éste era un desarrollo fortuito en el proceso del tratamiento. La terapeuta aceptaba los enojos de Amy, aunque en ocasiones se dirigieran hacia ella (la terapeuta). Significaban que Amy estaba cambiando

su visión de sí misma, de una víctima sumisa a una persona a quien se le había hecho daño. La terapeuta buscaba ahora facilitar esa expresión de coraje y, al mismo tiempo, el desarrollo de mecanismos de aceptación socialmente adecuados. Para lograr tales objetivos, explicaba a Amy que podía cambiar las reglas del juego si lo deseaba, pero que debían ponerse de acuerdo sobre éstas antes de retomar el juego. Amy respondió positivamente y empezó a inventar nuevos juegos (y nuevas reglas para viejos juegos) en los que se reflejaban sus experiencias de abuso. Junto con la terapeuta, creó juegos y reglas que representaban su vida de todos los días y los asuntos con los cuales estaba luchando.

La terapia individual de Amy continuó hasta que la niña llegó a los doce años y medio. Para entonces, aunque aún era bastante tímida, había ya desarrollado una sana imagen de sí misma, contaba con varios amigos y participaba en un equipo de fútbol. Aunque la terapeuta detuvo las sesiones individuales con ella, el proceso de finalización se condujo de tal modo que permitiera a Amy volver sí, siendo ya adolescente, lo necesitaba. Esto se hizo para que no viviera el eventual regreso a la terapia como un fracaso ni como un paso atrás en la vida.

El caso de Jean

Jean tenía la misma edad que Amy cuando empezó el tratamiento. Era víctima del mismo tipo de abusos sexuales, pero el proceso de tratamiento tomó un camino marcadamente distinto.

Nadie está seguro de quién es el padre de Jean. Su mamá, April, vivía en el mundo de las drogas y las bandas de motociclistas cuando contaba con alrededor de veinte años. En ese tiempo tenía relaciones promiscuas

heterosexuales y homosexuales y consumía fuertes cantidades de diversas drogas. De hecho, hay largos periodos de los cuales April no tenía ningún recuerdo. Jean había sido separada del cuidado de su madre cuando, en una primera ocasión, ella y un amigo fueron aprehendidos tratando de vender mercancía robada. En esa época la niña estaba malnutrida y mostraba signos de abuso tanto físico como, posiblemente, sexual. A la edad de tres años fue colocada con unos parientes, una tía y un tío quienes tenían otros dos niños mayores y vivieron muchas dificultades con Jean durante varios años. La menor hacía berrinches incontrolables en los cuales gritaba, pateaba y escupía o mordía a quien tratara de controlarla. Tenía severos terrores nocturnos y durante más de un año no pudo dormir sola. Además, era sexualmente provocativa con los adultos y cruel con los otros niños y los animales. Después de dos años difíciles, pareció calmarse y responder positivamente al ambiente estable de sus tíos.

Aun cuando a los seis años Jean seguía siendo una niña difícil con quien el contacto no era cosa sencilla, las cosas iban relativamente bien cuando su mamá reapareció asegurando que era una mujer completamente cambiada. Desde ese momento, la niña no dejó de insistir en que quería irse con ella. Los tíos tuvieron que aceptar que cuando estaba con April, la menor mostraba un carácter muy diferente al habitual: obediente y afectuosa con su mamá. Los tíos no reconocieron en esto la típica actitud sumisa y pseudomadura de los niños víctimas de abuso y creyeron que era un signo de una relación potencialmente sana entre la niña y su mamá. Después de gran insistencia de parte de Jean y muchas promesas de April, los tíos permitieron a la niña regresar con su mamá. Muy pronto, April se mudó llevándose a Jean, supuestamente porque había conseguido empleo en otra ciudad.

Los tíos de Jean no volvieron a verla hasta que tenía cerca de nueve años. Fue encontrada en una redada policiaca en una casa conocida como centro de tráfico de drogas y escandalosas fiestas de bandas de motociclistas. La madre logró escapar a la redada, pero a la niña la encontraron en una recámara con dos hombres que posteriormente fueron encarcelados por hostigamiento y posesión de narcóticos. Más tarde se supo que Jean había sido víctima de ese tipo de abuso durante varios años. La madre la había dejado al cuidado de amigos que abusaban de ella y que la habían obligado a participar en relaciones sexuales grupales durante orgías en las que le habían administrado drogas. Un hombre con el que April vivía, un motociclista, solía tener relaciones sexuales con Jean —incluyendo la sodomización.

Como resultado, los tíos de Jean recibieron la custodia legal de la niña. Pronto buscaron tratamiento para ella, pues cuando volvió a su cuidado, hacía unos berrinches terribles, similares a los de antaño. No podía dormir sola por las noches y nada más descansaba realmente cuando sus tíos le permitían dormir en su cama. En ocasiones se mostraba sádica y (o) sexualmente provocativa con los demás niños. Su conducta hacia sus maestros variaba entre la conciliación y la rebeldía. Debido a su falta de concentración y deficiente retención, su desempeño en la escuela estaba por debajo del nivel de su edad. Jean insistía en que debía volver con su madre pues ésta la necesitaba.

Cuando llegó a terapia por primera vez, no parecía angustiada por dejar a sus tíos o por encontrarse a solas con un extraño. Al entrar a la oficina de la terapeuta, caminó por el cuarto inspeccionando cuidadosamente los libros, juguetes y demás mobiliario. Luego se sentó frente a la terapeuta, cruzó las piernas en forma sugestiva y

dijo: "¿Y ahora, en qué puedo servirle?". Con su estilo agresivo, Jean claramente trataba de defenderse de su miedo y ansiedad ante esta nueva situación con un adulto extraño. La terapeuta contestó, de manera amigable, que la reunión tenía como objetivo ayudarlo a adaptarse a vivir con sus tíos y a resolver lo que había sucedido en el pasado. La respuesta de la menor fue que no era necesario pues de todas maneras ella iba a volver a vivir con su mamá sin importar lo que tuviera que hacer para lograrlo. La terapeuta le dijo de manera firme pero amable que no podía volver a vivir con su mamá porque ahí habían abusado de ella. Después de este intercambio, le hizo varias preguntas sobre su escuela y sus amigos y Jean contestó con corrección.

Cuando la terapeuta se reunió con los tíos se enteró de que la conducta sádica y sexualmente provocadora de Jean se había agudizado. Temían que, si empeoraba, no podrían quedarse con ella. Desde su punto de vista, los berrinches a los tres años eran una cosa, pero ahora que tenía nueve temían que pudiera lastimar a otro niño. Agregaron que Jean era especialmente sádica con los más pequeños.

La terapeuta les sugirió realizar una evaluación completa del caso de Jean, incluyendo pruebas psicológicas, antes de formular un plan de tratamiento. Mientras tanto, les recomendó que no dejaran que jugara con otros niños sin ser supervisada. Solicitó su consentimiento para hablar a la escuela de Jean en relación con sus necesidades especiales, y de inmediato lo obtuvo.

Durante las pruebas psicológicas, Jean se portó hostil pero pudo realizar las tareas más concretas como las de las pruebas WISC-R y la Prueba Temática de Percepción (TAT). Las respuestas a la WISC-R mostraron que era una niña lista, muy enojada, que intentaba de-

fenderse de una ansiedad terrible y de impulsos agresivos debidos a la hipervigilancia y la atención compulsiva a los detalles. Su hostilidad, destinada a contener sus sentimientos de desamparo e inadecuación, se manifestó en una larga serie de críticas sobre las subpruebas de la WISC-R llamándolas "estúpidas, tontas", etcétera, aunque en casi todas ellas obtuvo buenos resultados.

Resultó claro que una de las formas en que Jean había logrado sobrevivir a las experiencias de abuso de su pasado había sido el desarrollo de un "velo de competencia" pseudomadura. Esto le permitía funcionar sorprendentemente bien, pero bajo esa superficie era de una gran fragilidad. Cuando sentía que su forma de protección era atacada, de inmediato contraatacaba. Y puesto que la prueba WISC-R le pareció una amenaza a su competencia o sus capacidades, Jean tenía que desafiar a la fuente de la amenaza.

Sus respuestas a la prueba TAT estuvieron plagadas de violencia. Muchas de las historias que contó tenían finales felices en los cuales gente superpoderosa lo graba vencer a los enemigos. Otras expresaban temas de gente que se reunía en bandas para vengarse de cosas malas que les habían hecho en el pasado. La prueba Rorschach fue demasiado para Jean y tuvo que ser detenida antes de llegar a su fin. Por ejemplo, una mancha de tinta evocaba una imagen que parecía salirse de la tarjeta y escurrirse por el escritorio. Jean respondió ante la mancha diciendo: "Huesos rotos y quemados... huesos rotos y sangre —no, hojas rotas y quemadas". Azotó la tarjeta sobre el escritorio y se puso a arrancarle hojas a una plancha que había ahí, mientras cantaba: "Huesos y hojas rotos". La terapeuta guardó la tarjeta y condujo a Jean a otra actividad neutral.

El pronóstico inicial no fue muy positivo. Sin embargo, la terapeuta pensó que trabajando con las defensas de la niña (esto es, su compulsividad y su deseo de ser competente) sería posible lograr cierto control sobre su actitud provocadora y hacerla más receptiva al tratamiento. Su actitud parecía un intento por ganar control del abuso que había sufrido haciendo una cierta réplica del mismo y le servía para identificar y describir aspectos de lo que le habían hecho.

La terapeuta consideró igualmente que un plan de tratamiento que estimulara la regresión o que hiciera salir su cólera sería un error en ese momento debido a varias razones. En primer lugar, Jean no tenía los cimientos de un niño normal y las experiencias de la primera infancia que, por ejemplo, tuvo Amy, de modo que la estructura de su ego era muy vulnerable. En segundo lugar, sus defensas eran apenas eficaces y frecuentemente perdía el control de maneras muy primitivas. En contraste, la conducta rígida y evasiva de Amy (aunque superficialmente parecía más patológica) de hecho contenía sus instintos destructivos primarios. Y dado que su superego estaba fundamentalmente sano, una vez que se sintió segura pudo usar el proceso de regresión como un medio para recuperar su nivel de desarrollo. Logrado esto, pudo pasar a expresar su coraje a través de una terapia constructiva que resultó realmente catártica. En el caso de Jean, una terapia de ese tipo, en la cual se impulsara la catarsis, no resultaría benéfica en ese momento sino que habría desatado una furia incontenible.

La meta inicial de la terapia de Jean fue apuntalar su ego mediante experiencias de construcción de éste, que ella pudiera aceptar, dado el negativo autoconcepto que tenía. También era importante trascender el patrón

de dominio-a-través-de-la-identificación-con-el-agresor, así que la terapeuta se reunió con una de sus maestras y con sus parientes para ponerse de acuerdo sobre un programa consistente de modificación de la conducta, basado en informes diarios enviados de la escuela a su casa.

La terapeuta ayudó a la profesora a comprender que, como resultado de la ansiedad de la niña, la duración de su atención a una cosa o actividad no correspondía con la de una menor normal de nueve años. Por tanto, su trabajo debía ser presentado en progresiones menores de las que se pedían a los otros niños de la clase. También recomendó que, dado el poco control que tenía sobre sus impulsos, Jean debía ser supervisada constantemente. Explicó que la niña probablemente necesitaría un programa como éste, con cambios periódicos, durante un año al menos.

La terapia empezó con dos sesiones semanales para Jean. La terapeuta las estructuró con cuidado para que pudieran servir, simultáneamente, para construir su ego y reforzar su superego. La hora de la terapia fue dividida en tres periodos de quince minutos con actividades diferentes y uno más para limpiar y ordenar. Las actividades iban desde armar rompecabezas hasta simples dibujos y juegos. Debían ser un reto suficiente para que Jean no se aburriera, pero suficientemente simples para no presionarla. Cuando su comportamiento era inadecuado, se detenía la actividad y, si hacía comentarios fuera de lugar, la conversación se cambiaba para enfocarla hacia: 1) la intención del mensaje que trataba de enviar y 2) cómo podía sentirse la otra persona cuando hacía ese tipo de comentarios. La terapeuta guiaba entonces la conversación hacia la forma en que Jean debía haberse sentido cuando abusaban de ella.

A medida que avanzaba la terapia paralelamente al programa escolar de modificación de la conducta y al trabajo de los padres adoptivos en el hogar, el comportamiento de Jean mejoró significativamente tanto en la escuela como en casa. Sin embargo, continuaba actuando con dramatismo y provocación ante la terapeuta. Resultó claro que separaba su mundo en "todo malo contra todo bueno". En ese contexto, empezaba a transferir la cólera que sentía contra su madre hacia la terapeuta, lo cual era un signo positivo. No obstante, tal división de la gente y las cosas en buenos y malos quería decir que estaba enfocando sus pensamientos negativos en una dirección con el fin de funcionar adecuadamente en otra. Visto más sutilmente, eso también quería decir que Jean empezaba a desarrollar suficiente fuerza de ego como para tolerar nuevos métodos en la terapia.

La menor aún conservaba una fantasía idealizada de su mamá y la expresión de coraje en su contra implicaba el riesgo de perder dicha fantasía. Con la mira de romper con esa visión de todo bueno o todo malo que tenía de las cosas, la terapeuta comenzó a contarle cuentos durante y entre las actividades de juegos. El tema era que a veces la gente buena comete errores y hace cosas malas, pero que debemos reconocer que hacer algo malo no hace que una persona sea completamente mala. Uno aún puede sentir simpatía por ella.

Al principio Jean desvalorizó las historias diciéndole que eran "bobas" pero comenzó a interesarse cuando la terapeuta hizo una serie sobre una niña, su mamá y los amigos de ésta. Pronto Jean comenzó a hacer preguntas sobre los personajes queriendo conocer más detalles. Después preguntó cómo actuarían éstos en tal o cual situación.

Un día, Jean pidió a la terapeuta que le contara sobre su propia infancia y sobre su escuela. Al hablar de la escuela, la terapeuta tuvo especial cuidado de mencio-

nar las cosas que no le salían bien y las ocasiones en que algo que había hecho la había metido en problemas, así como las cosas buenas que le sucedieron. Jean escuchó cuidadosamente por un rato y luego exclamó: "¿Tú te metiste en problemas?... ¡Tú no puedes haberte metido en problemas. Eres demasiado buena-buena, demasiado perfecta!" La terapeuta le aseguró que había hecho muchas cosas malas y cometido muchos errores. La niña la miraba fijamente con gran asombro. Era claro que algunas de sus viejas formas de ver las cosas se disolvían ante los ojos de la terapeuta. Y el momento fue uno de aquellos que hacen que tantos meses de lucha con una niñita difícil valgan la pena.

Jean hacía miles de preguntas sobre las experiencias infantiles de la terapeuta. Entonces le contaba sobre algo que ella había hecho o sentido y le preguntaba qué hubiera hecho o cómo se habría sentido ella. Las actividades estructuradas continuaron por un poco más de tiempo, pero era claro que Jean estaba lista para pasar a juegos expresivos y de proyección. Empezó jugando en una casa de muñecas en la cual obsesivamente representaba "fiestas nocturnas" llenas de hombres que daban miedo. Este juego la conflictuaba mucho y la hacía actuar dramáticamente. Por ejemplo, durante una sesión describió una escena en la que un hombre se encerró en el baño con ella; entonces corrió hacia el plato en el que la terapeuta tenía dulces, se llenó la boca de ellos y luego empezó a aventarlos por todo el cuarto.

La terapeuta caminó hacia ella y le quitó el plato de dulces, diciéndole que entendía que las muñecas le habían traído malos recuerdos, así que podía dejar de jugar. Le dijo que no tenía que enojarse o decir que algo le daba miedo o la espantaba para dejar de jugar. Le contó un cuento sobre una niñita que había sido tan lastimada que llegó al punto en el que le daba miedo tener miedo. Al

final del cuento, Jean se había calmado y pudo decirle que tenía muchísimo miedo. La terapia continuó progresando muy bien. En el momento en que escribimos esto Jean tiene trece años, viene una vez al mes y participa en un grupo de jovencitas.



cuatro

Tratamiento de la víctima adolescente



La adolescencia es una de las etapas más complejas y turbulentas de la vida que suele poner a prueba la paciencia de los adultos más pacientes. Cuando un trauma sexual se introduce en este tiempo naturalmente problemático, la situación puede plantear cuestiones especialmente difíciles al terapeuta.

En los casos de abuso sexual de adolescentes, el terapeuta generalmente tiene que ayudar al adolescente a resolver asuntos relacionados con su comprensión de sí mismo, la cual aún está en desarrollo, así como aquellos relacionados con su sexualidad, también en desarrollo. Más aún, las relaciones familiares del adolescente, lo mismo que sus relaciones con la gente de su edad, pueden verse seriamente afectadas por la agresión sexual.

En este capítulo se analiza, en primer lugar, uno de los asuntos más importantes enfrentados por los terapeutas que tratan a víctimas adolescentes de agresiones

sexuales.* Se continúa con una explicación del fenómeno llamado síndrome del trauma de la violación y su ciclo de recuperación. Después se estudian las cuestiones planteadas por la "violación secreta", caso en el que la víctima adolescente intenta ocultar la agresión a sus padres. Se consideran los diversos efectos de una agresión como primera experiencia sexual de la adolescente. Se analizan métodos de terapia para tratar a la víctima, a la luz de sus relaciones difíciles y a menudo llenas de coraje con su familia, y del impacto de una agresión de este tipo en el sistema familiar. Se presentan ejemplos de casos en los cuales la adolescente fue víctima de abuso en la infancia, incluyendo uno de violación multitudinaria.**

Visión de conjunto

El tratamiento de una víctima adolescente de violación suele ser difícil, pues hay varias razones que la hacen resistirse al mismo. La chica puede estar luchando por probarse a sí misma que "está bien" y que no ha sido lastimada emocionalmente por la agresión, de modo que rechaza, al igual que muchas víctimas adultas, la necesi-

* Su enfoque principal se dirige a la evaluación y el tratamiento de víctimas adolescentes del sexo femenino. Aunque también los varones sufren hostigamiento sexual, la gran mayoría de las víctimas son mujeres. En el capítulo 6 analizaremos el tratamiento y la evaluación de los casos de muchachos puberes los cuales también se aplican en gran medida a los adolescentes.

** En relación con los adolescentes, la violación es mucho más frecuente que el hostigamiento, por lo cual el primero es el término que usaremos para referirnos al tipo de agresión estudiado en este capítulo.

dad de ser ayudada. Otro asunto que puede retrasar el tratamiento es que una adolescente, después de ser violada, suele pasar por un período de conducta autodestructiva o de un profundo autodesprecio, lo cual hace imposible su participación en el proceso sano y constructivo de una psicoterapia. Más aún, ella pudo haber estado haciendo algo malo o prohibido que condujo a que fuera violada, y su sentimiento de culpa la hace resistirse al tratamiento.

Es posible que la familia también oponga resistencia. Llevados por sus deseos, muchos padres llegan a creer que la agresión en realidad no lastimó a su hija, así que evitan ver los síntomas del trauma. Quizá presienten excesiva atención al mal comportamiento de la muchacha, sin darse cuenta de que ha sido herida emocionalmente. Por desgracia, este enojo de los padres tan sólo hace que el sentimiento de culpa de ella se profundice, intensificando el potencial para actitudes autodestructivas.

Incluso en los casos en la conducta de las adolescentes condujo a la agresión, de cualquier manera se trata de víctimas que no estaban preparadas para tal terrible realidad. Por lo general, la agresión es completamente inesperada y la adolescente lucha con su terror y su incapacidad para creer lo que pasa, al tiempo que trata de lidiar con la realidad de vida-o-muerte del suceso. Los adultos cercanos deben controlar cuidadosamente su cólera o su frustración ante la actitud invitadora al peligro o rebelde que pudiera haber conducido a la violación, recordando siempre que aunque una adolescente clame que "lo sabe todo" y que tiene derecho a ser independiente, en realidad es todavía una niña que lucha por llegar a la edad adulta. La comunicación con una adolescente traumatizada puede requerir de un cui-

doso intento por acercarse a la niña lastimada y asustada que hay dentro, sin ofender sus esfuerzos por alcanzar la independencia.

Para lograr un tratamiento exitoso, tarea nada fácil, debe trabajarse con ambos aspectos de la psique adolescente.

Efectos posteriores a la violación

Algunas de las confusiones psicológicas generadas por la agresión sexual son tan fundamentales que normalmente no pensamos en ellas. Uno de los dilemas básicos de este tipo es la pérdida de los límites territoriales. Una agresión sexual es una agresión a la última de las fronteras territoriales, la piel. Sólo hay tres situaciones en las cuales nuestros cuerpos pueden ser penetrados en contra de nuestra voluntad: cuando nos disparan, nos apuñalan o nos violan. La penetración involuntaria de esa frontera tan primitiva provoca en la víctima la sensación de no estar entera. Es común que experimente una extraña fragmentación personal y desorientación, originadas por la invasión temporal de la frontera de la piel.

Tal sentimiento puede ser especialmente devastador en una adolescente que aún está en el proceso de definir quién es y de individualizarse respecto de sus padres. A esa edad se tiene una enorme necesidad de sentirse una persona completa y separada, y el rompimiento de esa percepción puede causar serias repercusiones en el desarrollo posterior. En consecuencia, desde el inicio del tratamiento, el terapeuta debe trabajar para ayudarla a reconstruir un sano sentido de las fronteras de su persona y de su integridad.

Otro dilema psicológico de gran importancia que la violación pone de relieve es la percepción de la víctima sobre su propia capacidad para controlar su entorno, proceso que comienza alrededor de los dos años de edad, cuando un niño aprende la palabra "no". Este aprendizaje de cuánto control se tiene sobre el entorno se halla en total funcionamiento durante la adolescencia. Y, de pronto, la jovencita es confrontada con una situación en la cual se halla completamente desprovista de poder para evitar que suceda una cosa así. Tal experiencia de total desamparo puede ser devastadora en quien aún está luchando por descubrir sus posibilidades de mando sobre diversos aspectos de su vida.

El tercer dilema que surge del trauma de la violación se relaciona con la confianza básica de la víctima en los demás. Durante su crecimiento, la mayoría de los niños asumen que los demás no les harán daño. Los adolescentes, en especial, están convencidos de que las advertencias de sus padres sobre los peligros del mundo son estupideces y que, no importa lo que pase, ellos "pueden controlar la situación".

El cuarto aspecto es que la identidad sexual en desarrollo de la adolescente y el papel que el sexo jugará en su vida pueden verse muy afectados por una violación. A diferencia de la víctima adulta, sexualmente madura, que en la mayoría de los casos puede distinguir entre la violación y el sexo compartido de mutuo acuerdo, la violación de una adolescente puede ser su primera experiencia sexual. En consecuencia, más tarde puede confundir el sexo con la violación.

Finalmente, otra confusión con la cual la adolescente puede tener que luchar es la pregunta: "¿Por qué me pasó a mí una cosa semejante?". Los adolescentes son narcisistas y egocéntricos por naturaleza y tienden a ver

la causalidad en relación con ellos mismos. Por tanto, son vulnerables a la autculpabilización durante esa etapa del desarrollo. El terapeuta debe tener presente que las jóvenes víctimas tienden a interiorizar la violación o a autoculparse de ella mucho más que los adultos. A menudo una víctima adolescente llega a la conclusión de que fue violada porque era "mala" o "buena para nada"; o bien, que fue castigada por haber hecho algo malo; o que, debido a la violación, ha perdido todo su valor como ser humano. El terapeuta debe explorar todo el tema de la causalidad y la culpa con ella para asegurarse de que no ha incorporado la agresión de una manera que la conduzca a creer que es mala o que no vale nada. En algunos casos, quizá tenga que dedicar un buen tiempo a esto.

El terapeuta debe recordar que, aun en medio de la turbulencia de sus vidas, los adolescentes tienen un cierto orden. Pero, después de una agresión sexual, la víctima tiene que tratar de entender un evento azaroso y violento. El azar que la vida implica es ya difícil de describir para un adulto pero es aun más confuso para un adolescente, menos capacitado para hacer frente a un concepto tan abstracto. Y la grandiosidad natural de una adolescente, que la hace ver su mundo en términos relativos a ella misma, limita su capacidad para poner su papel dentro de la violación en sus justas proporciones.

El terapeuta también debe considerar que, en caso de que la adolescente haya sido víctima de abuso en su infancia, esta segunda agresión puede reforzar su autopercepción de víctima, de objeto a la merced de ese tipo de eventos. Al igual que Peters (1976), Browne y Finkelhor (1986) y Yates (1987), pensamos que los adolescentes que sufrieron abuso sexual siendo niños están en mayor riesgo de ser nuevamente agredidos que quienes no pasaron por ese trance. En estos casos, el terapeuta

debe averiguar si la víctima adolescente estaba o no re-presentando de nuevo una situación pasada, con la fantasía inconsciente de que en esta ocasión no habría un trauma sexual como resultado.

Síndrome del trauma de violación y ciclo de recuperación

El síndrome del trauma de violación y el ciclo de recuperación son procesos que ayudan a la psique, durante el trauma mismo y posteriormente, a volver a un nivel estable de funcionamiento. Estos procesos son fundamentalmente parecidos al proceso de duelo descrito por Lindemann (1944). Durante la terapia, el terapeuta debe facilitar a la adolescente su progresión a través de la respuesta al trauma y el ciclo de recuperación; a la vez, ayudar a la familia a entender el proceso y a brindarle guía y apoyo emocional. Si la víctima adolescente recibe el tratamiento y el apoyo que necesita, puede curar las profundas cicatrices emocionales provocadas por heridas psicológicas no atendidas que a menudo son el daño más serio causado por la agresión sexual.

Componentes específicos del síndrome y etapas del ciclo

Por lo general, la víctima de violación está completamente impreparada para enfrentar la agresión. Ésta la toma por sorpresa y, durante unos momentos, su mente trata de comprender el significado de lo que está sucediéndole. Se llena de pensamientos como: "Esto debe ser un sue-

ño", "Esto es una mala broma", o "Esto no puede ser real". Cuando la cruda realidad ("¡Dios mío, es cierto!") le llega, puede invadirla momentáneamente la histeria, pero pronto su principal objetivo es la supervivencia: "Haré lo que quiera, pero no me mate".

En la figura 1 se muestran las etapas de la respuesta al trauma y del ciclo de recuperación.

Respuesta al trauma de la violación

La agresión

Incredulidad

Toma de conciencia de la realidad de la agresión

Estado consciente de supervivencia

(Fin de la agresión o escape)

Ciclo de recuperación posterior al trauma

Shock

Negación de lo ocurrido

Depresión

Cambios de estado de ánimo

Cólera

Reflexión filosófica

Permitirse descansar

Figura 1. Adaptada de Everstine, D. S. y Everstine, L. *Personas en crisis*. México, D. F., Editorial Pax, 1993.

Cuando la víctima comprende lo que le está sucediendo, entra en un estado mental de supervivencia (Everstine y Everstine, 1983, 1993), un estado extrañamente frío

y sin emociones por el que pasan quienes luchan por su vida. Durante este tiempo, sus emociones se mantienen al margen para poder atender a sus necesidades más inmediatas de supervivencia. También puede haber una distorsión sensorial y en la percepción del tiempo. Puede parecer como si las cosas sucedieran en cámara lenta durante la agresión. Si la víctima lucha o es herida, probablemente no sienta el dolor en toda su intensidad, pues se halla en un estado disociativo.

Cuando la víctima es liberada, generalmente entra en estado de shock. Algunas presentan un cuadro histérico o una reacción sumamente emocional pero, según nuestra experiencia, la mayoría de las adolescentes víctimas de violación permanecen en shock por un periodo de 24 horas hasta tres o cuatro días. Mientras se encuentran en esa fase, su afectividad puede ser plana. Su aspecto es de atolondramiento, confusión o incluso de hartazgo. Ese tipo de conducta puede ser fácilmente malinterpretado por un observador no entrenado como si no hubieran sido afectadas o como si no les importara la agresión. A menudo, padres bien intencionados que desean ver a su hija "en buen estado" malinterpretan la actitud desaparecida de la adolescente; o es posible que padres que de por sí ya estaban enojados por la conducta de su hija malinterpreten el estado de shock como una prueba de su irresponsabilidad. En ambos casos, un terapeuta debe explicarles cuidadosamente que la muchacha no es en absoluto indiferente a lo que sucedió, así como los componentes clínicos de esta etapa.

Cuando la víctima sale del shock, durante cierto tiempo entra en un estado de negación en el cual trata de mostrar que la violación no ha cambiado o afectado seriamente su vida. Durante ésta, la muchacha puede hacer afirmaciones como: "No le permitiré que me dañe aún

más" o "Yo puedo resolver el asunto". Lo adecuado es que el terapeuta tome una posición de apoyo, pero que al mismo tiempo le ayude a enfrentar el hecho de que algo serio realmente ocurrió, para que pueda proceder con el proceso de recuperación en vez de mantenerse rígida en su negación. Este estado puede durar de unos días hasta varias semanas.

Enseguida, la víctima suele entrar en una etapa de depresión, en la cual la cólera, resultado de la agresión, se vuelca hacia el interior. La gente cercana a ella tiene considerables dificultades para entender por qué no expresa una cólera profunda después del ataque. Algunas víctimas sí logran expresar su cólera de inmediato, pero la mayoría no. Sus seres queridos, que frecuentemente se encolerizan por la agresión, pueden malinterpretar esa falta de expresión del enojo y reaccionar con sospecha y desconfianza. Esto puede complicarse aún más porque durante esta depresión algunas adolescentes pasan por una fase de promiscuidad o conducta autodestructiva que en realidad es resultado de su estado de ánimo y de la sensación de haber perdido su valor como seres humanos. Algunas llegan a pensar que han sido ensuciadas al punto de ya no valer nada. Otras experimentan desórdenes en la alimentación o, simplemente, suben de peso sin explicación clara como expresión de sus conflictos sobre su identidad sexual. Si una adolescente pasa por una fase autodestructiva o de autodesprecio, sus padres necesitarán apoyo del terapeuta para asegurar que la forma en que enfrenten esa actitud no intensifique los sentimientos de poca valía.

Ahora bien, no todas las víctimas adolescentes de violación responden con una conducta promiscua o autodestructiva. Aunque hemos comprobado que la mayoría pasa por una fase de conducta de alguna manera distorsionada, hay jovencitas que tan sólo se comportan

con cierto retraimiento y silencio. Tal vez evitarán el contacto social con muchachos y, en casos extremos, pueden desarrollar fobia a la escuela o bien, agorafobia. Desgraciadamente, en el caso de muchas de las chicas que responden a la agresión de manera silenciosa, frecuentemente se considera que no necesitan atención psicológica. Esto puede ocurrir en una familia en la cual los deseos de los padres de que su hija se recupere rápidamente, nublan su visión y les impiden ver su sufrimiento. En ciertos casos, a los padres también les resulta más fácil evitar lidiar con el desarrollo de la sexualidad de su hija, pues se trata de un tema con el cual tienen grandes dificultades. De hecho, el retraimiento de la hija de sus contactos sociales (de muchacha a muchacho) puede ser un alivio para ellos o, como Burgess y Holmstrom dicen con claridad:

Uno de los asuntos que los padres deben aprender a enfrentar es la sexualidad de sus hijos. Con una violación aparece una confirmación real de que su hija ha estado expuesta a una situación sexual; y es importante saber cómo se le trata en relación con ese conocimiento. Por ejemplo, ¿acaso los padres: 1) ignoran el hecho y no mencionan la violación; 2) se vuelven sobreprotectores de la hija en relaciones normales de muchachos con muchachas; o 3) niegan el impacto de la situación? (1978, p. 78).

A medida que la fase depresiva del ciclo de recuperación se desvanece, la víctima puede pasar por un periodo de cambios repentinos de estado de ánimo. Esta fase puede causar miedo a la víctima pues en ella de pronto tiene percepciones de lo que era su persona antes de la agresión y ante cualquier nimiedad vuelve nuevamente a la depresión. La muchacha requiere la reconfirmación del

terapeuta de que esto no es más que otra etapa en el ciclo de recuperación posterior al trauma y que pronto pasará.

Después del periodo de cambios repentinos de estado de ánimo, llega el de la cólera intensa. Si la etapa previa de depresión fue bien trabajada en la terapia, esa cólera se dirigirá a un objeto apropiado, básicamente, el agresor. Sin embargo, cuando no hay una base clínica sólida para dirigir ese enojo, pueden surgir problemas en algunas de las relaciones con hombres más importantes en la vida de la muchacha. Por ejemplo, puede transferir su enojo en contra de hombres "seguros", como su padre, su novio o su hermano.

Es muy probable que las personas cercanas a la víctima también necesiten apoyo durante esta fase de recuperación. Debido al aparente enojo contra todo lo que la rodea, la gente, especialmente los hombres, tienen dificultades para comprender a la víctima. La familia necesita ser ayudada para no personalizar ese enojo y para comprender su verdadero sentido: la expresión simbólica de la cólera de la víctima en contra de su agresor. Los familiares pueden sentirse injustamente acusados cuando la cólera de la víctima aparece largo tiempo después de la violación, en muchos casos, cuando el enojo de la familia ya es menor. A partir de pensamientos llenos de deseos, es posible que hayan subestimado la duración del trauma.

Las etapas finales de reflexión filosófica y descanso, en las cuales la víctima asume qué tanto su vida ha sido cambiada por la agresión sufrida y cómo continuará en adelante, son frecuentemente difíciles de completar durante la adolescencia. La razón es que la tarea requiere manejar conceptos filosóficos abstractos que los adolescentes no son capaces de comprender racionalmente. El terapeuta debe darse cuenta de que los adolescentes viven en un mundo básicamente gobernado por sus emo-

ciones. Ven las cosas casi siempre en términos del concepto de sí mismos que aún está en formación, esto es, de manera experimental. A pesar de que muchos adolescentes parecen muy maduros en su forma de comprender algunos conceptos filosóficos, esto puede ser sólo palabrería si el adolescente no los ha interiorizado completamente. Él generalmente aprende haciendo las cosas, mientras que el adulto tiende a conceptualizar antes de actuar. Así que no es buena idea que el terapeuta proyecte un proceso cognoscitivo propio de adultos a una víctima adolescente, pues ésta tenderá a conceptualizar estas fases de reflexión filosófica en el proceso del trauma de una manera superficial; y, en ese caso, se trata de un cierre temporal y no definitivo del proceso de recuperación. Por ejemplo, pocas muchachas de 16 años pueden comprender cabalmente por qué pasaron por un período de actitud promiscua después de la violación, pero más tarde, a los 20 años, pueden entender con mayor idea su comportamiento y asumirlo más adecuadamente.

Lo significativo de estas reacciones retardadas es que una víctima adolescente puede necesitar volver a la terapia durante un breve período al acercarse a los veinte años o al rebasarlos. Si el terapeuta lo considera necesario, podrá ayudarlo a pasar por un ciclo de recuperación en su nuevo nivel de comprensión. Además, debe dejarse abierta la puerta para que la adolescente vuelva más tarde a la terapia si lo necesita.

La violación secreta

Aun cuando se dice que aproximadamente la mitad de las violaciones se cometen en contra de adolescentes, hemos observado que éstas son quienes menos tienden a

denunciar lo sucedido ante las autoridades. Tristemente, muchas no dicen a sus padres o parientes lo que les ha sucedido. El trance por el que pasa una víctima de violación durante la respuesta al trauma y el ciclo de recuperación, es especialmente trágico cuando nadie a su alrededor sabe lo que le ha pasado. Muchas violaciones quedan sin detectar durante largos períodos y, en consecuencia, los padres pueden malinterpretar la conducta extraña de su hija. El terapeuta debe considerar que algunos de sus casos de adolescentes —que han llegado a tratamiento por una enorme diversidad de razones— pueden ser ejemplos de este tipo de violación "secreta" o "silenciosa".

Algunos de los síntomas que presentan las víctimas adolescentes de violación son, de acuerdo con Hilberman (1976) y Everstine y Everstine (1983), los siguientes:

1. cambio repentino en la personalidad
2. rápido descenso en el nivel de desempeño escolar
3. retraimiento de la escuela o las actividades sociales
4. conducta promiscua evidente
5. conducta fóbica repentina
6. retraimiento de las actividades sociales
7. conducta obviamente autodestructiva o toma excesiva de riesgos
8. abuso de drogas
9. problemas con la alimentación como la bulimia o la anorexia
10. repentino e inexplicable aislamiento de parientes y compañeros

Cualquiera de estos comportamientos debe ser visto como un grito de auxilio por parte de una adolescente. El terapeuta debe considerar que muchas adolescentes no se sienten en confianza para decirle a un extraño que han sido violadas. De tal forma, si la respuesta inicial de la muchacha es negativa o evasiva, no debe asumir que es definitivamente cierta o completa hasta que no logre establecer una buena relación con la paciente. En estos casos, el o la terapeuta puede hacer comentarios de apariencia neutral: "Apenas me estás conociendo y estoy seguro de que no te sientes en confianza para decirme algunas cosas ahora. Más adelante, cuando nos conozcamos mejor, tal vez tengas ganas de hablarme de ellas".

En general, es importante que los psicoterapeutas reflexionen sobre el hecho de que miles de víctimas adolescentes de agresiones sexuales "secretas" o "silenciosas", no son reconocidas como víctimas. En cambio, se les etiqueta erróneamente de delincuentes, promiscuas, malas o "enfermas".

Tratamiento de la víctima adolescente de violación

La familia

Al igual que en el caso de una víctima de violación en edad adulta, la respuesta de las personas emocionalmente cercanas a ellas puede contribuir a determinar cuán bien se recupere una adolescente después de una agresión sexual. Vale la pena subrayar la necesidad de que los padres actúen de manera apropiada. Efectivamente, en

muchos casos la actitud excesivamente extrovertida o arriesgada por parte de la adolescente puede haber provocado directa o indirectamente la agresión. Aun así, la joven probablemente no tenía ni la menor idea de que su comportamiento provocaría una violación, aunque sus padres hubieran tratado de prevenirla respecto de los peligros.

Por desgracia, los padres que ya estaban enojados con su hija por alguna razón pueden imprudentemente tomar la posición de que ella merece haber sido violada por su comportamiento reciente. Esta falta de sensibilidad es doblemente desafortunada; en primer lugar, porque asume que la adolescente era capaz de comprender que su conducta provocaría la violación; y en segundo lugar, porque una chica con actitud en exceso extrovertida puede haber resultado aún más traumatizada por la violación pues su actitud arriesgada fue provocada por problemas previos en la familia. La víctima ha tenido que soportar una espantosa lección y no necesita que se lo reiteren aquellos de quienes necesita amor y respaldo.

Se recomienda que el terapeuta se reúna con los padres de la víctima tan pronto como sea posible dentro del proceso de tratamiento. Se debe tener en mente que también ellos son víctimas de la agresión y tal vez necesiten ayuda para asumir y comprender lo que ha sucedido dentro de su familia. Algunas de estas reuniones pueden hacerse sin la presencia de la hija pues un ambiente privado puede propiciar que expresen sus sentimientos sobre lo sucedido; además, es mejor que algunos de esos sentimientos no se exterioricen frente a la víctima.

En estas sesiones, el terapeuta puede revisar temas como: 1) los sentimientos y prejuicios de los padres en relación con la violación; 2) los sentimientos de desamparo o fracaso ante el hecho de no haber podido prote-

ger correctamente a su hija; 3) en qué forma la conducta de ella pudo haber provocado la violación; 4) cómo deben discutir los asuntos importantes con su hija; 5. la sexualidad de la chica; 6) cómo hablar del asunto de la violación—si es apropiado hacerlo—con los hermanos y hermanas de la víctima. Todos son temas difíciles para los cuales muchos padres necesitan ayuda del terapeuta.

A pesar de los muchos esfuerzos positivos para comprender el fenómeno, la violación continúa siendo un problema profundamente malentendido sobre el cual mucha gente tiene aún ideas estereotipadas. El terapeuta debe auxiliar a los padres de la víctima para que comprendan que su hija tal vez necesite aprender a ser más cuidadosa y responsable de sus actos; sin embargo, eso no puede lograrse con explosiones de enojo. Y no importa cuánto quieran proteger a su hija, no pueden protegerla siempre de las cosas difíciles de la vida.

El sexo es un tema difícil de tratar para la mayoría de la gente y muchos padres temen el día en que tendrán que "hablar del asunto" con sus hijos adolescentes. Ante todo, la violación de una hija los obliga a tratar el tema de su sexualidad y, dado que la violación puede haber sido la primera o una de sus primeras experiencias sexuales, es fundamental que se le ayude a separar el significado de la agresión del sexo compartido con el consentimiento de ambos participantes. Esto no siempre es una tarea simple, pero puede ser facilitada de manera importante si los padres son receptivos al escuchar los sentimientos de su hija al respecto. La actitud de "Hagamos-como-que-nada-ha-pasado", simplemente no sirve de nada.

Con el fin de que los padres puedan comprender mejor la conducta de su hija después de la agresión, es importante que reciban una explicación del síndrome del trauma por violación y del ciclo de recuperación. Por úl-

timo, se les debe dar una estimación del tiempo necesario aproximado para que la víctima se recupere, para que no crean, equivocadamente, que su hija debe volver a la normalidad tan pronto como se curen los moretones. Nuestra experiencia indica que se requiere un mínimo de seis meses de tratamiento y, en algunos casos, varios años de terapia.

Fuentes de complicación

Algunos factores pueden complicar el tratamiento de las víctimas de violación adolescentes. Primero, la muchacha puede haber conocido antes a su agresor o agresores, por ejemplo, es posible que vayan a la misma escuela. Si denuncia la violación, puede ser objeto de chismes crueles o amenazas por parte del agresor o los amigos de éste. No debemos olvidar que durante el proceso legal un agresor acusado puede tranquilamente estar libre y seguir asistiendo a la escuela. Segundo, si la víctima no denuncia el crimen o no se da seguimiento legal al caso, puede verse obligada a enfrentar a su agresor o agresores cotidianamente. Cualquiera de estas situaciones puede ser espantosamente dolorosa para ella. El terapeuta debe estar dispuesto a ayudarle a decidir lo que debe hacer en tales situaciones.

La muchacha puede haber sido víctima de una violación multitudinaria y conocer o no a los agresores. Las cosas se complican porque posiblemente es sólo una de varias víctimas a las que puede o no conocer. En nuestra opinión, y de acuerdo con Burgess y Holmstrom (1978, p. 67), cada agresión exige atención clínica por separado. El terapeuta nunca debe tratar una violación multitudinaria como si fuera un solo evento para así no tener que escuchar los detalles difíciles de cada agresión. Más

bien, debe tratar de concientizar sus sentimientos personales al respecto y cuidarse de no silenciar involuntariamente a la víctima ni evitar que trabaje en comprender sus sentimientos respecto de cada agresor y cada violación. En caso de que haya más de una víctima de una violación multitudinaria, los problemas de interacción e interrelación se multiplican. En tales casos, cada víctima deberá trabajar con sus sentimientos en relación con cada una de las otras víctimas, tanto durante como después de la violación, en caso de que hayan sido sus amigos anteriormente.

Escuchar sin juzgar

El terapeuta nunca debe presionar agresivamente para obtener detalles de una violación, con el fin de que no se le malinterprete como morboso o irrespetuoso de las fronteras personales de la muchacha. En cambio, debe transmitir su preocupación y su deseo de conocer los detalles, pensando siempre que hay una gran diferencia entre animar y presionar. Debido al daño profundo provocado por la violación en el sentimiento de integridad de la víctima, es vital que el terapeuta le comunique un enorme respeto hacia esas fronteras ya lastimadas.

La mejor estrategia consiste en asumir un papel no enjuiciante que apoye el proceso de enfrentamiento y adaptación y que no apoye los mecanismos patológicos de tolerancia. Si la víctima adolescente no es capaz de admitir ante el terapeuta o ante sí misma cuán traumatizada ha sido por la violación, se recomienda no desafiarse su actitud de "Estoy-muy-bien, -la-violación-no-me-afectó".

Cuestionar esa afirmación podría ser tomado por la víctima como una segunda agresión. Cualquiera afirmación respecto de la seriedad de la situación debe ser

cuidadosamente meditada pues, de otra manera, puede hacer que la víctima, ya de por sí suficientemente atormentada, abandone la relación terapéutica. O, tal como lo dijera una joven cliente: "Gracias por no decirme cuán confundida estaba. Si usted lo hubiera dicho entonces (justo después de que fue violada), jamás hubiera vuelto a verlo. Lo habría odiado". Incluso a los 15 años, esa muchacha sabía cuán importante fue que el terapeuta respetara sus fronteras.

Otro asunto delicado con el cual hay que lidiar a lo largo de la terapia es el concerniente a las precauciones que la víctima debe tener para no volver a ser violada. De cualquier modo, el tema debe ser presentado de tal manera que no implique culpabilidad de parte de la muchacha en la violación ya ocurrida. Más bien, se puede enmarcar el asunto de la responsabilidad y la culpabilidad diciéndole que debe valorarse a sí misma y, con base en ello, cuidarse. Un cambio tan radical en su marco de referencia puede tomarle mucho tiempo a una adolescente, si ésta ya ha interiorizado la idea de que es una víctima o una persona que no vale nada. De ser así, el terapeuta debe entremezclar información que contradiga semejante autoimagen tantas veces como le sea posible a lo largo de (toda) la terapia.

Conducta en exceso extrovertida

Algunas víctimas de violación adolescentes tienden a sexualizar sus relaciones con los muchachos o con los hombres, generalmente de forma por completo inadecuada. Esto suele suceder porque la joven se ha colocado en el papel de víctima y porque su autoestima ha llegado a niveles tan bajos que percibe que su único valor ante los hombres es sexual. Desgraciadamente, esta inapropiada

actitud seductora se autoafirma cuando los muchachos o los hombres no saben qué le ha pasado a la chica y malinterpretan lo que está haciendo.

Cuando se trata a una joven con esta conducta, el terapeuta debe tener cuidado de que no se sienta crítica; debe enfocar en la forma en que se ve a sí misma. Durante el proceso, puede tratar de darle información para que ella empiece a construir una auto-imagen más sana sobre la cual basar una conducta futura adecuada.

Cuando se reviven traumas no resueltos

Al entrar en la adolescencia, los muchachos pasan por un desarrollo cognoscitivo muy grande, de modo que muchos conceptos que antes estaban fuera de su comprensión, de pronto aparecen perfectamente claros. Cuando esto sucede, cualquier trauma sexual previo que no había sido revelado o resuelto puede de pronto revivir para el adolescente. En otras palabras, un niño de seis años quizá no comprende el completo significado sexual o social de haber sido hostigado sexualmente, pero a los catorce años sí podrá. Los efectos de un anterior abuso sexual pueden de pronto volver a la superficie, a menudo en la forma de cambios bruscos de personalidad o conducta. De hecho, es más probable que un adolescente revele sus traumas sexuales pasados a través de su comportamiento que diciéndoselo a un adulto. Las cosas empeoran porque muchos adolescentes que han sufrido de traumas no resueltos en la infancia tal vez no sepan por qué su comportamiento ha cambiado; o, acaso ni siquiera se den cuenta de que ha cambiado. Pueden proyectar su desorden interno en los adultos que les rodean y percibir que los conflictos implicados son causados por la injusticia o incomprensión de esos adultos. Cuando un sistema fami-

liar llega a ese triste estado, la conflictiva interacción padres-hijos puede perpetuarse, a pesar de que cada una de las partes crea que tan sólo responde a las malas actitudes del otro.

Debido a esta dinámica potencial, los terapeutas deben prestar particular atención a los casos en que sus clientes adolescentes muestran cambios conductuales repentinos, especialmente durante el inicio de la adolescencia. Los síntomas de un trauma sexual de la infancia que ha quedado sin resolver son similares a los anotados en relación con la violación "secreta" o "silenciosa": descenso inexplicable del desempeño escolar, retraimiento de la escuela o de otras actividades sociales, conducta promiscua o autodestructiva, abuso de sustancias energéticas, aislamiento del resto de la familia, intentos de escapar de casa o manifestaciones de desórdenes en la alimentación —sobre todo exesobulímicos. Hemos encontrado una importante cantidad de casos en los cuales un desorden en la alimentación surgió en la adolescencia pudo rastrearse hasta descubrir una agresión sexual durante la infancia.

Los traumas no resueltos pueden salir a la superficie lentamente, pero hemos visto que los síntomas evidentes lo hacen con bastante rapidez, generalmente en la época en que en la adolescente se despierta el interés por el sexo opuesto, lo mismo que por su floreciente desarrollo sexual. Como dijera una muchacha de 16 años: "No sé qué me pasó al cumplir 14 años. Algo tronó y ya nada me importaba. Estaba enojada con todos y me odiaba a mí misma."

Cuando esta joven empezó su terapia a los 16 años debido a su conducta incontrolable, al abuso de sustancias enervantes y a dos intentos de suicidio, no mencionó que un grupo de adolescentes la había violado cuando

tenía nueve años. Al revelarse este evento mientras se hacía historia clínica (y después de una exploración considerable), ella lo mencionó sin emoción y de inmediato agregó que no dijo nada a sus padres en ese momento (ni después) porque tenía miedo de los muchachos. Continuó diciendo que de todos modos "no era para tanto", pues a los nueve años en realidad no sabía lo que le estaba pasando. Esa actitud de desapego era obviamente una maniobra defensiva para ayudarlo a soportar un hecho terrible y doloroso.

Hizo falta mucho trabajo para darle confianza, para que por fin mostrara sus verdaderos sentimientos acerca de la agresión, especialmente la sensación de que algo en ella hizo que los muchachos la escogieran para violarla. Se había metido a un garaje con ellos porque le halagaba que niños mayores quisieran jugar con ella. Más adelante, cuando su madre habló con ella de sexo por primera vez, le dijo que sólo las chicas "malas" tienen relaciones sexuales con hombres con quienes no están casadas. Esa desafortunada, aunque bien intencionada, plática se realizó sólo unos meses después de la violación e impidió que la chica dijera a su mamá lo que le había sucedido pues creyó que pensaría que era mala. Cuando la información fue finalmente revelada, la actitud tan extrovertida de la muchacha pudo considerarse bajo una nueva luz y el terapeuta pudo trabajar con ella y con su familia en la solución del trauma.

Estudio de caso

A continuación presentamos el estudio de un caso en que el abuso sexual sufrido por una muchacha durante su infancia permaneció oculto un largo tiempo. Jackie tenía 16 años y medio cuando fue llevada a terapia y dijo que

no sabía cuándo habían abusado sexualmente de ella por primera vez; pensaba que pudo haber sido a los dos o tres años. En todo caso, recordaba que el abuso sexual formaba parte de su vida desde siempre. No se dio cuenta de que había algo "malo" o diferente en su experiencia hasta que cumplió once o doce años; entonces "simplemente empezó a odiar a todo el mundo", sobre todo a sí misma. Cuando comenzó la terapia tenía un sobrepeso al menos de quince kilos.

Aun cuando Jackie era una chica lista, sus calificaciones habían sido malas en la primaria, apenas pudo pasar la secundaria y, ahora en la preparatoria, estaba casi reprobada en la mayoría de las materias. Faltaba mucho a clases y, cuando asistía, se la pasaba interrumpiendo y discutiendo.

Según la chica, empezó a consumir drogas en la primaria y ya en secundaria tomaba y usaba cocaína, marihuana y anfetaminas con regularidad. Tenía pocas amigas pero no era realmente cercana a ninguna. Era famosa por su carácter explosivo y en varias ocasiones había sido expulsada de la escuela por pelear. Sus relaciones con los muchachos eran extrañas; raras veces salía y cuando lo hacía, generalmente era con chicos más jóvenes o menos maduros que ella. De cualquier modo, decía preferir la amistad de los hombres a la de las chicas pues le parecían más confiables e interesantes, y disfrutaba más de su compañía.

La relación de Jackie con su familia era muy tensa. Su madre, Corinne, sacudía la cabeza en señal de deseperación cuando la comparaba con sus otros dos hijos, buenos estudiantes en la universidad. Decía que ninguno había dado problemas excepto las típicas "cosas de chicos". De acuerdo con ella, Jackie había sido una niña feliz hasta aproximadamente los tres años de edad, época

en la que comenzó a dar problemas. Al principio Corinne pensó que pasaba por "una etapa difícil"; pero, al no cesar los berrinches ni la conducta desobediente, simplemente se resignó a la idea de que sus dos primeros hijos habían sido niños fáciles, mientras que ésta era una niña difícil por naturaleza.

Larry, el padre de Jackie, comentó que su relación con su hija era mejor y que la entendía hasta cierto punto porque él había tenido mal carácter cuando era joven y tuvo que aprender a controlarse. Pero incluso él admitía no estar realmente cerca de su hija y, cuando ella estaba "de malas", simplemente se mantenía a distancia.

Jackie hablaba con bastante desapego cuando se refería a su madre y su hermana mayor, describiéndolas como "simplicas" y "putas buenas" que pasaban su tiempo de compras y mirándose en el espejo. Su relación con su hermano era mejor y, aunque no eran muy cercanos, a ella le gustaba hacer cosas con él cuando regresaba de la universidad.

El abuso sexual del que Jackie había sido víctima desde su infancia no salió a la luz sino hasta cumplir los dieciséis años. Una noche, mientras visitaba a una amiga, las dos se emborracharon y decidieron contarse sus "peores secretos". Con tono indiferente, Jackie le dijo que desde hacía años tenía relaciones sexuales con uno de los mejores amigos de su papá. Con el paso de los días, la amiga fue preocupándose cada vez más por lo que Jackie le había contado. Finalmente se lo dijo a su madre, quien, a su vez, se preocupó y decidió llamar a la mamá de Jackie. Al escucharlo, Corinne supo que, por horrible que sonara, la historia era verdad. El asunto se confirmó cuando la hermana de Jackie, presente durante la llamada, dijo que ese hombre había tratado de molestarla cuando tenía cerca de ocho años, pero que ella le dijo que si no la dejaba, lo

acusaría. Ambas decidieron esperar a que el padre volviera del trabajo para decirse lo; después decidieron hablar con Jackie y denunciar todo a la policía.

Cuando los padres de Jackie hablaron con ella se sorprendieron y se sintieron ofendidos porque su hija estuvo relativamente tranquila e incluso un poco hostil hacia ellos. Jackie les dijo que tal vez nada hubiera pasado si se hubieran ocupado más de ella cuando era pequeña en vez de pasársela trabajando en el negocio dejándola con el hombre que había abusado de ella y con la esposa de éste.

Cuando el amigo del padre fue acusado del abuso, primero negó todo vehementemente diciendo que Jackie era una "delincuente ligeramente retrasada". Más tarde, cuando otras muchachas de la colonia de quienes también había abusado hablaron del asunto, argumentó solo contendere ante los cargos criminales.

Jackie fue enviada a nuestra clínica por el fiscal encargado del caso. Cuando empezó la terapia, estaba enojada y sospechaba de todo. Iniciaba las sesiones diciendo que no tenía absolutamente nada que decir a otro estúpido adulto, y luego hablaba sin parar durante toda la sesión. Debido a su actitud enojada y defensiva, la terapeuta decidió reunirse por separado con la chica y con sus papás con el fin de poder hablar mejor de los asuntos relacionados con la paternidad.

Los papás de Jackie inocentemente esperaban que la chica simplemente "saliera" de todo el asunto ahora que todos sabían lo que había ocurrido e intentaban hacer algo al respecto. Se sentían atacados en lo personal al ver que el comportamiento de Jackie no mejoraba rápidamente. De hecho, éste empeoró pues ella se sentía expuesta, vulnerable y confundida desde que se supo del abuso.

El primer paso que dio la terapeuta en relación con los padres fue ayudarles a formular expectativas razonables sobre lo que podía lograr una chica que había pasado por tanto. Aunque quisieran, simplemente no debían esperar de Jackie lo mismo que de sus otros dos hijos a la misma edad. Les hizo saber que necesitaría varios años para recuperarse y alcanzar su nivel normal de desarrollo. Incluso les avisó que probablemente serían el blanco de la futura cólera de la joven a medida que avanzara en el tratamiento. Les dio reforzamiento diciendo que habían hecho su mejor intento y que ella estaría ahí para auxiliarlos en el proceso. El ofrecimiento de guía y apoyo alivió mucho a los padres y, aunque no se les dijo lo que querían oír, salieron de la sesión con una sensación de dirección y con expectativas más claras.

Las sesiones de terapia de Jackie siguieron siendo turbulentas pues ella se debatía entre las dudas: por qué sus padres no se habían enterado de que estaban abusando de ella, y por qué sus hermanos (que frecuentemente estaban con ella en casa del amigo del papá) no habían sido hostigados, y por qué no habían podido hacer nada respecto de lo que sucedía. Se requirió un considerable trabajo clínico para que Jackie comprendiera y aceptara lo chicos y vulnerables que eran todos cuando el abuso comenzó. Necesitó tiempo para darse cuenta que entonces era demasiado pequeña incluso para saber lo que le estaban haciendo. Sólo después de trabajar en sus sentimientos de culpabilidad y responsabilidad y de describir detalladamente algunos de los abusos, pudo enfrentar el hecho de que tenía una forma de relación con su agresor. Retrospectivamente, aceptó que en su cabeza el abuso había sido un juego chistoso que habían jugado juntos y que no se había percatado de sus implicaciones ni de que era algo malo.

La terapeuta consideraba a Jackie una adolescente extremadamente vulnerable y deprimida, que usaba su cólera para protegerse de sus otras emociones. Su consumo de drogas podía ser visto como un intento de automedicación para soportar su depresión. Abordó el asunto de las drogas de manera directa, diciéndole que las usaba para detener el dolor emocional y que si quería volver a tener algún control sobre su vida y "no dejar que ese hombre la dañara aún más" —como ella decía desearlo—, tendría que dejar de usarlas y desarrollar mecanismos más eficaces para enfrentar la situación. Le dijo que si no estaba preparada para comprometerse voluntariamente a dejar las drogas, ella insistiría en que regularmente se le practicara exámenes de orina como parte del tratamiento. Tuvo cuidado de asegurarse de que el mensaje no sonara como castigo, sino que comunicara claramente su interés por ella y su decisión de no sentarse a observar cómo se autodestruía.

Durante esta crítica fase del tratamiento, la terapeuta trabajó cerca de los padres de Jackie para ayudarles a poner los límites adecuados a su hija mostrando preocupación, interés y consistencia. La manera en que anteriormente había interactuado con su hija para fijar los límites era, en principio, blanda por miedo a su mal carácter; después, excesivamente dura como resultado de la frustración, y, finalmente, el sentirse culpables por haber exagerado. La terapeuta creía que una reacción paterna más moderada ante la actitud de Jackie era esencial para el tratamiento. Un factor clave para ayudarles a lograrlo fue trabajar con sus sentimientos de culpa por haber estado tan ocupados en empezar su (ahora próspero) negocio y dejar a su hija expuesta al agresor. La terapeuta les guió para que dirigieran su energía emocional hacia el proceso de curación de Jackie, en vez de hacerlo hacia los

errores del pasado que ya no podían ser modificados. También pudo ayudarles a comprender que la joven pasaría por periodos de conducta desagradables, pero que éstos serían aspectos necesarios de su proceso de recuperación.

Al principio Jackie respondió a las nuevas reglas y límites con un estridente desafío, pero pronto se calmó, poniendo los límites a prueba sólo ocasionalmente. Empezó a mejorar lenta pero visiblemente una vez que hubo mayor consistencia en su familia. Aprendió a identificar las emociones que sentía y, en consecuencia, a pensar en cómo debía actuar, en vez de simplemente tratar de defenderse. Aprender a expresar sus emociones fue duro; por ejemplo, frases como: "Necesito tal cosa..." y "Eso me lastima..." virtualmente se le atoraban en la garganta. Entonces asumía una actitud beligerante que sólo provocaba incompreensión. Le parecía que mostrar sus necesidades emocionales a otra persona significaba darle poder para lastimarla.

Otro aspecto importante del tratamiento de Jackie fue que se sentía marcada por el abuso. Creía que la gente podía saber que había sido víctima del abuso con tan sólo mirarla. Esa sensación le impedía salir con muchachos o tratar de arreglarse, pues como se sentía "manchada", no creía posible que un chico la quisiera. La terapeuta pensó que un poco de trabajo en un grupo de chicas podría ayudarle en el proceso de liberarse de ese sentimiento. (Jackie solía decir que a causa de lo que le había pasado se sentía como un "verdadero monstruo".) Cuando la terapeuta presentó el caso a la persona que dirigía el grupo, decidieron que sí había un lugar para Jackie. El grupo tenía cuatro chicas en ese momento, dos de las cuales habían sido víctimas del mismo hombre que abusó de Jackie. Al escu-

char la proposición, ésta se entusiasmó y se sintió especialmente atraída por la posibilidad de hablar con otras chicas hostigadas por su agresor.

Más tarde confesó que la idea de reunirse con un grupo de extraños le había asustado pero, de todos modos, la experiencia le resultó muy benéfica, pues pudo darse cuenta de que no era la única chica que luchaba con ciertos problemas. En ese grupo se habló de algo que le ayudó mucho en la relación con sus padres: cuando dos de las muchachas —una de ellas víctima de su mismo agresor— habían tratado de decirle a sus padres lo que estaba pasando, éstos no les creyeron. Cuando lo oyó, Jackie reaccionó contra sus padres en una forma que expresaba sus conflictos sobre el apego, la dependencia y la intimidad.

Al siguiente fin de semana era el cumpleaños de su mamá y habían planeado una cena en un elegante restaurante con toda la familia. Jackie nunca había hablado en detalle de lo que su agresor le había hecho delante de sus padres y decidió que la cena era el momento ideal; así que comenzó a hablar del asunto con su mamá. Ésta le respondió: "¡Por Dios, no quiero oír eso ahora!". Obviamente, se inició un zafarrancho. Jackie salió corriendo del restaurante dejando a su madre llorando. La terapeuta recibió dos llamadas telefónicas, una de Jackie que se sentía herida y decía que su mamá la había rechazado cruelmente cuando finalmente trató de compartir con ella lo sucedido y la otra de Corinne, quien decía que Jackie intencionalmente había echado a perder su fiesta de cumpleaños. La terapeuta, sabiendo que ninguna de las dos versiones era exacta, sugirió reuniones conjuntas con madre e hija. En ellas ayudó a ambas a comprender lo sucedido en esa cena. Durante mucho tiempo Jackie quiso contar a sus padres lo que le habían hecho, pero

temía exponerse emocionalmente y ser rechazada por su mamá. Entonces, inconscientemente, escogió un momento completamente inapropiado, con amigos y parientes presentes, asegurándose de que le respondería negativamente. Así podría asumir su enojo y afirmar su postura de autoprotección huyendo del restaurante.

Una vez que Corinne comprendió que lo ocurrido no había sido un ataque sino las maniobras defensivas de una adolescente asustada, reaccionó de manera adecuada y maternal. Incluso ahí, Jackie tuvo que hacer esfuerzos para presentarse emocionalmente vulnerable sin alterarse.

Después de este incidente, la terapia progresó considerablemente bien. Para cuando Jackie estaba en el segundo semestre de su último año de preparatoria, las reuniones con la terapeuta eran sólo mensuales y se preparaba el fin de la terapia, pero de pronto recomenzó el mal comportamiento. Empezó a hacer berrinches en casa y un día golpeó a su hermana porque ésta hizo un comentario negativo sobre ella. Nuevamente empezó a faltar a la escuela y, aunque ahora sus calificaciones eran buenas y ya había sido admitida en una universidad local, dejó de hacer su tarea diciendo que la escuela era para idiotas. Además, todo lo que sus padres decían era "estúpido", "baboso" o "equivocado". Ellos se preocuparon seriamente creyendo que todo lo logrado se estaba perdiendo.

La terapeuta se dio cuenta de que el repentino cambio de comportamiento de Jackie se debía a su temor de graduarse de la preparatoria, pues en ella ya se sentía segura y en confianza. Inconscientemente, en lugar de enfrentar el riesgo de un nuevo ambiente social, la universidad, se estaba preparando para reprobar en su último año y poder quedarse en un entorno cómodo y familiar. Para resolver esta crisis de transición, la terapeuta

volvió a ver a Jackie una vez por semana y a reunirse más a menudo con sus ansiosos padres. Durante las sesiones, se confrontó a la chica con la manera en que percibía su propia actitud y se le ayudó a sentirse más segura respecto de los avances emocionales y sociales alcanzados. Por otro lado, se le aseguró que el fin de la terapia en sesiones regulares no significaba que no podría regresar si tenía algún problema en el futuro. La terapeuta continuó viendo a Jackie hasta que terminó con éxito la preparatoria y llevaba medio semestre asistiendo a la universidad.

La adolescencia es un periodo turbulento en la vida de los jóvenes. En él aprenden a "probar los límites" en un esfuerzo por separarse de sus padres e iniciar su camino hacia sí mismos. Aquellos que son víctimas de una agresión sexual durante esta crítica etapa del desarrollo, pueden verse limitados en el cumplimiento de esa tarea. Consecuentemente, el tratamiento de una víctima adolescente consiste en ayudarle a resumir las sanas tareas del desarrollo y la formación de la identidad y la individualización. El terapeuta trata de sostener un delicado equilibrio dentro de la lucha del adolescente por renovar los pensamientos y sentimientos del niño con los del adulto. Se fomenta otro equilibrio entre la necesidad del adolescente de depender de su familia y su lucha por convertirse en una persona independiente. Estas tareas, cuando se realizan al máximo de las capacidades del terapeuta, pueden ser de una gran riqueza en cuanto a retos y recompensas.



cinco

Incesto



El trabajo del grupo de Mara Selvini Palazzoli en Milán nos ha mostrado que cuando las relaciones no son normales, esto es, cuando se pide a alguien que cumpla al mismo tiempo con dos papeles incompatibles, aparece una paradoja (1984). Un niño o adolescente atrapado en un incesto se sumerge en una paradoja de ese tipo, pues él o ella debe ser hijo, "amante" de su progenitor y "padre" del progenitor no involucrado sexualmente. En la paradoja incestuosa, desde el punto de vista del menor, el tiempo se modifica extrañamente, pues al mismo tiempo se detiene y se acelera. El menor es llevado a una relación sexual compleja más allá de su edad, donde el tiempo se acelera; pero esto también tiene el efecto de detener su tiempo, pues la relación es tan fuerte que retrasa el desarrollo de su personalidad.

Anteriormente solía pensarse que el incesto era una extraña y poco común forma de conducta humana. En 1955, Weinberg expresó el punto de vista generalizado de la siguiente manera.

El incesto, crimen universal, viola un tabú que es igualmente fuerte entre los primitivos como entre los sofisticados habitantes del mundo moderno... Es un recurso de personas muy problemáticas y perversas... A pesar de la fuerza social del tabú, el incesto sucede, aunque muy rara vez, en todas las sociedades occidentales. (pp. 3, 34)

En la actualidad, los científicos estudiosos del comportamiento consideran que esta visión no es real. Cada año hay miles de víctimas de incesto provenientes de todos los medios socioeconómicos y culturales. Aunque los penamientos, fantasías e impulsos incestuosos son parte del proceso de desarrollo normal de toda persona, la sociedad prohíbe incluso hablar del asunto. Ese rechazo tan sólo sirve para aislar o silenciar a los niños que están en peligro y evita que los que ya son víctimas del incesto puedan pedir la protección que urgentemente necesitan. Los autores prefieren guiarse por los conceptos de Anna Freud, quien escribió:

Lejos de existir sólo como una fantasía, el incesto es (también) un hecho, más frecuente en unas épocas que en otras. Entre las posibilidades de daño al desarrollo normal de un niño, el incesto es peor que el abandono, la negligencia, el maltrato físico o cualquier otra forma de abuso. Sería un error fatal subestimar su importancia o la frecuencia con la que ocurre. (1981, p. 34)

En este capítulo revisaremos las investigaciones y el trabajo teórico relacionados con el incesto, con una descripción de la evolución de los tipos más comunes de familias incestuosas y algunos factores que pueden ser útiles en

su análisis preliminar, incluyendo el caso de las acusaciones falsas. El capítulo termina con la exposición del tratamiento adecuado.

Nuestro tema fundamental es el fenómeno del incesto padre-hija. Tal como definimos en el Prefacio, incluimos en esta categoría el incesto cometido por cualquier persona que toma el papel del padre en la vida de la niña (el padrastro, el amante de la madre que vive en la misma casa, el padre adoptivo, el abuelo tutor). Creemos que es vital considerar la naturaleza de la relación de quien comete el incesto con la víctima. Por ejemplo, no debemos suponer que el incesto cometido por un padrastro o una figura paterna es menos traumático que el cometido por el padre biológico. Y se debe medir cuidadosamente el significado del papel paterno que la persona jugaba en la vida de la víctima.

Sabemos que a menudo el incesto es cometido por los hermanos, tíos o primos de una niña, pero concentraremos nuestra atención en los padres y las figuras paternas, con el fin de dar un enfoque preciso al tratamiento del tema.

El tabú del incesto

Aun cuando los pensamientos e impulsos incestuosos suelen merodear en la fantasía de niños y adultos, cuando los sucesos entran en la vida real de un niño, el resultado puede ser trágico. El tabú del incesto, virtualmente universal, obtiene su fuerza de sólidas razones biológicas, sociológicas y psicológicas. Es tan fuerte que no se habla de él y sirve para proteger a la estructura familiar, así como para promover el sano desarrollo de la especie humana. Las excepciones al tabú son muy raras y cuando

existen se restringen rigurosamente a la realeza o a rituales religiosos muy específicos (Meiselman, 1978, p. 9). Las pocas culturas que aceptan el incesto lo condenan y castigan estrictamente cuando ocurre fuera del contexto de las situaciones claramente predefinidas, además de que en la mayoría de los casos sólo permiten relaciones incestuosas entre hermano y hermana. En general, incluso las sociedades más primitivas prohíben las uniones incestuosas dentro de la familia nuclear (Murdock, 1949).

Existen muchas teorías relativas a los orígenes y razones del tabú del incesto. El intento de Freud (1913) de invocar una teoría de la "horda primitiva" nunca obtuvo aprobación y él mismo no se sentía satisfecho con tal explicación. Freud describió una "horda primitiva" gobernada por un duro y tiránico padre que prohibía a sus hijos el acceso a las mujeres de la horda. Debido a la tiranía paterna, los hijos se unieron para matarlo, devorándolo en un ritual canibal; como lo amaban, más tarde sintieron una pena tremenda. Entonces se percataron de que competirían entre ellos por las mujeres, por lo que crearon el tabú del incesto prometiendo practicar la exogamia. Actualmente, poca gente cree que esta alegoría explique cabalmente los objetivos y funciones del tabú del incesto.

El antropólogo Malinowski (1927) desarrolló una teoría que trataba de explicar el tabú en términos de la estructura del sistema familiar. Sostenía que las relaciones incestuosas confundirían los papeles dentro de la familia. Los intensos sentimientos que generan las relaciones sexuales desintegrarían el necesario equilibrio del poder en el seno de la familia, impidiéndole funcionar como un sistema socioeconómico.

Se pueden añadir importantes datos biológicos a las pruebas sociológicas, antropológicas y psicológicas que sostienen el profundo significado del tabú del incesto.

Meiselman (1978) resumió parte de la información biológica pertinente. Un estudio que reveló fuertes razones biológicas para el tabú del incesto es el de Seemonova (1971), en Checoslovaquia. En esa investigación, a lo largo de ocho años, se estudiaron los casos de 161 niños provenientes de familias incestuosas que fueron confrontados con un grupo de control, constituido por sus medios hermanos que no eran fruto de uniones incestuosas. Veinticinco por ciento de los niños nacidos en una relación incestuosa resultaron ser moderada o considerablemente retrasados, en contraste con ningún retraso en el grupo de control. Veinte por ciento de los hijos de incesto mostraron deformaciones congénitas o anomalías físicas graves. Sólo 43 por ciento de los hijos de incesto podían ser considerados normales, contra 89 por ciento en el grupo de control.

En resumen, el tabú del incesto tiene sólidas justificaciones sociológicas, biológicas y psicológicas. Protege a la estructura y la función del sistema familiar, promueve el desarrollo psicosexual de los niños y salvaguarda la sana evolución de la especie.

El sistema familiar incestuoso

El sistema familiar incestuoso evoluciona esencialmente en tres formas distintas: primero, tenemos el incesto en sistemas familiares agresivos y de escaso desarrollo social, como los que pueden encontrarse en algunas áreas rurales como los Apalaches. En esas familias, el patrón del incesto parece llevar varias generaciones habiéndose establecido como una parte "normal" de la vida. A menudo el comportamiento incestuoso no sólo ocurre entre

padre e hija, sino también entre hermanos.* De hecho, el padre puede guiar a su hijo hacia relaciones sexuales incestuosas con su hermana o con su madre (Cooper y Cormier, 1982; Raphling, Carpenter y Davis, 1967). Podemos describir ese tipo de familia como incestuosa "polimórfica".

El segundo tipo de familia incestuosa es aquella en la que el padre o los padres pueden haber sido víctimas de incesto (Cooper y Cormier, 1982; Everstine y Evershine, 1983) y tal vez repitan lo sucedido en contra de sus propios hijos. A partir de que el tabú del incesto ha sido roto, es más fácil que las generaciones siguientes lo vuelvan a violar (Meiselman, 1978; Raphling, Carpenter y Davis, 1967), pues ha dejado de ser un acto impensable. Los padres de este tipo tratan de resolver sus conflictos incestuosos de la infancia por medio de la experiencia de sus hijos. En algunos casos, un padre ha recreado la experiencia incestuosa exponiendo a un niño a *la misma persona* con la que él tuvo esa relación. En otros casos, el padre puede seleccionar a una pareja con características similares a las del miembro de la familia que cometió el primer incesto, para que recree el incesto con el niño.

* El incesto consensual entre hermanos, aunque no es tan traumático como el incesto padre-hija o madre-hijo, puede tener efectos profundos en la vida futura de los participantes. Ocurre generalmente en familias que pueden describirse como emocionalmente pobres. Los padres a menudo no cuidan ni son afectuosos con sus hijos y éstos satisfacen sus necesidades de afecto entre ellos mismos. Una relación incestuosa puede bloquear a estos niños para establecer relaciones amorosas más allá de esa relación prohibida. Y cuando se encuentra, dentro de la familia, alguien afectuoso y de edad apropiada, el niño regularmente tiene grandes problemas para salir de esa etapa detenida.

La tercera forma de sistema incestuoso tiene su origen en la relación que la madre tuvo con sus propios padres —los abuelos maternos de la víctima. La relación con su propia madre (la abuela de la niña) puede ser bien descrita como una relación del tipo "Cenicienta", en la que trató de agradar a una madre imposible de satisfacer. En su carencia de afecto, constantemente trataba de complacer a su madre para ganar su amor. Pero, tristemente, el amor por el que luchaba siempre estaba fuera de su alcance, pues una de las maneras usadas por la madre para controlar a su hija era precisamente retener el amor y la aprobación. Algunas de las madres de estas "Cenicientas" son personas esquizoideas o esquizofrénicas crónicas.

En muchos de estos casos, el padre de la mujer (abuelo de la víctima) también era emocionalmente inalcanzable, esto es, no se preocupaba por las necesidades emocionales de su hija. Tal vez estaba obsesionado por su carrera profesional, o sólo se interesaba en los hijos varones o simplemente era un padre descuidado y poco atento. Por otro lado, pudo haber una ausencia total del padre en la familia de esta mujer. En ese caso, sus primeras experiencias con las relaciones de hombre a mujer tal vez correspondan a sus interacciones con los diferentes hombres de su madre.

A partir de las frustraciones y vacíos de una infancia así, surgen las primeras semillas de un futuro sistema familiar incestuoso. Así, la mujer "Cenicienta" tiene una definición interna de la relación madre-hija: *la hija sirve a las necesidades de la madre*. Ha logrado invertir la naturaleza de la relación, lo cual se transforma en una "ficción ordenadora" cuando ella se convierte en madre.

Debido a su infancia de pobreza emocional, los deseos de esta mujer en torno al matrimonio implican

una relación de la que espera el amor y el cuidado incondicionales que no tuvo en la infancia. La secuela trágica es: escoge a un compañero que superficialmente puede satisfacer sus necesidades, pero que es fundamentalmente parecido al padre o a su sustituto. El hombre con quien se casa, escogido a partir de necesidades malentendidas, se muestra incapaz de satisfacer su exigencia de dependencia, misma que transmite a su hija cuando nace.

Al casarse, la mujer había esperado inconscientemente una satisfacción a sus deseos de amor y cuidado por su esposo. Cuando ve a su hija en el papel dependiente y necesitado de cuidados, mediante una trágica paradoja empieza a envidiar el sitio que ocupa en el sistema familiar. Con el tiempo, adopta un intercambio de roles con ella dentro de la estructura familiar. La desatiende e insiste en que el esposo se encargue de los cuidados que requieren tocar a la niña (como bañarla). En casos más graves, las madres impulsan directamente las relaciones incestuosas entre padre e hija.

Un sistema familiar incestuoso puede verse como la modificación de las fronteras generacionales en relación con uno o más de los hijos (véase Figura 2). Un factor de predisposición puede ser el que uno (o los dos) progenitor(es) haya(n) sido víctima(s) de incesto en su(s) familia(s) de origen, o bien, puede originarse en la relación de la madre con su propia madre, lo cual la lleva a cambiar papeles con su hija.

La madre en un sistema familiar incestuoso

El guión de la madre en un sistema familiar incestuoso puede ser de la siguiente manera: muy probablemente tiene ideas románticas respecto de lo que significa "estar casada". Pudo haber pensado que se casaba con alguien

"seguro", de acuerdo con su modelo imaginario del "padre-esposo", aunque realmente la elección haya sido alguien que está lejos de ambas cosas.

La negación es a menudo el primer mecanismo de defensa (Everstine y Everstine, 1983; Kaufmann, Peck y Tagiuri, 1954; Meiselman, 1978; Machotka, Pittman y Flomenhaft, 1967; Winer, 1962), ya que protege a la madre de ver, desde el principio, los aspectos negativos del hombre con quien se casa y luego le sirve para ignorar el abuso que su hija está sufriendo. Puede estar extremadamente inhibida sexualmente o no experimentar orgasmo. Esta disfunción tal vez sea resultado de su personalidad infantil o de una traumatización sexual a manos de su propio padre. En cualquiera de estos casos, las relaciones sexuales entre los padres pueden haber dejado de existir durante mucho tiempo antes de que se inicie la relación incestuosa entre padre e hija (Everstine y Everstine, 1983; Lustig *et al.*, 1966; Maisch, 1972; Winer, 1962).

Debido a que las expectativas originales de la madre en el sentido de encontrar a un "esposo-padre no fueron satisfechas, el matrimonio se ha convertido en una desilusión y, en el mejor de los casos, en una relación de "tregua". Las exigencias sexuales, los platos sucios y las responsabilidades de la maternidad han acabado con los sueños surgidos de su infancia emocionalmente pobre. La negación sobre la cual se apoya como defensa es muy importante para el funcionamiento interno de este tipo de sistema familiar (lo mismo que en otros sistemas familiares abusivos), pues sirve para cegar a los padres a lo que le están haciendo a sus hijos. De hecho, ese tipo de madre se caracteriza frecuentemente por no apoyar a su hija victimada (Everstine y Everstine, 1983; Kaufmann, Peck y Tagiuri, 1954; Meiselman, 1978), actitud que es muy difícil vencer debido a sus lejanos orígenes.

Familia normal		
Madre		Padre
Frontera generacional y sexual		
Hija		

Fase de transición		
Madre	↓ ↓	Padre
Frontera generacional y sexual		
Hija		

(En esta fase, cada uno de los padres ejerce una cierta presión sobre la frontera con el fin de modificar su posición.)

Familia en la cual están ocurriendo actos o amenazas incestuosos		
Madre	Frontera generacional y sexual	Padre Hija

Adaptada de Everstine, D.S. y Everstine, L. *Personas en crisis*. México, Editorial Pax, 1993.

El padre en el sistema familiar incestuoso

El padre en un sistema familiar incestuoso pudo, tal como ya dijimos, haber sido él mismo víctima de incesto, testigo de actos incestuosos realizados por su padre, o tal vez provenga de una familia en la cual se daba otro tipo de conducta incestuosa. Es muy probable que sea alcohólico y presente una fachada relativamente "normal" cuando está sobrio, pero se vuelva primitivo al consumir cualquier forma de enervante. Puede ser una persona introvertida incapaz de satisfacer las necesidades emocionales de su familia.

Muchos de estos padres funcionan adecuadamente en su vida profesional, pero sus capacidades emocionales y sociales son limitadas y superficiales. Son personas controladoras y dominantes, pero interiormente están llenos de miedos paranoicos y obsesiones sexuales (Cooper y Cormier, 1982; Gebhard *et al.*, 1965; Raphael, Carpenter y Davis, 1967); a pesar de su excesiva sexualidad, generalmente carecen de verdaderos conocimientos sobre ella. La reacción del padre incestuoso ante el rechazo de su papel sexual adulto por parte de su esposa generalmente es egocéntrica, hostil y confusa. Y es posible que no sea capaz de reconocer su enojo en contra de su esposa. El padre incestuoso, y en realidad toda la familia, exteriormente puede mostrar un gran respeto y afecto por los demás miembros de ésta.

Un ejemplo de la apenas escondida furia y de la sádica manipulación de un padre de su familia, es el caso de un hombre que hablaba de un gran amor por sus tres hijas y de su preocupación por su sano desarrollo sexual. Estaba determinado a hacer lo necesario para que sus hijas crecieran sexualmente sanas; y, para "asegurarlo", decidió que debía ser él quien las introdujera en los placeres del sexo, por lo que empezó a tener relaciones sexua-

les con cada una de sus hijas cuando éstas tenían entre diez y once años de edad. Le dijo a cada niña que la estaba iniciando en el sexo porque la amaba, y que continuaría teniendo relaciones sexuales con ella hasta que probara ser sexualmente sana mediante el hecho de tener orgasmos regularmente. Cada hija, por su parte, estaba completamente atrapada por su padre en su terror y su culpabilidad.

Los terapeutas deben tener cuidado con la preocupación que el padre suele profesar por su familia dentro de un sistema familiar incestuoso. La protección de la familia y el hogar en contra de la "destrucción" es un tema frecuente en estos padres. Y bajo ese velo de preocupación por la integridad y la seguridad de la familia puede esconderse una enorme cólera, desconfianza y vergüenza. Pensemos nada más que, cuando el padre escoge a una de sus hijas como pareja extramarital, en realidad está escogiendo a la pareja que resulta más catastrófica para el mantenimiento del sistema familiar.

Otro producto del énfasis en la lealtad y el amor a la familia es que pone una tremenda carga de responsabilidad —y frecuentemente de culpa por el incesto— en la hija sexualmente involucrada. Si deja que el secreto salga de la familia, la "destrucción" de ésta será culpa suya. Peor aún, si el secreto nunca sale de la familia, este tipo de mito familiar de cualquier modo desplaza la culpabilidad del padre incestuoso hacia su hija.

La niña como víctima

La niña de un sistema familiar incestuoso es realmente una figura trágica y una víctima en toda la extensión de la palabra. Yates (1974) lo expuso con gran precisión: "Son

víctimas porque no tienen ni la responsabilidad ni la capacidad para participar en el proceso de toma de decisiones. Incluso en los raros casos de las niñas seductoras y experimentadas que se aproximan a un adulto titubeante, es responsabilidad de éste el rechazar la invitación". (p. 482)

Desde nuestro punto de vista, es especialmente vergonzoso el hecho de que algunos niños y adolescentes son doblemente agredidos por quienes, dentro de las profesiones de asistencia, supuestamente deberían protegerlos. Parte de la literatura relativa a las víctimas de incesto, está desgraciadamente marcada por los equivocados escritos de 20 o 25 años atrás sobre el tema de la violación, en los cuales se desplazaba la responsabilidad del agresor hacia la víctima. Describiendo su actitud como pasiva o seductora, algunos autores simplemente evitaban tratar con el dolor y el horror que ésta sufría. De manera figurada, estas niñas se convertían en víctimas de una agresión posterior, llamada por Symonds (1980) "agresión secundaria", a manos de los profesionales de asistencia.

Autores sobre el tema del incesto como Rosenfeld, Nadelson y Krieger (1979), al igual que Henderson (1972), cometieron errores similares al prestar demasiada atención clínica a la actitud seductora o cómplice por parte de las niñas, abriendo a sus lectores la posibilidad de sospechar que ellas causaban la agresión y conspiraban con el padre incestuoso para continuar la relación. Una base para conclusiones erróneas de ese tipo la dio la investigación de Bender y Blau (1937) sobre "las relaciones sexuales de niños con adultos". La muestra estudiada consistía sólo de 16 niños, es decir, definitivamente un número insuficiente de casos para hacer generalizaciones sobre la población de víctimas infantiles. La selección de la muestra, hecha con edades y tipos de agresión dife-

rentes, no incluía ninguna víctima de incesto y carecía de un grupo de control. El trabajo de Bender y Blau, tristemente, sirve a los abogados defensores que desean absolver a su cliente echando la culpa al menor. Pensamos que esa investigación debería ser guardada junto con otras antigüedades, como la idea de Wilhelm Fliess respecto a que la neurosis es causada por desórdenes nasales.

Es cierto que algunas víctimas de incesto son seductoras, pero si un terapeuta se deja engañar por esa conducta, nunca podrá comprender lo que hay detrás de ella. Este tipo de conducta debe ser vista como un síntoma. De hecho, dirigir la atención hacia ella y al goce que la niña obtiene de la relación sexual también puede servir para proteger al terapeuta, pues éste puede enfocar en los "beneficios secundarios" y no enfrentar la naturaleza patológica del sistema familiar. Ciertamente, muchas víctimas obtienen beneficios secundarios considerables como afecto, atención y privilegios especiales. Pero uno debe preguntarse: ¿Estas niñas participan libremente en la relación o están negociando con favores sexuales el recibir afecto, atención y la sensación de ser importantes (que los niños deberían tener desde su nacimiento)?

Ciertamente, los niños son sexuales, pero no lo son de una manera genital, adulta. La sexualidad infantil es primitiva, autoerótica y exploratoria. Pero precisamente por esto al niño puede enseñársele a disfrutar de muchos tipos de contacto sexual (como lo anotamos en los capítulos 2 y 3), incluso aquellos que están más allá de su nivel normal de desarrollo. Esto sucede particularmente cuando un menor tiene carencias afectivas, como es el caso en muchos sistemas familiares incestuosos (DeYoung, 1982; Everstine y Everstine, 1983; Peters, 1976; Sgroi, 1979; Yates, 1982). Los menores tienen una enorme necesidad de cercanía y cuidado de los adultos y frecuentemente pagan un precio trágico por ellos.

No debemos olvidar que son los adultos quienes inician a los niños y les dan la definición de la fantasía a la cual llamamos "realidad". Desde temprana edad, los adultos de un sistema familiar le dan uno o varios papeles a cada niño y, al mismo tiempo, los mapas mentales y las claves de su mundo. Estos mapas delinean claramente lo que debe o no ver, creer o no creer, con el fin de funcionar dentro de la familia. No podemos ignorar cuán pequeño es el mundo de un niño y cuánto poder tienen los adultos sobre su mundo en evolución. Los padres de una víctima de incesto ejercen ese poder para moldear la realidad y la autodefinición del menor, de tal modo que él o ella no tienen más alternativa que orientarse hacia una sexualidad adulta. DeYoung (1982) describió con claridad el aprieto en que se encuentra un niño en un sistema incestuoso, y cómo lo resuelve asumiendo una personalidad seductora:

Dado que los niños pequeños dependen de sus padres para definir tanto la realidad como la moralidad, muchos entran en relaciones incestuosas voluntariamente, y cuando se dan cuenta de que esta conducta es ilegal y moralmente reproducible para los demás, pueden estar definitivamente atados a esa relación desde años atrás.

El niño o niña puede entonces darse una nueva personalidad de meretricio o prostituta —la cual es reforzada por las desviadoras técnicas de irresponsabilidad del padre incestuoso. De ahí surge una profecía autorrealizable, en la cual el menor se compromete activamente en una conducta, en este caso el incesto, de acuerdo con su nueva identidad. Al hacerlo, el menor reduce cual-

quier disonancia cognoscitiva que pudiera producirle una ansiedad demolidora durante la relación incestuosa y esencialmente se libera de la pesada responsabilidad de terminar con esta relación o de darla a conocer a alguien más. (p. 58)

Así pues, a estos niños se les *enseña* a ser lo que son. Es la dinámica familiar —en concreto, la inversión de los papeles de madre e hijo— lo que crea una conducta patológica en la niña (DeYoung, 1982; Everstine y Everstine, 1983; Furniss, 1984; Maisch, 1972; Meiselman, 1978).

Cuando una niña acepta pasivamente o participa activamente en la conducta incestuosa de su padre, sólo se necesita investigar la dinámica del sistema familiar para explicar su comportamiento. Para empezar, uno debe darse cuenta de que el sistema no da alternativa real alguna a la niña más que la aceptación del incesto. Debe subrayarse la carencia de un modelo de los roles a desempeñar, así como de alguien que la proteja. En este contexto, no es de sorprender que muchas relaciones incestuosas puedan continuar durante años. Otra razón por la cual un niño o niña puede participar pasivamente en dicha relación es su temor a la separación y la pérdida. Muchos de estos menores ya han experimentado la separación y la pérdida (DeYoung, 1982; Finkelhor, 1979) y son especialmente vulnerables ante la amenaza de mayor desintegración familiar; de tal manera, aceptan el incesto pensando que así mantienen unida a la familia.

Las víctimas de incesto confunden aspectos fundamentales de las relaciones. Muchas son incapaces de discriminar las formas de contacto erótico de aquellas simplemente afectuosas o amistosas (Yates, 1982, 1987a). Tienden a sexualizar la mayoría de las relaciones cercanas, ya sea para poner a prueba y determinar si la persona

es de fiar o simplemente porque no conocen otra manera de establecer una relación estrecha. Algunos, desafortunadamente, han aprendido a pagar con favores sexuales por el afecto que se encuentra en las relaciones.

Este problema de incapacidad de discriminar lo que es y lo que no es adecuado y la tendencia a sexualizar las relaciones, se complica aún más cuando la niña no tiene las habilidades básicas de contacto social. En lo superficial puede parecer socialmente más madura que otras niñas de su edad, pero esa madurez es más apariencia que sustancia. Como se dijo anteriormente, el modelo del papel paterno recibido es muy probablemente inadecuado.

Además, la relación incestuosa tiende a consumir tal cantidad de energía de la niña o adolescente que llega a interferir con su desarrollo en el nivel social. Yates (1982) lo expuso de esta manera: "El exagerado interés en el aprendizaje sexual parece distraer del aprendizaje social, e impedir una distribución de la libido más uniforme" (p. 483). En muchos casos, esos niños parecen capaces de aprehender el significado social de lo que hacen o dicen, pero en realidad no lo son. Ejemplos de ello van de la pequeña víctima de incesto de cinco años de edad que explicó a uno de los autores de este libro con gran admiración: "Le chupo el pito a mi papi y sabe tan rico", al caso de una adolescente prostituta que fue víctima de incesto hasta que escapó de su casa a los 14 años, y quien describía sus hazañas sexuales fríamente y con detalles explícitos.

El terapeuta debe estar preparado para ese tipo de comportamiento y, aunque sea muy chocante, no permitir que eso lo desvíe de los asuntos fundamentales con los cuales las víctimas infantiles están luchando. Claro que tratará de enseñarles a controlar ese comportamiento que sólo puede llevarlos a otras formas de abuso y al rechazo social acompañado de crueles etiquetas como "perdida" o "niña seductora".

Nuestra experiencia con víctimas de incesto concuerda con la de Yates (1982), quien descubrió que el "grado de erotización parece estar estrechamente relacionado con la intensidad y la duración de la unión incestuosa". (p. 842)

Siempre que un terapeuta se entere de ese tipo de comportamiento promiscuo o sexualmente agresivo por parte de una persona joven (especialmente en el caso de un menor preadolescente), debe indagar sobre sus orígenes. Debe preocuparse igualmente de un menor que muestra dificultades para sentirse cercano a los demás o para dejar que la gente se le acerque sin que muestre una actitud seductora.

Otra cuestión que complica el caso de muchas víctimas de incesto es la diferenciación entre la cólera y los sentimientos sexuales, como cuando ser lastimado y tener relaciones sexuales se confunden. Podemos ver el contraste que hay entre afirmaciones propias de un desarrollo sano como: "El sexo y el afecto, lo mismo que estar cerca, son agradables; pero cuando me lastiman o me siento enojado o temeroso es posible que no quiera estar cerca de ti". Pero, en muchos casos de incesto, el razonamiento común es: "Estaba cerca de mi padre y me usó sexualmente, me siento terriblemente confundida, ansiosa y enojada". Hemos descubierto que como resultado de esta contradicción con respecto a las formas normales de pensamiento, muchas niñas y adolescentes víctimas de incesto actúan de manera promiscua, especialmente cuando se sienten angustiadas o deprimidas.

Es bien sabido que buena parte de las bases para relaciones futuras tienen su origen en la forma y estructura de la relación entre padres e hijos. De ese lazo de confianza original —mis padres me protegerán— surge la capacidad de crear amistad y amor. Entonces, lo que se

daña o destruye con el incesto es un cimiento psicológico fundamental, a tal grado que de ahí pueden surgir algunos de los más serios problemas emocionales. La causa no es únicamente la unión sexual incestuosa, sino lo que ésta hace a la básica y especialmente valiosa relación de confianza entre padres e hijos, y dentro de la familia. Puesto que la imagen de uno mismo se crea y se define dentro del contexto familiar, esa traición a la confianza conduce a una autodevaluación por parte del niño o adolescente.

Efectos a largo plazo

De acuerdo con nuestra experiencia, muchas víctimas de incesto tienen dificultades considerables para establecer relaciones sanas y de confianza más adelante. Muchas no pueden y no logran tener amigos cercanos. Tan pronto como alguien entabla una relación de intimidad con ellos, tienden a terminar o evitar la amistad. Por otro lado, suelen sexualizar esas relaciones de manera frecuentemente inapropiada alejando una posible fuente de ayuda. Por ejemplo, si son lastimadas por alguien, algunas personas resuelven el conflicto actuando de manera promiscua o con una conducta autodestructiva, en forma muy similar a cuando, siendo niñas, resolvían el conflicto original asumiendo el papel de "putas". De este modo, se puede escribir un patético guión para la vida que será actuado mucho tiempo después del abuso original.

Otra forma en la que una relación dañada entre padre e hija puede afectar la dirección futura de la vida de la niña es cuando compulsivamente ésta escoge una pareja que abusará de ella o de sus hijos, repitiendo el

ciclo malsano. O puede ser que la víctima establezca un lazo irrompible con uno o ambos progenitores siendo incapaz de dejar su casa. Otras pueden utilizar mecanismos de defensa obsesivo-compulsivos que les permiten controlar el trauma incestuoso. Pueden adoptar un estilo de vida asexual u homosexual diseñado para protegerlas de contactos sexuales futuros, como métodos para hacer frente al conflicto incestuoso original. Es muy triste que muchas de esas víctimas silenciosas que no tienen una actitud abierta, son muy raras veces reconocidas en su carácter de víctimas.

A menudo surge la pregunta de por qué muchas víctimas de incesto desarrollan desórdenes en su carácter. Pensamos que al menos una parte de la respuesta se encuentra en el tabú del incesto. En cierto sentido se trata de la prohibición social más poderosa, aún más que el tabú en contra de matar. En muchas situaciones sociales se puede hablar de un impulso que conduce al homicidio, pero cuando alguien saca a colación el tema del incesto, incluso en los ambientes sociales más liberales, la atmósfera se enfría dado que el incesto es un acto impensable del cual no se puede hablar. Cuando una niña o adolescente se percata de que ha estado involucrada en el acto más reprochable, otros actos prohibidos parecen palidecer ante éste.

Otras razones por las cuales estos niños desarrollan desórdenes en su carácter pueden encontrarse en la estructura de la familia incestuosa. Estos sistemas son similares a los sistemas familiares esquizofrénicos, en el sentido de que definen la identidad del menor por su función. En un sistema esquizofrénico, la función del niño en cuestión es la de estar loco; dentro del sistema familiar incestuoso, la función del menor es ser la persona que es *usada* como objeto sexual. Así, él o ella aprende en un nivel fundamental dentro del sistema que la gente puede

usar a otras personas, aun para hacer cosas impensables. El "marco" (construcción) de la visión del mundo de ese niño generalmente empieza a darse en una etapa tan temprana del desarrollo moral, que él o ella no posee el modelo alternativo para definir el significado de las relaciones. Así, el tema dominante enseñado por el sistema familiar es: "Puedes usar a la gente para tus necesidades, aun cuando éstas estén prohibidas". Considerando el tipo de modelos accesibles a estos niños dentro de un sistema semejante, lo mismo que el retraso de una adaptación social apropiada causado por la hiperestimulación sexual prolongada, uno puede ver claramente por qué muchos de ellos se desarrollan en la manera en que lo hacen.

El problema de las acusaciones falsas

El tratamiento de una familia incestuosa debe considerar la validez de la acusación realizada por el menor. Sin embargo, los terapeutas han de tener presente que, excepto en situaciones en las que son citados a la corte, su función no es determinar la validez de lo dicho por un niño o niña. La denuncia debe ser presentada ante las autoridades competentes de forma que se adecue a las leyes sobre denuncia de abuso contra menores, en el sitio donde practica el terapeuta (véase capítulo 8). Entonces, éste debe permitir que la persona designada determine la veracidad o falsedad de la acusación. Desde nuestro punto de vista, un profesional concienzudo declinará la posición de realizar el doble papel de terapeuta y evaluador.

A menudo, las denuncias de incesto poco documentadas han sido descalificadas definiéndolas como "fantasías de incesto", cuentos de un niño con problemas

o la acusación de un menor atrapado en medio de un pleito por divorcio. Existen suficientes pruebas clínicas del hecho de que la mayoría de las acusaciones de incesto, especialmente aquellas realizadas por niños pequeños, son verdaderas (Bresse, *et al.*, 186; Cowie, Slater, 1968; Everstine y Everstine, 1983; Faller, 1984; Finkelhor, 1984; Green, 1986; Peters, 1976; Yates, 1987a). Ya sea que un niño haga una velada insinuación de que ha sido víctima de incesto o que la haga claramente, siempre se le debe tomar muy en serio. Nuestra experiencia nos ha mostrado (también véase Yates, 1987b) que cuando se le pregunta a los niños sobre los sucesos importantes de su vida, suelen ser muy veraces respecto de la información que consignan. Si lo que contaron resulta ser falso, el menor debe estar sufriendo de serios problemas psicológicos.* O tal vez, está solamente intentando salir de una situación familiar en la cual se siente atrapado y desesperado.

Un ejemplo puede ser el del niño o la niña que trata de deshacerse de un padrastro o madrastra en quien ve una amenaza emocional. Otra situación en la cual puede darse una falsa acusación de incesto es en el curso de un juicio de divorcio. El terapeuta debe actuar con extremo cuidado en situaciones tan delicadas y no saltar a conclusiones, a pesar de cómo se vean las cosas exteriormente. Por ejemplo, si el menor ya no vive con el padre acusado, él o ella puede hacer una denuncia falsa para dar gusto a su otro progenitor. De hecho, un menor espe-

* En el caso de niños o adolescentes gravemente desequilibrados que denuncian un incesto, una profunda revisión psicológica, incluyendo exámenes, generalmente revelará si el menor es capaz o no de discriminar la realidad.

cialmente dependiente puede ser objeto de un "lavado de cerebro" para que haga semejante denuncia (Green, 1986). Esto y otros "beneficios secundarios" pueden motivar falsas denuncias.*

Una regla general mencionada anteriormente, que cuanto más pequeño sea el niño más probable será que su denuncia sea verdadera, puede no aplicarse en este contexto. En los casos de divorcio, el terapeuta debe considerar que cuanto más pequeño sea el menor, más dependiente emocionalmente será de alguno de sus padres, siendo por lo tanto más vulnerable a las manipulaciones de un vengativo cónyuge dentro de un juicio. No debe subestimarse cuánto desgarrar y aterrorizar a ciertos niños el divorcio de sus padres. Algunos hacen cosas desesperadas por calmar a uno de sus padres cuya presencia y amor temen perder.

Ejemplo de un caso

Este caso ilustra la manera en que un niño puede ser atraído en medio de un divorcio difícil y en la subsecuente batalla por la custodia. El matrimonio de Valerie y Mike estaba viciado desde el principio. Retrospectivamente, Mike se dio cuenta de que se había casado con Valerie por lástima. Valerie se fue de su casa a los 16 años porque su padre, alcohólico, había abusado de ella física y sexualmente. Cuando Mike la conoció, ella tenía un trabajo y luchaba por terminar sus estudios en la universidad.

* El terapeuta puede pensar que el menor está describiendo algo visto en una revista o video pornográfico. Hemos descubierto (al igual que Yates, 1987a) que aunque las fantasías de los niños pueden ser poderosamente estimuladas por ese tipo de experiencias, pocos asumen actitudes en exceso extrovertidas como resultado de ellas.

Llevaban poco tiempo saliendo juntos cuando Valerie le dijo que estaba embarazada. Aunque Mike dudaba en casarse con ella debido a su caótico modo de vida, pensó que el matrimonio y un hijo podrían darle la estabilidad que necesitaba; y si él tenía paciencia, ella se calmaría. Pero el matrimonio estaba condenado desde su inicio; parecía que vivir juntos amplificaba los desacuerdos en vez de mejorarlos. Mike y Valerie tenían ideas completamente distintas sobre la manera de educar a un hijo. Ella, debido a su experiencia de abuso, era muy permisiva, mientras que Mike tenía patrones más estrictos. Pensaba que las reglas, los límites y la estructura eran buenos para los niños.

Después de dos años y medio de casados, Mike tuvo una breve relación con una mujer que conoció en su trabajo. Esto le causó problemas porque, en el fondo, él no creía en las relaciones extramaritales; sabía que eso dañaría a su matrimonio. Fue a ver a un psicoterapeuta porque sintió que necesitaba ayuda para resolver las cosas y decidir lo que haría. Después de seis meses de terapia, se dio cuenta de que mantenía su matrimonio únicamente por el interés en su hija Christina y que su relación con Valerie había ido de mal en peor. Mike decidió pedir el divorcio y hablar sobre la relación que había tenido, pues el secreto aún le molestaba. Su terapeuta le sugirió que tal vez no sería bueno hablarle a Valerie de ella pues hacía mucho que había terminado y tan sólo heriría y haría enojar a una mujer de por sí vulnerable. A pesar de ese consejo, Mike sintió que debía decirle todo a Valerie para lograr un final honesto y "limpio".

La consecuencia fue un divorcio muy difícil. Valerie sentía que le había hecho daño y se dispuso a vengarse por todos los medios posibles. Primero no permitía que Mike entrara en la casa para sacar sus pertenencias.

cias, malgastaba el dinero e incluso se rehusaba a dejar que Mike viera a Christina (que ahora tenía tres años). Valerie decía que tenía derecho de mantenerlo fuera de la casa y de gastar el dinero como quisiera; decía que su esposo no estaba moralmente capacitado para ver a su hija. Empezó una larga y amarga batalla legal. Al final, Valerie obtuvo un arreglo razonable sobre las propiedades y Mike, la custodia compartida de Christina. La niña debía pasar una semana alternadamente con cada uno de sus padres.

Valerie se opuso a esta forma de custodia compartida desde el principio, argumentando que ella y Christina no soportaban estar separadas. Utilizaba todas las excusas posibles para no permitir que Mike viera a la niña. Frecuentemente, cuando él venía por su hija tenía que enfrentar a Valerie quien, llorando, sostenía a Christina en sus brazos mientras ésta sollozaba. Entonces, Valerie decía cosas como: "Mami sabe que no quieres ir". Sin embargo, aunque lleno de dificultades, el arreglo de la custodia compartida continuó durante más de un año, pero Valerie no dejó de argumentar que la niña no quería ver a su papá y que además éste era un mal padre.

Durante ese tiempo, Mike empezó una nueva relación con una mujer llamada Nicole, quien tenía dos niños, uno de cuatro y otro de seis años. Estaba contento pues él y Nicole tenían mucho en común, pensaba que ella era una buena madre y creía que Christina (que ya tenía cuatro años) disfrutaría jugando con los hijos de Nicole. Convencido de que hacía lo correcto, Mike decidió que cada vez que fuera a buscar a Christina iría acompañado por Nicole y los niños, con la idea de que Valerie supiera de quién se trataba, en caso de que Christina hablara de ellos.

Un día, repentinamente, Mike se enteró de que Valerie y una terapeuta los habían acusado, a él y a Nicole, de abusar sexualmente de Christina y de expo-

nerla al uso de cocaína. De acuerdo con Valerie y la terapeuta, Christina había demostrado —utilizando muñecos anatómicamente precisos y dibujos explícitos— cómo su papá y Nicole habían tocado su "cosita", la cual le dolía. También había dicho que Mike y Nicole se habían enojado cuando la sorprendieron jugando con su polvo blanco especial. Por último, supuestamente Christina dijo que los hijos de Nicole eran malos con ella y la habían golpeado. Los derechos de visitar a su hija le fueron inmediatamente suspendidos a Mike y la policía inició una investigación de los cargos de abuso sexual y posesión de drogas.

Una mujer detective interrogó a Christina en dos ocasiones, pero en ninguna de ellas la niña volvió a hacer una acusación clara de abuso sexual. Entonces, Mike se prestó voluntariamente para una prueba de polígrafo y la pasó. Como resultado de ello, se retiraron los cargos criminales en su contra. Sin embargo, Valerie presionó para obtener la custodia de la niña y cancelar los derechos de Mike para visitarla.

Uno de los autores de este libro fue designado por la corte para realizar una evaluación y hacer recomendaciones relativas al asunto de la custodia. Aunque Valerie se resistió tanto como pudo a trabajar con la psicóloga y continuó viendo a su terapeuta privada junto con Christina, se pudo realizar una evaluación que incluyó la grabación de detalladas entrevistas con ambos padres, con Christina y con Nicole. Debido a la seriedad de los cargos, a cada uno de los adultos le fue aplicada toda una batería de pruebas psicológicas consistentes en la MMPI, la Rorschach, la Prueba de Percepción Temática, una prueba de Completar Oraciones y otra de Dibujar a una Persona. Se pensó que éstas ayudarían a determinar si alguno de ellos representaba una amenaza para Christina.

A la niña le fueron aplicadas las pruebas Rorschach, la Prueba de Percepción Temática (que preferimos a la prueba de Percepción para Niños en casos de este tipo, pues con ella se obtiene información más relevante) y la prueba de Dibujar a una Persona. Christina también participó en sesiones de juego utilizando muñecas, títeres y una casa de muñecas. Durante las sesiones de juego con muñecas, la evaluadora puso especial cuidado en evitar conducir a la menor en alguna dirección específica. Le planteó preguntas directas como: "Cuéntame cómo son las cosas cuando te quedas en casa de tu papá" y "Dime cómo es vivir con tu mamá". Se le daba tiempo para contestar y luego se le pedían detalles y aclaraciones. La evaluadora realizó un esfuerzo especial para evitar el reforzamiento de las respuestas de Christina en un sentido u otro. La información precisa era considerada fundamental y sólo podía ser obtenida manteniendo una cierta neutralidad y siendo paciente al trabajar con las capacidades cognitivas y los lapsos de atención propios de una niña de cuatro años de edad.

La evaluadora también decidió no trabajar con las muñecas anatómicamente precisas o con dibujos explícitos pues, en sí mismos, estos objetos pueden llevar al menor en cuestión a pensar en términos sexuales. Dado que los niños están acostumbrados a jugar con muñecos y ver dibujos de gente genítalmente neutral, llevarlos a una oficina profesional y mostrarles muñecos o dibujos con órganos genitales les transmite el mensaje de que en este caso el adulto está interesado en cuestiones relacionadas con el género o con la sexualidad. Y, en caso de que el menor sea vulnerable o haya sido guiado o presionado de alguna manera, él o ella responderá con referencias sexuales únicamente para complacer a un adulto a quien percibe como alguien poderoso. Por eso en este tipo de

evaluaciones recomendamos que los terapeutas eviten usar tales objetos, aun cuando los métodos alternativos requieran más tiempo.

La evaluadora habló con el pediatra de Christina y con su nana y visitó las dos casas de la niña. En casa de Nicole conoció a sus dos hijos. Además, habló por teléfono con la terapeuta que había hecho la denuncia inicial y revisó los archivos del tratamiento proporcionado. A partir de esta información empezó a revelarse la siguiente historia.

Christina estaba atrapada en medio de un divorcio no resuelto, porque, aunque su mamá estaba legalmente divorciada de su papá, emocionalmente seguía unida a él. Las pruebas psicológicas y las entrevistas revelaron que Valerie tenía una personalidad histérica y estaba proyectando el abuso sufrido en su infancia en la experiencia del divorcio. Estaba enredada emocionalmente con Christina y cada vez que la niña iba a casa de su papá ella se sentía emocionalmente herida. Cuando Mike inició su relación con Nicole, Valerie no lo pudo soportar y empezó a convencerse de que pasaba todo tipo de cosas en casa de él.

En contraste, la evaluación de Mike mostró que era una persona lógica pero idealista que usaba defensas obsesivo-compulsivas para protegerse del dolor emocional. Era básicamente un hombre bien intencionado que podía ser muy introvertido e insensible a las necesidades emocionales de los demás. La evaluación mostró que no era un hombre impulsivo ni naturalmente agresivo, en cambio, cuando mostraba su enojo tendía a actuar de manera pasiva-agresiva.

Al principio, Christina logró adaptarse a tener dos casas de padres solos, una estricta y la otra permisiva, en las cuales, al menos, ella era el centro de atención. Pero

cuando Nicole y sus dos hijos entraron en su problemático espacio vital, fue demasiado para ella, pues no sólo tenía que compartir a su padre con Nicole sino tenía que luchar contra dos niños rivales. El hecho de que su padre no percibiera la crisis por la que pasaba, simplemente la empujó hacia el temor y el enojo, y empezó a hacer berrinches y a resistirse a ir a su casa.

El pediatra de Christina informó a la evaluadora que la niña había sufrido una grave intoxicación ese verano. La erupción cubrió sus brazos, sus piernas y el área genital. Como remedio se le tuvo que aplicar una loción varias veces al día en las partes afectadas por la erupción, incluyendo sus genitales. La aplicación del medicamento era relativamente problemática, pues siendo dolorosa, Christina se resistía a ella. Por esta razón Nicole frecuentemente ayudaba a Mike a aplicar el remedio ya que era una labor difícil. Esto explica lo que ocurrió cuando Valerie llevó a Christina con su terapeuta. Apparently, al oír que Mike y Nicole la habían tocado, la terapeuta sacó las muñecas con precisión anatómica y pidió a Christina que le mostrara lo que le habían hecho. Obviamente, mostró que le habían tocado el área genital.

Esto se realizó en presencia de Valerie (al igual que todas las sesiones con esa terapeuta), y después la niña fue felicitada por su mamá y por la terapeuta por haber sido tan valiente al decir lo que papá le había hecho. En realidad se le había dado un claro mensaje a Christina, en el sentido de lo que debía hacer en la oficina de esa señora: específicamente, hablar mal de papá. La terapeuta no preguntó las razones por las cuales Mike y Nicole habían tocado sus genitales; ninguna de las sesiones fue videograbada y no había otros documentos de las mismas, aparte de las notas tomadas por la profesional. Más tarde, la evaluadora se enteró de que el polvo blanco con el que Christina había jugado en casa de su papá era

una substancia (TSP) que Mike estaba usando para limpiar la fachada de su casa antes de pintarla. Cuando la encontró jugando con ese polvo se lo quitó y la regañó por haberlo tomado.

A medida que se desarrolló la evaluación se vio claramente que Christina no había sido víctima de ningún abuso. De hecho, su conducta durante una de las sesiones fue muy reveladora; jugó alegremente en la casa de muñecas durante la mayor parte de la hora teniendo como tema las cosas que hacía en casa de su papá. Más tarde, cuando se reunió con su madre en la sala de espera, espontáneamente le dijo: "Ves mami, ya no tengo que ir más a la casa de mi papá". En resumen, Christina daba la impresión de ser una niña en edad edípica que se hallaba en conflicto con los nuevos rivales que había en su vida, y sufría por los efectos acumulados de la prolongada lucha entre sus padres por el divorcio. Apparently había sido conducida o estimulada por su mamá y por la terapeuta para decir cosas en contra de su padre. En general, la evaluación demostró que se trataba de una niña psicológicamente sana, que respondía emocionalmente al trauma del divorcio más que al trauma de un abuso.

Las recomendaciones finales de la evaluadora fueron que se restituyera inmediatamente la custodia compartida para el padre y que se debía designar un terapeuta para Christina que ninguno de los padres pudiera rechazar. Además, Mike debía trabajar con este terapeuta con el fin de ser más sensible a las necesidades de la niña. Por su parte, Valerie debía empezar una terapia individual para resolver los asuntos pendientes del divorcio y del abuso del que había sido víctima durante la infancia.

Este caso muestra cómo un padre en proceso de divorcio que proyecta sus fantasías perversas sobre el otro progenitor, puede efectivamente guiar a un menor,

de por sí angustiado o confundido, hacia un sistema engañoso. Estas manipulaciones se hacen posibles por la retención de la aprobación por parte del padre o la madre, de donde surge un incremento en las necesidades de dependencia del menor. Frecuentemente, un niño es bombardeado con información tergiversada sobre el otro progenitor y luego interrogado por el que acusa hasta que se rinde. Los terapeutas deben ser cuidadosos en su manera de proceder en tales casos, pues son extremadamente explosivos. De hecho, ambos padres pueden ser igualmente capaces de demostrar comportamientos destructivos en estas situaciones.

Hay casos en los cuales no ha ocurrido un verdadero incesto, pero en cambio se han presentado conductas seductoras o sexualmente inapropiadas. Entonces, se requiere igualmente atención clínica. En su gran mayoría, un cuidadoso examen del menor y de los adultos importantes revelará la verdad. En nuestra opinión, una escena de confrontación entre un padre acusado y un niño extremadamente angustiado y traumatizado, del tipo que proponen algunos terapeutas, rara vez logra algo más que empeorar el trauma existente. Lo mismo puede decirse de la proposición de Green (1986), en el sentido de que se entreviste al menor en presencia del padre acusado y así observar y evaluar su interacción. Esto llevaría a una velada confrontación y probablemente el menor traumatizado no tendría la fuerza para soportarla.

La mayoría de los niños son suficientemente sensibles para saber cuándo está ocurriendo algo raro o cuándo algo anda mal—incluso si los adultos tratan de esconder el hecho—, pero pueden no conocer las palabras exactas para describir lo que está pasando. La descripción del menor puede implicar que efectivamente se hizo un intento de relación incestuosa cuando en realidad no hubo tal. Quizá lo que trata de expresar sea provocado

por alguna forma de amenaza mal dirigida o alguna tensión dentro del sistema familiar. Por ejemplo, el menor pudo haber sido sobreestimulado o expuesto a una conducta sexual incorrecta por parte de los padres. Lo que él o ella describe (algo mitad realidad, mitad atemorizada fantasía) puede ser una premonición de problemas futuros. Los niños son frecuentemente conscientes de la dinámica familiar básica de una manera intuitiva que los padres tal vez no quieren aceptar. Un menor puede sentir que algo anda mal o está por ocurrir, pero acaso no sepa exactamente qué es o no pueda expresarlo correctamente. Una de las razones posibles tras este tipo de acusación puede ser que el menor está pidiendo que se le proteja de alguno de sus padres, pues siente que hay una conducta sexual inapropiada, una amenaza sexual pendiente o un desplazamiento de los papeles sexuales dentro de la familia (tal como el que ocurre durante el período de "coraje" previo al incesto. Éste se analizará más adelante).

Finalmente, el terapeuta debe ser muy consciente de sus propios sentimientos personales que pueden entrar en una situación de este tipo. ¿No preferiría que "toda esta porquería" fuera una invención de la imaginación del menor para no tener que lidiar con ello? Uno no puede ignorar el hecho de que muchos niños que fueron víctimas de incesto estaban en tratamiento con terapeutas que no detectaron lo que sucedía o que no crearon el marco emocionalmente seguro para que el niño revelara lo ocurrido.

En resumen, el proceso de determinar si la acusación de incesto que hace un menor es o no verdadera debe ser tomado con extremo cuidado. Cuando un terapeuta forma parte de ese proceso, él o ella debe aproximarse a la evaluación de una manera objetiva, clínica, evitando ser arrastrado por la tormenta emocional que esos casos pueden causar.

A continuación presentamos una lista de ideas generales para ayudar al terapeuta en esas situaciones:

1. Evaluar la condición psicológica del niño o adolescente con el fin de determinar si es o no capaz de percibir el mundo con precisión, de acuerdo con su desarrollo mental. ¿Sufre el niño o la niña de alguna condición psicológica que pudiera limitar su juicio?
2. Evaluar el comportamiento del niño o adolescente de acuerdo con los criterios que sirven para diagnosticar a los menores que han sufrido de abuso sexual (capítulo 2 para los niños y capítulo 4 para los adolescentes).
3. Evaluar cuidadosamente a ambos padres de manera individual, lo mismo que en términos de su relación actual. En otras palabras, saber si uno de ellos gana algo como resultado de una acusación de este tipo y si es capaz de influir abierta o cubiertamente en el niño. ¿Tiene alguno una historia de problemas psicológicos o de consumo de enervantes que pudiera desinhibir su conducta al punto de actuar irracionalmente?
4. En los casos más serios o complejos es aconsejable que la evaluación de los padres y del menor se realice por un terapeuta distinto, nombrado legalmente, con el fin de asegurar una evaluación desprejuiciada y protegerse uno mismo de una presión innecesaria.
5. El terapeuta debe considerar las opiniones sexuales de cada uno de los padres para determinar lo que consideran "normal" y lo que cada uno de ellos cree que es apropiado que conozca un niño y cómo siente que se le debe expresar el

afecto. No debe sorprenderse al descubrir que, especialmente en casos de divorcio, los puntos de vista pueden ser muy diferentes.

6. El terapeuta debe prepararse para reunirse con los adultos importantes, lo mismo que las personas que cuidan al niño como son las nanas, los maestros, pediatras y parientes, para obtener información relevante sobre el estado emocional y la conducta del niño, así como aquella que confirme o desmienta la acusación de incesto.
7. Los asuntos relacionados con los beneficios secundarios deben ser muy bien analizados. En la mayoría de los casos, cuando la acusación del abuso sexual sufrido por un menor es verdadera, éste no gana nada. En cambio, un niño teme la pérdida o la ruptura de la familia, la culpabilidad y la vergüenza. En consecuencia, la mayoría de quienes han sufrido el abuso tienen miedo de decirlo. De tal modo, la posibilidad de que obtenga beneficios secundarios al hacer una acusación falsa debe investigarse.
8. Se deben tomar las medidas necesarias para evitar al máximo que el menor sea presionado. Cuanto menos presión haya sobre él, más probable será que la información obtenida sea verdadera. A menudo la evaluación de un alegado es inadecuada debido a los tiempos que le son exigidos al terapeuta.
9. Cada sesión de evaluación debe grabarse, en audio o en vídeo, para demostrar que el niño o adolescente no fue dirigido ni obligado, lo mismo que para dar documentación sobre el uso de métodos correctos y desprejuiciados.

10. El menor debe tener un terapeuta individual que esté fuera del proceso de evaluación y con el cual tenga una relación confidencial. Muchos niños inmersos en este tipo de situación (especialmente en el divorcio) sienten que han sido lanzados a una zona de guerra en la que no hay un lugar seguro. Esa relación terapéutica protegida puede darle un sitio donde él o ella trabaje con sus confusos sentimientos.

*Evaluación de familias incestuosas**

¿Cómo es que los terapeutas llegan a enterarse de los casos de incesto? Como expusimos en una obra anterior (Everstine y Everstine, 1983, capítulo 9), muchos de estos casos se manifiestan a partir de las cosas que hacen los menores, por ejemplo, huir de casa, o desplegar actitudes sexualmente agresivas o inapropiadas, comportamientos autodestructivos o suicidas y (o) cambios repentinos en el desempeño o la conducta en la escuela.

En otro contexto, una familia incestuosa puede iniciar el tratamiento por el siguiente camino: una hija llega a la adolescencia y desea participar del comportamiento propio de su edad, como sería salir con muchos y tomar más parte en las actividades de sus compañeros fuera de la familia, pero su padre reacciona como un amante celoso y le impone restricciones inapropiadas; como resultado, ella se opone violentamente a esas reglas

* Ésta y la siguiente sección describen sólo la evaluación y el tratamiento de casos en los que ha ocurrido un incesto entre padre e hija.

excesivas. Cuando la hija reacciona así o se va de la casa, la familia puede buscar consejo profesional, no a causa del incesto sino para recuperar el control de la hija descontrolada. Lo que más nos debe interesar es que, a pesar de la creciente conciencia respecto del fenómeno del incesto, las familias incestuosas tienden a ser sistemas cerrados o aislados y rara vez buscan el tratamiento de manera voluntaria para resolver el problema del incesto en sí mismo.

Las relaciones sexuales incestuosas pueden detenerse cuando la hija llega a la edad en que puede concebir un hijo. En ciertos casos, la forma de contacto sexual se modifica por la copulación oral o anal, o bien, el padre escoge a otra hija menor como pareja sexual. Este cambio puede también causar una crisis en la familia y traerla al tratamiento. Sin embargo, incluso entonces, la mayoría de las familias se acercan a los terapeutas por lo que ellas mismas definen como problemas en el comportamiento de la hija, o porque el incesto ha sido descubierto y las autoridades las han obligado a seguir el tratamiento.

A continuación presentamos una lista de factores de riesgo que, de acuerdo con nuestra experiencia, nos pueden llevar a pensar que hubo o puede haber un incesto padre-hija dentro de una familia (resumido de Everstine y Everstine, 1983; véase también Browning y Boatman, 1977; Finkelhor, 1984, 1979; Meiselman, 1978):

1. Padre alcohólico
2. Padre exageradamente suspicaz o puritano
3. Padre violento o autoritario
4. Madre "ausente" o demasiado pasiva o incapaz de ser una fuerza protectora en la familia
5. Hija que juega el papel de madre, asumiendo muchas de las tareas de cuidado de la casa
6. Padres cuya relación sexual es problemática o inexistente

7. Situación en la que el padre debe estar frecuentemente a solas con la hija
8. Factores que pueden limitar el autocontrol del padre, como drogadicción, psicopatología o inteligencia limitada
9. Repentina actitud promiscua por parte de una joven
10. Una muchacha que no permite las amistades cercanas
11. Padres que no quieren o no permiten que su hija hable a solas con el terapeuta
12. Actitud hostil o paranoica hacia los extraños por parte de uno o de ambos padres, especialmente el padre
13. Incidentes previos o incesto en la familia nuclear de uno o ambos padres
14. Padres con infancias perturbadas en las que hubo inversión de los modelos y papeles
15. Celos exagerados por parte de un padre cuya hija recién llega a la pubertad

Estos eventos o características pueden servir al terapeuta como posibles indicadores de que está ocurriendo un incesto. Otra secuela común es una repentina conducta extraña o salvaje en la hija, especialmente si en ella se incluyen fantasías de naturaleza sexual. Geiser (1979, p. 58) descubrió que en una población clínica de menores con problemas, al menos 20% de ellos pudo haber sido víctima de incesto. Nosotros creemos que en la medida en que los terapeutas están cobrando mayor conciencia del problema, se identificará a muchas víctimas entre los niños y adolescentes con problemas graves, o internados en instituciones de asistencia.

Acercamiento al problema del incesto

¿Cómo sacar a colación el tema del incesto ante una menor o preguntarle si éste ha ocurrido? Si la niña tiene 10 u 11 años o más, en ausencia de los padres se puede decir algo como esto (adaptado de Everstine y Everstine, 1983): "Como sabes, las relaciones entre padres e hijas pueden volverse muy cercanas. Pero algunas de las cosas que me dijiste me dieron la sensación —y puedes detenerte si me equivoco, pues no siempre tengo la razón— de que algo pudo haber pasado entre tú y tu papá que te lastimó, te asustó o te confundió".

Si la niña ha hecho franca alusión al incesto, el terapeuta puede decirle: "Lo que me dijiste es comprensible. Mucha gente piensa que es terrible, pero aunque puede asustarnos, ocurre en muchas familias, y no es el fin del mundo. No porque sucedió en el pasado tiene que volver a suceder y yo haré todo lo que pueda para evitarlo en el futuro. Pero creo que es importante que conozca la verdad. ¿Hay algo más que me puedas decir al respecto?".

Cuando hay sospechas de incesto, el terapeuta debe tratar de construir una situación en la cual la niña se sienta lo más a gusto posible al contar su historia. Puede proceder de esta manera: "Pero tal vez no hubo efectivamente relaciones sexuales, aunque...". En cada paso el terapeuta va permitiéndole a la niña avanzar hacia el tema, dejando la oportunidad para que pruebe sus reacciones. "Tal vez se tocaron", es otra forma de tratar el asunto. De este modo se permite que la niña describa una parte, pero no todo lo ocurrido, dejándole la puerta abierta para cambiar de tema si es necesario.

Debemos asegurarnos de dar suficiente "distancia" emocional a la menor para que pueda retirarse si se siente amenazada, pero sin tener que abandonar por completo esa línea del interrogatorio. Utilizar la técnica de

"ilusión de alternativas", planteada por Erickson, puede ser útil para obtener un relato más completo de una chica asustada. El terapeuta puede decir: "Me puedes contar hasta donde te sientas a gusto respecto de lo que pasó entre tu padre y tú, y podemos esperar un rato antes de que me cuentes lo demás". Así se omite la opción de no continuar, pero se da a la niña un cierto control sobre qué tanto se revelará y cuándo.

Cuando se descubre el incesto

Al descubrir que el incesto está ocurriendo en una familia, no siempre es sabio ni necesario recomendar que la niña sea retirada del hogar, o proponer el rompimiento del sistema familiar. Es de lo más importante que el terapeuta esté consciente de sus propios sentimientos relacionados con el tema, con el fin de no actuar por arriba o por abajo de lo pertinente. Cualquiera de esos dos extremos puede contribuir a reforzar el mito familiar de que el resultado de la revelación del secreto será sólo "condena y destrucción", provocando probablemente que la víctima se retracte debido a que se han confirmado temores aún más grandes.

Como dijimos anteriormente, la sola mención del incesto puede introducir tensión en la conversación, mucho más de lo que lo hace el tema del abuso físico de los niños. Ésta es una de las razones por las cuales, durante años, la gente prefería considerar que una acusación de incesto pertenecía a las fantasías infantiles de un niño o una niña malcriados. Por otro lado, el tema del abuso físico evoca una cierta comprensión mutua, debido tal vez a que casi todo mundo puede admitir haber tenido, en un momento u otro, el ansia de golpear a un niño

desobediente. Y aunque la mayoría de la gente ha tenido pensamientos e impulsos incestuosos, no es socialmente aceptable hablar de ellos frente a otra persona. Es un tema difícil aun entre terapeutas, quienes conocen el impacto que sus sentimientos y prejuicios pueden tener sobre una familia a la que están tratando. Por tanto, es buena idea que quienes trabajen con familias incestuosas, lo hagan dentro de un equipo terapéutico. El trabajo en equipo es muy útil, pues el terapeuta tiene otros recursos para controlar y verificar sus impresiones clínicas. Un equipo que se reúne regularmente para consultas de casos, también puede ayudar con apoyo emocional al terapeuta, pues no se debe subestimar cuán emocionalmente desgastante resulta el trabajo con estas familias.

El descubrimiento del incesto puede significar para el terapeuta una enorme presión para no denunciarlo ante las autoridades (Everstine y Everstine, 1983, p. 147). Como ya mencionamos, no es raro que una víctima se desdiga y trate de convencerlo de que olvide el asunto. La amenaza subyacente es que si la familia se destruye debido a la revelación, la culpa será del terapeuta. Éste es un esfuerzo más por transferir a otras personas las responsabilidades de lo hecho por el padre sexualmente involucrado. La mayoría de estos padres tienden a evadir la responsabilidad por la pérdida del autocontrol, y su transferencia de la responsabilidad a otra persona frecuentemente es reforzada por los otros miembros de la familia que comparten los mismos mitos.

Esta conspiración del miedo es uno de los principales métodos usados por las familias incestuosas para protegerse y sostenerse. El terapeuta que permite que se le haga partícipe de la conspiración estará tomando un camino peligroso hacia el *modus vivendi* patológico de

la familia, lo mismo que hacia su complejo sistema de alianzas. En cambio, siendo franco respecto a su deber de denunciar los casos sospechosos de incesto, el o la terapeuta estará mostrando a la familia una manera sana y directa de confrontar los problemas. Además, le dirá con claridad: "No voy a entrar en su sistema. Estableceré reglas claras y estrictas y me conduciré de acuerdo con ellas".

Tanto las familias incestuosas como aquellas en las que se abusa de los niños, se caracterizan por negarse a entrar en tratamiento. Temen al cambio y a enfrentar los insidiosos problemas que han logrado esconder tan bien. Debido a esta tendencia, puede que sea necesario aprovechar la fuerza legal de un proceso sobre el caso, como medio para conducir a estas familias más allá de la primera y atemorizante etapa inicial del tratamiento. Nosotros hemos visto que el incesto no se detendrá, incluso una vez que ha sido denunciado, a menos que la familia reciba tratamiento. Y es muy probable que también se requiera una estricta supervisión legal.

Preguntas que deben contestarse antes de iniciar el tratamiento

Vale la pena insistir en que la mayoría de las familias incestuosas pueden reconstruirse de manera sana si se les da el tratamiento y los servicios de apoyo necesarios. Lo esencial es evaluarlas cuidadosamente antes del tratamiento, para que el plan de la terapia pueda asegurar una adecuada protección del menor. Una exhaustiva evaluación de la familia también puede ayudar a tomar la decisión legal sobre si el nivel de supervisión o separación familiar es apropiado durante el proceso de tratamiento. Es de esperarse que, en ciertos casos, el menor necesite

ser retirado de la custodia de sus padres. Ésta puede ser una situación extremadamente difícil y muy traumática, tanto como el mismo incesto. Sin embargo, cuando no existen los recursos suficientes dentro de la familia para proteger al menor de un abuso futuro, éste debe ser retirado de ella por su propia seguridad.

La madre es una figura clave en la evaluación de la familia en lo que se refiere a los recursos para proteger al niño de un futuro abuso. El terapeuta será llamado a responder preguntas fundamentales, relacionadas con la capacidad materna de asumir un papel protector apropiado en la familia. Evidentemente, lo primero que se debe hacer es comprobar el nivel de estabilidad mental básica, tanto del padre como de la madre, para ver si son psicológicamente capaces de funcionar como padres. Enseguida, el terapeuta debe considerar cómo se enteró la madre de la acusación del incesto en contra de su esposo y cómo reaccionó ante ello. ¿Se comportó de manera racional? ¿Tomó inmediatamente las medidas necesarias para proteger a su hija y buscar ayuda? ¿Hubo una lógica básica en sus acciones, aun cuando inicialmente soportó el shock y la consternación? ¿Estuvieron sus actos encaminados hacia el cuidado de la niña, o bien reaccionó ante el descubrimiento con rechazo y negación? ¿Rechazó la acusación calificándola de mentira o fantasía rehusándose a considerar su veracidad? ¿Acaso la niña contó el secreto a alguien más porque temía la reacción de su madre? Si trató de decirselo a su madre, ¿acaso ésta le transmitió el mensaje de que no estaba dispuesta a escucharla? Según nuestra experiencia, cuando hay tal negación y ausencia de apoyo hacia la niña de parte de la madre, generalmente es necesario dar supervisión legal y retirarla de su hogar.

El terapeuta también ha de considerar la frecuencia y la duración de la experiencia incestuosa. En caso de que después del primer incidente, la niña haya ido directamente a pedir ayuda a su madre (y la haya obtenido), uno puede asumir que hay una patología menos seria en el sistema familiar que cuando el incesto ha continuado por un período considerable. ¿Es posible que haya continuado durante años sin que la madre se percatara de ello? No es probable. En la mayoría de los casos en los que el incesto pudo haberse detectado y denunciado años atrás, seguramente más de un miembro de la familia ha gastado gran cantidad de energía emocional para mantener el *status quo* del sistema incestuoso. Y dado que más de un miembro ha estado involucrado, ya sea de manera activa o pasiva encubriendo el incesto, el terapeuta debe ser especialmente cuidadoso en la evaluación de esas familias.

Sería bueno que se preguntara por qué es ahora que el problema está saliendo a la luz. ¿Por qué la niña no pidió ayuda a su madre antes? Generalmente, la respuesta es que sabía que no obtendría ayuda alguna. La razón puede ser que la madre estuviera aterrorizada por un marido brutal. O puede haber sido el tipo de familia en el que la madre se coludió pasivamente con el incesto y hasta ahora está dispuesta a reconocer su complicidad. En tal caso, el terapeuta puede tratar de averiguar si en verdad está dispuesta también a detener el incesto de una vez por todas. O si hay algún factor que la conduzca a hablar abiertamente, aunque en realidad intenta mantener el sistema familiar incestuoso.

Un ejemplo de esta situación se dio cuando una madre vino a nuestra clínica, para denunciar que había descubierto una relación incestuosa de más de tres años

entre su marido y su hija de nueve años de edad. De acuerdo con la madre, la niña le había confiado el horrible secreto el día anterior. Exteriormente, parecía una figura verdaderamente trágica, profundamente herida por el descubrimiento del incesto y decidida a proteger a su hija de abusos futuros. Sólo más tarde, cuando ciertas circunstancias sospechosas llevaron al terapeuta a analizar la situación más detalladamente y consultar a un médico que había visto a la niña con anterioridad, se supo la verdad. Al examinar a la menor, el médico había encontrado pruebas de abuso sexual. Le dijo a la madre que tenía 24 horas para denunciarlo ante las autoridades, o si no, él lo haría. Además, en entrevistas con la niña, el terapeuta se enteró posteriormente de que en varias ocasiones la madre había estado presente en el cuarto mientras el incesto se llevaba a cabo, lo cual fue corroborado en la confesión del padre.

Por tanto, en casos de incesto de larga duración, el o la terapeuta debe estar completamente seguro de conocer toda la historia. No se debe asumir que los miembros de la familia le dirán todo lo que ha ocurrido.

Finalmente, un asunto que el terapeuta debe considerar al realizar la evaluación de una familia incestuosa, es la diferencia de edad que hay entre el padre y la hija sexualmente involucrada (Everstine y Everstine, 1983, p. 157). Si el terapeuta sospecha que se está dando un incesto entre un padre y su hija de dos o tres años de edad, la intervención tiene que ser más completa y agresiva que en caso de que la niña sea mayor, pues es de esperar que la patología sea mayor en estos padres. Debido a que puede haber un mayor riesgo de que el padre sexualmente involucrado pierda nuevamente el control, una niña de dos o tres años necesita protección inmediata. En cam-

bio, si la víctima es una adolescente, el terapeuta puede tratar de intervenir más cuidadosamente con el objetivo de desarrollar una relación de confianza con ella. Las víctimas adolescentes en ocasiones tienen más alternativas disponibles, pero los niños pequeños cuentan con pocos medios para encontrar ayuda y protección.

Temas sobre el tratamiento básico

Cuando el incesto es descubierto, el terapeuta debe considerar que toda la familia en cuestión está en crisis. Quiénes trabajan con ella deben hacerlo de común acuerdo para proteger al menor y darle apoyo. La familia necesita una estructura y tanta información como sea posible en relación con el curso seguido por el proceso legal.

El sistema y los individuos que lo componen

Los terapeutas deben estar alertas a que, durante la fase inicial de crisis-del-descubrimiento del incesto, cada uno de los miembros de la familia se encuentra en un considerable riesgo de suicidio y deben ser cuidadosamente vigilados. No debe ignorarse a los hermanos de la víctima, pues más tarde se puede descubrir que también ellos fueron víctimas del incesto, o acaso crean que de alguna manera son responsables o culpables por ello. Así pues, los terapeutas involucrados en el caso deben prepararse para jugar un papel muy activo de dirección hasta no estar seguros de que la crisis ha pasado.

Se debe permitir a la víctima que desarrolle una conducta de acuerdo con su edad, que ventile y trabaje en sus sentimientos relativos al incesto y, más tarde, que recupere el nivel de aprendizaje social que perdió a lo

largo de la duración del incesto. Sólo en raras ocasiones es posible realizar este esencial trabajo clínico dentro del contexto de sesiones familiares. De cualquier modo, antes de conducir *cualquier* terapia en la que se incluya al padre incestuoso, el terapeuta debe estar seguro de que éste asume toda su responsabilidad por el delito y está dispuesto a presentar una verdadera disculpa ante su hija. Estamos convencidos de que mientras un padre abusivo no asuma su responsabilidad y se disculpe auténticamente, no es apropiado que el terapeuta impulse el contacto entre él y la niña.

En la etapa inicial debe atenderse a los padres tanto individualmente como juntos, si no se han separado. Si éste es el caso, deben ser vistos a solas, con sesiones conjuntas ocasionales para tratar asuntos relacionados con los hijos (cuando sea posible). Esto no significa que la terapia familiar se olvide durante la etapa inicial del tratamiento; se está realizando, pero con los miembros del sistema vistos como individuos con el fin de que, eventualmente, se puedan reunir para trabajar en una entidad *unida*, como sucede en una sesión de terapia familiar habitual. E, incluso en los casos en los que la familia no se reúne, se puede decir que el trabajo en el sistema se está realizando a través de las terapias individuales de cada uno de sus miembros relevantes. Furniss (1984) escribió:

En casos de abuso sexual de menores, el trabajo terapéutico orientado hacia la familia no necesariamente implica que todas o la mayoría de las reuniones terapéuticas sean conjuntas. En ocasiones resulta inevitable o parece indicado ver a diferentes miembros de la familia o a subgrupos de ésta por separado. Pero aun el trabajo indivi-

dual debe integrarse a través de una estrecha cooperación entre los servicios involucrados. (p.309)

En resumen, las sesiones de toda la familia pueden ser una meta hacia la cual se puede guiar el trabajo durante las etapas iniciales del tratamiento, pero no son la modalidad idónea al empezar a trabajar con la mayoría de las familias incestuosas.

Al principio del tratamiento de estas familias, es sabio estructurar la terapia de modo que refleje cómo le gustaría a uno que cambiara el sistema familiar. Por ejemplo, los padres, deben aprender a funcionar como adultos capaces de atender a sus propias necesidades emocionales sin usar a sus hijos para ello. Además, los padres tal vez tengan que trabajar problemas psicológicos no resueltos con sus propios padres y familias de origen.

Cuando cada uno de los padres, lo mismo que la hija, tiene su propio terapeuta, se modela la estructura básica de un sistema en el cual los padres son dos individuos adultos, con una clara frontera generacional entre su identidad y la de su hija. En esta etapa es vital que los terapeutas trabajen conjuntamente, con un equipo que está ayudando a los miembros de una familia para que se desarrollen como miembros independientes de un sistema sano. Si el trabajo individual funciona correctamente, el equipo terapéutico puede avanzar hacia el establecimiento de subsistemas sanos dentro de la familia. Por ejemplo, la pareja puede empezar a reunirse con un terapeuta para trabajar los temas relacionados con asuntos de los subsistemas marital y paterno. El terapeuta que trabaja con la pareja durante este periodo debe dirigirlos a comprender que es mejor separar el subsistema marital del subsistema paterno, y que ciertos temas, como la sexualidad de los padres, deben permanecer dentro del

primero de esos subsistemas. La mayoría de estos padres constituyen una pareja disfuncional y, por tanto, requieren un trabajo considerable sobre la compatibilidad sexual, para alcanzar un nivel más sano.

Cuando la familia incestuosa incluye a más de un hijo, el terapeuta ha de tratar de reforzar la frontera generacional ayudando a los niños a desarrollar un subsistema fraterno separado. Esto puede lograrse ya sea por medio de sesiones con los hermanos o dentro de un grupo de niños. La decisión debe basarse en la complejidad y la severidad del caso, lo mismo que en las edades de los niños. Iniciar una terapia de toda la familia sólo resulta aconsejable cuando el funcionamiento de los subsistemas se ha asegurado.

Un tema crucial, que el terapeuta ha de trabajar con los padres en las familias incestuosas, es que ninguno de ellos puede recrear su infancia perdida o imaginaria a través de sus hijos. Aunque resulta importante que el terapeuta conozca lo sucedido en su historia, un interminable análisis de la misma llevaría a un callejón sin salida. Como observara Selvini Palazzoli (1984): "El presente contiene al pasado", y es el pasado contenido en el presente lo que debe trabajarse con el fin de ayudar a esos padres a empezar a funcionar como adultos aquí y ahora.

El terapeuta que trabaja con padres incestuosos debe ser muy disciplinado, tener en mente un plan de tratamiento y enfocarse con claridad hacia la transformación de sus formas actuales de comportamiento. En muchos sentidos, él o ella estará dando a esos padres el modelo de lo que es un papel sano de padre o madre, estableciendo expectativas claras de comportamiento y prohibiendo las racionalizaciones o intentos manipuladores encaminados a transferir la responsabilidad de controlarse a sí mismos.

*El trabajo con la niña**

La víctima de incesto necesita tener su propio terapeuta por varias razones. Necesita la seguridad de estar ante una persona independiente con quien podrá llegar a sentirse suficientemente segura como para compartir sus sentimientos relativos a lo ocurrido. Y necesita una clara separación de su proceso respecto del de sus padres. Suele no ser fácil establecer una relación de confianza con la víctima de incesto y se debe hacer todo lo posible para que ella sienta que su relación con el terapeuta es privada y segura. El terapeuta no debe sospechar nada si los comentarios iniciales de la niña respecto del incesto son emocionalmente planos, o incluso (superficialmente) positivos. Una vez más, uno no debe sorprenderse si la menor hace claros avances sexuales, si es seductora en general o si se comporta de cualquier otra forma sexualmente inapropiada. Este comportamiento cesará cuando empiece a sentirse segura con el terapeuta.

Como mencionamos en el capítulo 3, si un menor tiene este tipo de comportamiento, el terapeuta debe transmitirle claramente el mensaje de que se le acepta a él o a ella, pero no su conducta. Y, al igual que en los casos de hostigamiento, debe tratar de lograr que la niña sea capaz de exteriorizar el abuso como un evento que le sucedió, y no como parte de su concepción de la "realidad" de quién o qué es ella. Este proceso de exteriorización será vital para el desarrollo futuro de la personalidad de la niña, y contribuirá a que se base en un sano concepto de sí misma y un sentimiento de valor personal.

* En el capítulo 3 se expone una descripción más detallada del proceso de psicoterapia individual con menores en edad preescolar y escolar. En el capítulo 4 se presenta la descripción de los métodos terapéuticos individuales para los adolescentes.

En general, no es buena idea hacer que una víctima de incesto (o cualquier menor víctima de una agresión sexual) relate su historia completa de inmediato, a menos que esto sea de vital importancia, pues hay asuntos relacionados con la confianza y las fronteras personales que son esenciales para el desarrollo de la terapia de estos niños. La mayoría necesita hablar de todo lo sucedido, pero no deben ser presionados para hacerlo. En primer lugar, la niña puede malinterpretar al terapeuta creyendo que su interés obedece a la curiosidad, o incluso es una forma de avance sexual. En segundo lugar, si está involucrada en un proceso legal por el abuso, inevitablemente tendrá que decir su historia varias veces a adultos extraños, y relatar una y otra vez los detalles puede convertirse en una forma de actuación sexual para ella, lo mismo que en una manera inapropiada de excitación adulto-menor. Finalmente, ha sufrido algo más que una relación sexual patológica, de modo que el terapeuta debe orientar el tratamiento al contexto en que vive el menor. Si pone demasiado énfasis en lograr que el niño o la niña le cuente los detalles sexuales, este proceso profundizará el mito de que el menor es un objeto sexual dentro de las relaciones niño-adulto y no una persona completa. Además, se puede debilitar la estructura esencial de la relación terapéutica, la cual debe ser un modelo sano y seguro de las relaciones niño-adulto, donde la menor no tiene que hacer favores sexuales para que haya reciprocidad. Éste es el ambiente en el que se le debe animar a que relate su historia, siempre en sus propios términos.

Al principio de la terapia debe evaluarse cuánto puede aceptar o no la menor (Everstine y Everstine, 1983, pp. 158, 159). La intención del terapeuta es, en primer lugar, acercarse y tranquilizar a la niña. Pero aunque tal intención al acercarse para consolar a la niña sea auténti-

ca, debe considerar que, debido a su historia, estas niñas tienden a sexualizar las relaciones y pueden ser incapaces de discriminar entre las formas eróticas y no eróticas de contacto (Yates, 1982, 1987a). Dado que muchas de ellas no pueden interpretar correctamente los códigos sociales y los diferentes tipos de contacto, se recomienda que el o la terapeuta no las toque (o sea extremadamente cauteloso al hacerlo) durante la terapia.

Dado que la confianza de la víctima de incesto ya ha sido traicionada por un adulto en quien ella confiaba, el terapeuta debe estar preparado para ser continuamente puesto a prueba, y para enfrentar comportamientos provocadores por parte de la niña. Aun cuando su respuesta inicial sea de una gran dependencia, de cualquier modo verificará continuamente si el terapeuta es confiable. El asunto de la confianza es de capital importancia y en el proceso de establecer una relación, la menor puede "probar los límites" de un terapeuta durante largo tiempo para ver si su interés es genuino (Everstine y Everstine, 1983, pp. 158, 159; Yates, 1982, 1987a).

Los temas relevantes que emergen en el proceso de la terapia con víctimas de incesto son variados y complejos. Primero, la víctima debe resolver la confusión derivada del intercambio de roles entre su madre y ella, el cual le impidió ser una niña en toda la extensión de la palabra y ocuparse de su normal desarrollo infantil. Luego tenemos la necesidad de reparar el daño causado por la ruptura de la relación fundamental de confianza entre padre e hija y sus subsecuentes efectos sobre las demás relaciones. En tercer lugar, se debe tratar de ayudar a la víctima para que resuelva la aguda ansiedad provocada por haber sido estimulada sexualmente antes de que desarrollara una adecuada identidad y comprensión de la expresión de la sexualidad. El proceso de definición

de la personalidad y de desarrollo de la perspectiva de la vida no debe subestimarse, pues es el material básico a partir del cual se escriben los guiones de vidas positivas o las profecías autorrealizables.

El trabajo con el padre

Durante el desarrollo de la terapia, el padre incestuoso debe hacer un relato completo de lo que hizo a su hija y asumir completamente la responsabilidad por ello (Everstine y Everstine, 1983; Furniss, 1984). Lograr esto último no es tarea fácil. Algunos padres racionalizan tratando de disminuir la gravedad del suceso, insistiendo en que la niña disfrutó la relación; otros creen que al confesar lo que han hecho, mágicamente pueden lavar su responsabilidad. Por dramáticas que sean, las confesiones y declaraciones del padre en el sentido de que es una persona completamente nueva, habrán de tomarse con sumo cuidado. Es raro que la gente desbarate en un instante patrones de comportamiento de toda una vida.

Cuando el responsable del incesto intenta evadir la responsabilidad, el pronóstico del tratamiento de cualquiera de los padres no es muy bueno. De cualquier modo, la aceptación de la culpabilidad por parte del padre realísticamente debe ser vista sólo como un principio, pues todavía hay un considerable trabajo clínico por realizar sobre temas como el control de los impulsos, la correcta expresión del enojo, asumir un papel paterno sano en la familia y la capacidad de cuidar de los hijos adecuadamente. De hecho, el padre tiene que aprender a expresar el afecto y relacionarse con su hija o hijas de una manera no sexual y debe dejar de identificar el sexo con el poder. Durante el proceso se le puede guiar para que desarrolle una relación sexual más sana y "recíproca" con su esposa

(Jackson, 1968). Además, si se piensa que el padre consume alguna forma de enervante, uno no puede considerar que el hogar sea un sitio seguro para la víctima del incesto mientras no se haya resuelto ese problema. Si el padre incestuoso tiene un problema de dependencia del alcohol o alguna droga y vive fuera del hogar, pensamos que no se le debe permitir que regrese hasta que su problema haya sido controlado.

Como dijimos antes, un paso crítico en los esfuerzos del padre incestuoso para recuperar su papel auténtico de padre, es que presente una disculpa ante su hija por lo que le hizo. Esto no siempre es sencillo, y a menudo ha de planearse y supervisarse cuidadosamente. Se debe encontrar un equilibrio respecto de cuándo el padre es capaz de disculparse y cuándo la niña está preparada para escuchar la disculpa sin sentirse culpable o sin aprovechar la oportunidad para expresar su cólera en contra de él. Muchas víctimas pasan por un periodo de intensa cólera o de fluctuaciones incontroladas entre amor y odio hacia el padre incestuoso; de modo que es necesario pensar bien cuál es el momento adecuado para llevar a cabo esa disculpa, cuyo objetivo fundamental no es humillar al padre, sino iniciar el proceso de ayudarlo a cumplir con un adecuado papel de adulto y a ser responsable de sus actos.

El trabajo con la madre para reconstruir una dualidad madre-hija

De acuerdo con nuestra experiencia, una buena relación de trabajo clínico con la madre de estas familias es vital para el éxito del tratamiento, ya sea que los esposos vivan juntos o no. En muchos casos, la madre tiene tales problemas de necesidades insatisfechas de dependencia y tales conflictos internos relativos a su propia madre, que mien-

tras no entre en tratamiento tan sólo obstaculizará la terapia de su hija. Al igual que sucede con la madre de un menor agredido sexualmente (capítulo 3), ésta puede intentar sabotear la terapia trayendo a la niña tarde a las sesiones, interrumpiendo las mismas, olvidando citas, o quejándose de uno de los terapeutas o servicio de asistencia ante otro terapeuta o servicio. La mejor prevención es realizar un exhaustivo trabajo individual con ella, hasta que se sienta suficientemente segura en el plano emocional para tolerar el tratamiento de su hija. Uno de los aspectos fundamentales que debe ser trabajado al inicio del tratamiento, es la "herida" emocional que puede haber conducido inicialmente al incesto —específicamente el enojo de la madre por la demanda de cuidado y atención por parte de su hija cuando sus propias demandas estaban insatisfechas. A esto se añade la relación de amor/odio con su propia madre que, como consecuencia, la hace incapaz de aceptar su papel maternal en su totalidad.

Durante esta etapa inicial del tratamiento, el terapeuta no debe dejarse desviar por las manipulaciones de la madre para tratar únicamente su oposición a su propia terapia o a la de su hija. Eso le permitiría a ella "sellar" los asuntos más importantes que debe enfrentar en el proceso de lucha con el terapeuta.

Desde otro punto de vista, el profesional debe ser sensible al hecho de que muchas madres de familias incestuosas poseen antecedentes que pueden incluir un grave abuso, y (o) negligencia, y que algunas fueron ellas mismas víctimas de incesto durante la infancia. En tales casos, las cicatrices emocionales del maltrato original deben ser atendidas, para que la madre pueda funcionar de acuerdo con el papel que le corresponde dentro de la familia. Una vez que empiece a resolver los asuntos que le impidieron funcionar como una madre eficaz y protec-

tora y que sea más capaz de asumir su papel materno, el terapeuta puede trabajar activamente hacia el establecimiento de una dualidad madre-hija saludable.

El restablecimiento de esta dualidad debe considerarse un aspecto fundamental del tratamiento, ya sea que la familia permanezca unida o esté separada. El trabajo terapéutico puede realizarse en el contexto de sesiones conjuntas madre-hija o en un grupo para madres e hijas. La selección de la forma de tratamiento se realiza de acuerdo con factores como la edad de la niña, la gravedad y la complejidad de los temas clínicos por resolver. Las metas de esta parte del tratamiento (en grupo o sólo con la madre y la hija), son establecer un lazo emocional entre ambas y ayudarles a desarrollar un mutuo sentimiento de empatía. Es a partir del fortalecimiento de este lazo que se puede evitar el abuso en el futuro. Con el fin de que la madre y la hija lo alcancen, el terapeuta debe estar preparado para vencer la fantasía, el enojo y la proyección en ambas pacientes. Se puede empezar haciéndolas participar conjuntamente en actividades agradables y que no representen ninguna amenaza, como escuchar música, dibujar, contar cuentos o mirar fotos. Puede pedir a cada una que cuente a la otra lo que piensa y cómo se siente. Luego, preguntarles cómo piensa una que se siente la otra. No debe sorprenderse de que, aun en el contexto de una actividad simple y neutral, tanto la hija, pero especialmente la madre, tendrán considerables dificultades para comprender e interpretar los sentimientos y pensamientos de la otra. En los inicios del tratamiento, el terapeuta probablemente necesitará tomar un papel relativamente activo para enseñar a madre e hija cómo reconocer y responder adecuadamente a los sentimientos de la otra. A medida que desarrollen la capacidad de comprenderse mutuamente, él podrá cambiar su papel de director e instructor por uno más bien interpretativo.

Cuando la madre y la hija son capaces de "leer" las claves emocionales de la otra con cierta precisión, el terapeuta puede empezar a crear un lazo emocional más profundo entre ambas, utilizando las técnicas de cariño o establecimiento de lazos descritas por Long (1986). Si la hija es relativamente pequeña, uno puede pedir a la madre que la tome en su regazo y la arrulle o meza mientras el terapeuta la conduce hacia una plática sobre cómo se siente la otra persona. En el caso de una niña mayor, la madre puede tomar la mano de su hija o abrazarla, o cada una puede acariciar el rostro de la otra mientras hablan de cómo se sienten. Al igual que en las etapas iniciales de esta aproximación, al principio el terapeuta puede jugar un papel directivo; si las cosas funcionan bien, se puede transferir el papel más activo a la madre a medida que su capacidad de comprender y cuidar de su hija se va desarrollando.

Una vez que el terapeuta considera que la madre ha desarrollado una razonable empatía y cuidado por su hija, puede llevarla a explorar un nivel más profundo dentro del trabajo clínico. Puede pedir a cada una que describa algún evento del presente o pasado reciente desde la perspectiva de la otra. En otras palabras, se pide a la madre que describa cómo se sintió su hija respecto del abuso en cuestión y viceversa. Entonces, cuando el proceso se lleva a cabo satisfactoriamente, el terapeuta puede guiarlas hacia el trabajo directo sobre la experiencia del incesto.

El trabajo con los abuelos

En el caso de la familia incestuosa donde la madre tuvo una relación de tipo "Cenicienta" con su madre (la abuela materna de la víctima), el terapeuta nunca debe subestimar el poder que tienen esos abuelos dentro del sistema

familiar. Si no considera a los abuelos dentro del tratamiento, puede enfrentar serias dificultades. A veces el papel y la influencia de los abuelos son obvios, pero más frecuentemente se expresan sólo de manera sutil; sin embargo, son una fuerza importante dentro de la familia que debe ser considerada. Cuando esas madres se separan de sus esposos suelen volverse especialmente vulnerables ante la influencia negativa de sus propias madres; en ocasiones regresan a vivir con ellas al inicio de la separación. Hemos observado que mientras la madre de la víctima no logre individualizarse y romper con la relación simbiótica con su propia madre, no se encontrará en condiciones para proveer a su hija la protección y el cuidado necesarios. La razón es que sus propios conflictos respecto de lo que una madre es y hace son demasiado profundos.

Terapia de grupo

Muchas víctimas de incesto responden favorablemente a la terapia de grupo como parte del programa de tratamiento. Estos grupos deben estar bien estructurados y ser conducidos por terapeutas experimentados. Los niños y adolescentes que participan en el grupo deben ser clínicamente monitoreados para descubrir si están preparados emocionalmente para trabajar en un grupo. Cada participante debe dedicarse a los asuntos que sean congruentes con los de los otros niños o adolescentes del grupo. Recomendamos que los grupos se limiten a tres y diez miembros, tal como lo proponen Furniss (1984) y Furniss, Bingley-Miller y Bentovim (1984). Este trabajo de grupo puede ser una manera de ayudar a la víctima a deshacerse de sus sentimientos de aislamiento y de ser diferente de los otros niños.

Además de los grupos de niños, los grupos de padres pueden ser un buen respaldo del tratamiento, una vez que éstos han realizado el trabajo individual del inicio. Los grupos de madres o de madres e hijas son medios potencialmente útiles para conducir una parte del trabajo madre-hija ya descrito. Los grupos de padres incestuosos pueden ser un instrumento muy poderoso para el tratamiento, cuando son guiados por un terapeuta hombre de carácter fuerte. Tales grupos requieren una guía bien entrenado, suficientemente sólido como para vencer las fuertes defensas de esos padres, lo mismo que las complicadas manipulaciones de autoprotección que suelen usar. Pero también debe ser alguien capaz de darles un modelo estimulante o una figura paterna alternativa.

La terapia de grupo debe iniciarse cuando el terapeuta considera que algún miembro de la familia está listo para ella, pero sólo como complemento de la terapia individual. La integración a un grupo como primera modalidad de tratamiento no debe hacerse hasta que el equipo de terapeutas llegue a un acuerdo al respecto. Debido a las complejidades clínicas planteadas por estas familias, debemos subrayar el concepto de equipo y la importancia de consultar a sus miembros, antes de realizar alteraciones significativas al plan de tratamiento.

Es sabio considerar que no todas las familias incestuosas pueden llegar a reconstruirse de una manera sana; muchas se hacen a sí mismas exigencias poco realistas, asegurando de este modo su fracaso. Es importante que el terapeuta sea cuidadoso al respecto, principalmente porque se ha realizado muy poca investigación sobre las técnicas de tratamiento para los agresores sexuales (véase también Finkelhor, 1987). De hecho, existe una carencia de métodos de evaluación realmente válidos para discriminar a los agresores que pueden ser llevados a

tratamiento de aquellos que no lo son. Como consecuencia, el terapeuta tendrá que evaluar exhaustivamente a cada miembro de la familia con el fin de descubrir las posibilidades de reconstruir el sistema, lo cual puede ser un proceso largo que sólo puede lograrse con base en una extensiva terapia con cada uno de ellos; y, puesto que muchas familias nunca podrán alcanzar la reconstrucción, el terapeuta debe estar consciente de que su papel de ayudar a quienes no pueden reunirse nuevamente es tan importante como el trabajo con aquellos que sí lo logran.

Cuando no es posible reunificar a una familia, debe cuidarse que la separación de los padres dañe lo menos posible, o sea lo menos traumática posible, para la víctima del incesto. Más aún, el terapeuta tiene la responsabilidad de ayudar a que el menor entienda las razones de la separación, a que la asimile apropiadamente sin sentir que es su culpa. Obviamente, en la mayoría de los casos, la hija permanecerá con la madre después de la separación, y asegurar que esté protegida de futuros abusos es una labor crucial del terapeuta.



SEIS

El niño víctima



El concepto freudiano de "fase de latencia" se refiere al periodo del desarrollo, en ambos sexos, que va del quinto año de edad hasta la pubertad (Hinsie y Campbell, 1970, p. 427). En el caso de los niños varones, la pubertad se alcanza a los trece años. En este capítulo se presenta el tema del hostigamiento sexual de niños que se encuentran en este proceso de preparación de su papel sexual en la vida. Los años formativos son especialmente importantes para los varoncitos porque: 1) son aún relativamente impotentes en sus relaciones con los adultos y 2) aún no han "descubierto" a las niñas. Estas razones los hacen especialmente vulnerables a las agresiones de pedófilos.

Los niños en la fase de latencia no son en absoluto inactivos desde el punto de vista sexual, y si el término "latencia" implica un periodo de potencialidad, puede llevar a confusión. Especialmente a partir de los nueve o diez años, la mayoría de los niños entran en una rica

forma de experimentación que puede ser bien caracterizada como "sexualidad silenciosa". Excitados por la fantasía, pero perdidos en la perplejidad, los niños meditan sobre el tema durante horas inventando vagas teorías sobre las diferencias entre ambos sexos; realizan furtivas investigaciones en todos los libros médicos, enciclopedias o revistas que están a su alcance con el fin de responder a sus filosas preguntas sobre la anatomía y el destino.

El niño en esa etapa anterior a la pubertad pasa por años de angustia y confusión, que requieren gran ayuda y conducción por parte de los adultos. Sin embargo, en muchos casos los niños temen confesar sus fantasías o hacer preguntas a su padre, y son totalmente incapaces de expresar correctamente sus necesidades a su madre. (De hecho, el meollo del asunto es que son incapaces de saber cómo se sienten las niñas o las mujeres respecto de cualquier cosa.) Debido a que el tema del sexo es tan importante para el niño y al mismo tiempo algo reprimido por el fuerte tabú, tan sólo trata de esconder sus sentimientos y esconderse a sí mismo en un rincón. Ahí se le encuentra a menudo, soñando despierto con su colección de estampillas o su computadora o enfrascado en un diálogo incomprensible con su mascota de confianza.

Durante esos días de tormenta subterránea, quienes duermen pueden ser los padres. Piensan que entienden a su hijo y, sin embargo, como se ha vuelto extrañamente "tranquilo y callado" (lo cual se puede entender como "dócil" o "manejable"), tienden a ignorarlo y atender a otros asuntos. A menudo hay algún hermano o hermana menor que apenas está pasando por la ansiedad de haber entrado a la escuela, o tal vez los padres tan sólo se sienten aliviados por esas "vacaciones" de sus duras tareas paternales. En todo caso, el padre puede haber simplemente olvidado su propia etapa de represión sexual y la madre, no haber tenido una experiencia similar que le proporcione una buena perspectiva del asunto. Desde

el punto de vista de la madre, el niño se ha vuelto distante y raro, abandonando los fuertes lazos que tenía con ella a los seis o siete años. Por su lado, el niño no puede permitirse la cercanía anterior con su madre pues tiene que descubrir y comprender el "secreto" de su relación con ella y —algo aún más importante— de la relación entre ella y su padre. Si a esta edad tiene la mala suerte de ser testigo de relaciones sexuales, el trauma puede causarle un efecto profundo, no sólo por lo que aprende de la experiencia, sino por la infinidad de preguntas que tendrá que explorar.

Haya sido o no testigo de relaciones sexuales, de todos modos a este niño se le puede considerar altamente vulnerable, pues sus defensas son superficiales y débiles. Es especialmente susceptible a la influencia de los adultos fuera de su familia, tal vez porque los padres han perdido el contacto con sus preocupaciones y sus temores. Su espacio mental es una "ruidosa y floreciente confusión" y es presa fácil de cualquier forma benigna de control exterior. Es en este estado de ánimo que el agresor suele encontrar a su víctima.

Frecuencia del problema

En un artículo comúnmente citado, Finkelhor (1980) estimó que aproximadamente un nueve por ciento de la población masculina de Estados Unidos había sido hostigada sexualmente durante la infancia (p. 267), aunque otras estimaciones anteriores eran inferiores.* A pesar de que

* En su amplio estudio de las encuestas de prevalencia en la literatura de investigación, Finkelhor (1984, p. 166) informa de estimados que varían entre un 2.5% y un 8.7%. Se cree que lo más prudente es aceptar el estimado más alto, para efectos de prevención.

durante años se pensó que la frecuencia de hostigamiento a niñas era de diez a doce veces mayor que el sufrido por los niños, los datos actualmente aceptados (*San Francisco Chronicle*, 1985) nos dan una proporción de dos a uno (con preponderancia del hostigamiento en contra de niñas). Si estas cifras son exactas, es claro que un problema social altamente pernicioso ha sido finalmente reconocido después de décadas de olvido.

Otra característica demográfica de importancia, que diferencia a los niños de las niñas víctimas, es que el porcentaje de agresores *ajenos a la familia* es mucho mayor en el caso del hostigamiento sufrido por varones. En un estudio (Finkelhor, 1979), la relación fue de 83 por ciento a 56 por ciento (agresores de niños y niñas ajenos a la familia respectivamente). Esto se debe al hecho de que la forma más común de incesto es la relación entre padre e hija, lo cual significa que la mayor parte de las agresiones a niños son realizadas por hombres que no son sus padres. En todo caso, diferentes y exhaustivas investigaciones han demostrado que el agresor prácticamente siempre es un hombre; por ejemplo, Reinhart (1987) descubrió que el 96 por ciento de los agresores de su muestra de 189 casos eran hombres (p. 231).

Efectos en el niño

La agresión sexual afecta a los niños de manera diferente que a las niñas. Por ejemplo, se ha descubierto que ellos tienden a ser mucho más reservados respecto de la experiencia traumática; se cree que temen revelar la agresión a los miembros de su familia, tal vez por su necesidad de jugar el papel masculino de ser "fuerte y reservado" (Finkelhor, 1984; Fritz, Stoll y Wagner, 1981). Este fenó-

meno puede también explicarse por el hecho de que los niños reciben amenazas más duras del agresor que las recibidas por las niñas para que no digan nada. El miedo del niño quizá esté relacionado directamente con el grado y el contenido de la amenaza. Además, los niños pueden rehusarse a hablar de la experiencia debido al tabú en contra de la homosexualidad; esto es, si el agresor fue un hombre, el menor puede sentir la doble trampa de la censura por: 1) haber sido incapaz de defenderse y 2) la confusión de su identidad sexual.

Contrariamente a lo que ocurre con las niñas, se piensa que los niños agredidos han sido menos dañados por la experiencia. Este error de las investigaciones (Finkelhor, 1984; Fritz *et al.*, 1981) puede originarse en la concepción del método más comúnmente utilizado para recabar este tipo de información (cuestionarios supervisados de los recuerdos de hombres que alguna vez fueron agredidos). O puede que sea algo relacionado con el problema antes mencionado, a saber, que los niños son más temerosos de denunciar el hostigamiento. De ser esto verdadero, la conclusión es que los hombres que alguna vez fueron agredidos sexualmente pueden tratar ansiosamente de minimizar el efecto que el hecho tuvo en ellos. Al menos dentro de la cultura estadounidense, los hombres tienden a realizar un cierto "control del daño" emocional a partir del cual, una vez que confiesan haber participado en alguna acción, niegan que eso tuviera un significado importante para ellos.

En resumen, los niños que sufren una agresión sexual difieren de las niñas porque reprimen más el evento y sus consecuencias. Pensamos que esta tendencia *no* ayuda al desarrollo del ego. Así, mientras las niñas pueden ser mucho más gravemente traumatizadas por el hostigamiento, su candor natural respecto de los senti-

mientos, lo mismo que su mayor deferencia hacia la autoridad paterna, puede aumentar las posibilidades de que encuentren más rápidamente ayuda para su dolor.

Efectos en la familia

Existe poca investigación sobre la reacción familiar cuando se les revela que un miembro ha sido agredido sexualmente. Por tanto, nos apoyaremos en la experiencia de nuestra práctica clínica. Baste con decir que las repercusiones evidentes son devastadoras. El efecto principal es una tremenda confusión en la mayoría de los padres que reciben ese tipo de noticia. También para los hermanos suele ser un asunto de completa incompreensión. La primera reacción de las personas importantes que rodean al niño puede conceptualizarse como de *shock*.

Esto no significa que los padres —o los hermanos— no hayan sido más que testigos inocentes del evento. La posible complicidad de los miembros de la familia en el proceso que condujo a la agresión será expuesta detalladamente en una siguiente sección. En este contexto vale la pena anotar que las reacciones de los miembros de la familia pueden ser manifestaciones de sus propios sentimientos de culpa.

Inmediatamente después de la agresión, la dinámica de la familia se convierte en pura confusión. Al igual que cuando ocurre un accidente grave en la vida de un integrante y cada uno debe descubrir "cómo sentirse" al respecto, este tipo de agresión conlleva conflicto y cambios inevitables en el proceso familiar. Debido al tabú social en contra de la sexualidad "desviada" o "precoz", la familia debe cerrar filas y enfrentar la reacción de los vecinos y de toda la sociedad. El niño agredido debe ser

protegido de la censura y la burla de sus compañeros de escuela y de juego. Debe ponerse en claro ante los demás que sus hermanos no tienen que ver en este escándalo; y los padres seguramente desearán deshacerse siquiera de las capas más profundas de sus sentimientos de culpa.

Dentro de la familia misma es probable que se realice una reconstrucción de los papeles en la cual, al menos por cierto tiempo, el papel que normalmente juega el niño víctima se suspenda. Dado que él ha sido "herido", otros deben ocupar su lugar temporalmente. Lo peor es que nadie sabe por cuánto tiempo será. Un importante elemento de tensión creado por este tipo de trauma es que los que más quieren a la víctima se preguntan primero: "¿cuándo acabará esto?" y luego se desesperan porque "toma demasiado tiempo". En ciertas familias, el niño es puesto en el papel de inválido misterioso. En otras, se le trata alternadamente como paria o como el recientemente arrepentido hijo pródigo. Por ejemplo, puede ser enviado a casa de un pariente por un tiempo, hasta que los padres ordenen sus pensamientos y curen sus propias heridas. Durante su estancia fuera de casa, el niño toma el papel de Odiseo en una aventura lejana, a quien se le perdonan muchas cosas cuando regresa. Tales rituales tienen un valor más bien simbólico que real para él. No importa qué forma tome, esta pérdida del lugar correcto del niño es uno de los mayores obstáculos para que se dé el proceso de reconciliación que se describirá más adelante.

Efectos a largo plazo

La larga serie de pérdidas psicológicas típicamente sufridas por un niño agredido puede resumirse de la siguiente manera:

1. Su confianza en una persona (a menudo) mayor es traicionada.
2. Se ve inmerso en un espacio temporal en el cual las secuencias normales del desarrollo de la sexualidad se entremezclan o aceleran fuertemente.
3. Se le hace sentirse menos masculino por haber sido forzado a hacer algo en contra de su voluntad.
4. Es colocado en un nuevo y desestabilizador papel dentro de su familia.
5. Se vuelve vulnerable a la posible burla de sus compañeros y otras personas, como si fuera alguien "diferente".

Obviamente, ninguna de estas dificultades entra en el rango de las calamidades *esperadas* de la infancia o la adolescencia. Cualquiera de ellas puede contribuir a una reacción neurótica y, tomadas en conjunto, las experiencias son activos ingredientes del trauma. Además de la realidad de la agresión sexual en sí misma, estas cuestiones contribuyen a extender la traumática experiencia más allá del momento en el que los actos físicos cesan. Así pues, la pesadilla puede ser menos terrible que el despertar.

Al ayudar al niño a recuperarse, el terapeuta debe siempre recordar que este trauma ocurrió durante un período de rápido crecimiento emocional. Por ello, el tratamiento consiste, en parte, en ayudarle a recuperar su nivel de desarrollo. Este proceso puede compararse con el hecho de llevar a una persona a tomar un tren y llegar tarde a la estación; tal vez valga la pena apresurarse para llegar a la próxima estación antes de que el tren lo haga. Pero, como tal vez ese esfuerzo llegue a fallar, quizá sea más inteligente esperar el próximo tren. Sin embargo, el niño debe llegar al siguiente nivel de desarrollo y cualquier intento de intervención habría de tomar en cuenta el factor del tiempo.

En conclusión, el daño causado por la agresión sexual es tan grande que podemos considerar que el niño o adolescente está limitado tanto psicológicamente como en lo que se refiere a su entorno. Los efectos en el equilibrio familiar son profundos, de modo que la reconstrucción del ego herido y la restauración de la debilitada estabilidad familiar pueden ser un largo proceso, que quizá tome años en ciertos casos.

Origen de la agresión

Este crimen tiene su origen en un contexto patológico de dos ramas: una dentro de la familia de la víctima y otra dentro de la distorsionada fantasía de la vida del agresor. En esta sección se examina primero el medio que puede llevar a un niño a convertirse en una víctima potencial. Más adelante rastreamos las claves hacia las motivaciones del agresor potencial.*

* Se debe hacer una distinción entre dos tipos claramente diferentes de agresor. Algunos pedófilos violan a sus víctimas; estos psicópatas son parecidos a los asesinos múltiples, cuyas víctimas son generalmente escogidos al azar. En esencia, ellos odian a los niños. El menor agredido es aquel que pasa por ahí en el momento inadecuado y se convierte en un "blanco oportuno". En contraste, la mayoría de los pedófilos en realidad buscan una relación con la víctima y se sienten ligados al niño física y/(o) psicológicamente. Una vez que se establece la relación, el agresor la cultiva cuidadosamente. Esta distinción implica que, mientras algunos niños son agredidos *en contra de su voluntad*, la mayoría son activamente *conquistados* por el hostigador sexual. El proceso permite que el abuso sexual se prolongue y se repita (a diferencia de un evento único). En este capítulo se expone principalmente la forma más común de abuso sexual de niños.

Dinámica familiar

La vulnerabilidad ante la agresión sexual se deriva de más de una fuente y ésta es una razón por la cual el trauma subsecuente es tan difícil de tratar. Así como no existe ninguna familia típica de donde surja la víctima, tampoco puede haber una aproximación estereotipada de la terapia familiar para estos casos. Existe una variedad de alianzas familiares patológicas y estilos deficientes de enfrentar la vida que incrementan la probabilidad de que uno de los hijos, en este caso un muchachito, se convierta en víctima de una agresión sexual. Algunos de tales ambientes familiares se pueden ejemplificar con la siguiente tipología encontrada en nuestra práctica, aunque en ningún caso se trata de una lista exhaustiva:

- una situación en la cual los padres están a punto de separarse o divorciarse; este tipo de competencia puede hacer que uno o varios hijos sean usados como objeto de negociación
- una familia nuclear que incluye a un miembro no nuclear, como un hijo adoptivo (o un hijo que técnicamente no "pertenecer" al núcleo porque es ilegítimo); este tipo de niño a menudo es víctima de negligencia dentro del hogar; también, algunas constelaciones familiares requieren un chivo expiatorio, papel conveniente para el niño cuyo estatus es incierto; contrariamente a lo que sucede en la familia esquizofrénica, algunas familias permiten que un miembro sea expuesto al peligro proveniente de alguien *fuerza* del círculo familiar
- una familia con un solo progenitor en la cual, por ejemplo, el niño que se queda con su madre es llevado a realizar el papel de "hombrecito de la casa" (o esposo sustituto) ante la madre

- una familia en la cual hay un niño que, debido a influencias desconocidas durante la primera infancia, es afeminado; la acción del conflicto familiar resultante de esa difícil tendencia puede llevar a la táctica de intentar ignorar el problema, lo cual se convierte en una forma de negligencia.

Cada una de estas orientaciones familiares o patrones de funcionamiento se describirá detalladamente a continuación.

El niño atrapado en una guerra entre los padres puede sufrir de muchas maneras, y la peor no es sólo "perderse en la escaramuza". Cualquier médico o terapeuta que realiza trabajo forense con casos de custodia sabe cuán crueles pueden ser algunos padres al juzgar las capacidades paternas o maternales de su pareja. Esto obviamente es el medio para obtener la custodia principal o alguna otra concesión en el eventual arreglo de divorcio.

El niño que se halla en la fase anterior a la pubertad cuando atestigua estas desavenencias, se siente devuelto por ellas pues guarda resentimiento hacia el padre acusador y culpabilidad empática hacia el acusado. En el peor de los casos, este niño se sentirá responsable por los supuestos errores de ambos padres. Aunque muchos menores no sufren un daño permanente a causa de su participación en el proceso de divorcio, todos son afectados por él y algunos no pueden soportarlo. Las defensas más elementales y superficiales de algunos se llevan a su límite cuando se desintegra la familia. Y si el niño es obligado a escoger con cuál de sus progenitores desea permanecer —como frecuentemente ocurre cuando tiene ocho o nueve años o más—, el estrés que se crea es extremo, pues se le coloca en una situación en la que no puede

ganar. En tales circunstancias, cuando el centro de la vida de un niño está hecho un caos, no es sorprendente que sea receptivo a un cuidado paternal proveniente de una fuente ajena al hogar.

Si el menor ha sido designado como chivo expiatorio de la familia o es visto de manera "diferente", puede sentir que una pared invisible e incomprensible lo separa de los otros miembros. Este niño puede ser el "hijo de en medio" a quien se le priva de la atención y el afecto de los padres porque hay demasiados niños y no hay amor suficiente para todos. O puede ser el hijo menor de padres que tuvieron uno más de lo que debían. Más aún, dentro de una familia, fruto de la unión de dos familias, puede estar como "perdido". Este niño puede sufrir un destino tan complicado como el de ser ignorado, pero a medida que aumenta su aislamiento del núcleo de la familia, va creciendo su separación respecto de sus padres.

Un ejemplo del niño que es un extraño dentro de su propia familia es el que fue víctima de incesto con su madre de los cuatro a los seis años. Cuando sus padres se divorciaron, el niño fue enviado con su padre debido a que su madre no era capaz de cuidarlo. Con el tiempo se descubrió que el padre, un hombre de muy poca inteligencia, tampoco podía encargarse de él, de modo que una tía suya fue convencida a adoptarlo. Durante un corto tiempo esta tía pareció ser quien mejor cumplía el papel materno, hasta que ella y el tío tuvieron un hijo. En esa época el niño estaba entrando en la fase de latencia, pero los padres adoptivos se ocupaban más y más de su nuevo hijo.

Poco a poco, el niño fue encargado al hermano del padre adoptivo para que lo cuidara. Este hombre abusó sexualmente de él durante un año. Primero víctima de su propia madre y luego de un pariente, este niño fue traicionado en dos ocasiones por un sistema familiar defectuoso.

El niño que debe servir a su madre de "hombrecito de la casa" pierde su infancia antes de saber cómo disfrutarla. Este menor sin padre necesita del amor de su madre más que nadie, pero ella tiene sus propias necesidades, y sus mecanismos para enfrentar la vida pueden no estar a la altura de la tarea de ser ambos padres ante su hijo. En un caso marcadamente diferente del anterior, el niño también se encontró en un laberinto de alianzas. Su padre biológico había abandonado a su madre poco después de nacer él y más tarde apareció un padrastro que le dio el cuidado paterno que no había conocido; el apellidado del niño fue cambiado por el del padrastro a quien él idealizó. Cuando el niño tenía cerca de ocho años, su madre se divorció de este segundo marido y le impidió verlo durante varios años. Cuando por fin la madre se dio cuenta de que su hijo necesitaba una figura de autoridad masculina en la vida, lo inscribió en el programa "Hermano Mayor", pero ahí precisamente sufrió el abuso sexual en manos de su "Hermano Mayor" durante varios meses. En dos ocasiones la madre había abandonado un matrimonio desastroso creando una relación simbiótica con su único hijo, cuya lealtad hacia ella entró en un agudo conflicto con su necesidad de asimilar la masculinidad y avanzar hacia su desarrollo como hombre.

Un niño afeminado descubrirá que el intervalo anterior a la pubertad se hace cada vez más doloroso. Los padres se irán angustiendo por el "estado" del niño y su angustia no hará sino confundirlo aún más. Es posible que el menor no tenga ningún parámetro para juzgar sobre su propia masculinidad, de modo que probablemente se pregunte qué ha hecho para que sus padres lo miren frunciendo el ceño.

En un caso de este tipo, un chico de 14 años había llegado exitosamente a la pubertad soportando los conflictos él solo, pues tenía miedo de confiarle esas cosas a

su puritana madre divorciada. Aun cuando ya había tenido experiencias heterosexuales, el muchacho era todavía muy delicado, sensible y tímido. Su madre, malinterpretando eso como tendencias homosexuales, decidió inscribirlo en una organización juvenil, con el resultado de que sus peores miedos se realizaron cuando su hijo fue agredido sexualmente por uno de sus consejeros.

El tema subyacente en el anterior recuento de los factores que contribuyen a que un niño carezca de las defensas necesarias en contra del abuso sexual es la ausencia del padre. Los ejemplos de casos presentados dan una clara descripción del efecto en el niño del rechazo por parte de su padre, sin importar la forma que éste adopte y cuyo peor caso es el abandono. La fuente del dilema del niño es la experiencia de perder al padre en un periodo crítico del aprendizaje de la masculinidad. Muchos niños víctimas de abuso sexual son esencialmente, de un modo u otro, niños sin padres. Éste ha sido obligado a abandonar el hogar o ha abandonado su papel de padre en el preciso momento en que el hijo más necesita su presencia, su mirada y su estímulo. Cuando el jovencito no tiene el modelo masculino apropiado durante este crítico periodo preadolescente, como si estuviera hechizado, experimenta un retraso en su proceso mientras su cuerpo evoluciona de acuerdo con su propio programa. El padre perdido se convierte en el héroe idealizado y, en la fantasía, el agresor toma ese lugar. El niño que está en riesgo de sufrir el abuso es aquel que carece de guía sobre los valores sexuales. Encuentra maestros fuera de su casa, pero pueden tanto servirle de él como servirle de influencia benéfica.

La renuncia de una figura paterna como guía de un jovencito es la clave de la comprensión de su susceptibilidad a convertirse en víctima del abuso sexual, lo mis-

mo que un punto de partida para la psicoterapia después de la agresión y el trauma que se deriva de ella. Esta aproximación al problema será expuesta en detalle en la última sección de este capítulo.

La mentalidad del agresor

De acuerdo con cualquier patrón de conducta razonable, la persona que agrede sexualmente a un pequeño niño es un psicópata que no merece ninguna simpatía. Pero de acuerdo con el perfil policiaco anteriormente citado (capítulo 1), el hostigador sexual frecuentemente esconde su identidad tras un manto de respetabilidad. Repitiendo, este tipo de persona generalmente tiene entre veinte y treinta años, es profesional, está casado y tal vez tenga hijos, habiendo hecho creer a quienes lo rodean que es un "buen ciudadano" fuera de toda sospecha. Si esta descripción es acertada, se trata de un tipo de criminal difícil de localizar y aún más difícil de condenar y castigar. Con el fin de desmascarar a ese tipo de travesti, vale la pena echar un vistazo a lo que hay detrás de la máscara.

El hostigador suele escoger a niños como víctimas porque le resultan objetos "seguros" sobre los cuales fácilmente puede ejercer control. El niño, por su parte, generalmente sufre de la ausencia o carencia de un padre, de modo que el agresor inicialmente se aprovecha de esa necesidad. Trata entonces de convertirse en consejero, confesor o "amigo" del niño. En cierta ocasión, un hombre agredió durante dos años al menos a 30 niños de entre seis y quince años en un barrio residencial utilizando un plan muy astuto. Consiguió trabajo en una tienda que permanecía abierta hasta muy noche y se había convertido en centro de reunión de los jovencitos del barrio. A escondidas les daba dulces, bebidas gaseosas o revistas

de *comics* y en ocasiones cerveza, hasta que los chicos confiaban en él y lo consideraban un "buen tipo". Luego usaba los regalos como anzuelo para invitarlos a su casa. Los engatusaba para que le tomaran fotografías mientras tenía relaciones sexuales con otros niños y luego los chantajeaba con esto para obligarlos a tenerlas ellos también. Este patrón de abuso fue descubierto cuando uno de los chicos, sintiéndose rechazado por el agresor, contó a sus padres lo que estaba sucediendo. Nosotros participamos en el tratamiento del trauma sufrido por cuatro de las muchas víctimas de este hombre.*

El ejemplo anterior muestra cómo un astuto pedófilo puede buscar y aprovecharse de la vulnerabilidad de niños necesitados. Se convierte en el "buen papá" que nunca se enoja ni castiga arbitrariamente, que acepta al niño por lo que es y satisface sus caprichos. Sin ser necesariamente consciente de ello, el agresor explota la intensa curiosidad sexual del niño y le da ciertas respuestas (aunque erróneas) a sus preguntas sobre cómo sienten y qué hacen los adultos.

El tipo de hombre que satisface sus necesidades agrediendo niños, muy probablemente fue el mismo agredido durante su infancia. Haya sido así o no, de todos

* El agresor había sido encarcelado en dos ocasiones anteriormente por el mismo crimen y condenado a seis años de cárcel, pero fue soltado bajo la condición de que recibiría asistencia psicológica. Después de 45 sesiones grupales de asesoramiento, un psicólogo recomendó que se le diera la libertad sin condiciones. Más tarde, se supo que había abusado de niños durante los últimos meses de su sesión. El verdadero terror comenzó cuando se terminaron éstas y pasaron más de dos años antes de que volviera a ser encarcelado. Finalmente fue sentenciado a 104 años de prisión.

modos se trata de alguien que se quedó bloqueado en una fase adolescente del desarrollo, lo cual no se refiere a lo que la persona hace sino a cómo se *siente*. Esto fue muy bien aclarado por Geiser (1979), quien escribió: "Los agresores de niños son, probablemente, ellos mismos niños en lo psicológico. Se identifican más fácilmente con niños y se sienten más cómodos en su presencia" (p. 89). Este grotesco Peter Pan, cuyo entrenamiento psicosocial se detuvo durante la adolescencia, muy probablemente no tuvo una correcta presencia paterna. Su experiencia lo llevó a convertirse, ante sus víctimas, en el padre idealizado; siendo al mismo tiempo perversamente capaz de castigar a su propio padre negligente a través de sus crímenes.

El agresor es un hombre que debido a sus deficiencias tiende a depender de mujeres en cuanto a cuidados y apoyo. Siempre ha encontrado una fuente de alivio en las mujeres adultas que lo guiaron a lo largo de su primera infancia. Como resultado, se ha vuelto dependiente de las figuras de autoridad femeninas siendo consciente de este aspecto de sí mismo. En un nivel inconsciente, tiene una fuerte identificación con las mujeres, pero nunca se atrevería a admitir o confrontar a esa *per sona* interior.

El agresor de niños tiende a negar su homosexualidad. Como dijera Geiser (1979): "No es raro que un agresor de niños exprese fuertes sentimientos en contra de los homosexuales" (p. 92). Este autoengaño es la clave para comprender el hecho de que en muchos casos es un hombre casado y padre de niños. Al no tener experiencias homosexuales directas de adulto a adulto se las arregla (mediante cierta lógica) para evadir el estigma de ser "gay" viviendo una mentira al compartir su vida con una mu-

jer. No se considera bisexual porque sus relaciones homosexuales con los chicos no "cuentan". En ese clima de autoengaño e impostura no sorprende que en muchos casos el matrimonio de un agresor de muchachitos haya sido una relación superficial sin amor anterior al descubrimiento de la realidad. La razón por la cual dura tanto tiempo puede ser la relación de dependencia acordada dentro de la pareja, en la cual la mujer está satisfecha de jugar el papel materno.

En resumen, el hostigador de muchachos es una personalidad inadaptada que se aferra a las mujeres y trata de probar su valía como hombre. Sus víctimas son escogidas porque son impotentes para resistirse a él debido a su obsesión de encontrar un padre, misma que el agresor probablemente experimentó siendo niño. Este tipo de agresor es un homosexual con una diferencia: no es capaz de aceptar su homosexualidad y gasta mucha energía en dispersar las sospechas que pueden pesar sobre él. A diferencia del homosexual, no busca una pareja, sino un esclavo.

Y puesto que es un psicópata que no se conoce a sí mismo, puede dañar a otros durante mucho tiempo. Resulta evidente que un agresor sexual de niños es terriblemente resistente al tratamiento o la rehabilitación; pero los métodos para vencer esa resistencia no son el tema de este libro.

No hay mucha investigación al respecto, pero algunos terapeutas concuerdan en que el hombre agresor más seriamente perturbado es ambivalente sobre si su víctima es un niño o una niña. Esto es, el agresor de un niño igual puede agredir a una niña si se le presentara la oportunidad. Una de tales opiniones fue firmemente expuesta por Geiser (1979) de la siguiente manera:

Cualquier grupo seriamente interesado en la seguridad sexual de los niños en el salón de clases haría bien en concentrarse en los pedófilos: hombres sexualmente interesados en los pequeños, sin importar su sexo. (p. 93)

Este punto de vista puede ser correcto conceptualmente, pero no es exacto en cuanto a los detalles. En realidad, hay pedófilos que no se interesan en absoluto en los varoncitos. Encontramos a un agresor de este tipo en la prisión, en donde empezaba una condena de 21 años por haber raptado y violado a una niña. La larga sentencia se justifica porque ya había sido antes condenado por el mismo crimen.

El hombre presumía de lo hecho. Decía que había tenido muchos encuentros sexuales con mujeres anteriormente (nunca se había casado), pero que encontraba que éstas eran muy difíciles de satisfacer y llevarlas a alcanzar un orgasmo. En cambio, las niñas eran fáciles de satisfacer: "Te dejan hacer lo que sea, les encanta". Este hombre admitía voluntariamente su crimen y aceptaba la sentencia que pesaba sobre él como algo merecido. Sin embargo, el orden de los sucesos que lo condujeron a secuestrar niñas puede considerarse desde otro ángulo. Su comportamiento lo llevó a una situación en la cual sería encarcelado por muchos años compartiendo una celda con otros hombres. Él sabía eso desde antes, pues ya había estado en prisión. A través de la agresión en contra de una niña había realizado una fantasía homosexual que era incapaz de articular o comprender. En pocas palabras, existe una corriente subterránea de homosexualidad latente en la orientación sexual del pedófilo que busca muchachitas. Su caso es el de la personalidad

extremadamente inadaptada porque simultáneamente lo terrorizan las mujeres y es incapaz de hacer realidad su atracción por los hombres.

Métodos de tratamiento recomendados para los niños víctimas de abuso sexual

Una preocupación central de la psicoterapia para niños víctimas de una agresión sexual debe ser la necesidad de reconciliación del niño con su padre o, en los casos más difíciles, de un padre sustituto. Esto inicialmente nos hace considerar la conveniencia de una aproximación a partir de la terapia familiar, pues cualquier liga sana que se pueda restablecer entre padre e hijo requiere el cambio de alianzas en el resto del sistema familiar—por ejemplo, entre el padre y los hermanos del chico o entre madre e hijo. Tal aproximación será abordada más adelante en esta sección, después de la presentación de un caso frecuente en el cual el padre está realmente ausente de la vida del niño, o en el cual la reconciliación entre ambos no sería aconsejable.

Una cuestión fundamental que debemos mencionar aquí es la expectativa de que los niños imiten, tan pronto como sea posible en su desarrollo, las cualidades de la masculinidad consideradas ideales en nuestra cultura. Por ejemplo, se espera que los hombres sean sexualmente agresivos, y se les considera débiles o tontos si muestran miedo o confusión en torno al funcionamiento de la sexualidad. A partir de esto, en casi todas las familias se deja que los niños se las arreglen solos para averiguar qué es el sexo y que se guarden sus du-

das para ellos mismos. Estos factores son constitutivos del problema del niño agredido porque su conducción hacia una actividad sexual prematura puede introducir la duda de su adaptación a su papel de hombre. De hecho, se ha sometido a los halagos de otra persona cuando debió rechazarlos; se dejó llevar por un impulso físico cuando debió resistir con todas sus fuerzas. Es claro que el hostigamiento no sólo detiene el desarrollo sexual del niño. Pone en duda su capacidad para defender los valores que le han sido enseñados desde temprana edad, pone en duda su moralidad y su identidad masculina.

Este tipo de desafío para la capacidad de un niño de volverse hombre, puede ser aún más duro en el caso de que haya sido agredido por una mujer o una muchacha. En tal caso, los papeles del agresor y del sometido se invierten. Por ejemplo, un niño de diez años fue agredido por una vecina adolescente, y aunque aparentemente sólo sucedió en una ocasión, los padres se alarmaron ante su incapacidad para negarse y durante un tiempo no pudieron evitar poner en duda la resistencia del niño ante cualquier forma de tentación.

Cuando se desafía la confiabilidad de una persona, su propia capacidad de confiar en los demás puede verse sacudida. Por ello, el establecimiento de la confianza es crucial para iniciar el tratamiento de un niño traumatizado. Se debe pensar muy seriamente si el terapeuta debe ser un hombre o una mujer. Su sexo presenta ventajas y desventajas en este tipo de casos; los varones en edad preadolescente y adolescente responden mejor al tratamiento con hombres, mientras los pequeños de seis o menos años de edad, se relacionan mejor con una terapeuta mujer. Pero si el consejero hombre de alguna manera le recuerda a su agresor a la víctima, ya sea por su apariencia o por su manera de ser, la transferencia necesaria tal vez no se realice.

Es probable que el niño tenga dificultad en contar a una mujer terapeuta lo que le sucedió. Sería esperar demasiado suponer que le cuente los detalles de la agresión sexual a una mujer que nunca antes ha visto. De hecho, tal como exponeremos más adelante, el hijo de una madre soltera o sola puede incluso rehusar decirle a ella los detalles de lo ocurrido. Considerando todo esto, el niño de nueve años o más, probablemente debe ser visto, al menos al principio, por un hombre terapeuta. La ventaja más importante es la oportunidad de usar la terapia como medio para desenredar la problemática relación entre padre e hijo, o para construir un puente hacia nuevas fuentes de cuidado paterno para el niño que ha sido abandonado por su padre. La transferencia, si se crea de manera satisfactoria, puede servir para atraer la atención del padre o del más cercano equivalente paterno. Es importante que ese hombre ponga atención pues su compromiso con una nueva forma de percibir al niño será vital en las etapas finales de la terapia.

Etapas iniciales

Se requiere paciencia para establecer la confianza. Cuando un niño que ha sido sexualmente agredido llega a la oficina de un terapeuta, es muy probable que sienta temor si no ha tenido antes este tipo de encuentro. Si no ha sido correctamente preparado por sus padres, es posible que también esté resentido. La mayor dificultad es que, en un nivel consciente, el niño se da menos cuenta de que tiene un problema de lo que pueden ver los adultos cercanos. Sabe que le ha pasado algo "terrible" y puede o no sentirse mal al respecto, pero no se le puede hacer intuir que "está mostrando síntomas" o "sufriendo de un desorden emocional". No se da cuenta de que está viviendo un trauma porque está en el trauma.

Lo que el niño desea más que nada, especialmente durante las primeras semanas después de haberse revelado el abuso sexual, es olvidar completamente el asunto. Quiere jugar con sus amigos o irse a pescar con su padre, o ver televisión—cualquier cosa que él perciba como vivir una vida normal y le asegure que la pesadilla ha terminado. Visitar el consultorio de un terapeuta no está en la agenda de un niño.

El terapeuta procederá con más precaución que la acostumbrada para el establecimiento de la transferencia con el niño, reconociendo y aceptando sus resistencias como una fase natural en la recuperación del trauma. En la primera sesión, cuando uno o ambos padres han acompañado al niño al consultorio, es buena idea recibirlos presentándose a uno mismo y pedir al niño que pase solo a la sala de terapia. El objetivo es evitar que se quede solo en la sala de espera durante un largo rato mientras los adultos hablan de "su caso" y su angustia se incrementa minuto a minuto. (Este procedimiento debe ser explicado a los padres cuando hacen la primera cita.) Cuando el niño esté en el consultorio es conveniente empezar inmediatamente con una serie de preguntas fáciles de contestar, tales como su edad, el grado que cursa en la escuela, el nombre de su escuela, sus materias preferidas, las que menos le gustan y su deporte favorito. Si el niño está extremadamente tenso, estas preguntas pueden prolongarse como una forma de toma de historia clínica con el propósito de calmarlo. La mayoría de los niños se sienten cómodos ante este tipo de cuestionario pues les recuerda la rutina escolar normal.

Después de un breve tiempo para conocerse de esa manera, se abren varios caminos posibles. Por ejemplo, el terapeuta puede empezar el proceso haciendo prue-

bas si éste es el método de trabajo adoptado para la terapia. Una vez disminuidos los temores del niño, generalmente se le puede convencer de hacer varios dibujos del tipo Dibuja a una Persona (Harris, 1963) en el primer día. Una alternativa consiste en que el terapeuta le diga cuáles son las posibilidades de terapias de juegos en el tratamiento, como damas, ajedrez, etcétera o construir modelos para armar un auto o un avión. El objetivo inmediato es darle al niño una idea de qué beneficios obtendrá de sus posteriores visitas. Una meta más amplia es poner en claro, desde el principio, que el terapeuta está preocupado por él y lo considera una persona, y no una víctima. Hacia el final de la sesión, el niño puede ser conducido a la sala de espera, de preferencia dándole un juego o actividad para que se distraiga, mientras el o los padres entran al consultorio en su lugar. Ya sea en ésta o en entrevistas posteriores con los miembros de la familia, es importante que el terapeuta conozca tantos detalles respecto del abuso como sea posible obtener.

En la segunda sesión se continúa el proceso de conocerse mutuamente (y se pueden aplicar más pruebas de proyección si así se desea), pero el objetivo principal es establecer las bases contractuales de la relación entre el terapeuta y el niño. Se deben dar pautas para que éste sepa que dentro de la terapia hay cosas más profundas que los simples juegos o la realización de pruebas con el fin de ayudarlo a construir expectativas realistas sobre lo que se busca con las sesiones. En el capítulo 3 se presentó una sugerencia sobre cómo presentar esas pautas a niños de ambos sexos. El objetivo es animar al menor para que describa lo que le sucedió de manera tan completa como le sea posible. Este recuento será vital para la terapia, pues permite que el terapeuta comprenda la forma en

que el niño *percibió* la agresión. También aclara el punto de vista del niño sobre qué tipo de relación existía entre el agresor y la víctima antes de que se diera el abuso sexual. De hecho, es necesario saber qué fue lo que condujo al abuso y qué significado tuvo desde el único punto de vista que cuenta: el del niño.

Bien sea en la segunda sesión o más tarde en el tratamiento —lo cual debe ser indicado por la intuición del terapeuta—, es importante realizar la siguiente secuencia de afirmaciones (ésta es una aproximación que puede modificarse como se desee tanto en su forma como en su contenido):

1. Sé que has tenido una experiencia con un adulto. Alguien te hizo algo malo que no debía haber sucedido; sin embargo, eso no acaba con tu vida.
2. Es importante que me digas lo que sucedió y que lo hagas cuando estés listo. Yo estoy aquí para escucharte, no para hacer un montón de preguntas o para darte una conferencia. Si hay algo de lo cual no quieres hablar, no tienes que hacerlo.
3. Si tú quieres, puedo decirle lo que me cuentas a tu (papá, mamá, adulto importante). No le diré nada a menos que estés de acuerdo.

Se entiende que estas afirmaciones deben ser dichas con suavidad y precaución. En el caso de un niño extremadamente frágil, deben estructurarse de forma aún más sutil.

Una muy útil fuente de información, respecto del estado actual de la dinámica de personalidad del niño, es la batería de pruebas de proyección comúnmente usadas tales como la Rorschach y la TAT (o CAT con niños muy

pequeños). Cuando no se tiene otra información, al menos se puede evaluar la intensidad del trauma. Además, si el niño tiene problemas en la escuela como síntoma posterior al trauma, se puede medir el nivel en el cual su desempeño ha descendido por debajo del que corresponde a su edad (por ejemplo, usando la Prueba de Desempeño de Rango Amplio, *Wide Range Achievement Test*). Si la diferencia es importante, se puede aplicar una prueba de Coeficiente Intelectual, mediante la cual tal vez se vea que el niño tiene las capacidades necesarias para desempeñarse correctamente en el grado que le corresponde de acuerdo con su edad, pero no ha podido concentrarse en la escuela debido al trauma.*

Recoger la información sobre los sucesos reales de la agresión, ya sea directamente con el niño o con su familia, lo mismo que medir la magnitud de la patología posttraumática del niño, constituyen las primeras tareas de la etapa inicial de la terapia. Un factor que puede prolongar esa fase es la posibilidad de que el niño esté poniendo a prueba al terapeuta; esto es, puede aparecer una fase de oposición que dificulte convencerlo de cooperar con cualquier aspecto de la terapia. Cuando pasa esa "tormenta" de cólera mal enfocada y se considera que se ha establecido firmemente la transferencia entre el terapeuta y el niño y entre el terapeuta y la familia, se puede empezar el proceso de tratamiento con el máximo esfuerzo.

* Debido a que los resultados en las pruebas de Coeficiente Intelectual (por ejemplo, la WISC-R) son afectados de manera negativa por factores de estrés, es posible que el desempeño del niño esté por debajo de sus capacidades reales. Entonces se deben revisar detalladamente las otras fuentes de información, como los resultados de pruebas anteriores.

Etapas intermedias

El tratamiento tiene un doble propósito: reconstruir el ego del niño y restaurar la unidad familiar, al igual que sucede en el caso de una niña que ha sido víctima de una agresión sexual (véase capítulo 3). Puesto que los dos objetivos están positivamente interrelacionados, se les perseguirá simultáneamente con una bien planeada estrategia de tratamiento. En un caso ideal, se ayudará al niño a desplazarse exitosamente a través de las diferentes etapas de las respuestas al trauma y el ciclo de recuperación; entonces se le reintegrará a su nivel de comportamiento previo a la agresión y, finalmente, a su sistema familiar. En la vida real esto sucede raramente, si acaso alguna vez. El niño puede marcar el procedimiento con periodos de fuerte oposición o episodios de comportamiento difícil. Uno o más miembros de la familia pueden dar la impresión de desear que la terapia falle y en ocasiones su falta de cooperación detiene el avance. Así, el proceso está frecuentemente marcado por falsos inicios e interrupciones.

El mejor plan de tratamiento con el cual se puede empezar es el que se concentra en la víctima, considerando a los miembros de la familia como pacientes colaterales. Con el tiempo y el avance hacia la recuperación del niño se puede desplazar el énfasis hacia los asuntos familiares. Incluso en tal caso, los miembros de la familia pueden asistir ocasionalmente a la terapia desde el principio, siempre y cuando se haga saber al niño por qué están ahí durante alguna sesión.

Si se establece la transferencia, un terapeuta hombre puede ofrecer al niño el sustituto paterno que necesita. Esto se logra de diversas maneras y una de las más importantes es mediante el ejemplo y la presencia. El niño

necesita saber que el terapeuta "estará ahí" cuando lo necesite porque se siente inseguro o porque necesita hablar con alguien. Aún más importante es que el niño sepa que el terapeuta lo acepta sin juzgarlo. Este mensaje es transmitido con la *afirmación*. El terapeuta puede mostrar su preocupación porque el niño tenga éxito en cualquier cosa que intente y que aprenda a aceptar sus errores utilizando juegos de mesa y otras actividades conjuntas como armar modelos a escala. La vida está llena de accidentes que suelen llegar en el momento en que la gente se siente con su mejor suerte. Por extensión, cualquier persona puede sufrir un accidente tan terrible —y tan absurdo— como una agresión sexual. Uno puede aprender y crecer a partir de esas experiencias.

El niño que sufrió una agresión y que muy probablemente ante sus ojos y los de sus padres la experimentó como un fracaso, necesita reconstruirse a sí mismo con base en una serie de experiencias de éxito. Esto se explica porque ni él mismo ni sus seres queridos pueden considerar la agresión sexual simplemente como un triste acontecimiento de la vida. No obstante, el antídoto contra la duda sobre las propias capacidades que crea el "fracaso" es una demostración real o imaginaria de que uno sí es una persona capaz. A menudo, esto se puede realizar de la manera más sutil, por ejemplo, un niño cuyos hermanos siempre han sido exitosos en juegos sencillos puede obtener una importante autoestima al ganarle a un adversario fuera de su familia. Esto es mejor aún si se trata de un adulto.

A medida que el niño va ganando confianza, se puede esperar que él o los padres noten el cambio. Su padre o madre puede percatarse de que está avanzando y posiblemente esté más dispuesto a ayudar en la terapia. Se puede hacer participar al padre o madre en este proceso

de recuperación invitándolo a que asista a la sesión de terapia durante los 10 o 15 minutos del final. Se debe avisar al niño sobre ello preguntándole: "¿Te molestaría que tu madre o tu padre estuvieran aquí un rato?". Si la respuesta es negativa, el terapeuta puede preguntarle: "¿Hay algo que quieras que le pregunte cuando entre?".

Más adelante en el proceso de tratamiento, tal vez sea posible preguntarle (antes de que entren los padres): "¿Si le (les) pregunto qué has estado haciendo mal últimamente, qué crees que contestará(n)?". Como se trata de una formulación de tipo condicional, se entiende que la pregunta no tiene necesariamente que ser planteada. La respuesta del niño informará al terapeuta sobre sus preocupaciones actuales en relación con su padre o madre, lo mismo que sobre los temas más recientes relacionados con la disciplina en el hogar.

Si el niño responde a esa pregunta exponiendo una queja que el padre o madre probablemente hará, el terapeuta puede preguntarle directamente si le autoriza para mencionar el asunto cuando él o ella entre. Generalmente el niño estará de acuerdo, sobre todo si siente que el terapeuta le apoyará en caso de que surja alguna discusión. De ser así, el terapeuta está introduciendo un tema que ha sido preocupación del niño respecto de sí mismo en un contexto en el cual está protegido de las emociones de sus padres por una tercera persona. El objetivo es crear un diálogo entre personas cuya comunicación ha sido distorsionada por un evento traumático. La incompreensión que se ha introducido entre padre e hijo puede disminuirse cuando se les pide que hablen sobre sus problemas en presencia de una tercera persona interesada.

Con el paso del tiempo tal vez se deseará utilizar más ampliamente este formato para las sesiones terapéuticas, aumentando gradualmente el tiempo dedicado a la

interacción entre el niño y su padre o madre. Más tarde se puede invitar al otro padre (o tutor) para que participe con el fin de que lo que comenzó como un problema en y del niño sea identificado como un asunto familiar. Cuando sea apropiado se podrá realizar una sesión con los padres por separado para descubrir cómo están percibiendo el desarrollo del tratamiento. La realización de estas reuniones debe acordarse previamente con el niño, para que no tema que se traicione su confianza.

En ciertos casos los hermanos del niño pueden participar en la terapia. Éstos son aquéllos en los que el niño es muy "cercano" a uno de sus hermanos o hermanas o aquéllos en los que la relación se ha visto deteriorada desde que ocurrió el abuso. Ambas situaciones requieren la evaluación de los cambios en la relación y los reacomodos entre ambos niños producidos por los sucesos traumáticos. La víctima necesita ayuda en su relación con su hermano o hermana para que obtenga nuevas fuentes de aceptación y apoyo. En muchos casos se pide que el hermano o hermana muestre un nivel de comprensión o de simpatía que están más allá de sus capacidades de entendimiento o de sentimiento. Una clave posible para despertar la comprensión empática del hermano o hermana es hacer que tome conciencia de que él o ella también pudo haber sido víctima del abuso.

Finalmente, la búsqueda del padre debe resolverse. Si existe un lazo padre-hijo que puede ser renovado y fortalecido, eso es mucho mejor para ambos. Esto se logra sólo cuando el padre es consciente de su negligencia en relación con su hijo y está preparado para reconstruirla. No debe culpar a al menor por la agresión sexual que sufrió y debe hacer un esfuerzo para lograr que el agresor sea atrapado y castigado. En pocas palabras, debe asumir su papel paterno de protector y maestro mediante el ejem-

plo. Es posible que requiera consejo profesional destinado a mejorar sus capacidades paternas.

Algunos padres no estarán a la altura del reto. Se trata de aquellos que de un modo u otro se han distanciado excesivamente de sus hijos. Para algunos niños, el padrestro o el compañero de su madre no es ningún consuelo. Irónicamente, el problema comienza y termina en el mismo sitio: el niño busca llenar una deficiencia en su vida encontrando a una figura paterna que lo traiciona y si el padre "natural" lo rechaza una vez más, volverá a ser vulnerable. En diferentes niveles de desarrollo, esta vulnerabilidad invita a otras formas de abuso, pero abuso de cualquier modo.

El terapeuta sólo puede personificar al "buen papá" durante una o dos horas a la semana, de modo que será útil (si es posible) trabajar con el padre o tutor intensamente tanto junto con el niño como en sesiones por separado. Aquí también es probable que se dé un proceso de pruebas tanto del niño como del adulto, para descubrir si se puede confiar en el terapeuta y dejarlo que se acerque al sistema padre-hijo.

En los casos, demasiado frecuentes, en que el padre o sustituto niega el problema o evita la terapia, se necesitan otros métodos. Se puede animar a la madre a buscar tantos sustitutos paternos para el niño como sea posible, en fuentes como grupos deportivos, clubes de niños, clases especiales de música o canto, grupos de actividades extraescolares como coleccionistas de estampas o de modelos a escala, actividades eclesísticas y otras. De hecho, muchos padres de tiempo parcial pueden satisfacer las necesidades de un niño que ha perdido a su padre. Por razones evidentes, la madre debe escoger muy cuidadosamente a las personas antes de inscribir a su hijo en esas actividades.

Etapas finales

El trauma del abuso sexual nunca será completamente borrado de la mente de una víctima. Aunque logrará "adaptarse" a él, no lo puede desaparecer. Así pues, el niño y el hombre en que se convertirá han sido alterados para siempre por el incidente, pero esto de ningún modo resta importancia a la contribución del tratamiento, aunque da un marco claro a nuestras ambiciones. Como terapeutas, buscamos ayudar a que los niños que han sido agredidos recomienzen su vida lo mejor posible y a que sean llevados a un sitio seguro en donde sea menos probable que ocurran cosas de la misma índole. Estos criterios de tratamiento exitoso engloban todas las posibilidades. Ante todo, el terapeuta debe reconocer el hecho de que estos niños tal vez tengan que volver a tratamiento más de una vez a lo largo de su proceso de desarrollo.

Desde un punto de vista realista, podemos terminar el tratamiento cuando se ha llegado a la mayoría de los siguientes objetivos:

1. El niño ha experimentado un trabajo de asimilación del trauma por medios como haber consultado al terapeuta cómo percibió el abuso, haber exteriorizado su cólera en contra del agresor y (o) haber transitado correctamente a lo largo de las etapas del ciclo de recuperación.
2. Cuando hay pruebas de que el niño ha recuperado un nivel de desarrollo apropiado a su edad cronológica. Por ejemplo, el niño en edad anterior a la pubertad debe ser capaz de competir con sus compañeros en juegos y deportes y en el trabajo escolar o tan sólo en el compartir actividades. Debe tener al menos un amigo cerca-

no de su edad, y portarse relativamente bien en compañía de adultos. El niño que ha llegado a la pubertad debe mostrar cada una de las características anteriores y, además, mostrar los primeros signos de la vanidad masculina (esto es, preocupación por la higiene y la apariencia); y debe ser capaz de interesarse por algún tipo de relación con una niña. Si no se percibe ninguno de estos indicadores de lo que es el adolescente, es probable que el niño esté aún en proceso de recuperación del trauma, en el periodo que puede describirse como "de pataleo".

3. Se ha logrado establecer o se está estableciendo una mejor relación entre el niño y al menos una figura de autoridad masculina, de preferencia su padre: esto es el núcleo de la terapia, y su parte más difícil.
4. El niño y su familia se han reconciliado, reinsertándolo en sus plenos derechos como miembro de la familia con un estatus seguro y un papel aceptado. Si esto hacía falta antes del abuso, ahora es doblemente necesario.

Estas consideraciones implican que el niño necesita reintegrar su sentido de valía personal y su identidad, al mismo tiempo que necesita encontrar un sitio protegido dentro de su entorno. La terapia no puede crear estos cambios, pero puede echarlos a andar y ayudarles a evolucionar.



siete

Adultos que fueron traumatizados en la infancia



Desde tiempos inmemoriales ha habido personas que abusan sexualmente de niños y adolescentes, generalmente de los más vulnerables, lo cual aumenta la tragedia. Y cuando usamos como base los datos de niños que actualmente sufren de abuso sexual cada año, para tratar de determinar el número de personas de la población adulta actual que fueron traumatizadas durante su infancia o adolescencia, el resultado es alarmante. Desde la consideración más conservadora, esa población es muy grande. Sin embargo, finalmente los terapeutas están empezando a descubrir claras evidencias de este escondido fenómeno y a estudiar sus implicaciones en la psicoterapia con pacientes adultos.

Este capítulo pretende dar a los terapeutas una visión clínica de las características de los adultos que sufrieron de abuso sexual durante la infancia o la adolescencia. El capítulo se enfoca inicialmente hacia tres cate-

gorías de esta, frecuentemente mal comprendida, población: 1) aquellos que trataron de decirse a alguien obteniendo una respuesta que los hizo no volver a intentar divulgar su secreto; 2) aquellos que se lo dijeron a alguien pero no recibieron el apoyo o la ayuda que necesitaban para resolver el trauma, y 3) los que no dijeron nada a nadie.

Obviamente, ha habido niños y adolescentes que pudieron decirle a alguien lo que les ocurrió y que obtuvieron la ayuda y protección que necesitaban. Y, de vez en cuando, la vida cura espontáneamente brindando las experiencias correctivas que se necesitan. Pero, de acuerdo con nuestra experiencia, esos casos son pocos y muy raros. Los ejemplos más frecuentes son aquellos en los que el trauma ha perdurado, lastimando bajo la superficie como una "bomba de tiempo psicológica" (Peters, 1973).

Este capítulo comienza con una descripción de cómo algunos adultos que fueron agredidos sexualmente durante su infancia encuentran el camino hacia el tratamiento. La primera sección pone un énfasis especial en ayudar al terapeuta a identificar a la víctima previamente "secreta" de un trauma sexual infantil. Sugerimos la forma en que el terapeuta puede irse acercando para hacer que su cliente saque ese tipo de trauma a la luz de una manera tolerable. Damos las razones por las cuales algunas víctimas de la infancia y la adolescencia permanecen calladas durante años, y por qué frecuentemente se sienten obligadas a reproducir su papel de víctimas a lo largo de la adolescencia y la edad adulta—a menudo mediante un comportamiento autodestructivo. A continuación se describen algunos errores comunes en los que puede incurrir el terapeuta, los cuales suelen mezclarse con el trauma original, sellando el silencio de la víctima. El capítulo termina con sugerencias para el tratamiento de estos clientes.

Descubrimiento del secreto

La población actual de personas que fue traumatizada sexualmente en la infancia o la adolescencia constituye un grupo trágico. Fueron jóvenes en una época en la cual su sufrimiento era si acaso rara vez reconocido. En muchos casos, los absolutamente reales abusos que sufrieron fueron desechados como fantasías; o los consideraron culpables por haber causado la agresión debido a su mal comportamiento o a su conducta "seductora". Muchos han sido equivocadamente catalogados por la sociedad, mal diagnosticados por profesionales que debían ayudarles y que sólo sirvieron para ahondar sus sentimientos de aislamiento y autodevaluación, y para dar validez a sus historias autodestructivas al confirmar sus sentimientos de subestima mediante el uso de una etiqueta clínica.

El terapeuta debe saber que muchas personas que fueron agredidas sexualmente no contarán espontáneamente lo que les ocurrió. Nuestra experiencia clínica sugiere que muchas víctimas pasan un tiempo considerable en una relación terapéutica antes de desarrollar suficiente confianza para sacar el tema a la luz (véase también Everstine y Everstine, 1983; Gil, 1971; Lister, 1982). Y aun cuando el tema sea introducido, puede no ser de manera directa. En algunos casos, la víctima no define lo que le hicieron como una forma de abuso. Es posible que se defiendan racionalizando para considerar que esos incidentes fueron sólo "parte de la vida". O puede haber aceptado las racionalizaciones del agresor como realidad e interpretado el hecho como algo que él o ella se merece. Muchos adultos traumatizados en el inicio de su vida perciben el abuso como una "definición" de ellos mismos, esto es, construyen una autoimagen que incor-

pora al abuso, en vez de verlo como algo que les sucedió. Los traumas pasados y presentes son considerados atributos de la persona.

Al igual que sucede con muchas víctimas jóvenes, estos adultos pueden contar inicialmente al terapeuta más sobre el abuso mediante su actitud que con palabras. Por ejemplo, las personas que tienen una larga historia de comportamiento autodestructivo o suicida pueden haber sido víctimas de abuso en la infancia. Pruebas recientes de esto han sido proporcionadas por Harrison, Lumry y Claypatch (1984), Bagley y Ramsay (1985), Briere (1984) y Sedney y Brooks (1984). Además, las personas que escogen parejas abusivas en sus relaciones o que continuamente se colocan en situaciones en las que serán lastimadas física o emocionalmente, también pueden ser vistas desde este ángulo (Briere, 1984; Russell, 1987). Muchos adultos traumatizados en la infancia han interiorizado el suceso traumático como parte de la estructura de su personalidad —de una persona que no merece cuidado— y frecuentemente desarrollan un estilo de vida que tiende a perpetuar su posición de víctimas (Miller *et al.*, 1978). Aunque algunos son claramente suicidas, es más común que tomen riesgos extremos, que abusen del alcohol o de las drogas (Briere, 1984; Herman, 1981), o que tomen decisiones vitales que los conducen al fracaso. Una vez más, estas personas se perciben a sí mismas como carentes de valor y, por lo tanto, no saben cómo (o consideran innecesario) cuidarse a sí mismas. Otras víctimas más desesperadas consideran que la única manera de vengarse de los adultos que abusaron de ellas es suicidándose (véase Everstine y Everstine, 1983, capítulo 11).

Los clientes con problemas de personalidad histórica o que se despersonalizan o "desconectan" también deben ser tratados con cuidado especial. Pueden descri-

bir sus síntomas como "sentirse adormecidos", "cerrarse emocionalmente" o (literalmente) "desconectarse" en situaciones en las cuales sienten una cólera intensa, ansiedad, confusión o dolor. En una ocasión, una víctima de agresión sexual durante la infancia accidentalmente se causó quemaduras de segundo y tercer grado durante una discusión familiar. Un día, mientras cocinaba, su hermana y su madre empezaron una discusión emocionalmente fuerte. La hermana entró corriendo a la cocina y pidió que la cliente tomara partido por ella y mientras la hermana le gritaba, ella tocó la estufa quemándose seriamente. En ese momento era completamente inconsciente de lo que le ocurría y sólo después se percató de que se estaba lesionando.

Hemos observado que algunos individuos (hombres y mujeres) promiscuos o aparentemente incapaces de sentir "apego" en las relaciones amorosas de confianza, pueden haber sido víctimas de abuso sexual en su infancia. Pueden fácilmente participar en encuentros sexuales con extraños, pero tienen grandes dificultades para formar y mantener relaciones sanas con una pareja. Pueden entrar a la terapia quejándose de sentirse perdidos y aislados de la vida. Muchos parecen bien adaptados socialmente, pero de hecho llevan vidas solitarias, carentes de lazos cercanos y compromisos. Debido a que temen tanto la intimidad, tienden a igualar la cercanía con el ser usados o rechazados, de modo que se retiran de todas las relaciones en general. Es por esto que los pacientes que sufren de pánico al acercarse a la posibilidad de una relación amorosa, deben ser cuidadosamente observados por el terapeuta para descubrir si no hay oculta una historia de abuso sexual en la infancia.

Aunque este tipo de trauma suele estar presente en la historia de una personalidad altamente disfuncional

(véase DSM-III-R, 1987, pp. 346-347), es necesario diferenciar a las personas con traumas sexuales no resueltos de la infancia de aquéllas efectivamente disfuncionales, masoquistas o manipuladoras. Aunque superficialmente comparten ciertas características, la dinámica emocional del comportamiento autodestructivo o exagerado de la persona disfuncional o masoquista es muy diferente de la que sufre de un trauma sexual infantil no resuelto. Muchas víctimas infantiles de trauma sexual han sido mal diagnosticadas como disfuncionales, histéricas, manipuladoras o simplemente como clientes "malos" o "moles". Es cierto que el trabajo con este tipo de personas puede ser extremadamente difícil, pero en muchos de estos casos hay más en la conducta del cliente que la manipulación, el probar los límites o la búsqueda de atención. El terapeuta debe evitar que su respuesta a esa conducta refleje coraje o frustración por no poder controlar al difícil cliente, debe ser consciente del mensaje que le trata de transmitir con su conducta.

Con el fin de evitar los malos entendidos, podemos afirmar la necesidad de plantear límites claros con los clientes cuya conducta es exagerada. Pero el terapeuta debe también reconocer que algunos de ellos (esto es, aquellos que sufrieron de abuso sexual en su infancia) acaso intentan expresar lo indecible con su comportamiento (Nelson, 1982). En la mayoría de los casos, la elaboración de preguntas bien pensadas y cuidadosas a lo largo de un cierto periodo es el mejor medio para descubrir cuáles clientes sufren de los efectos del abuso sexual (véase también Gil, 1971; Katan, 1973; Lister, 1982; Peters, 1973). Rara vez se trata de hacer una pregunta en especial; más bien, se utiliza un periodo de cuestionamiento sensible y cuidadoso, durante el cual el cliente probará

las respuestas del terapeuta en todos los niveles, para descubrir si se trata de una persona de confianza que puede recibir el secreto.

Las personas agredidas sexualmente durante la infancia pueden buscar el tratamiento porque sienten una angustia indefinida al pensar en la paternidad o la maternidad, al convertirse ellos mismos en padres, o cuando uno de sus hijos se aproxima a la edad en la que ellos sufrieron del abuso sexual.* Más aún, hay casos en los que uno de los padres que trae a un niño o niña que ha sido sexualmente agredido, fue víctima también de ese tipo de agresión en su infancia, quizá aproximadamente a la misma edad que su hijo o hija. No es poco común que estos padres traten de "trabajar" su propia experiencia a través del trauma de su hijo.

La relación entre el terapeuta y el cliente

La aproximación inicial de cuidadosa observación por parte del terapeuta es un paso crucial, pues en estos casos varias fuerzas actúan simultáneamente. Por ejemplo, el cliente puede considerar que el terapeuta oscila entre dos papeles incompatibles. Al principio, puede ser confundido con el "mal padre o madre" que no descubrió o no respondió apropiadamente a lo que le hicieron al cliente durante su infancia (el padre que no podía o no quería ver que el menor sufriera y que estaban abusando de él o ella, y que no supo protegerlo; el padre que, según creía el niño,

* El tema de los padres que, habiendo sufrido de abuso sexual en su infancia, abusan a su vez de sus hijos fue abordado en el capítulo 5.

era indiferente o aceptaba el abuso). En la otra modalidad, el terapeuta puede convertirse en el idealizado "buen padre o madre", específicamente el padre que hubiera podido percibir lo que le sucedía al niño, que habría detectado el abuso protegiéndolo de mayores daños.

Esta fase inicial de observación puede complicarse aún más por las defensas del cliente, en el caso en que el abuso sexual haya sido reprimido al punto de resultarle inaccesible en la actualidad. De modo que puede estar pidiendo al terapeuta que intuya lo que pudo no haber sido consciente al iniciarse la terapia, de hecho, que sepa lo que él o ella no sabe. Aquí encontramos una paradoja que recuerda el dilema enfrentado por el Príncipe Calaf en *Turandot*, la ópera de Puccini, un misterio sin claves.

Las defensas del cliente

Independientemente de esa obvia represión, un cliente puede también haber disminuido la intensidad del suceso mediante alguna forma de proceso disociativo. Como una mujer resumiera de manera muy clara, después de describir años de un brutal abuso sexual y físico de manos de su padre: "Sabes, no es tan malo que te golpeen. Después del primer golpe ya no sientes nada". Es probable que este tipo de defensas se manifiesten a los protectores y amigos, en ciertos casos, el único alivio para la víctima. Al abandonar esas defensas y decir a alguien lo que sucedió, la persona puede sentir que su único escudo le ha sido arrebatado y que él o ella ya no tiene la anestesia contra el dolor de la agresión inicial. Una cliente describió a su anterior terapeuta, guía de un grupo de mujeres, que había atacado sus defensas ante el grupo, diciendo: "¡La terapeuta me atacó! Quiso arrebatarme mi manera de enfrentar las cosas. Sé que soy dura. Tengo un

escudo y hay algunas cosas que no quiero ver. Pero me protejo de la mejor manera que conozco. ¿Quién es ella para atacarme... quitándome todo lo que tengo para protegerme de mí misma? ¿Me va a proteger ella? ¡No! No hace falta decir que la mujer nunca regresó a ese grupo.

Dado que los mecanismos de defensa de estas personas pueden ser el único apoyo que les ha permitido soportar hasta ahora, el terapeuta debe ser muy cauteloso. Si confronta esas defensas de manera directa, sin preparar el terreno, será considerado como otro agresor. El cliente puede escoger entre dos alternativas: escapar de la terapia o, si es especialmente dependiente, desarrollar una transferencia patológica con el terapeuta. En tal relación, la persona puede desarrollar una forma de apego al terapeuta fundamentalmente masoquista y que, en la mente del cliente, puede ser una reminiscencia de su relación con quien abusó sexualmente de él o ella.

En el trabajo con estas personas, el profesional debe estar siempre atento al hecho de que el poder implícito en la transferencia terapéutica puede ser fuente de terror para aquellos adultos traumatizados en la infancia, pues no poseen las bases de una sana relación de confianza entre padre e hijo. De hecho, uno de los temas clínicos iniciales es la falta de confianza y la consecuente incapacidad de la persona para establecer relaciones íntimas sanas. La experiencia terapéutica no debe jamás reproducir la angustia del abuso sufrido por la víctima.

El que algunas personas de quienes se abusó sexualmente durante su infancia puedan dar la apariencia de haberse endurecido, de haber logrado el éxito y la sabiduría propia de su edad, quizá confunda aún más las etapas iniciales del tratamiento. El terapeuta debe percibir que esa apariencia fuerte y ruda no es más que un velo que cubre al aterrorizado niño que hay adentro.

Como ya mencionamos, el desarrollo psicológico a menudo se detiene cuando se inicia el abuso sexual, así que pueden darse dos tipos de pacientes: el adulto excesivamente defendido y el menor bloqueado. Esto puede colocar al terapeuta en la difícil posición de tener que formular las cosas de manera que las comunique tanto a los aspectos infantiles como a los aspectos adultos de la víctima; una actuación de equilibrio de connotaciones que no es fácil ejecutar.

El pacto del silencio

Obviamente, uno se pregunta cómo es que algunas de estas personas guardan silencio durante tantos años. ¿Por qué conservan sus secretos por tanto tiempo? ¿Por qué gastan tanta energía emocional en mantener el secreto, tal vez alejando a las personas que trataban de ayudarles al mostrar un comportamiento difícil o realizar exigencias prácticamente imposibles de satisfacer?

Para entender el largo silencio de aquellos que sufrieron de abuso sexual en su infancia o adolescencia, el terapeuta debe analizar la estructura interna de la relación de abuso e identificar la interacción que se establece entre la víctima y el agresor. La extraña actitud del cliente comienza a cobrar sentido una vez que se comprenden los elementos de esa relación. El lector tal vez se pregunte por qué usamos el término "relación" si algunos niños y adolescentes son agredidos sexualmente por gente completamente extraña. Nosotros consideramos que aun cuando el agresor y la víctima hayan sido totalmente desconocidos y sólo se encontraron en el incidente abusivo, se ha creado una relación dentro de la mente del niño o adolescente, con un poder maligno para controlar los

elementos de su comportamiento en los años subsiguientes. Este tipo de lazo se complica y se fortalece cuando la víctima *sí* tuvo una relación anterior con su agresor.

En la mayoría de los casos de agresión sexual en contra de un niño o adolescente, aparecen dos tipos de amenaza que inducen al silencio: primero, la de que el menor tenga que hacer lo que el agresor desea. Este tipo de forzada sumisión puede ir desde una sutil coerción que halaga o engaña, hasta una abierta amenaza de violencia física. Una vez que la persona sucumbe ante esta amenaza inicial, crece el poder del agresor y aparece una forma de relación que la víctima acepta implícitamente. El reconocimiento del dominio del agresor es un primer paso crítico, pues obliga a la víctima a hacer lo que éste le pide.

La sumisión se fortalece aún más con la segunda amenaza, la obligación de callar. Una vez que el niño o adolescente se rinde ante esta segunda exigencia, la relación abusiva cobra vida propia en la dinámica interna de la víctima. Este lazo se convierte en algo aún más poderoso si él o ella sufre repetidamente de abuso a manos de la misma persona, o si los adultos cercanos actúan de tal manera que confirman el poder del agresor sobre él o ella (esto es, ignorando los intentos del menor por revelar que algo anda mal o bien exponiéndolo totalmente a posteriores abusos).

En algunas situaciones, el miedo del menor a la respuesta de sus padres ante lo sucedido sirve para aumentar el poder del pacto de silencio. Además, en muchos casos como éste, el niño o adolescente fue agredido mientras hacía algo que le estaba prohibido por sus padres, lo cual da al agresor el mágico papel de servir de castigo por la desobediencia de la víctima. En este tipo de situaciones, el menor entra en una suerte de complicidad con el agresor haciendo una forma de "promesa". Lister

(1982) describió este proceso de la siguiente manera: "Uno hace una promesa para evitar más dolor y casi inevitablemente siente una obligación para el futuro, un deseo de que ya no haya más dolor" (p. 874).

Lo que sella el contrato entre el menor y el agresor es que cuando cesa el abuso, se deja ir a la víctima. Esto parece paradójico, pero el que el abuso se detenga fortalece la promesa de la víctima porque, en su mente, el agresor que tiene el poder de detenerse tal vez tenga el poder de comenzar nuevamente, y el próximo abuso puede ser peor que el anterior. Si la víctima se somete ante el agresor manteniendo el secreto, tal vez esa persona decida no volver a atacarla.

Las víctimas jóvenes de agresiones sexuales, al igual que las mayores, otorgan poderes sobrehumanos a sus agresores, aunque esta equivocada percepción se ve aumentada en los niños porque el agresor puede efectivamente tener un poder considerable sobre ellos en condiciones normales—esto es, como padre, pariente, profesor o alguna otra función de confianza (Everstine y Everstine, 1983). Cuando se considera que en la mayoría de los casos el hostigamiento sexual es perpetrado por personas conocidas de la víctima (86 por ciento en los casos estudiados por Cupoli y Sewell, 1988; 99 por ciento en el estudio de Kendall-Tackett y Simon, 1987; 96 por ciento en el de Reinhart, 1987), resulta evidente que decir a sus padres lo que ha ocurrido constituye un tremendo acto de valor por parte del menor.

Errores comunes de los terapeutas

Aun cuando un paciente haya estado en terapia anteriormente, no se puede asumir que él o ella ha hablado a su

anterior terapeuta sobre sus traumas sexuales del pasado. Hemos observado que muchas personas cuyo trauma no había sido descubierto, antes habían pasado por experiencias terapéuticas, algunas de ellas muy positivas. En ese tratamiento fueron incapaces de hablar del abuso por varias razones. En algunos casos, el terapeuta puede haberle dado mensajes en el sentido de que ese tema le hacía sentirse incómodo y no quería tratarlo. Lister (1982) hizo una lista de errores comunes cometidos por los terapeutas que evitan que el cliente revele un trauma sexual de la infancia: 1) una focalización sobre los procesos intrapsíquicos a costa de la atención de las realidades exteriores; 2) insinuaciones sutiles en el sentido de que "si pasó algo, tal vez usted lo provocó"; 3) francamente dejar pasar información histórica relacionada con violencia, amenazas o temor a la violencia, o 4) negativa a considerar la posibilidad de que lo que se le está diciendo a uno sea literalmente verdadero (p. 875).

No podemos exagerar la importancia de que el terapeuta esté siempre alerta ante sus propios problemas y cómo éstos pueden estorbar el proceso de tratamiento. Hemos descubierto que uno de los principales errores consiste en sugerir implícitamente que la víctima "provocó" lo que le ocurrió cuando él o ella era joven. Ésta puede ser una situación muy complicada, pues muchos adultos que fueron sexualmente traumatizados durante su infancia o adolescencia escogen parejas abusivas, o provocan el maltrato del cual sufren constantemente. Es trágico que estos adultos, por un lado, estén siempre buscando explicaciones y, por otro, recreen el incidente traumático de modo que les confirma que son personas despreciables. De tal manera, la intervención del terapeuta debe buscar el rompimiento de ese círculo de autoderrota.

Si el profesional se centra sólo en la actual conducta autodestructiva y no se percató de lo que el paciente está tratando de comunicar mediante ella, y si además se olvida de que cuando el trauma ocurrió el o la paciente era efectivamente una víctima inocente, las amenazas y la culpa transmitidas en el momento del abuso se verán confirmadas por la terapia. Así, el terapeuta se coloca en el papel del padre negligente.

Con miras a evitar esto, él debe interpretar el significado de la conducta autodestructiva, para que el cliente pueda comprenderla, y también debe poner límites adecuados. Este equilibrio entre poner límites e interpretar no es algo fácil de lograr. Para asegurar que los dos mensajes sean recibidos, el terapeuta debe estar seguro de que sus propios sentimientos sobre el sexo y la violencia, lo mismo sobre qué tanto la gente puede controlar su destino, han sido examinados rigurosamente.

Aceptar que este mundo no siempre es justo es algo especialmente difícil para los profesionales de la salud mental, quienes consideran que al menos controlan la dirección que dan a sus vidas (siempre y cuando tengan una actitud sana y tomen decisiones inteligentes). Enfrentar esa dura realidad es difícil porque implica aceptar nuestra propia vulnerabilidad. Sin embargo, si uno piensa en desenmarañar las frecuentemente complicadas historias de gente que sufrió de abuso sexual en la infancia, uno debe al menos estar dispuesto a considerar que estos adultos fueron víctimas inocentes en algún momento de sus vidas. Ante todo, esta verdad exige ser reconocida.

Víctimas cuyos hijos son víctimas

Aunque puede cobrar una forma patológica, en cierto modo es un signo positivo de la psique el intentar comu-

nicar, mediante el comportamiento de la persona, que se ha sufrido de abuso. La forma más seria que esto puede tomar es cuando un padre que una vez fue víctima coloca a su hijo o hija en una situación en la cual puede convertirlo en víctima a su vez, con el fin de poder trabajar lo vivido por él durante su infancia. Los padres que hacen esto deben ser atendidos con extremo cuidado, pues aun que su actitud es extremadamente patológica, de todas maneras están tratando de curar sus heridas de la infancia. Se requiere gran sensibilidad para ayudar a que ese padre o madre cobre conciencia de lo que está pasando, pues generalmente no sabe lo que le hace a su hijo y cree que trata de ser "buen padre". Así, debe evitarse hacerles sentir que han sido malos padres al exponer a su hijo o hija para que fueran dañados. En cambio, el terapeuta debe enfocar las necesidades infantiles de comprensión, cariño y protección de estas personas para poder dirigir las hacia una resolución terapéutica del trauma original.

Mensajes ocultos

Algunas personas con traumas infantiles no resueltos pueden comunicarlos a un terapeuta creando un nuevo trauma durante la terapia. Según nuestra experiencia, este tipo de recreaciones suele ocurrir una vez que la terapia ha avanzado positivamente durante un cierto periodo, de modo que pueden tomar al terapeuta completamente por sorpresa. Este trauma recreado puede asumir muchas formas: la persona puede ser golpeada en un pleito, o ser asaltada o verse envuelta en líos con la policía. El incidente generalmente es provocado por una excesiva toma de riesgos que, desde el punto de vista del terapeuta, estaba bajo control. Si trata este incidente como un comportamiento excesivo, límite o masoquista (esto es,

con miras a que la persona se dé cuenta de cómo sus actos pueden provocar cierto comportamiento en los demás), puede cometer un grave error, pues pierde de vista el punto más importante del comportamiento. Aun cuando la víctima ha provocado el suceso, éste ha ocurrido en el contexto del intento de decir al terapeuta algo sobre el trauma original. Así pues, si uno asume la tradicionalmente aceptada "mano dura" con el cliente que tiene una conducta exagerada para forzarle a responsabilizarse por sus actos, se corre el riesgo de volverse como los adultos que, en la infancia de la víctima, no se percataron o no respondieron apropiadamente ante el abuso. De hecho, si el terapeuta adopta una posición de castigo, puede parecer aún peor que los padres negligentes. El terapeuta no sólo es sordo ante los gritos de la víctima pidiendo comprensión, sino que la castiga por luchar por comunicar lo que le ocurrió anteriormente.

En una situación así, el terapeuta debe investigar si hay o no un mensaje oculto en el comportamiento del cliente y permitirle que responda a este tipo de interpretación. Él o ella puede inicialmente rechazar la interpretación, de modo que el terapeuta deberá ser paciente y cuidadoso en la observación de los detalles del resto de la conducta verbal y no verbal del cliente, para confirmar o no la posibilidad de la existencia de traumas sexuales de la infancia.

Si cree que ese trauma existe pero la persona insiste en negarlo, no recomendamos usar técnicas de confrontación. Muy probablemente, el cliente se defiende con rigidez y ese tipo de aproximación puede resultar impertinente. Centrarse en asuntos clínicos quizá sea una mejor estrategia, tratando asuntos como la forma en que uno se puede proteger mejor, evitando los temas de la

culpabilidad y la responsabilidad. Además, el terapeuta debe comunicar que él comprende y respeta las defensas del cliente y que no tratará de arrebatárselas. Es posible sugerir que la persona tal vez tenga sueños o recuerdos incómodos que pueden salir a la superficie periódicamente y que no tiene por qué pelearse con esos pensamientos, sino que puede hablar de ellos al terapeuta, sin importar cuán vagos o extraños parezcan.

Dilemas del tratamiento

A lo largo del proceso de tratamiento es necesario equilibrar el cuestionamiento cuidadoso y directo con una sensible demanda de material reprimido, al tiempo que se le da al cliente una sensación de seguridad y control. La meta es que él o ella no se sienta empujado a dejar la terapia porque se ha vuelto demasiado peligrosa. Debemos reconocer que tratar a adultos con traumas sexuales no resueltos de la infancia, no es tan simple como comunicar que uno reconoce el trauma, hacer las preguntas adecuadas y ¡Eureka!- resolver el problema. En cambio, esta terapia es en muchos casos un largo y lento proceso en el que cuidadosamente se intenta sacar a la luz el trauma original a un ritmo que el cliente pueda tolerar, al tiempo que se le ayuda a comprender por qué él o ella ha actuado de cierta manera después de ocurrido el trauma. Finalmente, el terapeuta debe crear un ambiente propicio para que se expresen los verdaderos sentimientos del cliente sobre el trauma. Debe hacer saber a la víctima que, ante todo, reconoce todo el rango de emociones que un niño experimenta en una experiencia traumática de esa magnitud.

Los adultos generalmente miran hacia la infancia con percepciones y capacidades intelectuales de adultos, olvidando cuán grandes y poderosos parecen los mayores ante los niños; hasta sus más sutiles amenazas son terribles para ellos. Los adultos que fueron traumatizados en la infancia frecuentemente cometen los mismos errores de percepción, lo cual intensifica sus actuales sentimientos de depresión e inadaptación. A menudo se recuerdan a sí mismos como mayores y más competentes de lo que realmente eran en el momento en que fueron agredidos. Muchos carecen de la comprensión de lo que un niño de esa edad puede hacer o entender. De tal modo, sienten una intensa culpa o vergüenza por lo que dijeron o hicieron durante los hechos traumáticos.

Ejemplo de caso

Un ejemplo de ese tipo de distorsión se encuentra en la descripción de un trauma sexual de la infancia (revelado durante la terapia) de una mujer de 27 años de edad. Era hija de una muy joven madre soltera que la dejaba sola (siendo ella muy pequeña) durante largos periodos, mientras realizaba raros trabajos. Una vez, cuando la cliente tenía como tres años de edad, su madre la sentó en las escaleras frente a su casa con unos juguetes, le dijo que se quedara ahí mientras ella iba a trabajar y que volvería más tarde para hacer la comida. Mientras ella estaba sentada, vino un hombre que la engatusó para que lo acompañara al sótano de un edificio cercano; ahí la sodomizó.

Cuando su madre, acompañada por la policía, finalmente la encontró acurrucada en el sótano con las ropas desgarradas, le gritó que era una niña mala porque había desobedecido yéndose con un extraño. Más tarde,

la niña fue examinada e interrogada por la policía en un hospital cercano. El policía que la encontró (creyendo ayudar) también la regañó duramente por haberse ido con un extraño.

Cuando esta mujer contó la historia siendo adulta, dijo que después de la agresión nunca había podido dormir si su cama no estaba contra la pared. Dormía con la espalda pegada a la pared para poder ver al hombre si trataba de "venir por ella" nuevamente en la noche. Dijo que además tenía miedo de que él estuviera debajo de la cama para tratar de acuchillarla a través del colchón.

Los detalles de la agresión fueron posteriormente confirmados durante una entrevista privada con la madre de la niña. Ella dijo que en esa época tenía 19 años y trataba de ganarse la vida. Pensó que era mejor no hablar más de la agresión para que la niña pudiera olvidarla y creía que su hija era tan pequeña que en realidad no entendía lo que le había pasado, de modo que siendo "firme" con ella aseguraba que sería más cuidadosa en el futuro. Aunque esta madre actuó de manera poco juiciosa en el tratamiento del trauma de su hija, se trataba de una joven mujer bien intencionada que realmente se preocupaba por su hija, pero que simplemente no comprendía la complejidad de lo ocurrido.

La víctima no volvió a hablar de la agresión sino hasta la edad de doce o trece años, cuando empezó a cavilar sobre el asunto. Finalmente, le preguntó a su madre por qué había sido atacada por ese hombre cuando tenía tres años. Con la intención de que su hija se volviera más cuidadosa, la madre le respondió que probablemente había sido porque ella era una niña rebelde y demasiado madura. A partir de esta conversación, la jovencita no volvió a mencionar el suceso, pero poco tiempo después empezó a abusar de las drogas y a comportarse promi-

cuamente. A la edad de dieciocho años había sido nuevamente víctima de otra agresión sexual, había sufrido dos sobredosis de drogas y se prostituía periódicamente.

Debido a que las secuelas de su primer trauma sexual no resuelto no fueron reconocidas como la causa de su difícil comportamiento en la adolescencia, la víctima fue equivocadamente diagnosticada por diversas agencias (y terapeutas) como una adolescente rebelde, promiscua y drogadicta. En otras palabras, se trataba únicamente de un problema de comportamiento. Esto le hizo confirmarse a sí misma que era una persona mala que merecía castigo.

Inicialmente, fue llevada a terapia por la policía después de que sufrió una violación brutal a la edad de 27 años. Durante la violación había sido fuertemente golpeada y le habían fracturado varias costillas. Al principio se resistía a la idea de ver a un terapeuta más, pero uno de los detectives ocupados del caso estaba preocupado por ella e insistió en que viera a alguien, de modo que ella "aceptó la idea para callarle la boca".

Cuando la joven llegó a la primera sesión de terapia todavía estaba mal herida. Trató de dar una imagen ruda y mundana. Cuando la terapeuta le expresó preocupación por sus heridas, ella respondió cínicamente que no era la primera vez que la golpeaban y que "no era para tanto", pues ella había aprendido a ya no sentir. Narró la historia de su vida con un verborreico recuento de hechos y se resistió mucho a cualquier pregunta sobre detalles o a dar más información.

La terapeuta pensó que había algo más en esta joven mujer de lo que se podía ver en la superficie. Era brillante, sensible y considerablemente aguda en su percepción de los demás, aunque no de sí misma. Sus medios hermanos eran personas relativamente bien adaptadas y

la familia, tal como ella la describía, no encajaba en el tipo de sistema que produce gente desequilibrada o autodestructiva. Pero su conducta negativa, su miedo a la cercanía y su capacidad para adormecerse ante el dolor, hicieron que la terapeuta sospechara que algún evento traumático podía ser la fuente de sus problemas.

En las etapas iniciales de la terapia, esta joven mujer se resistió a hablar sobre sus primeros años de vida. Simplemente decía que ella y su madre habían pasado por épocas difíciles antes de que su madre se casara con su padrastro, un relativamente exitoso hombre de negocios. También dijo que no tenía recuerdos claros de su vida anterior a su entrada a la escuela, aproximadamente a los seis y medio años de edad, cuando la madre se volvió a casar.

A medida que avanzó la terapia, empezó a dar indicios de una infancia trágica y llena de negligencia. Después de hablar de algo relativo a sus primeros años, se volvía obstinada con la terapeuta y luego asumía un comportamiento en exceso arriesgado como conducir un auto en estado de ebriedad o salir con hombres desconocidos que la maltrataban. Parecía buscar que la terapeuta la rechazara o se disgustara con ella, mientras que ésta le señalaba la relación entre lo que revelaba en la terapia y el comportamiento subsecuente, agregando cuidadosamente que la mujer era, de todos modos, esencialmente una buena persona. Le decía que, aunque no podía forzarla a abandonar esa conducta autodestructiva, ese modo de actuar no bastaría para que ella (la terapeuta) la abandonara. Entonces, le explicaba por qué ella creía que era una buena persona, merecedora de un mayor cuidado que el que se daba a sí misma.

Pasaron varios meses tormentosos antes de que la agresión sufrida a los tres años saliera a la luz. Cuando

finalmente sucedió esto, la mujer experimentó el recuerdo como una niña aterrorizada. Rompiendo en llanto, admitió que todavía tenía miedo de que el hombre que la agredió volviera y la matara si lo deseaba y que definitivamente había algo malo en ella que lo había atraído. No comprendía en absoluto cuán inadecuado era haber dejado a una niña de tres años de edad sola frente a la entrada de un edificio durante un largo lapso.

Después de dos sesiones muy tensas, ante el fracaso de los argumentos lógicos para convencer a la mujer de que no era responsable ni había causado la agresión con alguna falta intrínseca, la terapeuta decidió abordar la cuestión en forma diferente. Le pidió a una amiga que llevara a su hija de tres años de edad para que estuviera presente en la siguiente sesión con la cliente. Mientras jugaba y hablaba con la niña, la terapeuta le hizo varias preguntas, incluyendo algunas sobre qué haría en ciertas situaciones que ilustraban con claridad las capacidades normales de una niña de esa edad. Cuando la menor dejó el consultorio para volver con su madre, la cliente le preguntó por qué la había traído. Le respondió que comprendería en un momento, pero que antes ella debía responder a ciertas preguntas, como qué tan capaz era esa niña, si había algo sexual en una pequeña de esa edad o si era correcto dejar sola a una niña así durante largos períodos. En sus respuestas, la mujer expresaba su clara comprensión de que una niña pequeña no debe ser dejada sola, que no tiene nada sexual y que tiene escasas habilidades para resolver problemas. Entonces, la terapeuta le recordó que ella tenía exactamente esa edad cuando fue dejada sola en la puerta del edificio y luego agredida. Ella quedó profundamente sorprendida pues, dijo, estaba segura de que cuando sucedió la agresión, era más grande en edad y tamaño. Pero haber podido ver y hablar con una niña de la edad que tenía cuando fue agredida, le

dio una sensación más real de lo ocurrido. Desde ese momento, la paciente logró un cambio básico, a partir del cual empezó a trabajar en la transformación del concepto de sí misma (de una persona mala y poco valiosa a quien deseaba castigar y destruir), por uno más sano. Pudo ver la agresión original como algo que le sucedió a una niña vulnerable y no como algo que ella había provocado debido a algún defecto interior.

La necesidad de ayudar a una víctima de la infancia a corregir la subestimación de sí misma debe subrayarse. El equivocado desprecio de estas personas por sí mismas puede tomar varias formas, pero cada una de ellas esconde la culpabilidad y la vergüenza de un menor que sufrió del abuso sexual. Algunas formas de odio a sí mismo son más obvias que otras, como es el caso de la joven mujer que acabamos de describir. Otras víctimas ocultas son personas solitarias y aisladas, incapaces de crear relaciones cercanas y duraderas. Tal vez se hacen a sí mismas poco atractivas de algún modo —en su apariencia o con sus actos— con el fin de alejar a la gente de ellos.

Debido a que su empobrecida autoimagen no soporta el amor o el cuidado de otros, estas víctimas pueden asumir el papel de salvadores o cuidadores en sus relaciones con los demás. En éstas, siempre buscan agradar a la otra persona y todo lo hacen "por ella", pero no pueden soportar sus cuidados pues es algo muy amenazante. En este tipo de creación de reacciones (y a nivel consciente), la persona no puede tolerar el delegar el control en otro. El resultado es que a menudo se siente usada y despreciada por toda la gente, pero es incapaz de ver que es ella quien crea la estructura de esas relaciones. Muchos entran en relaciones de una intensidad tan empalagosa que alejan a la otra persona o se encuentran en situaciones en las que constantemente se aprovechan de ellos.

El cariño y el cuidado tienen una fuerte carga emocional para estas víctimas. Y, a menudo, la única manera en que soportan que se les cuide es enfermándose o hiriéndose. Así, muchas de ellas padecen enfermedades psicosomáticas o tienen tendencia a sufrir accidentes. Existen varias razones para este comportamiento. Primero, debido a que estas personas se disgustan a sí mismas (especialmente su cuerpo, pues supuestamente fue la atracción de éste lo que condujo a la agresión) no toleran el cuidarse, especialmente su físico. Pueden llegar a racionalizar el hecho de que recibir cuidados como resultado de una enfermedad o dolor físico es correcto, por lo que sus cuerpos han sufrido o han sido "castigados". En segundo lugar, la víctima puede llegar a asociar el cuidado con la agresión misma, pues tal vez el agresor manifestaba cuidados sólo durante o después del abuso. De este modo han sido condicionados a aceptar ser cuidados sólo únicamente a partir de una experiencia dolorosa o de algún tipo de encuentro sexual abusivo. En tercer lugar, el cuidado puede haber sido ligado con los beneficios secundarios obtenidos a partir del abuso, como regalos, privilegios o atención especial asociados con el trauma.

La terrible sensación de inadaptación y baja autoestima que sienten los adultos traumatizados sexualmente durante su infancia, puede esconderse tras una actitud hostil o excesivamente agresiva. Estas víctimas se encolerizan con facilidad, manifestando una rabia infantil causada por males reales o imaginarios. Suelen ser muy tajantes y alinearse siempre del lado del bien y la justicia. Debido a que muchas de sus percepciones del mundo se congelaron en una etapa temprana como consecuencia de la experiencia traumática, tienden a ver el mundo en blanco y negro y de manera muy concreta. Ven a la gente y las cosas sólo como buenas o malas y aunque algunas

de ellas pueden proyectar una personalidad superficial contraria, se perciben a sí mismas como inadaptadas; piensan que no merecen nada bueno o que si reciben algo bueno, serán castigadas. Éste es un asunto muy delicado para el terapeuta, quien debe trabajar cuidadosamente para ayudar al cliente a reestructurar su visión del mundo de una manera más flexible y menos punitiva.

A medida que avanza la terapia

Como ya dijimos, los terapeutas deben proceder lentamente con los adultos que fueron traumatizados sexualmente durante su infancia. Especialmente durante las primeras etapas del tratamiento, es muy probable que necesiten ser convencidos de que es bueno recordar y hablar de lo sucedido. Necesitan recibir el mensaje: "Si algo malo te sucedió, eso no hace de ti una persona mala", algo marcado de tal manera que lo puedan escuchar. No se puede menospreciar la importancia que tiene el decirles esto, una y otra vez, hasta que sean capaces de incorporar esa idea a sus creencias.

Los terapeutas deben pensar que sus propias asociaciones relativas al cambio y al potencial para el crecimiento personal pueden ser diferentes de las de los adultos que sufrieron de abuso sexual en la infancia. La diferencia es que las experiencias de la infancia de la víctima frecuentemente fueron acompañadas de vergüenza, culpabilidad y miedo. Cuando uno expresa el deseo de cambiar, eso esencialmente implica una queja sobre el estado actual de las cosas, y esa queja puede haber sido prohibida o castigada con amenazas de abusos peores. Una mujer contó que en cierta ocasión en que su padre empezó a abusar de ella, se echó a llorar. Su padre le puso

una almohada sobre la cara diciendo: "Cállate o te daré una verdadera razón para llorar". No hace falta decir que nunca volvió a llorar. De modo que para estas personas, la sola expresión del deseo de que las cosas sean diferentes puede ser más amenazante de lo que uno se imagina.

Con el fin de comprender completamente cómo funcionan las defensas de este tipo de clientes, el terapeuta debe investigar la forma en que la persona *sobrevivió* psicológicamente al abuso, así como la lógica que existe por debajo de las técnicas de sobrevivencia utilizadas. Por ejemplo, es importante saber si el niño o la niña "adormeció" el dolor, hizo como que nada pasaba, hizo como si estuviera en otra parte o como si fuera invisible, o se "desconectó" de su cuerpo de alguna manera. ¿Su defensa consistió en tratar de complacer a *todo el mundo*?

Luego se puede revisar cómo se explicó la víctima a sí misma la agresión cuando ésta cesó. Esto a menudo brinda una importante información sobre cómo se veía a sí misma la persona en relación con el agresor. Esa investigación también puede dar información sobre el concepto que la víctima tiene de sí misma.

A partir del grado de eficiencia de las defensas de la víctima, el terapeuta puede evaluar hasta dónde el concepto de sí misma ha sido afectado por el incidente, para empezar a ayudarla a desarrollar defensas adultas adecuadas. Pero se debe tener cuidado para que esta intervención clínica se base en la sensación del cliente sobre su propia identidad, reconociendo su punto de vista sobre cómo se debe autoproteger.

No se ha de restar importancia a la creación de una cabal comprensión respecto de cómo se ve el cliente a sí mismo, en relación con lo sucedido. Esto es vital, pues las experiencias de la infancia o la adolescencia de la víctima pueden ser tan diferentes de las del terapeuta que

éste literalmente es incapaz de imaginar cómo se sentía ella en ese tiempo. El camino hacia la comprensión puede ser oscurecido por defensas como la racionalización y la disociación, lo mismo que por los malos resultados de terapias anteriores. Una vez que el terapeuta se dedica a resolver este asunto crucial, puede entonces ayudar a la víctima a crearse una sensación más positiva de su persona.

Cuando el terapeuta responde ante una víctima adulta en una forma libre de juicios, le demuestra de manera concreta que las cosas pueden cambiar hacia algo mejor. Obviamente, el proceso sólo comienza por ahí, y avanza cuando el terapeuta trabaja con incrementos tolerables para la persona. Debe alternar el foco del tratamiento entre el mundo interior y las percepciones de sí mismo del cliente, con el papel que juegan esos asuntos en la forma en que los otros reaccionan ante él.

Al principio ese proceso es efectivamente muy lento, mientras se analiza, interpreta y pone en una nueva perspectiva el pasado. Aun así, el pasado sólo debe usarse para determinar su influencia en el comportamiento actual. Una defensa común en los adultos que fueron traumatizados en su infancia es enfrascarse en una interminable contemplación y discusión de sus historias personales. Esto puede ser un intento por revivir una juventud perdida o evitar al tratamiento del asunto más a la mano, es decir, el cambio de los viejos patrones de comportamiento. El terapeuta debe medir el tiempo que dedicará al tratamiento de la infancia de la víctima antes de convencerla de que es el momento de moverse hacia el presente. Por horribles que sean las experiencias pasadas de estos adultos, en muchos sentidos, vistas retrospectivamente, lo son menos que un futuro lleno de incertidumbre. Más aún, a la persona le pueden faltar experiencias vitales para saber cómo responder cuando se le

presentan posibilidades positivas. Tal vez este asunto sea fuertemente debatido, pero el terapeuta debe tomar una posición firme: específicamente, una vez que se ha logrado la comprensión fundamental de los traumas pasados de la víctima, el pasado debe trabajarse sólo en la medida en que se relaciona con el presente y el futuro de la persona. Al trabajar para reorientar a un cliente hacia el presente y el futuro, el terapeuta debe prepararse para enfrentar cierto enojo del cliente por el hecho de no poder "arreglar las cosas" relativas al pasado.

Es probable que las víctimas necesiten una importante ayuda para lograr aceptar que no tuvieron cuidados paternos y (o) maternos especialmente buenos o consistentes. Este asunto se torna complejo cuando se ha dado una alternancia de abuso y cariño, o abuso combinado con otras formas de beneficios secundarios. Separar en la memoria los aspectos buenos de los malos del agresor, puede ser una lucha relativamente difícil. Debido a la visión de blanco/negro y bueno/malo que estas personas tienen del mundo que las rodea, es posible que se requiera mucho trabajo para lograr que comprendan la dualidad de la naturaleza humana. Al igual que sucede con otras víctimas de abuso en la infancia, los adultos que lo fueron cuando niños suelen enfrentar un dilema, pues a pesar de lo que les hicieron, aún aman o sienten afecto por el agresor. Ésta es otra situación en la cual el terapeuta debe reconocer sus propios sentimientos y prejuicios. No suele ser fácil para una persona normal, que nunca pensaría en maltratar sexualmente a un menor, dejar sus sentimientos de lado para poder ver al agresor como alguien que es simultáneamente amado y odiado. En esos casos, se debe luchar por entender la relación del cliente con el agresor desde la perspectiva infantil, para entonces poder guiarlo hacia una visión del agresor lo más realista posible.

Es de esperarse que en cierto momento, la víctima tenga que trabajar una cólera importante en contra del agresor. Sentirá un enorme alivio al poder finalmente expresar las emociones reprimidas; pero, al mismo tiempo, puede sentirse muy asustada por ellas. En cualquiera de estos casos, el terapeuta debe intentar equilibrar la necesidad de exteriorización con la necesidad de control. Los autores han descubierto que, durante esta fase del tratamiento, muchos clientes desean confrontar al agresor. Aunque algunos terapeutas aprueban e incluso estimulan ese tipo de confrontación, nosotros no lo hacemos. Según nuestra experiencia, y la de Gil (1971), ese tipo de confrontación rara vez se desarrolla como el cliente quisiera. A menudo, al planearla, la víctima elabora una fantasía en la cual el agresor hará alguna forma de reparación por el abuso, cuando en realidad lo más factible es lo contrario. El agresor puede haber reprimido o distorsionado el abuso de una manera que le proteja, para poder descartar la confrontación como una mentira o queja absurda de una persona desequilibrada.

Pensamos que esas confrontaciones pueden ser tratadas mejor de manera simbólica dentro del contexto de la terapia, esto es, la víctima puede expresar sus sentimientos hacia una silla vacía o a través de cualquier otra forma de representación de papeles, en vez de hacerlo directamente en contra del agresor. Obviamente, algunos insistirán en ese tipo de confrontación, de modo que cuando eso ocurra, lo mejor que uno puede hacer es cuidar de que existan expectativas realistas de lo que se obtendrá de tal encuentro y considerar el riesgo que se corre de perder completamente la relación con esa persona en el futuro a causa de la confrontación.

Una forma de ayudar a las víctimas para que comprendan cuán bien están cuidando de sí mismas, es hacerles ver el proceso mediante el cual toman sus decisio-

nes importantes y descubrir qué tipo de diálogo interno y proceso de toma de decisiones llevan a cabo. ¿Cómo se hablan a sí mismas cuando están decidiendo qué hacer? ¿Se retan para enfascarse en situaciones peligrosas o potencialmente abusivas porque "merecen" castigo? ¿Y fantasean que en esta ocasión alguna imaginaria "buena persona" vendrá a salvarlas? La transformación de ese diálogo interno negativo en uno sano de autocuidado es un paso fundamental para que un adulto resuelva el trauma de la infancia. Mientras ese nuevo diálogo interno no empiece a cambiar, la mayoría de las intervenciones exteriores caerán en oídos sordos.

Etapas finales de la terapia

Las relaciones en general plantean problemas serios y complejos para los adultos que sufrieron de abuso sexual en su infancia, pues carecen de algunas de las piezas fundamentales que se requieren para construir amistades y relaciones de pareja sanas. Si el cliente mantiene una relación amorosa permanente o estable, tal vez el terapeuta deseará reunirse con la otra persona. Al considerar los muchos aspectos concernientes a las relaciones, debe primero explorar con el cliente el asunto de hablar del abuso sufrido con su amigo o persona amada —no porque él o ella tenga que avergonzarse de algo, sino porque mucha gente no entiende lo que sufren los niños de quienes se ha abusado sexualmente, y el cliente quizá no reciba el apoyo y la comprensión que espera. El terapeuta debe recordar que, a pesar de la importante educación del público y la propaganda relacionada con el tema del abuso sexual de menores, muchos conservan ideas equivocadas al respecto. Así que, aunque hablar a otros del abuso sufrido puede despertar sentimientos muy intensos en el cliente, es mejor que el terapeuta mencione la desagradable posi-

bilidad de que surjan reacciones insensibles, con el fin de evitar que la víctima se encuentre sorpresivamente en una situación dolorosa.

Otro asunto importante, concerniente a las relaciones, es que los adultos que fueron víctimas de abuso sexual en la infancia pueden de alguna forma colocar a sus parejas en el papel del agresor original. Pueden escoger gente abusiva como pareja, o apresurarse hacia relaciones amorosas con la fantasía de que, esta vez, la persona amada mágicamente hará que desaparezcan sus problemas. Un adulto que sufrió de abuso en su infancia puede sentirse engañado o traicionado cuando ese tipo de relación no lo "cura" mágicamente. Es aun más común el que las intensas necesidades de dependencia por parte de la víctima hagan alejarse a los posibles amantes, lo cual deja a la persona con el sentimiento de que se aprovecharon de ella o de que no merece ser amada. Muchas víctimas se encuentran con parejas que se sienten satisfechas en el papel de salvador o que están más a gusto en relaciones con alguien frágil o vulnerable. Este tipo de pareja puede sentirse amenazada cuando la terapia comienza a cambiar el equilibrio de fuerzas dentro de la relación.

El terapeuta debe tener cuidado al considerar que los adultos que sufrieron de abuso sexual en la infancia tienen la tendencia, consciente o inconsciente, de transformar sus relaciones en relaciones abusivas. Esto no necesariamente lo hacen porque disfruten del abuso; es más factible que lo hagan porque asocian el abuso con la intimidad. Ésta es la razón principal por la cual muchos de ellos pasan tantas dificultades para amar y ser amados. En algunos casos, cuando la relación se vuelve íntima, la víctima hace algo para crear distancia o inestabilidad. Otra razón por la cual crean esa inestabilidad o escogen parejas abusivas, es que muchos tienen la creencia básica

de que serán castigados si les ocurre algo bueno. Como desquite por haberse atrevido a ser felices, hacen algo para obstaculizar la relación o aceptan parejas que continuarán abusando de ellos.

Es difícil creer que estos clientes no puedan recibir una relación que, a pesar de las vicisitudes de la vida, sea fundamentalmente sana. Para ellos, la palabra "relación" encierra la amenaza de dolor emocional. A lo largo del tratamiento, el terapeuta se planteará como meta la transformación de ese tipo de definición para hacerla más sana.

Otra forma en la cual la baja autoestima del cliente interfiere con su capacidad de establecer relaciones amorosas, es que le bloquee su capacidad de identificar y expresar sus necesidades de manera apropiada. Esta incapacidad puede tomar varias formas. La víctima puede tener la expectativa de que los otros mágicamente sepan cuáles son sus necesidades, de manera similar a como lo haría un idealizado "buen padre o madre". Cuando la persona amada no es capaz de intuir esas necesidades, la persona se siente traicionada o no amada. Otras víctimas de abuso sexual en la infancia son, en gran medida, inconscientes de sus necesidades emocionales; se sienten insatisfechas y vacías, pero no pueden identificar con claridad las causas de ello. Quizá pasen de una relación a otra, en busca de alguien en quien encontrar satisfacción.

Para algunas víctimas infantiles, la vulnerabilidad que forma parte del amor es simplemente imposible de tolerar. En estos casos, la terapia de grupo con otros adultos que hayan sufrido abuso en la infancia puede ser un marco adecuado para que aprendan a establecer relaciones emocionales con los demás. A través de un grupo de ese tipo pueden aprender a vivir las relaciones entre adultos dentro de un ambiente protegido. Sin embargo,

en el caso ideal, los clientes que sufrieron abuso sexual en la infancia también deben ser vistos individualmente mientras participen en un grupo.

Los papeles que suelen asumir estos adultos en las relaciones varían desde el dominante hasta el sumiso. Algunos no pueden tolerar una relación a menos que sientan que tienen el control total. Otros son extremadamente sumisos ante sus parejas y temen que si no las complacen constantemente dejarán de ser amados. Los asuntos corrientes de las relaciones, el dar y recibir, son un motivo de lucha constante para estas personas, pues en cierta ocasión tuvieron que "pagar" por el afecto y la intimidad, además de que los asocian con un excesivo y arbitrario ejercicio del poder de alguien sobre ellos.

La relación adulta entre los padres y las víctimas silenciosas de incesto durante la infancia, puede ser una fuente especial de serios problemas. Muchas víctimas de incesto continúan teniendo una relación con uno o ambos padres. Sin embargo, cuando la pareja actual de la víctima se entera de ese abuso sexual del pasado, enfrenta gran dificultad para comprender el deseo de la víctima de conservar una relación con "esos monstruos". Las reacciones de la pareja de una víctima de incesto pueden ir desde desear castigar a ambos padres hasta sospechar que la víctima no haya sido en realidad un participante inocente en la experiencia incestuosa.

Idealmente, el terapeuta trabajará con la víctima para ayudarlo a manejar las reacciones de su pareja. Pero, por lo general, es aconsejable que se reúna con la persona para aclarar las complejidades de este tipo de relaciones entre padres e hijos y para subrayar la necesidad de permitir al cliente resolver el trauma por sí solo. Claro está que debería tomar medidas más firmes si en la actualidad el padre incestuoso tiene contacto con los hijos de la víctima, con el fin de asegurar que los nietos no estén en

peligro de que se abuse de ellos. De no ser por las situaciones en las que los nietos pueden estar en riesgo (y asumiendo que las limitaciones relativas a la denuncia y procesamiento del incesto ya han prescrito*), el terapeuta debe ayudar a la pareja del cliente a comprender que se debe dejar que la víctima resuelva la relación con sus padres a su manera.

En resumen, el terapeuta que trata adultos que fueron víctimas de traumas sexuales en la infancia debe prepararse para enfrentar con mucha sensibilidad una gran cantidad de asuntos clínicos. Es de esperarse que estos clientes llegarán a la terapia con quejas y síntomas que no necesariamente conducirán al terapeuta a advertir que el abuso sexual forma parte de sus experiencias infantiles. Más aún, una vez que la realidad de ese temprano abuso se ha revelado, es probable que en un principio el cliente se resista a convertir el asunto en el centro de la terapia. De cualquier modo, el terapeuta que persevera y siente compasión por esas víctimas será ampliamente recompensado cuando ellas alcancen un cambio y crecimiento significativos.

* Un caso reciente de la corte puede dar esperanza a quienes desean iniciar un proceso por casos de hostigamiento que hace mucho tiempo fueron "barridos bajo la alfombra". En Los Angeles, una mujer de 28 años de edad inició un proceso legal contra su padre acusándolo de agredirla sexualmente desde los siete hasta los 19 años de edad. La importancia del caso es que la ley actual (en California) prohíbe dar curso a una acusación de ese orden después del decimonoveno cumpleaños de la víctima. Con el fin de poner a prueba el estatuto de esas limitaciones, el caso probablemente se llevará a la Suprema Corte de California. Su avance será cuidadosamente observado por personas que nunca han sido compensadas por el trauma que sufrieron, lo mismo que por quienes se interesan por ellas (*San Jose Mercury News*, 1986, p. 8B).

ocho

El abuso sexual de menores y sus consecuencias legislativas en México

En este capítulo se analizará el abuso sexual a menores en el contexto de la realidad mexicana, haciendo especial referencia a los aspectos institucionales y legislativos vinculados con este fenómeno. En el capítulo correspondiente en el texto original (*Legal and Ethical Considerations*), se estudia la legislación norteamericana y, más específicamente, la del estado de California. Por tal razón, el editor consideró pertinente sustituirlo por un texto más próximo a la legislación y a la realidad propias de los países latinoamericanos y de México en particular, muy distantes de la tradición jurídica existente en los Estados Unidos.

Para abordar esta temática, se partirá de su delimitación conceptual y de una breve caracterización del abuso sexual a menores en México, desde la perspectiva de la violencia intrafamiliar. Después, se estudiarán las instituciones que participan en el tratamiento y la prevención de este problema, y la legislación—y sus límites—existente al respecto.

Delimitación conceptual

Existen diversas definiciones del maltrato de menores. En México, el consenso es amplio en cuanto a definirlo como las acciones u omisiones intencionales y habituales que sufre un menor de edad, provenientes de los padres, tutores o responsables de su seguridad y que le provocan daños físicos o psicológicos que interfieren directamente con su pleno desarrollo como ser humano.

Los elementos fundamentales de esta definición son claros, pero habría que destacar que las negligencias de las que es víctima un menor también deben ser consideradas como maltrato (forma pasiva)—el cual, en un extremo del continuum, nos llevaría al abandono—, y que en las formas activas se incluye también el abuso sexual.

En la actualidad encontramos igualmente grandes similitudes en las diversas definiciones internacionales, lo que significa un importante avance para las investigaciones transculturales que tanto han contribuido a la comprensión del fenómeno.

Esta perspectiva internacional del problema, en los términos de la definición aquí asumida, quedó consolidada el 20 de noviembre de 1989 al aprobarse en las Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta Convención, instrumento central de la defensa de los derechos de los menores en la actualidad, vino a perfeccionar los anteriores instrumentos existentes: la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, que mejoraba, a su vez, la Declaración de Ginebra de 1924.

En el artículo 19 de dicha Convención se señala:

1. "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial."

La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por el Senado Mexicano el 31 de julio de 1991 y entró en vigor el 2 de septiembre del mismo año al ser publicada en el Diario Oficial de la Nación. Así se convirtió en Ley Nacional, al igual que la legislación positiva ya existente al respecto, que discutiremos más adelante.

Breve caracterización del problema del abuso sexual en México

A pesar de que en otros países la investigación sobre el abuso sexual a menores es, de todas las formas de maltrato infantil, la más desarrollada en la actualidad,¹ en nues-

1 Véase el más reciente número de la revista "Child Abuse & Neglect", Volumen 17, Enero-Febrero, 1993, número especial, *Clinical Recognition of Sexually Abused Children*, Pergamon Press, Nueva York, 1993.

tro medio se ha visto considerablemente rezagada.² Por tanto, la información al respecto es poco sistematizada, a pesar de que la creación de las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), ha contribuido a centralizar los registros. Por tal razón, los datos que aquí se presentarán provienen, en su mayoría, de esas Agencias.

En cuanto a la incidencia y las características de este fenómeno, se ha encontrado que entre el 60 por ciento y el 70 por ciento de las víctimas que sufren una violación en la ciudad de México son mujeres menores en edades entre los 13 y 18 años, y que *aproximadamente en el 30% de los casos el abuso sexual es protagonizado por algún pariente cercano*.

El dato sobre la proporción de menores puede variar pero la supremacía de menores violadas, frente a adultas violadas, es más o menos coincidente en la mayoría de los registros.

Según estadísticas de las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales, en 1989 se recibieron en el Distrito Federal 1,434 denuncias de violación; en 1990, 2,434 y hasta septiembre de 1991, se recibieron 2,595, lo que da un promedio de nueve denuncias de violación por día, de las cuales se puede deducir que unas seis corresponden a menores.

En cuanto a los casos atendidos en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), también de la PGJDF, encontramos que en 1992, de 3,329 casos agu-

2 La que se considera como la primera investigación sistemática realizada en México sobre el maltrato infantil, fue la realizada por Marcovich, J., en 1977 en el Hospital Infantil de México, pero esta investigación no incluyó el abuso sexual.

dos de maltrato a los que se dio atención, el 88% correspondió a mujeres adultas y el 12% restante a menores de 20 años (403 casos).³

En relación con otros registros provenientes de organizaciones no gubernamentales, la información es diversa, sobre todo porque trabajan con grupos muy pequeños de sujetos agredidos sexualmente.⁴ Sin embargo, un dato interesante que se desprende de los registros de tres de las principales Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan con problemas de violencia sexual (CIDHAL, COVAC y AVISE), es que los familiares son responsables del abuso sexual a menores en un porcentaje que varía entre el 30 y el 60% de los casos reportados; y, si se suma a otros agresores conocidos, prácticamente en el 80% de los casos que se reportan el agresor es un familiar o un conocido de la niña o niño.⁵ AVISE, por ejemplo, informa que de 143 casos atendidos en 10 meses, el 34% de los agresores fue el padre de la víctima.

En cuanto a la edad de ésta, encontramos que la mayor concentración de casos ocurre entre los 15 y los 18 años, y entre un 85 y un 90% corresponde al sexo femenino. El sujeto agresor, prácticamente en un 100%, es el padre o un familiar del sexo masculino.

3 CAVI, *Perfil estadístico anual de la violencia intrafamiliar*, periodo enero-diciembre de 1992, enero 1993.

4 Si se desea profundizar en la información proveniente de estas organizaciones no gubernamentales y en datos relativos a los servicios de las mismas, véase Azaola, E. et al., *El maltrato y el abuso sexual a menores: una aproximación a estos fenómenos en México*, sin editorial, México, 1992, pp. 69-91 y 144-155.

5 *Ibidem*, p. 83.

Estas características del abuso sexual a menores son prácticamente inversas a las que se observan en el maltrato físico: en el primero, el principal agresor es la madre; en el segundo, el padre; respecto a la edad, cuanto mayor es el niño, menor la probabilidad de ocurrencia de la agresión física; en la agresión sexual, sucede lo inverso. Y, finalmente, en el primero, la mayoría de los sujetos pasivos son varones y en el segundo, mujeres.

Instituciones que participan en el tratamiento y la prevención del abuso sexual en México

La atención gubernamental a la problemática del abuso sexual varía ampliamente en los diferentes estados de la República y el Distrito Federal. Sin embargo, existen dos instancias a escala nacional de donde provienen las principales acciones para enfrentar y prevenir esta realidad: el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que participa fundamentalmente a nivel preventivo y de asistencia social, y las Procuradurías Generales de Justicia de los estados y del Distrito Federal, que reciben las denuncias penales por parte de las víctimas o sus familiares. Es en el Distrito Federal donde más se ha avanzado en programas específicos al respecto; por tal razón se hará especial referencia a esta entidad federativa.

En marzo de 1982 se crea por primera vez en México un programa específico dirigido a la prevención del maltrato infantil, el programa PREMAN, ubicado dentro de la Dirección de Asistencia Jurídica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), creán-

dose también la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Instancias similares se fueron estableciendo en las diversas oficinas estatales del DIF.

Primordialmente, el programa PREMAN instaló un servicio permanente de recepción de denuncias por vía telefónica, el cual se ha convertido en la principal fuente de detección de casos de maltrato. Las llamadas incluso pueden ser anónimas. Otra vía de canalización de casos hacia el Programa son las instituciones de salud pública, sobre todo los hospitales infantiles, en ocasiones las escuelas públicas y, finalmente, las denuncias escritas de familiares, vecinos o amigos de las víctimas de maltrato.

Aun así, la cantidad de denuncias no parece corresponder con la problemática real. Por ejemplo, de acuerdo con datos de esta Institución, el PREMAN del DIF-DF, desde su creación en 1982, y hasta diciembre de 1992, había recibido un total de 11,514 denuncias de maltrato, de las cuales 4,063 fueron comprobadas como verdaderas. El principal peso de la labor de investigación de las denuncias recae en un cuerpo de trabajadores sociales que además establece, dependiendo de la problemática detectada, a qué área debe canalizarse el caso. Se incluye la asistencia legal, médica y psicológica. Muchas de las acciones se realizan en coordinación con los centros del Sistema de Salud o centros del propio DIF, como sucede con el Instituto Nacional de Salud Mental. También puede establecerse la necesidad de sacar al menor de su núcleo familiar y canalizarlo hacia alguna institución de internamiento o albergue temporal.

En cuanto al aspecto jurídico, la intervención se coordina con la propia Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, para los casos que involucran cuestiones civiles o familiares; y si se establece la necesidad de ejercer acción penal, el caso se turna a la Procuraduría General de Justicia. Cabe destacar que esto es lo que ocu-

re, usualmente, con los casos de abuso sexual, los cuales no son atendidos directamente por el DIF, sino derivados a las agencias del Ministerio Público.

Son, por tanto, las Procuradurías Generales de Justicia las principales instancias de recepción de denuncias en los casos de abuso sexual. Al respecto, existen en el seno de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal algunas Agencias Especializadas para su atención: las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales —ya mencionadas en este trabajo—, y las Agencias Especializadas en Asuntos de Menores.

Las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Delitos Sexuales fueron creadas en abril de 1989 para atender exclusivamente las averiguaciones previas relacionadas con esos delitos. Su objetivo central es ofrecer atención con personal especialmente capacitado —predominantemente femenino—, y con todos los servicios requeridos para la adecuada investigación de estos casos. Uno de los aspectos importantes que se introdujo fue, por ejemplo, la posibilidad de que la identificación del presunto responsable sea realizada por la víctima a través de una cámara de Gessel, o cristal de una sola dirección. La idea básica de todo el servicio es lograr que las víctimas de esos delitos no sean de nuevo "victimizadas" —como usualmente ocurría—, al hacer la denuncia correspondiente.

En la actualidad existen cuatro de tales Agencias en el Distrito Federal⁶ y otras similares se han creado en algunos estados de la República, las cuales reciben casos tanto de adultos como de menores.

6 La Núm. 46, ubicada en la Delegación Miguel Hidalgo; la Núm. 47, en la Delegación Coyoacán; la 48, en la Delegación Venustiano Carranza, y la 49 en la Delegación Gustavo A. Madero.

Otras agencias especializadas que pueden conocer de este tipo de casos son las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Asuntos de Menores, creadas en el Distrito Federal en 1990, y dependientes de la Dirección General del Ministerio Público en lo Familiar y Civil, de la Procuraduría del D. F. Inicialmente se crearon tres de estas agencias⁷ pero en la actualidad sólo funciona una. En ella se atiende todo tipo de situación relacionada con menores, incluyendo asuntos de divorcio donde se discute la patria potestad de los hijos, casos de menores infractores y casos de menores víctimas de maltrato físico y (o) sexual.

La Agencia específica, de las ya indicadas, donde debe hacerse la denuncia de un caso de abuso sexual de un menor variará según el lugar del hecho. En los estados donde no existen agencias especializadas, la denuncia se hará en la agencia del ministerio público correspondiente, también según el lugar de ocurrencia del delito.

Lo anterior es en cuanto al proceso penal; no obstante, hay otros programas gubernamentales y no gubernamentales que pueden dar atención a estos casos. Tal es la situación de los hospitales infantiles y, más específicamente, del Instituto Nacional de Perinatología, que tiene un programa especial para adolescentes que han resultado embarazadas a consecuencia del abuso sexual. Este programa, "Programa de Atención al Adolescente del INPer" fue creado en 1991 y tiene cobertura nacional.

7 Agencia Núm. 57, en la Delegación Cuauhtémoc; Agencia Núm. 58, en la Delegación Alvaro Obregón, y Agencia Núm. 59, en la Delegación Gustavo A. Madero. En noviembre de 1992, las dos últimas pasaron a ser Agencias Especializadas en Robo de Infantes.

Otro programa de reciente creación, del que ya hablamos aquí, es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar de la PGJDF. Esta institución, dependiente de la Dirección de Atención a Víctimas, comenzó a operar en octubre de 1990 dirigiendo sus servicios únicamente al Distrito Federal y zonas conurbadas. Ofrece asistencia psicosocial y jurídica a víctimas, familiares y agresores y realiza también actividades preventivas.

En cuanto a organizaciones no gubernamentales (ONG) que fueron las que iniciaron realmente este tipo de servicios, existen diversos programas que sería largo enumerar. Algunos de los que más tradición tienen en asistencia a víctimas de delitos sexuales son el Programa Interdisciplinario de Atención a Personas Violadas (PIAV), dependiente de la Facultad de Psicología de la UENEP-Iztacala-UNAM, que ofrece sus servicios desde 1987 en el Estado de México; la Asociación Mexicana Contra la Violencia Hacia Las Mujeres, A. C. (COVAC), creada en 1984 y que en la actualidad ofrece sus servicios al Distrito Federal y el Estado de México; Ayuda a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual (AVISE), y el Centro de Apoyo a Mujeres Violadas (CAMVAC), ambos operando en el Distrito Federal.

En suma, tres elementos pueden deducirse de la información anterior: a) que estos programas son todos de muy reciente creación, lo cual quiere decir que la problemática del abuso sexual se ha comenzado a estudiar y enfrentar en México hace sólo muy poco tiempo; b) que la mayoría de los programas que ofrecen servicios especializados se encuentran en el Distrito Federal o en el Estado de México, y c) que prácticamente ninguno de estos programas está dirigido de manera exclusiva a niñas y niños, lo cual reduce las posibilidades de ofrecer un servicio

realmente especializado y pensado en función de las necesidades —muy particulares— del menor victimizado sexualmente.

Aspectos legislativos

Sobre este tema vale la pena subrayar, en primer término, que no existe en México un código integral o una legislación especial destinada a la protección del menor y la familia, como ocurre en otros países. Por ello, para conocer la normatividad relativa al maltrato de menores, hay que transitar por el Código Penal y Procesal Penal, por el Código Civil, la Ley de Salud, la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, etc. En la última compilación de Legislación sobre Menores realizada por el DIF, este organismo incorpora 60 instrumentos jurídicos diversos, a nivel nacional, que tienen que ver con los menores.⁸ Esto dificulta de manera considerable el conocimiento integral de la problemática.

Se analizará, a continuación, la legislación más relevante en cuanto al abuso sexual, sin olvidar lo ya señalado: que la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas pasó a ser Ley Nacional desde septiembre de 1991.

Las últimas reformas realizadas en el campo jurídico y relacionadas con nuestro objeto de estudio, corresponden al Código Penal para el Distrito Federal. Dichas reformas operan desde enero de 1991 y constituyeron un

⁸ DIF, Dirección de Asistencia Jurídica, *Compilación de Legislación sobre Menores 1986-1987*, México, 1988.

indudable avance en el campo de la protección de los menores. En forma global podría considerarse como su mayor aporte el agravamiento de las penalidades correspondientes a determinados delitos de tipo sexual, cuando éstos fuesen cometidos por los padres del menor o por quienes ejerciesen la patria potestad.

Hasta la entrada en vigor de estas modificaciones, en muchos casos las penalidades eran las mismas si la acción era cometida por una persona perteneciente al grupo familiar o por un extraño al mismo. Hay que precisar que esta ausencia de particularidad se mantiene en la mayoría de los Códigos Penales de los estados, con lo que se sigue dejando de lado el hecho de que un delito de éstos, cometido por un padre o una madre —llamados a ser la principal fuente de protección para el niño—, es una conducta que tendrá mayores repercusiones psicológicas y aun físicas en el posterior desarrollo del menor.

En relación con el abuso sexual, las figuras que más nos interesan son las contenidas en el Título Decimoquinto del Código Penal para el Distrito Federal. El mismo Título fue modificado, pasando de la denominación *Delitos sexuales*, a la denominación "*Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicossexual*", con lo cual se asume ya un enfoque orientado a los menores de edad.

Este Título abarca los cuatros tipos penales más importantes para el tema bajo estudio: Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación. Se inicia con la figura del *Hostigamiento Sexual* (artículo 259 bis), que antes no existía como tipo penal: "Al que con fines lascivos asedia reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días de multa. Si el

hostigador fuese servidor público y utilizase los medios o circunstancias que el encargado le proporcionase, se le destituirá de su cargo". Esta figura constituyó un definitivo avance, tanto en materia de adultos (especialmente para la protección de mujeres trabajadoras), como de menores. En cuanto a estos últimos, la mayor implicación del artículo será, probablemente, en relación con el abuso sexual por parte de los maestros en las escuelas, conducta que con cierta frecuencia ocurre; aunque también puede tener implicaciones para los menores que trabajan.

El artículo 260 es relativo al Abuso Sexual (sustituye al tipo penal que anteriormente se denominaba "Atentados al pudor"): "Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá pena de tres meses a dos años de prisión. Si se hiciere uso de la violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán hasta en una mitad".

Enseguida, el artículo 261 agrava la penalidad incrementándola a un intervalo posible de seis meses a tres años de prisión, o tratamiento en libertad o semilibertad, en caso de que la misma acción prevista en el artículo 260 se ejecute en una persona menor de 12 años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a ejecutarlo. En este caso el legislador tomó muy en cuenta la edad del sujeto pasivo, intentando una mayor protección de los menores de 12 años. Sin embargo, cabe señalar que el término *abuso sexual* no se utiliza en la legislación en el sentido en que lo hemos manejado en este trabajo.

El artículo 262 relativo al Estupro, establece una penalidad de tres meses a cuatro años de prisión "al que tenga cópula con persona mayor de doce años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio

de engaño". Desaparecen en las reformas de este artículo la precisión que se hacía en la anterior redacción de que la mujer debía ser "casta y honesta" y se elimina el sexo del sujeto pasivo.

El artículo 265 tipifica el delito de Violación: "Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a catorce años...". En el artículo 266 se equipara la violación a: "I. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de doce años de edad" y "II. Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo".

En todos los casos analizados se incrementaron las penalidades previstas hasta antes de 1991. Pero más importante aun resulta lo establecido en el artículo 266 bis: "Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando:

I. El delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas.

II. El delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amasío de la madre del ofendido en contra del hijastro. Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima.

III. El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada."

Estas precisiones y agravamientos de las penalidades constituyen también un importante acierto en materia de protección de los menores contra el abuso sexual a nivel intrafamiliar.

Sin embargo, no encontramos el mismo acierto en el Capítulo III del mismo Título, relativo al Incesto (artículo 272). Aquí se establece que además de la penalidad que se aplicará al ascendiente (de uno a seis años de prisión) que incurra en la acción, también se penalizará al descendiente con seis meses a tres años de prisión. De ello se deduce la presunción, por parte del legislador, de que el menor ha participado por voluntad propia en la acción, desestimando el hecho de que en cualquier relación de este tipo hay un ejercicio del poder por parte del adulto y que el niño no se encuentra en posibilidad psicológica ni física de rechazar la acción, menos si ésta proviene de una de las personas más relevantes en su vida.

Otros tipos penales atinentes a esta problemática los encontramos en el Título Octavo del Código Penal, relativo a Delitos Contra la Moral Pública y las Buenas Costumbres en sus Capítulos II (Corrupción de Menores e Incapaces) y III (Trata de Personas y Lenocinio). Así, el artículo 201 castiga "Al que procure o facilite la corrupción de un menor de dieciocho años de edad o de quien estuviere de hecho incapacitado por otra causa, mediante actos sexuales, o lo introduzca a la práctica de la mendicidad, ebriedad, toxicomanía o algún otro vicio..." con una pena de tres a ocho años de prisión y días multa. En el artículo 203 se prevee una duplicación de la sanción cuando "...el delincuente fuese ascendiente, padrastro o madrastra del menor, privando al reo de todo derecho a los bienes del ofendido y de la patria potestad sobre todos sus descendientes".

Este importante agravamiento de la sanción previsto por el artículo 203, no se contempla, sin embargo, en el caso del delito de **Trata de Personas y Lenocinio** (artículos 206 a 208). En él, si bien se agrava la sanción para el caso en que la acción recaiga sobre menores de edad, no se contempla un agravamiento mayor si los autores son los padres o tutores de dichos menores.

Por último, deseamos poner énfasis en que en la legislación mexicana no se establece la responsabilidad penal de aquellos profesionales que, conociendo de un caso de abuso sexual a un menor, no lo notifiquen a las autoridades correspondientes para proteger al menor de nuevos abusos y prevenir acciones similares que recaigan sobre otros niños. Este aspecto es de suma importancia para la prevención de dichas acciones y aparece como el punto central de los aspectos tratados en la versión original del capítulo 8 de este libro. En efecto, en muchos estados de los Estados Unidos, y específicamente en el estado de California, se establece el deber legal que tiene, por ejemplo, un médico o un terapeuta, de reportar cualquier "sospecha razonable" que tenga de que un niño ha sido abusado sexualmente. De hecho, una violación a lo anterior se considera un delito, pudiendo tener como consecuencia el pago de una multa, la pérdida de la licencia de ejercicio profesional y el envío a prisión hasta por seis meses. En estos casos, el privilegio del secreto profesional queda anulado.

Éste es un aspecto que resulta fundamental para una política realmente preventiva en materia del abuso de menores, pero en México, el Título Decimosegundo del Código Penal del DF, sobre Responsabilidad Profesional, no contempla nada al respecto.

De todo lo anterior, un aspecto queda claro: la necesidad de conformar un Código Especial para la protección de los menores, donde la realidad de éstos sea enfocada de manera integral y multidisciplinaria. No hay que olvidar que el solo hecho de tipificar ciertas conductas y agravar las penalidades no resuelve un problema como el del abuso sexual a menores en el ámbito intrafamiliar, pues la realidad demuestra que muy pocas veces se ejerce acción penal en estos casos. De ahí que, aunque el aspecto legislativo sea un punto de partida fundamental, la búsqueda de soluciones al respecto debe ir más allá.

Lo primordial quizá siga siendo la necesidad de aceptar la existencia generalizada de este fenómeno y de estudiarlo cabalmente, para entender las características que asumen en nuestro medio y de ahí partir para establecer las medidas más adecuadas de enfrentarlo y prevenirlo.

Ana Josefina Álvarez Gómez *



* Ana Josefina Álvarez Gómez es Coordinadora de la Maestría en Política Criminal de la ENEP Acatlán, UNAM, Miembro de "Defensa de los Niños Internacional" y de la "Asociación Internacional Contra el Abuso y la Negligencia Hacia los Menores".

Bibliografía

- Adams, M. S. y Neil, J. V. "Children of incest." *Pediatrics*, 40(1), 55-63, 1967.
- American Psychiatric Association. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*, Tercera edición revisada. American Psychiatric Association, Washington, D.C., 1987.
- Bagley, C. y Ramsay, R. *Disrupted childhood and vulnerability to sexual assault: long-term sequelae with implications for counseling*. Documento inédito presentado ante la "Conferencia sobre asistencia a sobrevivientes de abuso sexual", Winnipeg, Canadá, 1985.
- Bauer, R. y Stein, J. "Sex counseling on campus: Short term treatment techniques." *American Journal of Orthopsychiatry*, 43, 824-893, 1973.
- Bender, L. "Offended and offender children." En R. Slovenko (Editor), *Sexual behavior and the law*. Charles C. Thomas, Springfield, IL., 1965.

- Bender, L. y Blau, A. "The reaction of children to sexual relations with adults." *American Journal of Orthopsychiatry*, 7, 500-518, 1937.
- Brandt, R. y Tisza, V. "The sexually misused child." *American Journal of Orthopsychiatry*, 44, 80-87, 1977.
- Bressee, P., Stearns, G. B., Bess, B. H. y Packer, L. S. "Allegations of child sexual abuse in child custody disputes: a therapeutic assessment model." *American Journal of Orthopsychiatry*, 56(4), 560-569, 1986.
- Briere, J. "The effects of childhood sexual abuse on later psychological functioning; defining a 'post-sexual-abuse syndrome'." Ponencia presentada en la "Tercera Conferencia Nacional sobre Victimización Sexual de Menores". Washington, D. C., 1984.
- Browne, A. y Finkelhor, D. "The impact of child sexual abuse: a review of the research." *Psychological Bulletin*, 99(1), 66-77, 1986.
- Browning, D. H. y Boatman, B. "Incest: Children at risk." *American Journal of Psychiatry*, 134, 69-72, 1977.
- Burguess, A. W. y Homstrom, L. L. *Rape victims of crisis*. Robert J. Brady, Bowie, MD, 1974.
- . "Complicating factors in rape: adolescent case illustrations." En A. W. Burgess, A. N. Groth, L. L. Homstrom y S. M. Sgroi (Editores), *Sexual assault of children and adolescents*. Lexington Books, Lexington, M. A., 1978.
- . "Rape trauma syndrome." *American Journal of Psychiatry*, 131(9), 981-986, 1984.
- Cooper, I. y Cormier, B. M. "Inter-generational transmission of incest." *Canadian Journal of Psychiatry*, 27, 231-235, 1982.
- Cowie, J., Cowie, V. y Slater, E. *Delinquency in girls*. Humanities Press, Atlantic Highlands, NJ, 1968.

- Cupoli, J. M. y Sewell, P. M. "One thousand fifty-nine children with a chief complaint of sexual abuse." *Child Abuse and Neglect*, 12, 151-162, 1988.
- DeFrancis, V. *Protecting the child victim of sex crimes committed by adults: final report*. The American Humane Association, Denver, 1969.
- DeYoung, M. "Innocent seducer or innocently seduced? The role of the child incest victim." *Journal of Clinical Child Psychology*, 11(1), 56-60, 1982.
- Erickson, M. H., Rossi, E. L. y Rossi, S. I. *Hypnotic realities*. Irvington, Nueva York, 1976.
- Everstine, D. S. y Everstine, L. *Personas en crisis*. Editorial Pax, México, 1993.
- . *Psychotherapy and the law*. Grune & Stratton, Orlando, 1986.
- Faller, K. C. "Is the child victim of sexual abuse telling the truth?" *Child Abuse and Neglect*, 8, 473-481, 1984.
- Finch, S. M. "Adult seduction of the child: effects on the child." *Medical aspects of Human Sexuality*, 7, 170-187, 1973.
- Finkelhor, D. *Sexually victimized children*. The Free Press, Nueva York, 1979.
- . "Risk factors in the sexual victimization of children." *Child Abuse and Neglect*, 4, 265-273, 1980.
- . "Sexual abuse: a sociological perspective." *Child Abuse and Neglect*, 6, 95-102, 1982.
- . "The sexual abuse of children: Current research reviewed." *Psychiatric Annals*, 17(4), 233-237, 241, 1987.
- y Browne, A. "The traumatic impact of child sexual abuse: a conceptualization." *American Journal of Orthopsychiatry*, 55(4), 530-541, 1985.
- Freud, A. "A psychoanalyst's view of sexual abuse by parents." En P. B. Mrazek y C. H. Kempe (editores), *Sexually abused children and their*

- families. Pergamon Press, Nueva York, 1981.
- Freud, S. (1913). *Totem and Taboo*. (A. A. Brill, Trans.) Vintage, Nueva York, 1946.
- Fritz, G., Stoll, K. y Wagner, N. "A comparison of males and females who were sexually molested as children." *Journal of Sex and Marital Therapy*, 7(1), 54-59, 1981.
- Fromuth, M. E. The relationship of childhood sexual abuse with later psychological and sexual adjustment in a sample of college women. *Child Abuse and Neglect*, 10, 5-15, 1986.
- Furniss, T. "Organizing a therapeutic approach to intra-familial child sexual abuse." *Journal of Adolescence*, 7, 309-317, 1984.
- Gagnon, J. H. "Female child victims of sex offenses." *Social Problems*, 13, 176-192, 1956.
- García, D. "Child abuse increasing, aid money decreasing." *San Francisco Chronicle*, p. 10, noviembre 11, 1986.
- Gebhard, P., Gagnon, J., Pomeroy, W. y Christensen, C. *Sex offenders*. Harper & Row, Nueva York, 1965.
- Geiser, R. L. *Hidden victims: The sexual abuse of children*. Beacon Press, Boston, 1979.
- Gibbons, T. C. N. y Prince, J. *Child victims of sex offenses*. Folleto publicado por el Institute for the Study and Treatment of Delinquency, Londres, 1963.
- Gil, D. G. "Violence against children." *Journal of Marriage and the Family*, 33, 637-648, 1971.
- Goodwin, J. *Sexual abuse: incest victims and their families*. John Wright/PSG, Littleton, MA., 1982.
- Green, A. H. "True and false allegations of sexual abuse in child custody disputes." *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, 25, 449-456, 1986.
- Groth, N. y Birnbaum, J. "Adult sexual orientation and

- the attraction to underage persons." *Archives of sexual behavior*, 7(3), 175-181, 1978.
- Harris, D. B. *Children's drawings as measures of intellectual maturity*. Harcourt, Brace & World, Nueva York, 1963.
- Harrison, P. A., Lumry, A. E. y Claypatch, C. "Female sexual abuse victims: perspectives on family dysfunction, substance use, and psychiatric disorders." Ponencia presentada en la "Segunda Conferencia Nacional para Investigadores sobre Violencia Familiar", Durham, NH., agosto de 1984.
- Heiman, J. R., LoPiccolo, L. y LoPiccolo, J. "The treatment of sexual dysfunction." En A. S. Gurman y D. P. Kniskern (editores), *Handbook of family therapy*. Brunner/Mazel, Nueva York, 1981.
- Henderson, J. D. "Incest: a synthesis of data." *Canadian Psychiatric Association Journal*, 17, 299-313, 1972.
- Herman, J. L. *Father-daughter incest*. Harvard University Press, Cambridge, MA., 1981.
- Hilberman, E. *The rape victim*. Basic Books, Nueva York, 1976.
- Hinsie, L. E. y Cambell, R. J. *Psychiatric dictionary* (cuarta edición). Oxford University Press, Nueva York, 1970.
- Jackson, D. D. *The mirages of marriage*. W. W. Norton, Nueva York, 1968.
- Katan, A. "Children who were raped: Psychoanalytic study of the child." *University Press*, 28, 208-224, 1973.
- Katz, S. y Mazur, M. A. *Understanding the rape victim*. John Wiley & Sons, Nueva York, 1979.
- Kaufmann, L., Peck, A. L. y Tagiuri, C. K. "The family constellation and overt incestuous relations between father and daughter." *American*

- Journal of Orthopsychiatry*, 24, 266-277, 1954.
- Kendall-Tackett, K. A. y Simon, A. F. "Perpetrators and their acts: data from 365 adults molested as children." *Child Abuse and Neglect*, 11, 237-245, 1987.
- Landis, J. T. "Experiences of 500 children with adult sexual deviation." *Psychiatric Quarterly Supplement*, 30, 91-109, 1956.
- Lindemann, E. "Symptomatology and management of acute grief." *American Journal of Psychiatry*, 101, 141-148, 1944.
- Lister, E. D. "Forced silence: a neglected dimension of trauma." *American Journal of Psychiatry*, 139(7), 872-875, 1982.
- Long, S. "Guidelines for treating young children." En K. MacFarlane y J. Waterman (editores), *Sexual abuse of young children*. Guilford Press, Nueva York, 1986.
- Lustig, N., Dresser, J. W., Spellman, S. W. y Murray, T. B. "Incest: a family group survival pattern." *Archives of General Psychiatry*, 14, 31-40, 1966.
- MacDonald, J. M. *Rape offenders and their victims*. Charles C. Thomas, Springfield, IL, 1971.
- MacFarlane, K. "Sexual abuse of children." En J. R. Chapman y M. Gates (editores), *The victimization of women*. Sage, Beverly Hills, CA, 1978.
- y Waterman, J. *Sexual abuse of young children*. Guilford Press, Nueva York, 1986.
- Machotka, P. F., Pittman, F. S. y Flomenhaft, K. "Incest as a family affair." *Family Process*, 6, 98-116, 1967.
- Maisch, H. *Incest*. Stein & Day, Nueva York, 1972.
- Malinowski, B. *Sex and repression in savage society*. Routledge & Kegan Paul, Londres, 1927.
- McCauldron, R. J. "Rape." *Canadian Journal of Corrections*, 9, 37-57, 1967.

- Meiselman, K. *Incest: a psychological study of causes and effects with treatment recommendations*. Jossey-Bass, San Francisco, 1978.
- Miller, J., Moeller, D., Kaufman, A., Divasto, P., Fitzsimons, P., Pather, D. y Christy, J. "Recidivism among sexual assault victims." *American Journal of Psychiatry*, 135, 1103, 1104, 1978.
- Murdock, G. P. *Social structure*. Macmillan, Nueva York, 1949.
- Nelson, S. *Incest: fact and myth*. Stramullion, Edinburgo, 1982.
- Peters, J. J. "Child rape: defusing a psychological time bomb." *Hospital Physician*, febrero, 46-49, 1973.
- , "The psychological effects of childhood rape." *World Journal of Psychosynthesis*, 6, 11-14, 1974.
- , "Social, legal and psychological effects of rape on the victim." *Pennsylvania Medicine*, 78, 34-36, 1975.
- , "Children who were victims of sexual assault and the psychology of the offenders." *American Journal of Psychotherapy*, 30, 398-417, 1976.
- Porter, F. S., Blich, L. C. y Sgroi, S. M. "Treatment of the sexually abused child." En S. M. Sgroi (editor), *Handbook of clinical intervention in child sexual abuse*. Lexington Books, Lexington, MA, 1982.
- Price, V. "Rape victims. The invisible patients." *The Canadian Nurse*, 71, 29-34, 1975.
- Raphling, D. L., Carpenter, B. L. y Davis, A. "Incest: A genealogical study." *Archives of General Psychiatry*, 16, 505-511, 1967.
- Reich, J. W. y Gutierrez, S. E. "Escape/aggression incidence in sexually abused juvenile delinquents." *Criminal Justice and Behavior*, 6, 239-243, 1979.

- Reinhart, M. A. "Sexually abused boys." *Child Abuse and Neglect*, 11, 229-235, 1987.
- Rosenfeld, A. A., Nadelson, C. C. y Krieger, M. "Fantasy and reality in patients' reports of incest." *Journal of Clinical Psychiatry*, 40, 159-164, 1979.
- San Francisco Chronicle*. "Many adults were abused as children, new poll finds." P. 51, 26 de agosto de 1985.
- San José Mercury News*. "Woman challenges age limit in incest law by suing at 28." P. 88, 12 de noviembre de 1986.
- Schultz, L. G. "The child as a sex victim: socio-legal perspectives." En L. G. Schultz (editor), *Rape victimology*. Charles C. Thomas, Springfield, IL, 1975.
- Sedney, M. A. y Brooks, B. "Factors associated with a history of childhood sexual experience in a nonclinical female population." *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, 23, 215-218, 1984.
- Seemanova, E. "A study of children of incestuous matings." *Human Heredity*, 21, 108-128, 1971.
- Selvini Palazzoli, M. "At what point do systems consult an expert?" Ponencia ante la Segunda Conferencia Bianual del Mental Research Institute y del Emergency Treatment Center, Munich, RFA, julio de 1984.
- Sgroi, S. M. "Child sexual assault: some guidelines for intervention and assessment." En A. W. Burgess, A. N. Groth, L. Holmstrom y S. M. Sgroi (editores), *Sexual assault of children and adolescents*. Lexington Books, Lexington, MA, 1978.
- . "The sexual assault of children: dynamics of the problem and issues in program development." En *Sexual Abuse of Children*. Community Council of Greater New York, Nueva York, 1979.

- . "A conceptual framework for child sexual abuse." En M. Sgroi (editor), *Handbook of clinical intervention in child sexual abuse*. Lexington-Books, Lexington, M. A., 1982.
- Symonds, M. "The 'second injury' to victims." *Evaluation and Change, Special Issue*, 36-38, 1980.
- Tufts New England Medical Center, Division of Child Psychiatry. *Sexually exploited children: service and research project*. Informe final ante la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia. Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Washington, D.C., 1984.
- Weinberg, S. K. *Incest behavior*. Citadel Press, Nueva York, 1955.
- Weiner, I. B. "Father-daughter incest: a clinical report." *Psychiatric Quarterly*, 36, 607-632, 1962.
- Westermeyer, J. "Incest in psychiatric practice. A description of patients and incestuous relationships." *The Journal of Clinical Psychiatry*, 643-648, agosto de 1978.
- Yates, A. "Children eroticized by incest." *American Journal of Psychiatry*, 139(4), 482-485, 1982.
- . "Psychological damage associated with extreme eroticism in young children." *Psychiatric Annals*, 17(4), 257-261, 1987a.
- . "Should young children testify in cases of sexual abuse?" *American Journal of Psychiatry*, 144(4), 476-480, 1987b.